

Unterrichtung

durch die Bundesregierung

**Bericht des Bewertungsausschusses und des ergänzten Bewertungsausschusses
zur telemedizinischen Leistungserbringung im Einheitlichen Bewertungsmaßstab
für das Berichtsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung.....	14
Teil A Bericht des Bewertungsausschusses.....	20
1 Einleitung.....	20
1.1 Inhaltliche Umsetzung des Berichts im Rahmen der Anpassungen des § 87 SGB V durch das Digital-Gesetz (DigiG)	20
1.2 Datengrundlage.....	20
2 Videosprechstunde.....	23
2.1 Allgemeine Erläuterungen.....	23
2.2 Regelungen und Vergütung im EBM.....	24
2.3 Berechnungsfähige Leistungen im Rahmen der Videosprechstunde im Jahr 2023.....	29
2.4 Leistungsentwicklung.....	31
2.5 Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Leistungsbereichen und einzelnen Leistungen durch die bundeseinheitliche Kennzeichnung.....	33
2.6 Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit.....	34
2.7 Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Einrichtungsformen	36
2.8 Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Fachgruppen und Anteil der Fachgruppen an allen abgerechneten Videosprechstunden	37
2.9 Anzahl Ärztinnen/Ärzte, die Videosprechstunden abrechnen, im Verhältnis zu allen Ärztinnen/Ärzten einer Fachgruppe	40
2.10 Versicherte und Behandlungsfälle mit Videosprechstunden.....	42
2.10.1 Gesamtanzahl von Versicherten und Behandlungsfällen mit Videosprechstunden.....	42
2.10.2 Ausschließliche Video-Behandlungsfälle.....	43
2.10.3 Anteil Video-Behandlungsfälle an allen Behandlungsfällen	43
2.11 Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten mit Inanspruchnahme von Leistungen im Rahmen der Videosprechstunde	45
2.11.1 Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten in Bezug auf einzelne Leistungsbereiche der Videosprechstunde.....	46
2.11.2 Betrachtung der Morbidität von Versicherten für ausgewählte Inanspruchnahmen der Videosprechstunde	52
2.12 Authentifizierungen im Rahmen von Videosprechstunden.....	54
3 Videofallkonferenzen.....	56
3.1 Allgemeine Erläuterungen.....	56
3.2 Regelungen und Vergütung im EBM.....	56
3.3 Leistungsentwicklung.....	58
4 Telemonitoring bei Versicherten mit Herzinsuffizienz	60
4.1 Allgemeine Erläuterungen.....	60
4.2 Regelungen und Vergütung im EBM.....	62
4.3 Leistungsentwicklung.....	64
4.4 Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit sowie nach Einrichtungsformen und Fachgruppen.....	69
4.5 Anzahl zugelassener Ärztinnen und Ärzte zum Telemonitoring Herzinsuffizienz nach KV-Bezirken	74
4.6 Stand der Versorgungseinrichtungen im 4. Quartal 2023.....	75

4.7	Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten im Telemonitoring Herzinsuffizienz	77
5	Telemedizinische Funktionsanalysen von ICD- und CRT-Geräten	80
5.1	Allgemeine Erläuterungen	80
5.2	Regelungen und Vergütung im EBM	80
5.3	Leistungsentwicklung	82
5.4	Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit sowie nach Fachgruppen und Einrichtungsformen	84
5.5	Anteil telemedizinischer Funktionsanalysen an allen ICD- und CRT-Funktionsanalysen	86
5.6	Behandlungsfälle und Versicherte mit Telemedizinischer Funktionsanalyse	88
5.6.1	Anteil telemedizinischer Funktionsanalysen an allen ICD- und CRT-Funktionsanalysen auf Behandlungsebene	88
6	Telekonsiliarische Befundbeurteilung radiologischer Aufnahmen	90
6.1	Allgemeine Erläuterungen	90
6.2	Regelungen und Vergütung im EBM	90
6.3	Leistungsentwicklung	92
7	Elektronische Patientenakte	93
7.1	Allgemeine Erläuterungen	93
7.2	Regelungen und Vergütung im EBM	94
7.3	Leistungsentwicklung	96
7.4	Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit sowie nach Fachgruppen und Einrichtungsformen	98
7.5	Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten mit Inanspruchnahme der ePA	103
8	Elektronische Arztbriefe	105
8.1	Allgemeine Erläuterungen	105
8.2	Regelungen und Vergütung im EBM bzw. der TI-Finanzierungsvereinbarung	106
8.3	Leistungsentwicklung	107
8.4	Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit sowie nach Einrichtungsformen	109
8.5	Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Fachgruppen und Anteil abrechnender Ärztinnen und Ärzte in den Fachgruppen	112
9	Anwendungen auf der elektronischen Gesundheitskarte	114
9.1	Allgemeine Erläuterungen	114
9.2	Notfalldatenmanagement	115
9.2.1	Regelungen und Vergütung im EBM	115
9.2.2	Leistungsentwicklung	116
9.2.3	Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit sowie nach Fachgruppen und Einrichtungsformen	121
9.2.4	Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten mit der Anlage eines Notfalldatensatzes	126
9.3	Elektronischer Medikationsplan	127
9.3.1	Regelungen und Vergütung im EBM	127
9.3.2	Leistungsentwicklung	128
10	Digitale Gesundheitsanwendungen	129
10.1	Allgemeine Erläuterungen	129
10.2	Regelungen und Vergütung im EBM	131

10.3	Leistungsentwicklung.....	134
10.4	Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit sowie nach Fachgruppen und Einrichtungsformen.....	135
10.5	Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten DiGA-Leistungen.....	139
Teil B Bericht des ergänzten Bewertungsausschusses		140
11	Einleitung.....	140
11.1	Inhaltliche Umsetzung des Berichts im Rahmen der Anpassungen des § 87 SGB V durch das Digital-Gesetz (DigiG)	140
11.2	Datengrundlage.....	140
12	Sektorenübergreifende Telekonsilien.....	141
12.1	Allgemeine Erläuterungen.....	141
12.2	Regelungen und Vergütung im EBM.....	141
12.3	Leistungsentwicklung.....	142
12.4	Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit sowie nach Fachgruppen und Einrichtungsformen.....	144
12.5	Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten mit Leistungen zu Telekonsilien ..	149
13	Telemedizinische Leistungen im Rahmen der Ambulanten Spezialfachärztlichen Versorgung (ASV).....	152
13.1	Allgemeine Erläuterungen.....	152
13.2	Regelungen und Vergütung im EBM.....	152
13.3	Leistungsentwicklung telemedizinischer Leistungen in der ASV.....	154
14	Telemedizinische Durchführung von Zweitmeinungsverfahren.....	155
14.1	Allgemeine Erläuterungen.....	155
14.2	Regelungen und Vergütung im EBM.....	156
14.3	Leistungsentwicklung.....	157
15	Versorgung im organisierten Not(-fall)dienst mit telemedizinischen Leistungen	158
15.1	Allgemeine Erläuterungen.....	158
15.2	Regelungen und Vergütung im EBM.....	158
15.3	Leistungsentwicklung.....	159
15.4	Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit und nach Fachgruppen sowie Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten mit einer Notfallpauschale als Videoleistung	160
16	Telemedizinische Leistungen in der koordinierten und strukturierten Versorgung insbesondere schwer psychisch kranker Versicherter.....	163
16.1	Allgemeine Erläuterungen.....	163
16.2	Regelungen und Vergütung im EBM.....	164
16.3	Leistungsentwicklung.....	165
Anhang		166

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zu Videosprechstunden, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden	28
Tabelle 2 Auflistung der wichtigsten im Berichtszeitraum im Rahmen der Videosprechstunde berechnungsfähigen Gebührenordnungspositionen	30
Tabelle 3 Abrechnungshäufigkeit der Leistungsbereiche, die per Video in den Jahren 2020– 2023 durchgeführt wurden	33
Tabelle 4 Abrechnungshäufigkeit der Videosprechstunde (GOP 01450) nach Einrichtungsformen in den Jahren 2020 bis 2023.....	37
Tabelle 5 Abrechnungshäufigkeit der Videosprechstunde (GOP 01450) nach Fachgruppen und Anteil an allen abgerechneten Videosprechstunden in % für das Jahr 2023.....	39
Tabelle 6 Anzahl Ärztinnen/Ärzte/Psychotherapeutinnen/-therapeuten (n Ä), die mind. einmal im Jahr eine Videosprechstunde (GOP 01450) abrechneten.....	40
Tabelle 7 Anzahl Versicherte und Behandlungsfälle mit Inanspruchnahme mindestens einer Videosprechstunde (GOP 01450) in den Jahren 2020-2023.....	42
Tabelle 8 Ausschließliche Videobehandlungsfälle (ohne persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt) ...	43
Tabelle 9 Verhältnis von ausschließlichen und kombinierten Video-Behandlungsfällen zu ausschließlich persönlichen Behandlungsfällen im Jahr 2023.....	44
Tabelle 10 Krankheitsspektrum auf Grundlage von überproportional häufig vorliegenden ICD-Diagnosen im Behandlungsfall bei Versicherten mit Videosprechstunde.....	53
Tabelle 11 Durchführbarkeit von Fallkonferenzen per Video.....	56
Tabelle 12 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zu Videofallkonferenzen, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden	57
Tabelle 13 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in den Jahren 2020 bis 2023 für die GOP 01442.....	58
Tabelle 14 Neue Gebührenordnungspositionen mit dem Beschluss des EBA in seiner 76. Sitzung, getrennt nach PBA/TMZ.....	62
Tabelle 15 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zum Telemonitoring bei Herzinsuffizienz, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden.....	63
Tabelle 16 Abrechnungshäufigkeit von Leistungen, die von primär behandelnden Ärztinnen/Ärzten (PBA) berechnungsfähig sind, nach Einrichtungsformen im Jahr 2023	71
Tabelle 17 Abrechnungshäufigkeit von Leistungen, die von telemedizinischen Zentren (TMZ) berechnungsfähig sind, nach Einrichtungsformen im Jahr 2023	72
Tabelle 18 Abrechnungshäufigkeit der Indikationsprüfung und der Betreuung von Versicherten im Telemonitoring durch primär behandelnde Ärztinnen/Ärzte (PBA).....	73
Tabelle 19 Durchschnittliche Leistungshäufigkeiten von telemedizinischen Zentren (TMZ) im 4. Quartal 2023	76
Tabelle 20 Gebührenordnungspositionen für die telemedizinischen Kontrollen (Funktionsanalysen) von ICD- und CRT-Geräten	81
Tabelle 21 Abrechnungshäufigkeit pro Jahr der Funktionsanalyse im persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt bei Erwachsenen für ICD- und CRT-Aggregate	83
Tabelle 22 Abrechnungshäufigkeit und Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte der telemedizinischen Funktionsanalyse bei Erwachsenen im Jahr 2023.....	85
Tabelle 23 Abrechnungshäufigkeit der telemedizinischen Funktionsanalyse im Jahr 2023 nach Einrichtungsform.....	86
Tabelle 24 Anzahl der BHF und Versicherten mit mindestens einer durchgeführten telemedizinischen Funktionsanalyse.....	88
Tabelle 25 Gebührenordnungspositionen für die Beauftragung und Durchführung einer telekonsiliarischen Befundbeurteilung.....	91

Tabelle 26 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zur telekonsiliarischen Befundbeurteilung, die im Jahr 2022 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden.....	91
Tabelle 27 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € der Leistungen zur telekonsiliarischen Befundbeurteilung radiologischer Aufnahmen	92
Tabelle 28 Gebührenordnungspositionen im Zusammenhang mit der ePA.....	95
Tabelle 29 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zur elektronischen Patientenakte, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden.....	96
Tabelle 30 Regionale Abrechnungshäufigkeit der Leistungen zur ePA nach KV-Bezirken im Jahr 2023	99
Tabelle 31 Abrechnungshäufigkeit der Leistungen zur ePA nach Fachgruppen im Jahr 2023	100
Tabelle 32 Gebührenordnungsposition 01660 und Pseudo-Gebührenordnungspositionen 86900 und 86901 für Versand und Empfang von eArztbriefen.....	106
Tabelle 33 Leistungsbedarf für eArztbriefe in den Jahren 2022 und 2023	109
Tabelle 34 Gebührenordnungspositionen für das Management von Notfalldatensätzen	115
Tabelle 35 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zum Notfalldatenmanagement, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden.....	116
Tabelle 36 Leistungsbedarf zum Notfalldatenmanagement (GOP 01640 bis 01642) im Jahr 2023.....	118
Tabelle 37 Zuschlag für die Erstellung eines Medikationsplans.....	127
Tabelle 38 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zum Medikationsplan, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden	128
Tabelle 39 Auflistung der dauerhaften DiGA (n=29).....	130
Tabelle 40 Gebührenordnungspositionen für die DiGA somnio, Vivira, zanadio, Invirto, Oviva Direkt für Adipositas und Mawendo.....	132
Tabelle 41 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zu DiGA, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden.....	133
Tabelle 42 Leistungsbedarf in € der ärztlichen Leistungen zu DiGA in den Jahren 2022 und 2023.....	135
Tabelle 43 Gebührenordnungspositionen für die Einholung und Durchführung von Telekonsilien.	142
Tabelle 44 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zu Telekonsilien, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden	142
Tabelle 45 Leistungsbedarf in € der Leistungen zu Telekonsilien in den Jahren 2022 und 2023.....	143
Tabelle 46 Leistungen in der ASV aus Kapitel 50 EBM, die auch als Videosprechstunde/-fallkonferenz bzw. elektronische Version berechnungsfähig sind.....	153
Tabelle 47 Beschlüsse des ergBA und ergEBA zu telemedizinischen Leistungen in der ASV, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden.....	154
Tabelle 48 Eingriffe mit gesetzlich vorgesehenen Zweitmeinungsverfahren	156
Tabelle 49 Gebührenordnungsposition für die indikationsstellende Ärztin oder den Arzt zur Beratung über die Möglichkeit einer Zweitmeinung.....	156
Tabelle 50 Beschlüsse des BA zur telemedizinischen Durchführung von Zweitmeinungen, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden.....	157
Tabelle 51 Gebührenordnungspositionen für den organisierten Not(-fall)dienst, die als Videosprechstunde durchgeführt werden können.....	158
Tabelle 52 Gebührenordnungsposition für die patientenorientierte Fallbesprechung gemäß KSVPsych-Richtlinie.....	164
Tabelle 53 Abrechnungshäufigkeit für die GOP 01442, 01444 und 01450 pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023	166
Tabelle 54 Leistungsbedarf in € für die GOP 01442, 01444 und 01450 pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.....	166

Tabelle 55 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € pro Jahr für die GOP 01442, 01444 und 01450.....	166
Tabelle 56 Abrechnungshäufigkeit von Leistungen im Rahmen der Videosprechstunde.....	167
Tabelle 57 Regionale Abrechnungshäufigkeit des Technikzuschlags Videosprechstunde (GOP 01450) nach KV-Bezirken für die Jahre 2020 bis 2023.....	171
Tabelle 58 Abrechnungshäufigkeit der Videosprechstunde (GOP 01450) nach Fachgruppen in den Jahren 2020 bis 2023 und Anteil an allen abgerechneten Videosprechstunden in %.....	172
Tabelle 59 Prozentualer Anteil der überproportional häufigen ICD-Diagnosen von Behandlungsfällen von Versicherten mit Videosprechstunde	173
Tabelle 60 Regionale Abrechnungshäufigkeit der Authentifizierung von Versicherten (GOP 01444) im Rahmen der Videosprechstunde nach KV-Bezirken.....	176
Tabelle 61 Jährliche regionale Abrechnungshäufigkeit der Videofallkonferenz (GOP 01442) nach KV-Bezirken.....	177
Tabelle 62 Abrechnungshäufigkeit der Videofallkonferenz (GOP 01442) nach Einrichtungenformen in den Jahren 2020 bis 2023.....	177
Tabelle 63 Abrechnungshäufigkeit der Videofallkonferenz (GOP 01442) nach Fachgruppen im Jahr 2023	178
Tabelle 64 Abrechnungshäufigkeit aller Leistungen des Telemonitoring Herzinsuffizienz im Quartalsverlauf und insgesamt für das Jahr 2023.....	179
Tabelle 65 Leistungsbedarf in € aller Leistungen des Telemonitoring Herzinsuffizienz im Quartalsverlauf und insgesamt für das Jahr 2023.....	179
Tabelle 66 Abrechnungshäufigkeit der Leistungen des Telemonitoring Herzinsuffizienz, die primärbehandelnde Ärztinnen/Ärzte (PBA) betreffen.....	180
Tabelle 67 Abrechnungshäufigkeit von GOP des Telemonitoring Herzinsuffizienz, die telemedizinische Zentren (TMZ) betreffen.....	181
Tabelle 68 a: Anzahl der abrechnenden Telemedizinischer Zentren (TMZ) im 4. Quartal 2023 nach KV-Bezirken	182
Tabelle 69 Abrechnungshäufigkeit der telemedizinischen Funktionsanalyse von ICD- und CRT-Aggregaten.....	182
Tabelle 70 Leistungsbedarf in € der telemedizinischen Funktionsanalyse von ICD- und CRT-Aggregaten	183
Tabelle 71 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € der Leistungen der telemedizinischen Funktionsanalyse in den Jahren 2018 bis 2023	183
Tabelle 72 Abrechnungshäufigkeit der Leistungen der telemedizinischen Funktionsanalyse nach KV-Bezirken im Jahr 2023.....	184
Tabelle 73 Abrechnungshäufigkeit der Leistungen zur telemedizinischen Funktionsanalyse nach Fachgruppen im Jahr 2023.....	184
Tabelle 74 Abrechnungshäufigkeit der telekonsiliarische Befundbeurteilung radiologischer Aufnahmen - pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.....	185
Tabelle 75 Leistungsbedarf in € der telekonsiliarischen Befundbeurteilung radiologischer Aufnahmen - pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.....	185
Tabelle 76 Abrechnungshäufigkeit zur ePA pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.....	185
Tabelle 77 Leistungsbedarf in € zur ePA pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.....	185
Tabelle 78 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € pro Jahr zur ePA.....	186
Tabelle 79 Abrechnungshäufigkeit zur ePA nach Einrichtungenformen im Jahr 2023.....	186
Tabelle 80 Abrechnungshäufigkeit zu elektronischen Arztbriefen pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.....	186
Tabelle 81 Leistungsbedarf in € zu elektronischen Arztbriefen pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023	187

Tabelle 82 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € pro Jahr für eArztbriefe.....	187
Tabelle 83 Regionale Abrechnungshäufigkeit der Leistungen zu eArztbriefen nach KV-Bezirken.....	188
Tabelle 84 Abrechnungshäufigkeit für eArztbriefe nach Einrichtungenformen im Jahr 2023.....	188
Tabelle 85 Abrechnungshäufigkeit für elektronische Arztbriefe nach Fachgruppen im Jahr 2022	189
Tabelle 86 Abrechnungshäufigkeit zum Notfalldatenmanagement pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.....	189
Tabelle 87 Leistungsbedarf in € zum Notfalldatenmanagement pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.....	190
Tabelle 88 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € pro Jahr für Notfalldatenmanagement.	190
Tabelle 89 Regionale Abrechnungshäufigkeit der Leistungen zum Notfalldatenmanagement nach KV-Bezirken.....	191
Tabelle 90 Abrechnungshäufigkeit der Leistungen des Notfalldatenmanagements nach Fachgruppen im Jahr 2023.....	192
Tabelle 91 Abrechnungshäufigkeit für die Leistungen des Notfalldatenmanagements im Jahr 2023 nach Einrichtungenformen.....	192
Tabelle 92 Abrechnungshäufigkeit zu ärztlichen Leistungen im Zusammenhang mit DiGA pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.....	193
Tabelle 93 Leistungsbedarf in € für ärztliche Leistungen im Zusammenhang mit DiGA pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.....	193
Tabelle 94 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € pro Jahr für ärztliche Leistungen im Zusammenhang mit DiGA.....	193
Tabelle 95 Regionale Abrechnungshäufigkeit der ärztlichen Leistungen zu DiGA nach KV-Bezirken	194
Tabelle 96 Abrechnungshäufigkeit der Leistungen im Zusammenhang mit DiGA nach Fachgruppen im Jahr 2023.....	195
Tabelle 97 Abrechnungshäufigkeit für ärztliche Leistungen zu DiGA (GOP01471 bis 01476) nach Einrichtungenformen im Jahr 2023.....	196
Tabelle 98 Abrechnungshäufigkeit zu Telekonsilien pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.	196
Tabelle 99 Leistungsbedarf in € zu Telekonsilien in den Jahren 2022 und 2023 pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.....	196
Tabelle 100 Jährliche Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf für die Leistungen zu Telekonsilien.....	196
Tabelle 101 Regionale Abrechnungshäufigkeit für Telekonsilien nach KV-Bezirken im Jahr 2023.....	197
Tabelle 102 Abrechnungshäufigkeit für Telekonsilien nach Fachgruppen im Jahr 2023.....	198
Tabelle 103 Abrechnungshäufigkeit für Telekonsilien nach Einrichtungenformen im Jahr 2023...	198
Tabelle 104 Abrechnungshäufigkeit für die Notfallpauschalen I und II als Videoleistung seit der Einführung im 3. Quartal 2022 und im Jahr 2023.....	199
Tabelle 105 Leistungsbedarf in € für die Notfallpauschalen I und II als Videoleistung seit der Einführung im 3. Quartal 2022 und im Jahr 2023.....	199
Tabelle 106 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € für die Notfallpauschalen I und II als Videoleistung seit der Einführung im 3. Quartal 2022 und im Jahr 2023.....	199
Tabelle 107 Regionale Abrechnungshäufigkeit für die Notfallpauschalen I und II als Videoleistung nach KV-Bezirken im Jahr 2023.....	199
Tabelle 108 Abrechnungshäufigkeit für die Notfallpauschalen I und II als Videoleistung nach Fachgruppen im Jahr 2023.....	200

Tabelle 109 Abrechnungshäufigkeit für die Notfallpauschalen I und II als Videoleistung nach Einrichtungsformen im Jahr 2023.....	200
---	-----

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf (in €) der GOP01450 in den Jahren 2020 bis 2023.	31
Abbildung 2 Abrechnungshäufigkeit (AH) und Leistungsbedarf (LB, in €) der GOP01450 je Quartal	32
Abbildung 3 Regionale Abrechnungshäufigkeit des Technikzuschlags Videosprechstunde (GOP 01450) nach KV-Bezirken.....	35
Abbildung 4 Verteilung der abgerechneten Videosprechstunden (GOP01450) auf die Einrichtungsformen im Jahr 2023.....	36
Abbildung 5 Abrechnungshäufigkeit der GOP 01450 nach Fachgruppen	38
Abbildung 6 Anteil der Ärztinnen/Ärzten und Psychotherapeutinnen/-therapeuten, die mindestens eine Videosprechstunde (GOP 01450) abrechneten.....	41
Abbildung 7 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten, bei denen die Videosprechstunde (GOP 01450) im Jahr 2023 abgerechnet wurde.....	45
Abbildung 8 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten bei den Versicherten-, Grund- und Konsiliarpauschalen	47
Abbildung 9 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten bei der Inanspruchnahme von Gesprächsleistungen.....	48
Abbildung 10 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten bei der Inanspruchnahme von Einzelpsychotherapien.....	49
Abbildung 11 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten bei der Inanspruchnahme der Gruppenpsychotherapie.....	50
Abbildung 12 Anteil der Versicherten mit Inanspruchnahme von mindestens einer Videosprechstunde im Rahmen einer Psychotherapie.....	51
Abbildung 13 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € der Authentifizierung eines unbekannten Versicherten.....	54
Abbildung 14 Verhältnis von Authentifizierung zur Videosprechstunde	55
Abbildung 15 Abrechnungshäufigkeit der GOP 01442 (Videofallkonferenz) in den Jahren 2022 und 2023.....	59
Abbildung 16 Schematische Darstellung des Telemonitorings bei Versicherten mit Herzinsuffizienz	61
Abbildung 17 Abrechnungshäufigkeiten für die Indikationsstellung bei Versicherten für Telemonitoring Herzinsuffizienz für die primär behandelnden Ärztinnen/Ärzte	65
Abbildung 18 Abrechnungshäufigkeiten der Zusatzpauschalen für primär behandelnde Ärztinnen/Ärzte (PBA) vom 2. Quartal 2022 bis 4. Quartal 2023.....	66
Abbildung 19 Abrechnungshäufigkeiten der zentralen Behandlungs-GOP für telemedizinische Zentren (TMZ) vom 2. Quartal 2022 bis 4. Quartal 2023.....	67
Abbildung 20 Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit der Zuschläge (GOP 13585 und 13587) für die intensivste Überwachung.....	68
Abbildung 21 Regionale Abrechnungshäufigkeit der GOP 13583, 13584 und 13586 nach KV- Bezirken im Jahr 2023.....	70
Abbildung 22: Anzahl der Ärztinnen/Ärzte mit Genehmigung zur Durchführung des Telemonitoring Herzinsuffizienz zum 31.12.2023 (erste Zeile) nach KV-Bezirken	74
Abbildung 23 Anzahl der abrechnenden Betriebsstätten von primär behandelnden Ärztinnen/Ärzten (PBA) und telemedizinischer Zentren (TMZ) im 4. Quartal 2023	75

Abbildung 24 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten im Telemonitoring Herzinsuffizienz mittels implantierter Aggregate.....	78
Abbildung 25 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten im Telemonitoring Herzinsuffizienz mittels externer Geräte	78
Abbildung 26 Abrechnungshäufigkeit der telemedizinischen Funktionsanalyse von ICD- und CRT- Aggregaten bei Erwachsenen in den Jahren 2018 bis 2023.....	82
Abbildung 27 Leistungsbedarf in € der telemedizinischen Funktionsanalyse von ICD-Aggregaten und CRT-Aggregaten bei Erwachsenen in den Jahren 2018 bis 2023.....	83
Abbildung 28 Regionale Abrechnungshäufigkeit der GOP 13574 und GOP 13576 nach KV-Bezirken im Jahr 2023.....	84
Abbildung 29 Anteil telemedizinischer Funktionsanalysen an allen ICD- und CRT-Funktionsanalysen	87
Abbildung 30 Anteile in % der Behandlungsfälle, die mind. eine telemedizinische Funktionsanalyse erhalten haben.....	89
Abbildung 31 Abrechnungshäufigkeit der Gebührenordnungspositionen zur ePA in den Jahren 2021 bis 2023.....	96
Abbildung 32 Leistungsbedarf der Gebührenordnungspositionen im Rahmen der ePA in den Jahren 2021 bis 2023.....	97
Abbildung 33 Abrechnungshäufigkeit der Leistungen zur ePA im Quartalsverlauf in den Jahren 2022 und 2023.....	98
Abbildung 34 Abrechnungshäufigkeit der Leistungen zur ePA nach Einrichtungsformen im Jahr 2023	102
Abbildung 35 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten, bei denen eine Erstbefüllung einer ePA (GOP 01648) im Jahr 2023 abgerechnet wurde	103
Abbildung 36 Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten	104
Abbildung 37 Abrechnungshäufigkeit der (Pseudo-)Gebührenordnungspositionen für Versand und Empfang von eArztbriefen	108
Abbildung 38 Regionale Abrechnungshäufigkeit der Versandpauschale und der Empfangspauschale für eArztbriefe nach KV-Bezirken	110
Abbildung 39 Durchschnittliche Abrechnungen je abrechnende Einrichtung der Leistungen zu eArztbriefen im Jahr 2023, dargestellt nach Einrichtungsformen.....	111
Abbildung 40 Abrechnungshäufigkeit der Versandpauschale und der Empfangspauschale für eArztbriefe im Jahr 2023 je Fachgruppe	112
Abbildung 41 Anteil der Ärztinnen/Ärzte in den Fachgruppen, der die Versandpauschale und die Empfangspauschale für eArztbriefe im Jahr 2023 abgerechnet hat.....	113
Abbildung 42 Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit der Anlage eines Notfalldatensatzes in den Jahren 2020 bis 2023.....	117
Abbildung 43 Abrechnungshäufigkeit der Gebührenordnungsposition für die Anlage eines Notfalldatensatzes in den Jahren 2022 und 2023.....	117
Abbildung 44 Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit und des Leistungsbedarfes des Zuschlags Notfalldatensatz in den Jahren 2020 bis 2023.....	119
Abbildung 45 Abrechnungshäufigkeit für den Zuschlag Notfalldatensatz in den Jahren 2022 und 2023	120
Abbildung 46 Abrechnungshäufigkeit der Gebührenordnungsposition für die Löschung des Notfalldatensatzes in den Jahren 2022 und 2023.....	121
Abbildung 47 Regionale Abrechnungshäufigkeit für den Zuschlag für die Anlage eines Notfalldatensatzes nach KV-Bezirken im Jahr 2023.....	122
Abbildung 48 Die fünf Fachgruppen mit der größten Abrechnungshäufigkeit für den Zuschlag für die Anlage eines Notfalldatensatzes.....	123

Abbildung 49 Fachgruppen mit dem größten Anteil Ärztinnen/Ärzte, für die im Jahr 2023 GOP 01641 abgerechnet wurde.....	124
Abbildung 50 Durchschnittliche Abrechnungen der Anlage eines Notfalldatensatzes und des Zuschlags Notfalldatensatz je abrechnende Einrichtung.....	125
Abbildung 51 Anteil der verschiedenen Altersgruppen und Geschlechter derjenigen Versicherten, für die im Jahr 2023 ein Notfalldatensatz angelegt wurde.....	126
Abbildung 52 Abrechnungshäufigkeit der ärztlichen Leistungen zu den DiGA somnio, Vivira, zanadio, Invirto, Oviva direkt für Adipositas und Mawendo.....	134
Abbildung 53 Regionale Abrechnungshäufigkeit von ärztlichen Leistungen zu DiGA nach KV- Bezirken im Jahr 2023.....	136
Abbildung 54 Abrechnungshäufigkeit der ärztlichen Leistungen zu DiGA im Jahr 2023 nach Fachgruppen.....	137
Abbildung 55 Abrechnungen von Leistungen zu DiGA (GOP 01471 bis 01476) im Jahr 2023 nach Einrichtungsformen	138
Abbildung 56 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten, bei denen im Jahr 2023 eine DiGA-Leistung abgerechnet wurde.....	139
Abbildung 57 Abrechnungshäufigkeit der Einholung eines Telekonsiliums, Telekonsiliarischen Beurteilung und des Zuschlags für zeitaufwändige Telekonsilien pro Quartal.....	143
Abbildung 58 Regionale Abrechnungshäufigkeit der Einholung eines Telekonsiliums sowie der telekonsiliarischen Beurteilung nach KV-Bezirken im Jahr 2023.....	144
Abbildung 59 Abrechnungshäufigkeit der Einholung eines Telekonsiliums (GOP 01670) in den Fachgruppen.....	145
Abbildung 60 Durchschnittliche Abrechnungshäufigkeit pro abrechnende/n Ärztin/Arzt für die Einholung eines Telekonsiliums.....	146
Abbildung 61 Durchschnittliche Abrechnungshäufigkeit der telekonsiliarischen Beurteilung pro abrechnende/n Ärztin/Arzt in den Fachgruppen	147
Abbildung 62 Durchschnittliche Abrechnungen der Leistungen zu Telekonsilien je abrechnende Einrichtung im Jahr 2023.....	148
Abbildung 63 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten, bei denen eine Einholung eines Telekonsiliums.....	150
Abbildung 64 Alters- und Geschlechtsverteilung der Versicherten, bei denen eine telekonsiliarische Beurteilung im Jahr 2023 abgerechnet wurde	151
Abbildung 65 Abrechnungshäufigkeit der Notfallpauschale I und II als Videosprechstunde in den Jahren 2022 und 2023.....	160
Abbildung 66 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten, für die im Jahr 2023 eine Notfallpauschale als Videoleistung.....	162

Abkürzungsverzeichnis

AH	Abrechnungshäufigkeit
AKI-RL	Richtlinie über die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege
APK	Arzt-Patienten-Kontakt
AST-Daten	Daten der ärztlichen Abrechnungsstatistik
ASV	ambulante spezialfachärztliche Versorgung
BA, EBA	Bewertungsausschuss, Erweiterter Bewertungsausschuss
BfArM	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
BHF	Behandlungsfall
BMG	Bundesministerium für Gesundheit
BMP	Bundeseinheitlicher Medikationsplan
BMV-Ä	Bundesmantelvertrag-Ärzte
CRT	implantierbares Schrittmacher-System zur kardialen Resynchronisationstherapie
CRT-D	CRT-Schrittmacher mit Defibrillator-Funktion
CRT-P	CRT-Schrittmacher ohne Defibrillator-Funktion
CT	Computertomografie
DiGA	Digitale Gesundheitsanwendung
DiGAV	Digitale Gesundheitsanwendungen-Verordnung
DigiG	Digital-Gesetz
DPE	Datensatz persönliche Erklärungen
DVG	Digitale-Versorgung-Gesetz
DVPMG	Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz
eArztbrief	elektronischer Arztbrief
eAU	elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
EBM	Einheitlicher Bewertungsmaßstab
eGK	elektronische Gesundheitskarte
eHBA	elektronischer Heilberufsausweis
EKG	Elektrokardiogramm bzw. Elektrokardiograf
eMP	elektronischer Medikationsplan
ePA	elektronische Patientenakte
ergBA, ergEBA	Ergänzter Bewertungsausschuss, ergänzter Erweiterter Bewertungsausschuss
FA	Fachärztin/Facharzt
FnA	Funktionsanalyse
G-BA	Gemeinsamer Bundesausschuss
gematik	Nationale Agentur für Digitale Medizin
GKV	Gesetzliche Krankenversicherung
GKV-Spitzenverband	Spitzenverband Bund der Krankenkassen
GOP	Gebührenordnungsposition(-en)
GSP-Daten, GSPA-Daten	Daten aus der Geburtstagsstichprobe bzw. der anlassbezogenen Geburtstagsstichprobe
HA	Hausärztin/Hausarzt

HNO	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
ICD	Implantierbarer Kardioverter-Defibrillator
ICD-10-GM	10. Version der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, German Modification
IQWiG	Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
KBV	Kassenärztliche Bundesvereinigung
KHF	Krankheitsfall
KIM-Dienst	Dienst innerhalb der TI für die Kommunikation im Medizinwesen
KSVPsych	Koordinierte und Strukturierte Versorgung (KSV) insbesondere für schwer psychisch kranke Versicherte
KV	(Regionale) Kassenärztliche Vereinigung
KZT	Kurzzeittherapie
LB	Leistungsbedarf (in €)
LV-EF	Linksventrikuläre-Ejektionsfraktion des Herzens
LZT	Langzeittherapie
MGV	morbiditätsbedingte Gesamtvergütung
MRSA	methicillinresistenter Staphylococcus Aureus
MVV-RL	G-BA-Richtlinie Methoden vertragsärztliche Versorgung
MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
NIPT	Nichtinvasiver Pränataltest
NFD	Notfalldatensatz
NFDM	Notfalldatenmanagement
NYHA	New York Heart Association (Fachgesellschaft)
PBA	Primärbehandelnde/-r Ärztin/Arzt (Hausärztin/Hausarzt, Kinder- und Jugendärztin/Kinder- und Jugendarzt, Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin)
PDSG	Patientendaten-Schutz-Gesetz
PpSG	Pflegepersonal-Stärkungsgesetz
PVS	Praxisverwaltungssystem
QES	qualifizierte elektronische Signatur
QRS-Dauer	Zeitliche Dauer des QRS-Kurvenbestandteil des EKG – spiegelt die Erregungsausbreitung im Herzmuskelgewebe der Ventrikel wider
QS-V	Qualitätssicherungs-Vereinbarung
SGB V	Sozialgesetzbuch V
TSVG	Terminservice- und Versorgungsgesetz
TI	Telematikinfrastruktur
TMZ	Telemedizinisches Zentrum

Zusammenfassung

Der Bewertungsausschuss legt hiermit dem Bundesministerium für Gesundheit den sechsten Bericht gemäß § 87 Abs. 2a Satz 16 SGB V über den Stand der Beratungen zur telemedizinischen Leistungserbringung im vertragsärztlichen Bereich (Teil A) vor. Der ergänzte Bewertungsausschuss legt hiermit zugleich den vierten Bericht zur telemedizinischen Leistungserbringung in der sektorenübergreifenden Versorgung (Teil B) gemäß § 87 Abs. 2a Satz 16 SGB V vor. Der Berichtszeitraum umfasst das Jahr 2023.

In diesem Zeitraum wurde in den Gremien des Bewertungsausschusses und des ergänzten Bewertungsausschusses intensiv zur Thematik der telemedizinischen ärztlichen Leistungen und zur Umsetzung der Vorgaben aus den entsprechenden Gesetzen beraten und beschlossen.

Sechster Bericht des Bewertungsausschusses (Teil A)

Im Bereich der vertragsärztlichen Versorgung (Teil A) war bei der Videosprechstunde auf Jahres-sicht erneut ein Rückgang der Leistungsmenge zu verzeichnen. Mit dem Auslaufen der Pandemie-Situation und der zugehörigen Corona-Sonderregeln ab dem 2. Quartal 2022 zeigte sich die Leistungsmenge jedoch auf einem stabilen Niveau. Ein ähnlicher Befund lässt sich hinsichtlich der Videofallkonferenz (GOP 01442) stellen.

Anstiege der Leistungsmengen waren – wie bereits im Vorjahr – in den Bereichen des Telemonitoring Herzinsuffizienz, des eArztbriefes, bei einzelnen DiGA und der ePA zu verzeichnen. In Anbetracht des Potentials der ePA bewegte sich diese im Jahr 2023 jedoch noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Nach vielen Jahren des Anstiegs war im Jahr 2023 kein Zuwachs mehr bei der telemedizinischen Funktionsanalyse zu verzeichnen.

Videosprechstunde. Im Bereich der Videosprechstunde war auch im Jahr 2023 erneut ein deutlicher Rückgang der Abrechnungshäufigkeit gegenüber dem Jahr 2022 um 18 % auf ca. 2,2 Millionen Videosprechstunden zu verzeichnen. Maßgeblich hierfür war insbesondere das noch relativ starke 1. Quartal des Jahres 2022 mit noch bestehenden Corona-Sonderregelungen. In den nachfolgenden Quartalen zeigte sich hingegen kein wesentlicher Unterschied zwischen den Quartalen des Jahres 2022 und 2023 mehr. Mit dem 4. Quartal 2023 zeigte sich wieder eine leichte Zunahme der Videosprechstunde.

Als neue im Rahmen der Videosprechstunde durchführbare Leistungen kam eine Beratungsleistung im Rahmen der Kryokonservierung sowie die Möglichkeit der (Folge-)Verordnung von häuslicher Krankenpflege, medizinischer Rehabilitation sowie von Heilmitteln hinzu.

Einen nennenswerten Anteil an der Versorgung insgesamt nimmt die Videosprechstunde weiterhin im Bereich der Einzeltherapien bei der Antrags-Psychotherapie ein. In diesem Bereich wurden 4,2 % aller Leistungen per Video durchgeführt – hier war allerdings gegenüber dem Vorjahr 2022 (Anteil: 7,2 %) ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. In anderen Versorgungsbereichen, wie z. B. der Gesprächstherapie, fiel der Rückgang von 0,6 % im Jahr 2022 auf 0,5 % im Jahr 2023 etwas geringer aus.

In Bezug auf ihre Versichertenanzahl wurde die Videosprechstunde am häufigsten in den KV-Bezirken der Stadtstaaten und am seltensten in den östlichen Flächenländern durchgeführt.

Die Videosprechstunde wurde weiterhin in weiten Teilen von Ärzten/Ärztinnen im Bereich der sprechenden Medizin und Psychotherapeutinnen/-therapeuten durchgeführt (81 %). Die Anzahl der im hausärztlichen Versorgungsbereich durchgeführten Videosprechstunden stieg auf über 900.000. Damit wurden mit einem Anteil von 41 % an allen Videosprechstunden erstmalig mehr hausärztliche als psychotherapeutische Videosprechstunden (n=875.000, Anteil: 40 %) durchgeführt. Gegenüber dem Jahr 2022 mit knapp 1,5 Millionen Videosprechstunden war damit bei der Fachgruppe Psychotherapie zum zweiten Mal nach dem Jahr 2021 ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen.

Im Jahr 2023 führten insgesamt ca. 31.000 Ärztinnen/Ärzte Videosprechstunden durch – durchschnittlich ca. 70 Videosprechstunden pro abrechnende/n Ärztin/Arzt.

Betrachtet man den Anteil der Ärztinnen/Ärzte bzw. Therapeutinnen/Therapeuten, welche Videosprechstunden prinzipiell praktizieren (d. h. mindestens eine Videosprechstunde durchgeführt haben), an allen Ärzten der Fachgruppe, zeigt sich: Insbesondere in der Psychotherapie, aber auch in der Psychosomatik, ist der Anteil von Ärzten, die Videosprechstunden durchführen, mit fast 54 % bzw. 43 % besonders hoch. Hier gab es allerdings gegenüber dem Jahr 2022 einen leichten Rückgang. Die Gruppe der Hausärztinnen/Hausärzte war eine der wenigen Fachgruppen, die an dieser Stelle gegenüber dem Jahr 2022 eine Steigerung aufwiesen – von 8,4 % im Jahr 2022 auf 9 % im Jahr 2023.

Im Jahr 2023 wurde bei ca. 900.000 Versicherten eine Videosprechstunde durchgeführt – dies sind etwa 100.000 Versicherte weniger als im Jahr 2022. Die Anzahl an Behandlungsfällen (BHF), in denen eine Videosprechstunde durchgeführt wurde, blieb hingegen mit ca. 1,5 Mio. annähernd gleich, da weniger Videosprechstunden pro BHF durchgeführt wurden. Der Rückgang der Abrechnungshäufigkeit der Videosprechstunde im Jahr 2023 wurde damit durch eine Kombination aus Rückgang der Anzahl an Versicherten (- 10 %) und Rückgang der Anzahl an durchgeführten Videosprechstunden pro Versicherte/r mit Videosprechstunde begleitet. Die Videosprechstunden verteilten sich jedoch etwas gleichmäßiger über die Behandlungsfälle – im Sinne einer Steigerung der Anzahl von Behandlungsfällen mit Videosprechstunde je Krankheitsfall eines Versicherten mit Videosprechstunde.

Einen deutlichen Anstieg zeigte die Anzahl an ausschließlichen Video-Behandlungsfällen ohne persönlichen Kontakt – diese stieg auf ca. 633.000 an (2022: 413.000).

Versicherte, die Videosprechstunden in Anspruch nahmen, waren überdurchschnittlich im jüngeren Erwachsenenalter und mehrheitlich weiblich. So wurden ca. 50 % der Videosprechstunden von Versicherten zwischen 20 und 39 Jahren und insgesamt 60 % der Videosprechstunden von weiblichen Versicherten in Anspruch genommen.

(Video-)Fallkonferenzen. Mit einem Beschluss in der 702. Sitzung des BA wurde im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes eine neue Fallkonferenz (GOP 01682) aufgenommen, die auch im Rahmen einer Videosprechstunde durchgeführt werden kann.

Bei der Videofallkonferenz mit Pflegekräften (GOP 01442) wurden im Jahr 2023 insgesamt ca. 8.800 Konferenzen durchgeführt und damit ca. 15 % weniger als im Jahr 2022.

Telemonitoring Herzinsuffizienz. Im Bereich des Telemonitoring Herzinsuffizienz nahmen 201 abrechnende Telemedizinische Zentren (TMZ) im Jahr 2023 an der Versorgung teil und damit deutlich mehr als im 2. - 4. Quartal des Jahres 2022 (n=113). Die Zahl der primär behandelnden Ärzte/Ärztinnen (PBA) stieg leicht auf 362 (2. - 4. Quartal 2022: n=337). Die Rolle des PBA wurde zumeist von der Fachgruppe der Inneren Medizin (> 90 %) und weniger durch Hausärztinnen/-ärzte (<10 %) ausgefüllt.

Im 4. Quartal 2023 wurden ca. 6.500 Versicherte mit implantierten Aggregaten (GOP 13584) und ca. 3.300 mit externen Geräten (GOP 13586) überwacht. Der Anteil der Überwachung mit externen Geräten nahm damit gegenüber dem Vorjahresquartal von 22 % auf 34 % zu. Im gesamten Jahr 2023 wurde die GOP 13584 (Aggregate) ca. 21.000-mal und die GOP 13586 (externe Geräte) ca. 10.000-mal abgerechnet. Der Leistungsbedarf für die TMZ betrug ca. 6,1 Mio. Euro, die Leistungen der PBA für Indikationsstellung und Betreuung verursachten zusammengekommen einen Bedarf von ca. 420.000 €.

Eine (zeitlich) intensivierete Überwachung erfolgte bei der Überwachung mittels implantierter Aggregate in ca. 34 % und bei der Überwachung mittels externer Geräte in 12 % der Fälle.

Das Telemonitoring Herzinsuffizienz mit Aggregaten wurde – relativ zu der Anzahl der Versicherten in einer KV-Region – wie bereits im Vorjahr besonders stark in den Flächenländern Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt durchgeführt. Beim Telemonitoring mit externen Geräten lag die KV Hamburg nach einem sehr starken Anstieg der Leistungshäufigkeit an erster Stelle im Vergleich der KV-Bezirke.

Im Jahr 2023 wurden insgesamt ca. 11.000 Versicherte im Telemonitoring Herzinsuffizienz betreut, wobei ca. 77 % der Versicherten männlich waren.

Telemedizinische Funktionsanalyse. Die Häufigkeiten von telemedizinischen Funktionsanalysen von ICD- und CRT-Aggregaten stagnierten im Jahr 2023 weitestgehend und zeigten auch gegenüber der Funktionsanalyse im persönlichen Kontakt kein vermehrtes Wachstum mehr. Wie im Jahr 2022 wurden etwas über 11 % der Funktionsanalysen telemedizinisch durchgeführt, wobei sich 25.000 telemedizinische ICD- und 16.000 CRT-Kontrollen auf ca. 15.000 Versicherte bzw. 40.000 BHF verteilten. Bei einem Versicherten mit erfolgter telemedizinischer Funktionsanalyse wurde diese damit durchschnittlich in mehr als 2 BHF durchgeführt. In den KV-Bezirken Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern betrug der Anteil der BHF mit telemedizinischer Funktionsanalyse insgesamt mehr als 20 % - dies zeigt einen breitflächigeren Gebrauch dieser telemedizinischen Leistung.

Insgesamt entstand bundesweit im Jahr 2023 für die telemedizinische Funktionsanalyse ein Leistungsbedarf von 2 Mio. Euro.

Telekonsiliarische Befundbeurteilung von Röntgen- und CT-Aufnahmen. Bei der telekonsiliarischen Befundbeurteilung von Röntgen- und CT-Aufnahmen ist weiterhin keine nennenswerte Leistungsentwicklung ersichtlich. Gegenüber dem niedrigen Leistungsniveau des Jahres 2022 kam es hier insgesamt zu einem Rückgang. Damit standen in diesem Bereich

200 Beauftragungen zur telemedizinischen Befundbeurteilung weniger als 25 telekonsiliarischen Befundbeurteilungen gegenüber.

Elektronische Patientenakte – ePA. Im Jahr 2023 zeigten sich sowohl die Abrechnungshäufigkeit der Erstbefüllung einer ePA (GOP 01648) mit ca. 46.500 Abrechnungen als auch die Anpassung der ePA (GOP 01647) mit 90.500 Abrechnungen noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Damit wurden seit der Einführung der Vergütung für die Anlage einer ePA im Jahr 2021 insgesamt 93.000 ePA erstmalig angelegt. Der Leistungsbedarf aller Leistungen der ePA belief sich im Jahr 2023 auf 636.000 €. Ein niedriges Niveau bestand – trotz Steigerung gegenüber dem Jahr 2022 – weiterhin hinsichtlich der teilnehmenden Ärztinnen/Ärzte: So wurden z. B. 51 % aller ePA von der Fachgruppe der Hausärzte erstausgefüllt (Vorjahr: 39 %). Die Erstausfüllung erfolgte dabei lediglich durch 839 (2022: n=383) von insgesamt 63.549 Hausärztinnen/-ärzte in Deutschland – entsprechend einem Anteil von 1,3 % (2022: 0,6 %).

Wesentliche Änderungen sind erst mit der verpflichtenden Einführung der ePA als Opt-out-Leistung im Berichtsjahr 2025 zu erwarten.

Elektronische Kommunikation – eArztbriefe. Die elektronische Kommunikation unter Vertragsärztinnen und Vertragsärzten mittels eArztbriefen wird ausschließlich über spezielle Kommunikationsdienste innerhalb der Telematikinfrastruktur umgesetzt.

Für eArztbriefe wurde die Versandpauschale (Pseudo-GOP 86900) häufiger abgerechnet als die Empfangspauschale (Pseudo-GOP 86901) bei einer insgesamt dynamischen Entwicklung. So verdreifachte sich im Jahr 2023 die Abrechnungshäufigkeit der Versandpauschale für eArztbriefe annähernd (+182 %) auf rund 7,6 Mio. Abrechnungen und die der Empfangspauschale ebenfalls (+249 %) auf rund 4,8 Mio. Abrechnungen. Internistinnen/Internisten rechneten im Jahr 2023 mit rund 2,6 Mio. Abrechnungen besonders häufig Versandpauschalen für eArztbriefe (Pseudo-GOP 86900) ab, Hausärztinnen/Hausärzte mit rund 3,8 Mio. Abrechnungen den Großteil (80 %) der Empfangspauschalen (Pseudo-GOP 86901).

Notfalldatenmanagement – NFDM. Die Funktionalität der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) umfasst eine Speicherfunktion für eine begrenzte und fest definierte Menge Patientendaten. So können für Versicherte ein Notfalldatensatz, ein elektronischer Medikationsplan und Hinweise auf den Aufbewahrungsort eines vorhandenen Organspendeausweises oder weiterer persönlicher Erklärungen auf der eGK gespeichert werden. Die Abrechnungshäufigkeit des Zuschlags Notfalldatensatz für die Aktualisierung (GOP 01641) fiel mit ca. 365,8 Mio. Abrechnungen im Jahr 2023 sehr hoch aus, da die zuständige KV den Zuschlag bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen (insbesondere: Anschluss an die TI) einmal in fast jedem Behandlungsfall automatisch zusetzt.

Die Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) wurde im Jahr 2023 ca. 572.200-mal abgerechnet. Die Leistung verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 77 %. Die Anlage eines Notfalldatensatzes wurde mit ca. 334.500 Abrechnungen am häufigsten von der Fachgruppe Gynäkologie abgerechnet. Gegebenenfalls liegt die Spitzenposition dieser Fachgruppe darin begründet, dass Schwangerschaften ein medizinischer Anlass für die Anlage eines Notfalldatensatzes sind.

Digitale Gesundheitsanwendungen – DiGA. Im Jahr 2023 wurden 14 DiGA dauerhaft in das DiGA-Verzeichnis des BfArM aufgenommen, welches damit Ende des 4. Quartals 2023 insgesamt 29 dauerhafte DiGA umfasste. Für drei der im Jahr 2023 neu dauerhaft aufgenommenen DiGA hat das BfArM ärztliche Tätigkeiten bestimmt. Nach fachlicher Prüfung wurden im Jahr 2023 dafür drei neue Leistungen (GOP 01474, 01475 und 01476) in den EBM aufgenommen. Mit dem Auslaufen der Befristung der GOP 01470 wird die Erstverordnung einer DiGA seit Beginn des Jahres 2023 über die Versicherten- und Grundpauschalen vergütet. Im Jahr 2023 wurden insgesamt rund 29.000 ärztliche Leistungen zu DiGA (GOP 01471 bis 01476) abgerechnet, wodurch ein Leistungsbedarf von rund 213.000 € entstand.

Vierter Bericht des ergänzten Bewertungsausschusses (Teil B)

Der vierte Bericht des ergänzten Bewertungsausschusses zur telemedizinischen Leistungserbringung im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) gibt einen Überblick über die Neuerungen des Jahres 2023. Als Ergänzung zum Bericht des Bewertungsausschusses (Teil A) umfasst der Bericht des ergänzten Bewertungsausschusses (Teil B) diejenigen telemedizinischen Leistungen, die in der sektorenübergreifenden Versorgung durchgeführt werden. Durch Beschlussfassungen zwischen dem GKV-Spitzenverband, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft sind im betrachteten Zeitraum unterschiedliche telemedizinische Leistungen berechnungsfähig gewesen. Der Bericht geht für die Durchführung von sektorenübergreifenden Telekonsilien, Zweitmeinungen sowie von Leistungen in der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV), im organisierten Not(-fall)dienst und der koordinierten und strukturierten Versorgung insbesondere schwer psychisch kranker Versicherter (gemäß KSVPsych-Richtlinie) auf die Regelung und Vergütung im EBM ein. Zusätzlich stellt der Bericht die Leistungsentwicklung für sektorenübergreifende Telekonsilien und telemedizinische Leistungen im organisierten Not(-fall)dienst dar, da die vorliegenden Abrechnungsdaten aus der vertragsärztlichen Versorgung für diese Leistungen eine Auswertung erlauben.

Sektorenübergreifende Telekonsilien wurden im Oktober 2020 in die Versorgung aufgenommen. Im Jahr 2023 betrug der Leistungsbedarf für die sektorenübergreifenden Telekonsilien insgesamt ca. 915.000 €. Bei den Abrechnungszahlen fällt auf, dass die Einholung eines Telekonsiliums (GOP 01670) im Jahr 2023 rund zweieinhalbmals häufiger in den Abrechnungsdaten zu finden ist als die telekonsiliarische Beurteilung (GOP 01671). Die Einholung eines Telekonsiliums wurde ca. 48.400-mal abgerechnet, die Beurteilung dagegen ca. 18.900-mal. Die Fachgruppen der Hausärztinnen und Hausärzte sowie der Inneren Medizin rechneten die Einholung eines Telekonsiliums sowie die telekonsiliarische Beurteilung am häufigsten ab. Leistungen zu Telekonsilien wurden am häufigsten für Versicherte über 60 Jahre abgerechnet; diese Gruppe von Versicherten hatte einen Anteil von etwa 55 % an den Einholungen und abgegebenen Beurteilungen (GOP 01670 und 01671) an allen Versicherten mit Telekonsilien.

Telemedizinische Leistungen in der Ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung – ASV. Auch in der sektorenübergreifenden Versorgung im Rahmen der ASV sind telemedizinische Leistungen möglich. Seit Juli 2020 können in diesem Bereich Gespräche durch spezifische Leistungen im Kapitel 50 des EBM als Videosprechstunden durchgeführt werden. Dies betrifft die

Grundpauschalen für die Versorgung von Versicherten mit Hämophilie, psychotherapeutische Gespräche als Einzelbehandlungen, problemorientierte ärztliche Gespräche bei Mukoviszidose sowie die Vorstellung von Versicherten bei Tumorkonferenzen oder bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) im Rahmen der ASV. Auch die Anlage eines elektronischen Medikationsplans gehört unter bestimmten Voraussetzungen zum Leistungsumfang in der ASV. Dem Institut liegen keine Abrechnungsdaten zu Leistungen in der ASV vor.

Zweitmeinungen. Die Durchführung von Zweitmeinungen im Rahmen einer Videosprechstunde wurde im Juli 2021 in die Versorgung eingeführt. Versicherte haben einen Rechtsanspruch darauf, sich vor bestimmten planbaren Operationen (Eingriffen) eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in einer Richtlinie diejenigen Operationen fest, zu denen Ärztinnen und Ärzte Versicherte auf den Anspruch auf eine Zweitmeinung hinweisen müssen; Ende des 4. Quartals 2023 umfasste diese Liste neun Operationen. Für die Aufklärung und Beratung von Versicherten, auch als Videokontakt, und die Zusammenstellung der Unterlagen für eine Zweitmeinung können Ärzte und Ärztinnen die GOP 01645 abrechnen. Im Jahr 2023 wurden keine Abrechnungen für die GOP 01645 als reiner Videokontakt durchgeführt. Abrechnungen der GOP 01645 für Kontakte, die sowohl persönlich als auch per Video stattfanden („gemischte“ Kontakte), können in den Daten nicht identifiziert werden, da für diese keine entsprechende Kennzeichnung existiert.

Telemedizinische Leistungen im organisierten Not(-fall)dienst können seit Juli 2022 erfolgen. Im organisierten Not(-fall)dienst werden Versicherte behandelt, deren Erkrankungen akut und nicht lebensbedrohlich sind, sodass keine Benachrichtigung des Rettungsdienstes notwendig ist. Der Leistungsbedarf für die Notfallpauschale I (GOP 01210) oder Notfallpauschale II (GOP 01212) als Videosprechstunde belief sich im Jahr 2023 insgesamt auf rund 71.800 €. Der Großteil der Abrechnungen, rund 2.900 Abrechnungen, entfiel auf das 4. Quartal 2023 sowie auf die Notfallpauschale II, die bei Notfallkontakten zwischen 19:00 Uhr und 7:00 des Folgetages, am Wochenende und an Feiertagen Anwendung findet. Die Häufung der Abrechnungen in diesem Quartal hängt mit besonderen, zeitlich befristeten Angeboten während der Feiertage zum Jahresende in einigen KV-Bezirken zusammen.

Telemedizinische Leistungen in der Koordinierten und Strukturierten Versorgung insbesondere schwer psychisch kranker Versicherter – KSVPsych. Mit der Einführung der Versorgungsstruktur gemäß der KSVPsych-Richtlinie des G-BA sollen Versicherte mit einem komplexen, interdisziplinären Behandlungsbedarf in Netzverbünden aus Ärztinnen/Ärzten und Psychotherapeutinnen/-therapeuten in Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, anderen Gesundheitsberufen und ergänzenden Angeboten versorgt werden. Im Zusammenhang mit der KSVPsych-Richtlinie wurde im Oktober 2022 auch eine Fallbesprechung (GOP 37550) in den EBM aufgenommen, die optional als Videofallkonferenz stattfinden kann. Die Abrechnungen der GOP 37550 als Videofallkonferenz können nicht ausgewertet werden, da für diese in den Daten keine entsprechende Kennzeichnung existiert.

Teil A Bericht des Bewertungsausschusses

1 Einleitung

Mit dem vorliegenden Bericht (Teil A) soll die Aktivität des Bewertungsausschusses hinsichtlich der Umsetzung telemedizinischer Leistungen im ambulanten Versorgungssektor im Sinne der gesetzlichen Aufträge nach dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz in § 87 Abs. 2a Satz 7 SGB V und gemäß dem E-Health-Gesetz in § 87 Abs. 2a Satz 16 SGB V dargelegt werden. Es liegen bis jetzt fünf Berichte in zweijährigem Abstand aus den Jahren 2016 bis 2024 vor. Es ist erklärtes Ziel des Bewertungsausschusses, mit diesem Bericht Transparenz bei der Durchführung und Erfüllung der dem Bewertungsausschuss vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben herzustellen.

Die Inhalte, zu denen beraten und beschlossen wurde, sind im Bericht zu Themengruppen zusammengefasst. In jedem Kapitel des Berichts werden kurz die Begrifflichkeiten und rechtlichen Hintergründe allgemein erläutert und anschließend die Beschlüsse dargelegt, die im Berichtsjahr 2023 getroffen wurden oder in Kraft getreten sind. In den folgenden Unterkapiteln werden – bei Verfügbarkeit von Daten – die Leistungsentwicklung dargestellt und ggf. aus Sicht des Bewertungsausschusses interpretiert. Für das Verständnis werden gelegentlich Daten aggregiert dargestellt – die vollständigen Auswertungen sind alle im Anhang des Berichts aufgeführt.

1.1 Inhaltliche Umsetzung des Berichts im Rahmen der Anpassungen des § 87 SGB V durch das Digital-Gesetz (DigiG)

Mit dem am 26. März 2024 in Kraft getretenen Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens (Digital-Gesetz – DigiG)¹ wurden detaillierte Anforderungen bezüglich des Inhaltes des Berichts formuliert. Darüber hinaus wurde der Berichtszeitraum von zwei Jahren auf ein Jahr verkürzt. Der neue Berichtszeitpunkt wird auf den 1. Juni eines Jahres festgelegt, an dem der Bericht dem Ministerium für Gesundheit vorliegen muss.

Diese Änderungen wurden auch unter Berücksichtigung der vorliegenden Gesetzesbegründung bereits im Bericht aus dem Jahr 2024 (Berichtsjahr 2022) umgesetzt. Der hier vorliegende Bericht führt die Systematik des Berichts aus dem Jahr 2024 fort und berichtet die Änderungen und durchgeführten telemedizinischen Leistungen aus dem Jahr 2023.

1.2 Datengrundlage

Datengrundlage für die Auswertungen zu Abrechnungshäufigkeiten, Leistungsbedarf und Anzahl der abrechnenden Ärztinnen und Ärzte bzw. Psychotherapeutinnen/-therapeuten ist die

¹ Siehe Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens ([DigiG](#)) vom 22.03.2024 – Bundesgesetzblatt 2024 Teil I Nr. 101 (bgbl.de).

ärztliche Abrechnungsstatistik (AST-Daten). In den Vorberichten wurde noch teilweise auf Daten der arztseitigen Rechnungslegung (Arzt-RG) zurückgegriffen, wodurch es zu sehr geringen Abweichungen zu den Euro-Angaben für vergangene Jahre in diesem Bericht kommt.

Für Analysen, die Versicherte und Behandlungsfälle betreffen, wird die Geburtstagsstichprobe (GSP) oder die anlassbezogene GSP (GSPA) verwendet. Hierbei liegen die Abrechnungsdaten für eine Stichprobe von Versicherten auf Grundlage des Geburtskalendertages vor und werden auf die Gesamtheit der Versicherten hochgerechnet.

Auf Grundlage der GSPA erfolgten in diesem Bericht neben den Alters- und Geschlechtsanalysen auch Untersuchungen zur Morbidität anhand der Auswertung von Codes auf Grundlage der ICD – 10 – GM, die für jeden Behandlungsfall vorliegen. Insgesamt unterliegt die Zuordnungsfähigkeit von ICD-Kodes zum spezifischen Anlass einer Behandlung innerhalb eines Behandlungsfalles jedoch einer deutlichen Unschärfe. Zusätzlich kann es durch die Hochrechnung auf alle Versicherten auf Grundlage der Daten von ca. 23 % der Versicherten in der Geburtstagsstichprobe insbesondere bei Analysen mit niedrigen Fallzahlen zu Verzerrungen kommen.

Die im vorliegenden Bericht verwendeten Fachgruppen entsprechen nicht den Fachgruppen nach der Weiterbildungsordnung des Bundesarztregisters, sondern basieren auf den Abrechnungsgruppen nach Schlüsselverzeichnis 6², die aufgrund des Abrechnungsverhaltens der einzelnen Ärzte gebildet werden. Zusätzlich wurden in diesem Bericht einige Gruppen zusammengezogen.³

² Die im vorliegenden Bericht verwendeten Fachgruppen unterscheiden sich zum Beispiel von den [KBV-Schlüsseltabellen](#) sowie dem [Schlüsselverzeichnis 6](#) der AST-Daten – Kassenärztliche Bundesvereinigung (kbv.de) und Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

³ Folgende Fachgruppen im vorliegenden Bericht weichen von Schlüsselverzeichnis 6 der AST-Daten ab und setzen sich aus den in Klammern genannten Abrechnungsgruppen der AST-Daten zusammen: Fachgruppe Hausärztinnen/-ärzte (Allgemeinmediziner; Allgemeinmediziner/Internisten (Hausarzt); Hausärztliche Internisten; Arztgruppenübergreifende Praxen, hausärztlich; Sonstige Hausärzte); Fachgruppe Psychotherapie (Ärztliche Psychotherapeuten, SP Verhaltenstherapie; Ärztliche Psychotherapeuten; Psychologische Psychotherapeuten, SP Verhaltenstherapie; Psychologische Psychotherapeuten; Kinder- u. Jugendlichen-Psychotherapeuten, SP Verhaltenstherapie; Kinder- u. Jugendlichen-Psychotherapeuten; Fachgruppenübergreifende Praxen, nicht ärztliche Psychotherapeuten); Fachgruppe Chirurgie (Chirurgie; Neurochirurgie; Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie); Fachgruppe HNO und Phoniatrie (Hals-Nasen-Ohrenheilkunde; Phoniatrie und Pädaudiologie); Fachgruppe Dermatologie (Hautarzt); Fachgruppe Labor (Laboratoriumsmedizin; Laborgemeinschaften); Fachgruppe Innere Medizin (FA ohne Schwerpunkt; SP Angiologie; SP Endokrinologie; Gastroenterologie; SP Hämatologie/Onkologie; Kardiologie; SP Nephrologie; SP Pneumologie; SP Rheumatologie; Innere Medizin, schwerpunktübergreifend); Fachgruppe Neurologie und Nervenheilkunde (Neurologie; Nervenheilkunde) Fachgruppe Nuklearmedizin, Radiologie und Strahlentherapie (Nuklearmedizin; Radiologie; Strahlentherapie); Fachgruppe Psychiatrie (Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie; Psychiatrie); Fachgruppe Sonstige (Medizinische Versorgungszentren; Einrichtungen nach § 311 SGB V [aktuell § 402 Abs. 2 SGB V]; Fachwissenschaftler; Arztgruppenübergreifende Praxen, fachärztlich; Arztgruppenübergreifende Praxen, versorgungsbereichsübergreifend; Mammographie-Screening-Einheiten; Sonstige Leistungserbringer). In den Kapiteln 0 und 5 werden Schwerpunkte innerhalb der Fachgruppe Innere Medizin nicht zusammengefasst, da dort kardiologische Gebührenordnungspositionen ausgewertet werden, die nur für die Gruppe Innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie berechnungsfähig sind.

Auch die im vorliegenden Bericht verwendeten Einrichtungsformen sind nicht deckungsgleich mit den Organisationsformen aus den AST-Daten.⁴

Bei den Analysen zur Alters- und Geschlechtsverteilung wurde lediglich nach weiblichen und männlichen Versicherten differenziert.

⁴ Siehe [Schlüsselverzeichnis 14](#) der AST-Daten – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de). Abweichend von diesem Schlüsselverzeichnis werden Abrechnungen von Ermächtigten Einzelpraxen dem Krankenhausbereich zugeordnet. Neben den ermächtigten Einzelpraxen gibt es in den AST-Daten den Code 50 für Krankenhäuser, der im Bericht auf institutionelle Leistungen bezogen wird. Außerdem werden in den Tabellen und Abbildungen des vorliegenden Berichts jeweils alle Organisationsformen, die nicht einzeln dargestellt sind, der Einrichtungsform „Sonstige“ zugeordnet.

2 Videosprechstunde

2.1 Allgemeine Erläuterungen

Begrifflichkeiten

Eine Videosprechstunde ist ein Online-Kontakt in Echtzeit mit Videoübertragung zwischen Ärztin, Arzt, Psychotherapeutin oder Psychotherapeut und Versicherten. Neben der Befragung zu Symptomen und Krankengeschichte (Anamnese) können hier ggf. Krankheitsanzeichen in Augenschein genommen werden und – eventuell – bereits eine Diagnose gestellt werden. Im Bereich der Psychotherapie finden therapeutische und/oder bestimmte diagnostische Sitzungen in Form von Videosprechstunden statt.

Insbesondere bei langen Anfahrtswegen, zur Verlaufskontrolle (zum Beispiel nach kleineren Eingriffen), bei eher „administrativem Arztbedarf“ (Folgerezept etc.) und bei Beratungsleistungen kann die Videosprechstunde eine sinnvolle Hilfe sein und Versicherte müssen nicht für jeden Termin in die Praxis kommen. Die Ärztin/der Arzt oder die Psychotherapeutin/der Psychotherapeut muss dafür einen zertifizierten Videodienstanbieter auswählen, der einen sicheren technischen und datenschutzkonformen Ablauf der Videosprechstunde ermöglicht. Die Identität einer Versicherten oder eines Versicherten muss bei erstmaligem Kontakt authentifiziert werden.

Abzugrenzen von der eigentlichen Videosprechstunde sind Videofallkonferenzen. Diese dienen funktional als Besprechungen zwischen mehreren Ärztinnen und Ärzten oder zwischen Ärztinnen oder Ärzten und Pflegekräften bzw. nichtärztlichem Fachpersonal, mit oder ohne Anwesenheit der/des Versicherten.

Videosprechstunden und Videofallkonferenzen bedienen sich beide des gleichen Mediums Videoübertragung. Sie erfüllen jedoch einerseits mit dem direkten Patientenkontakt und andererseits mit dem hauptsächlich fachlichen kollegialen Austausch eine andere Funktion in der Versorgung. Daher wird die Entwicklung der Videofallkonferenzen getrennt in Kapitel 3 dieses Berichts dargestellt.

Rechtlicher Hintergrund

Im Laufe der letzten Jahre sind umfangreiche Veränderungen bei der Durchführung von ärztlichen Leistungen per Video insbesondere in § 87 Abs. 2a SGB V verankert worden.

Mit dem Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals (PpSG)⁵ wurde die bei Videosprechstunden bisher geltende Eingrenzung auf spezifische Krankheitsbilder für die ärztliche Durchführung im EBM mit Wirkung zum 1. Januar 2019 gestrichen und damit die Nutzung der Videosprechstunde wesentlich erweitert – insbesondere auch im Hinblick auf die psychotherapeutische Versorgung. Des Weiteren wurden telemedizinische Fallkonferenzen zur Verbesserung der Zusammenarbeit

⁵ Siehe Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals ([PpSG](#)) vom 11.12.2018 – Bundesgesetzblatt I S. 2394 (bgbl.de).

zwischen Pflegeheimen und niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in § 87 Abs. 2a SGB V erstmalig verankert.

Mit dem Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz (DVPMG)⁶ von 2021 wurden weitere Schritte unternommen, um die Digitalisierung flächendeckend in der Versorgung zu etablieren. So wurde die Vermittlung von Vor-Ort-Arztterminen um die Vermittlung telemedizinischer Leistungen (wie z. B. der Videosprechstunde) ergänzt und der organisierte Not(-fall)dienst – von an der kassenärztlichen Versorgung teilnehmenden Einrichtungen – um die Durchführung telemedizinischer Leistungen erweitert. Darüber hinaus sollten mit dem DVPMG telemedizinische Leistungen auch für Heilmittelerbringer und Hebammen ermöglicht werden und die psychotherapeutische Akutbehandlung im Rahmen einer Videosprechstunde durchführbar werden. Über ein Portal sollte es anbietenden Ärztinnen, Ärzten, Psychotherapeuten und -therapeuten und Versicherten einfacher ermöglicht werden, freie Videosprechstundentermine zu melden bzw. zu finden. Darüber hinaus wurden durch das DVPMG die behandlungsfall- und leistungsbezogenen Begrenzungen bei Videosprechstunden von 20 % auf 30 % erhöht (s. Kapitel 2.2 des Berichts). Mit dem am 26. März 2024 in Kraft getretenen Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens entfielen diese Begrenzungsregeln im SGB V komplett. Des Weiteren wurden der GKV-SV und die KBV beauftragt, Regelungen zu treffen, um Videosprechstunden in einem „weiten Umfang“ zu ermöglichen, und Qualitätsvorgaben für die Videosprechstunde und insbesondere auch für die Gewährleistung der Anschlussversorgung zu erarbeiten.

2.2 Regelungen und Vergütung im EBM

Die Durchführung von Leistungen im Rahmen einer Videosprechstunde ist prinzipiell seit dem 2. Quartal 2017 möglich. Anfänglich erfolgte die Vergütung der Videosprechstunde über eine eigenständige Videosprechstunden-GOP 01439 und den Technikzuschlag GOP 01450. Die Berechnungsfähigkeit insgesamt und die Berechnungsfähigkeit der GOP 01439 und GOP 01450 waren damit auf bestimmte Indikationen und Fachgruppen beschränkt. Eine detaillierte Darstellung der Historie liefern die vorangegangenen Berichte der Jahre 2018 bis 2022.⁷

⁶ Siehe Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege ([DVPMG](#)) vom 03.06.2021 – Bundesministerium für Gesundheit ([bundesgesundheitsministerium.de](#)).

⁷ Siehe Vorbericht 2022: [Bericht](#) des Bewertungsausschusses und des ergänzten Bewertungsausschusses zur telemedizinischen Leistungserbringung im Einheitlichen Bewertungsmaßstab, 06.12.2022 – Drucksache 20/4982. Siehe Vorbericht 2020: [Bericht](#) des Bewertungsausschusses und des ergänzten Bewertungsausschusses zur Überprüfung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes auf die Möglichkeit zur ambulanten telemedizinischen Leistungserbringung und über die als telemedizinische Leistungen berechnungsfähigen Konsilien, 07.12.2020 – Drucksache 19/25185 ([bundestag.de](#)). Siehe Vorbericht 2018: [Bericht](#) des Bewertungsausschusses zur Überprüfung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes auf die Möglichkeit zur ambulanten telemedizinischen Leistungserbringung, 26.11.2018 – Drucksache 19/6020 ([bundestag.de](#)).

Als Folge des Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals (PpSG) kam es mit dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 453. Sitzung⁸ zum 1. Oktober 2019 zur Streichung der GOP 01439 und zu einer Novellierung des Vergütungssystems der Videosprechstunde, welche strukturell bis heute Bestand hat.

Grundsätzlich erfolgt die Vergütung von Videosprechstunden seitdem über die Grund-, Versicherten- und Konsiliarpauschalen sowie sich darauf beziehende Zusatzpauschalen und nicht mehr über eine spezifische Leistung „Videosprechstunde“. Die oben genannten Pauschalen können von fast allen Ärztinnen, Ärzten, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten berechnet werden, auch wenn ausschließlich ein Arzt-Patienten-Kontakt im Rahmen einer Videosprechstunde stattfindet. Ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt im Behandlungsfall ist nicht mehr zwingend erforderlich. Allerdings hat der Bewertungsausschuss festgelegt, dass im Falle eines ausschließlichen Kontaktes im Rahmen einer Videosprechstunde Abschläge auf die Versicherten-, Grund- und Konsiliarpauschalen und sich darauf beziehende Zusatzpauschalen in unterschiedlicher Höhe zwischen 20 und 30 % erfolgen (siehe hierzu Vorbericht 2020). Hintergrund ist, dass bestimmte Aufwände für die Infrastruktur (Praxisräume, Personal etc.) nicht in dem Maße anfallen wie bei einem physischen Kontakt und nicht alle in den Pauschalen inkludierten Leistungsbestandteile im Rahmen einer Videosprechstunde durchgeführt werden können. Erfolgt im gleichen Quartal allerdings ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt, werden die Grund-, Versicherten- und Konsiliarpauschale und sich darauf beziehende Zusatzpauschalen in voller Höhe gezahlt.

Die Videosprechstunde stellt damit eine Kontaktart mit dem Versicherten dar, in dessen Rahmen bestimmte Leistungen durchgeführt werden können. Neben der Vergütung dieser Leistungen über die Grund-, Versicherten- und Konsiliarpauschalen können auch spezifische Leistungen, wie z. B. spezifische Gesprächsleistungen, im Rahmen der Videosprechstunde berechnet werden, sofern dies in der jeweiligen Abrechnungsbestimmung der Leistung oder an anderer Stelle des EBM erlaubt wird. Über diese spezifische Öffnung von Leistungen für die Videosprechstunde entwickelt sich der EBM seitdem kontinuierlich weiter.

Schon mit dem Beschluss in der 453. Sitzung des BA wurden so z. B. die Gebührenordnungspositionen für Fallkonferenzen um die Durchführbarkeit per Video erweitert, bzw. mit der **GOP 01442** (Videofallkonferenz) eine eigenständige Leistung für die Videofallkonferenz geschaffen (siehe Kapitel 3 des Berichts).

Darüber hinaus wurden mit dem Beschluss aus der 453. Sitzung des BA weitere wichtige Regelungen und die Vergütungsstruktur prägende Gebührenordnungspositionen zu Videosprechstunden eingeführt:

- **Begrenzungsregeln:** Mit dem Beschluss in der 453. Sitzung des BA wurden zwei wesentliche Begrenzungsregeln für die Durchführung von Leistungen per Videosprechstunde in den EBM eingeführt (Allgemeine Bestimmungen Nr. 4.3.1, Nr. 5 und 6): Erstens eine

⁸ Siehe [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 453. Sitzung mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

Begrenzung der Anzahl der Behandlungsfälle, die ausschließlich per Video⁹ durchgeführt werden können, auf damals 20 % aller Behandlungsfälle der Vertragsärztin, des Vertragsarztes, der Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten. Zweitens eine versichertenübergreifende Obergrenze von damals 20 % je Vertragsärztin/-arzt oder Psychotherapeutin/-therapeuten und je Gebührenordnungsposition, die entsprechend ihrer Leistungsbeschreibung auch im Rahmen einer Videosprechstunde durchgeführt werden kann.

- **Technikzuschlag:** Die **GOP 01450** ist der Technikzuschlag bei der Durchführung von Leistungen per Videosprechstunde. Mit dem Beschluss in der 453. Sitzung des BA kann der Technikzuschlag bei jedem Video-/(Fall-)kontakt abgerechnet werden, weshalb diese Gebührenordnungsposition nicht nur eine zentrale Rolle bei der Vergütung der Videosprechstunde einnimmt, sondern auch als ein guter Parameter für die Menge an Abrechnungen, die insgesamt per Video durchgeführt werden, genutzt werden kann. Die Auswertung der Leistungsentwicklung der GOP 01450 nimmt damit eine zentrale Rolle bei der Bestimmung der Leistungshäufigkeit der Videosprechstunde ein.
- Die **GOP 01450** wird mit 40 Punkten bewertet, allerdings wird für den Zuschlag ein Höchstwert von 1.899 Punkten je Ärztin, Arzt, Psychotherapeutin oder Psychotherapeut und Quartal gebildet. Durch die Mengenbegrenzung pro Ärztin/Arzt ist theoretisch denkbar, dass nach Erreichen des Höchstwertes keine weitere Abrechnung der GOP 01450 mehr durch die betreffende Ärztin/Arzt erfolgen könnte und es somit bei der Auswertung zu einer Unterschätzung der Anzahl an Videosprechstunden kommt. Aus praktischer Sicht dürfte jedoch die regelmäßige Abrechnung der GOP 01450 unabhängig von dem Erreichen einer individuellen Höchstgrenze der Regelfall sein, da das Erreichen des Höchstwertes erst mit der Abrechnung der KV festgelegt wird.
- **Authentifizierung:** Für die Vergütung des zusätzlichen Aufwands, der dem Praxispersonal entsteht, um eine oder einen der Praxis unbekannte(n) Versicherte(n) im Rahmen der Videosprechstunde zu authentifizieren, wurde die **GOP 01444** (Zuschlag Authentifizierung) befristet als Zuschlag (10 Punkte) zu den Versicherten-, Grund- und Konsiliarpauschalen aufgenommen. Die Befristung wurde dabei mehrfach verlängert (s.u.). Zukünftig sollen digitale Identitäten den Versicherten genauso wie die elektronische Gesundheitskarte als Versicherungsnachweis dienen.

Nach der mit der 453. Sitzung des BA geänderten Vergütungsstruktur für Videosprechstunden kam es im Verlauf – wie im SGB V vorgesehen – zu einer kontinuierlichen Ausweitung von Leistungen, die mittels Videosprechstunde durchgeführt werden können. Insbesondere mit dem DVPMG und im Rahmen der Corona-Pandemie wurden Leistungen um die Durchführung im Rahmen einer Videosprechstunde (vorübergehend) erweitert. Die zeitlich befristeten Corona-Sonderregeln¹⁰, die vom 2. Quartal 2020 bis zum Ende des 1. Quartals 2022 Gültigkeit hatten,

⁹ Bei ausschließlichen Videobehandlungsfällen handelt es sich um Behandlungsfälle in denen kein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt im Behandlungsfall erfolgte. Telefonische oder weitere mittelbare Kontaktformen können aber neben dem Videokontakt vorliegen.

¹⁰ Die letzte Verlängerung der Corona-Sonderregelungen erfolgte mit dem [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 579. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

umfassten die vorübergehende Aussetzung der behandlungsfall- und leistungsbezogenen Begrenzungen bei Videosprechstunden (bis dato durften nur 20 % der Behandlungsfälle sowie nur 20 % einer Leistung einer Ärztin/eines Arztes per Videosprechstunde abgerechnet werden). Darüber hinaus wurde zeitweise die Durchführung von psychotherapeutischen Sprechstunden und probatorischen Sitzungen im Rahmen einer Videosprechstunde bei gleichzeitigem Aussetzen eines notwendigen persönlichen Arzt-Patienten-Kontakts zur Eingangsdiagnostik, Indikationsstellung und Aufklärung bei der Initiation von psychotherapeutischen Sprechstunden ermöglicht (siehe hierzu auch Vorberichte 2020 und 2022).

Mit dem Beschluss aus der 589. Sitzung des BA¹¹ wurde die vom Gesetzgeber vollzogene Änderung des § 87 Abs. 2a SGB V zum 2. Quartal 2022 umgesetzt. Diese betraf die dauerhafte Anhebung der behandlungsfall- und leistungsbezogenen Begrenzungen bei Videosprechstunden von zuvor 20 % auf 30 %, sodass nach Auslaufen der Corona-Sonderregeln zum Ende des 1. Quartals 2022 eine Versorgung mittels Videosprechstunden auf einem erhöhten Begrenzungsniveau von 30 % ermöglicht wurde. Im Normalfall wird die 30 %-Regel dabei auf die Durchführung von Leistungen per Videosprechstunde in Bezug auf die Gesamtanzahl der betreffenden Leistungen durch eine Ärztin bzw. einen Arzt angewendet. Bei Leistungen aus dem Kapitel 35 EBM ist die Bemessungsgrundlage jedoch seit dem Beschluss des BA in seiner 597. Sitzung ausnahmsweise das Punktzahlvolumen aller von der Ärztin/Arzt bzw. Psychotherapeutin/-therapeuten berechneten Leistungen des Kapitels 35 EBM¹².

Anpassung der Vergütung der Videosprechstunde im oder zum Jahr 2023

Tabelle 1 zeigt die Beschlüsse des BA und des ergBA bezüglich der Videosprechstunde, die im oder mit Wirkung zum Berichtsjahr 2023 getroffen wurden.

¹¹ Siehe [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 589. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

¹² Mit Ausnahme der GOP 35152, die der klassischen 30 %-Abrechnungsbegrenzung pro GOP unterliegt.

Tabelle 1 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zu Videosprechstunden, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden. MGV = morbiditätsbedingte Gesamtvergütung.

Kategorie	Beschluss	Inkrafttreten	Inhalt/ GOP	Laufzeit/ Befristung
Finanzierung	603. BA	01.01.2023	Vergütung GOP 01450 außerhalb der MGV	31.12.2023
Verlängerung/ Finanzierung	626. BA	01.01.2023	Verlängerung GOP 01444 und Finanzierung außerhalb MGV (Verlängerung 453. BA, 570. BA)	31.12.2023
Neue Leistung/ Abrechnungsbestimmung	650. BA	01.07.2023	Durchführbarkeit per Video: Neue GOP 08622 (Reproduktionsmedizinische Beratung und Aufklärung (Kryo-RL)) und Kennzeichnung GOP 08619, 08621 und 08623 bei Videokontakt.	Nein
Finanzierung	664. BA	01.01.2024	Vergütung Videosprechstunde/ Videofallkonferenz (GOP 01442, 01450) und GOP 40128, 40129 außerhalb MGV	31.12.2024
Verlängerung	669. BA	01.01.2024	Verlängerung befristete GOP 01444	31.12.2025
Neue Leistung	691. BA	01.01.2024	Aufnahme GOP 30780 für Schmerztherapeuten als Spiegelung zu GOP 01472 (Verlaufskontrolle/Auswertung der DiGA somnio)	Nein
Abrechnungsbestimmung/Erweiterung Kostenpauschale	694. BA	01.01.2024	Im Rahmen Videosprechstunde durchführbar: Teil A: Leistungen GOP 01420, 01424 (Häusliche Krankenpflege-RL); GOP 01611, 01613 (Rehabilitations-RL); Erweiterung Kostenpauschale 40128 postalische Versendung (Folge-)Verordnung Krankenpflege, Rehabilitation und Heilmittel. Teil B: Bescheinigung für Bezug Krankengeld bei Erkrankung Kind	Nein

Inhaltlich wurden mit den in Tabelle 1 ersichtlichen Beschlüssen im oder zum Jahr 2023 folgende Änderungen implementiert oder beschlossen:

Eine Verlängerung der Vergütung der Authentifizierungsleistung (GOP 01444) bis zum 31. Dezember 2025 wurde mit dem Beschluss aus der 626. bzw. 669. Sitzung des BA¹³ ermöglicht. Grund war die sich weiter verzögernde Etablierung der digitalen Versichertenidentitäten und damit der weiterhin bestehende Zusatzaufwand für die Praxen bei der Authentifizierung der Versicherten.

Mit den Beschlüssen aus den 603. und 664. Sitzungen des BA,¹⁴ welche die Finanzierungsregelung außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen (MGV) zusammentragen, wurde die Finanzierung der GOP 01450 für das Jahr 2023 bzw. 2024 weiterhin über eine extrabudgetäre Vergütung gewährleistet. Dies betraf bei dem Beschluss aus der 664. Sitzung auch die

¹³ Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner [626.](#) und [669.](#) Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

¹⁴ Siehe Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner [603.](#) und [664.](#) Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

Kostenpauschale für die postalische Versendung von AU-Bescheinigungen und Verordnungen (Kostenpauschalen 40128, 40129).

Mit dem Beschluss aus der 650. Sitzung des BA¹⁵ wurde die Durchführung von Beratungsleistungen im Rahmen der Kryokonservierung nach GOP 08622 auch im Rahmen einer Videosprechstunde ermöglicht. Für die bereits bestehenden GOP 08619, 08621 und 08623 wurde die Kennzeichnungspflicht bei Durchführung der Leistungen per Videosprechstunde implementiert.

Ab dem Jahr 2024 war mit dem Beschluss aus der 694. Sitzung des BA¹⁶ die Berechnungsfähigkeit von Leistungen zur (Folge-)Verordnung der häuslichen Krankenpflege und psychiatrischen häuslichen Krankenpflege (GOP 01420, 01424) und der Verordnung von Rehabilitation (GOP 01611, 01613) auch im Rahmen einer Videosprechstunde möglich. Mit diesem Beschluss wurde auch die Kostenpauschale 40128 (postalische Versendung (Folge-)Verordnung Krankenpflege, Rehabilitation und Heilmittel) um diejenigen Sachverhalte erweitert, die auch im Rahmen einer Videosprechstunde durchgeführt werden können.

2.3 Berechnungsfähige Leistungen im Rahmen der Videosprechstunde im Jahr 2023

Im Berichtsjahr 2023 waren folgende Gebührenordnungspositionen – neben den Grund-, Konsiliar- und Versichertenpauschalen bzw. Zusatzpauschalen und Zuschlägen – im Rahmen der Videosprechstunde berechnungsfähig (Tabelle 2):

¹⁵ Siehe [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 650. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

¹⁶ Siehe [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 694. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

Tabelle 2 Auflistung der wichtigsten im Berichtszeitraum im Rahmen der Videosprechstunde berechnungsfähigen Gebührenordnungspositionen (GOP) (teilweise gruppiert; unb. = unbefristet, KZT = Kurzzeittherapie, LZT = Langzeittherapie). Nicht aufgeführt sind die Grund-, Versicherten- und Konsiliarpauschalen bzw. Zusatzpauschalen oder Zuschläge und GOP aus dem Bereich der ASV.

GOP	Bezeichnung	Quartal	bis
01444	Authentifizierung	2019/4	2025/4
01450	Technikzuschlag	2017/2	unb.
Ärztliche Gesprächsleistungen			
03230, 04230, 04231, 04355, 04430, 14220, 14222, 16220, 21216, 21220, 22220, 22221, 23220	Einzel-Gespräch, Beratung, Abklärung, Ärztliche Psychotherapie/Psychiatrie (Kinder/Erwachsene)	2019/4	unb.
30708	Beratung und Erörterung (Schmerztherapie)	2020/2	unb.
22222, 21221, 14221	Gruppenbehandlung: Ärztliche Psychotherapie, Psychiatrie (Kinder/Erw.)	2021/4	unb.
Einzeltherapie, Antrags-Psychotherapie Kapitel 35 EBM			
35401, 35402, 35405, 35411, 35412, 35415, 35421, 35422, 35425, 35571	Tiefenpsychologie, Analytisch, Verhalten, Zuschlag	2019/4	unb.
35591	Zuschlag KZT, Einzelbehandlung	2020/2	unb.
35431, 35432, 35435	Systemische Therapie (KZT+LZT, Einzelbehandlung)	2020/4	unb.
Psychotherapie Kapitel 35 EBM, nicht antragspflichtig			
35110, 35111, 35112, 35113, 35141, 35142, 35600, 35601, 30932	Erhebung Befunde, Übungen (Gruppe), Testverfahren, Neuropsycholog. T. (Einzelbehandlung)	2019/4	unb.
30933	Neuropsycholog. Therapie (Gruppe)	2021/4	unb.
35152	Psychotherapeutische Akutsprechstunde	2021/4	unb.
Gruppenpsychotherapie Kapitel 35 EBM			
35173-35178, 35503-35508, 35513-35518, 35523-35528, 35533-35538, 35543-35548, 35553-35558, 35703-35708, 35713-35718, 35572, 35593-35598	Psychotherapeutische, tiefenpsychologische, analytische, Verhaltens-, systemische Gruppentherapie, Zuschläge	2021/4	unb.
Fallkonferenzen			
37120, 37320	Fallkonferenz gemäß Anlage 27 und 30 BMV-Ä	2019/2	unb.
01442, 30706, 30210, 30948, 37400	Videofallkonferenz und andere	2019/4	unb.
37550	Fallbesprechung gemäß § 6 KSVPsych-RL	2022/4	unb.
37720	Fallkonferenz im Rahmen AKI-RL	2022/4	unb.
Andere			
08619, 08621, 08623	Beratung im Rahmen der Kryokonservierung	2021/3	unb.
08622	Beratung im Rahmen der Kryokonservierung	2023/3	unb.
01471	Verlaufskontrolle DiGA somnio	2021/1	unb.
01210, 01212	Notfallpauschale I + II	2022/3	unb.
01789, 01790	Beratung NIPT (Nichtinvasiver Pränataltest auf Trisomien)	2022/3	unb.
37700, 3706	Versorgung Versicherte im Rahmen AKI-RL	2022/4	unb.

2.4 Leistungsentwicklung

Wie in Kapitel 2.2 des Berichts erwähnt, lässt sich die Entwicklung der Inanspruchnahme der Videosprechstunde im Allgemeinen an der Abrechnungshäufigkeit der GOP 01450 ablesen, da diese bei jedem Videokontakt abgerechnet werden kann. Abbildung 1 gibt einen Überblick über die Abrechnungshäufigkeit und den Leistungsbedarf in € für das Jahr 2023 und über die Entwicklung in Bezug auf die Vorjahre seit Beginn der Neustrukturierung der Vergütung der Videosprechstunde mit dem ersten vollständigen Kalenderjahr 2020 (siehe Kapitel 2.2 des Berichts).

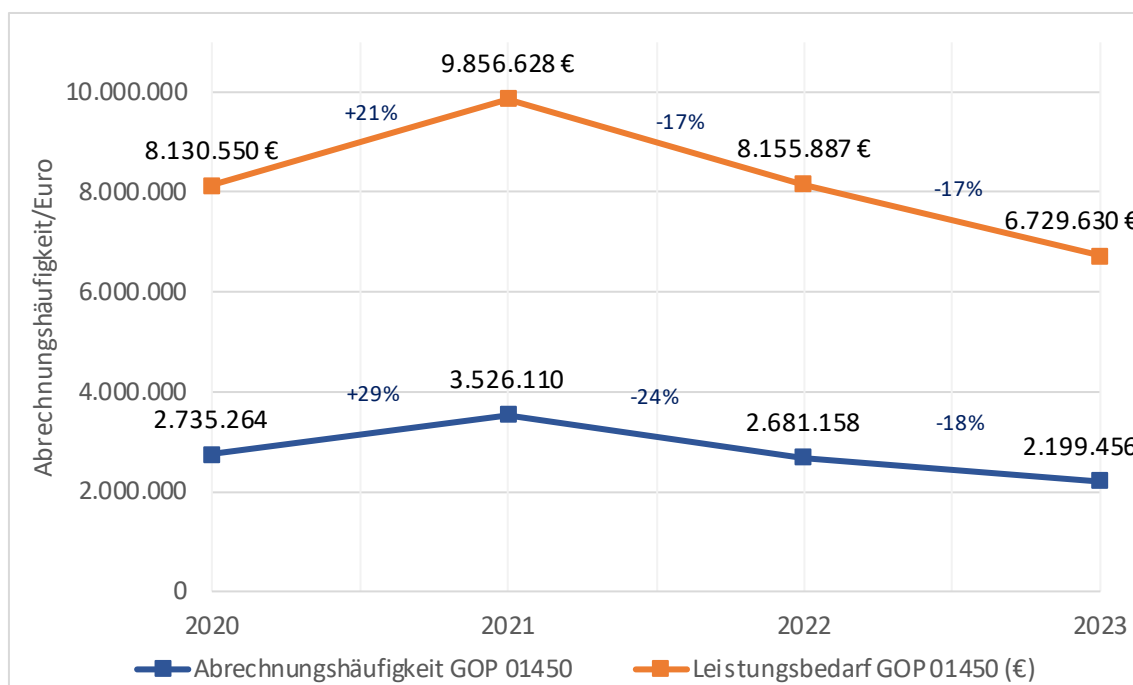


Abbildung 1 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € der GOP 01450 in den Jahren 2020 bis 2023.

Betrachtet man Abbildung 1, fallen im Wesentlichen drei Aspekte auf:

Sowohl die Abrechnungshäufigkeit (blaue Kurve) als auch der Leistungsbedarf in € (orangefarbene Kurve) steigen zum Jahr 2021 deutlich um 29 % an und sinken zum Jahr 2023 auf einen neuen Tiefstwert um 2 Millionen Abrechnungen und damit unter den Jahreswert von 2020 – dem ersten Jahr nach der Restrukturierung – ab.

Die deutliche Zunahme zum Jahr 2021 und die konsekutive Abnahme der Abrechnungshäufigkeit zum Jahr 2022 hin dürfte mit der im Rahmen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und insbesondere im Jahr 2021 zu verzeichnenden deutlichen Ausweitung der Videosprechstunde zusammenhängen (siehe Vorbericht 2022). In Anbetracht des hohen Anstiegs der Abrechnungshäufigkeit in dieser Ausnahmelage mit zusätzlichen passageren Abrechnungsmöglichkeiten erscheint der in Abbildung 1 verzeichnete Rückgang von 24 % zum Jahr 2022 und nochmalig von 18 % zum Jahr 2023 hin nachvollziehbar.

Der Leistungsbedarf der GOP 01450 (orangefarbene Kurve) zeigt – wie oben festgestellt – einen ähnlichen Verlauf, gestaltet sich jedoch aufgrund von Abrechnungsbegrenzungen

(Höchstmenge pro Ärztin/Arzt bzw. Psychotherapeutin/-therapeut) insgesamt um ca. 40 % niedriger, als bei einer Multiplikation von Punktwert der Leistung (40 Punkte) mit dem Orientierungswert und mit der Abrechnungshäufigkeit zu errechnen wäre. Dieser Höchstwert führt auch dazu, dass sich Schwankungen der Abrechnungshäufigkeit bei einer sehr hohen Abrechnungshäufigkeit der GOP 01450 nicht im vollen Umfang auf die Entwicklung des Leistungsbedarfs übertragen.

Eine detailliertere Darstellung hinsichtlich der Videosprechstunde liefert die Entwicklung auf der Quartalsebene (Abbildung 2):

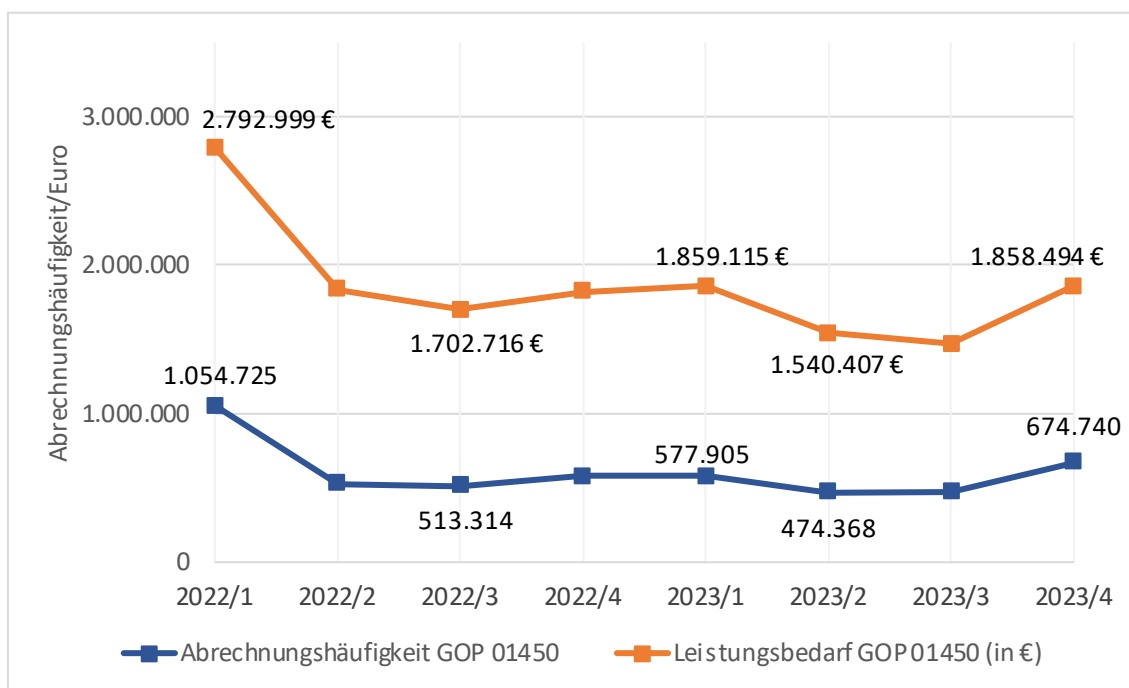


Abbildung 2 Abrechnungshäufigkeit (AH) und Leistungsbedarf (LB, in €) der GOP 01450 je Quartal.

Abbildung 2 zeigt den Verlauf der Abrechnungshäufigkeit der Videosprechstunde in Abhängigkeit vom betreffenden Quartal. Insgesamt zeigt sich vom 2. Quartal 2022 bis zum 3. Quartal 2023 ein relativ konstanter Verlauf um 500.000 Videosprechstunden pro Quartal. Der deutliche Rückgang der Gesamt-Abrechnungshäufigkeit vom Jahr 2022 auf das Jahr 2023 (s. Abbildung 1) scheint insbesondere durch den starken Rückgang der Abrechnungshäufigkeit mit Auslaufen der Corona-Sonderregeln nach dem 1. Quartal 2022 bedingt zu sein.

In Abbildung 2 ist noch eine Schwankung mit etwas niedrigeren Abrechnungshäufigkeiten im 2./3. Quartal (Frühling/Sommer) und höheren Abrechnungshäufigkeiten im 4./1. Quartal (Herbst/Winter) erkennbar. Zum 4. Quartal 2023 zeigt sich dann allerdings ein deutlicherer Wiederanstieg der Abrechnungshäufigkeit auf etwa 675.000 Abrechnungen.

Die Entwicklung der GOP 01450 und damit der Videosprechstunde ist in ihrer Veränderung auf Jahres- und Quartalsicht auch der Tabelle 53, Tabelle 54 und Tabelle 55 im Anhang zu entnehmen.

2.5 Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Leistungsbereichen und einzelnen Leistungen durch die bundeseinheitliche Kennzeichnung

Neben der Betrachtung der Gebührenordnungsposition 01450 als Surrogat-Parameter für sämtliche stattfindende Videokontakte lässt sich auch die Abrechnungshäufigkeit der einzelnen Leistungen betrachten, die spezifisch im Rahmen der Videosprechstunde durchgeführt werden. Dies ist möglich, weil – bis auf sehr wenige Ausnahmen – die Gebührenordnungspositionen mit einer bundeseinheitlichen Kennzeichnung versehen werden, wenn sie per Video durchgeführt wurden. Die Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit der in Tabelle 2 in Leistungsbereiche gruppierten Leistungen stellte sich wie folgt dar (Tabelle 3):

Tabelle 3 Abrechnungshäufigkeit der Leistungsbereiche, die per Video in den Jahren 2020–2023 durchgeführt wurden (für die Zusammensetzung der Leistungsbereiche siehe Tabelle 2). Für die Identifikation, dass die jeweilige Leistung per Video durchgeführt wurde, dienten die bundeseinheitlichen Kennzeichnungen im Fall der Durchführung per Video. In Klammern ist der Anteil an der gesamten Leistungsgruppe, also auch der nicht per Video durchgeführten Leistungen, angegeben. Sortiert nach Abrechnungshäufigkeit im Jahr 2023. ¹ Diese Leistungen sind erst ab dem 4. Quartal 2021 berechnungsfähig. ² Diese Leistungen sind seit dem 3. Quartal 2022 berechnungsfähig. ³ Die GOP 01470 war nur bis zum 4. Quartal 2022 berechnungsfähig. ⁴ Mit dem 1. Quartal 2022 liefen diese Leistungen aus.

Leistungsbereich	2020	2021	2022	2023
Einzeltherapien, Antrags-Psychotherapie	1.838.482 (9,4%)	2.340.044 (11,7%)	1.393.281 (7,2%)	843.786 (4,2%)
Gesprächsleistungen	941.714 (0,6%)	1.254.211 (0,8%)	1.010.363 (0,6%)	763.861 (0,5%)
Versicherten-/Grund-/Konsiliarpauschalen	233.452 (0,1%)	349.804 (0,1%)	412.931 (0,1%)	632.801 (0,1%)
Nicht antragspflichtige Psychotherapie-Leistungen	239.200 (0,7%)	376.838 (1,1%)	297.711 (0,8%)	159.183 (0,4%)
Gruppentherapien	.	2.712 (0,3%) ¹	13.149 (1,1%)	6.286 (0,4%)
Notfall Telemedizin (GOP 01210, 01212)	.	.	141 (0,0%) ²	3.796 (0,0%)
Beratung NiPT (GOP 01789, 01790)	.	.	221 (0,0%) ²	785 (0,0%)
DiGA (GOP 01470, 01471)	.	2.180 (5,6%)	5.037 (4,3%)	442 (7,5%) ³
AKI (GOP 37700, 37706)	.	.	.	82 (1,3%)
Beratungen Kryokonservierung	.	≤5 (0,2%)	≤5 (0,1%)	≤5 (0,1%)
Sonderregelungen Covid-19-Pandemie	341.931 (3,1%)	501.270 (4,2%)	147.333 (1,2%) ⁴	.

Auch in der Abrechnungshäufigkeit der einzelnen Leistungsbereiche lässt sich der Rückgang der per Videosprechstunde durchgeführten Leistungen vom Jahr 2021 über das Jahr 2022 bis zum Jahr 2023 bei vielen Leistungsbereichen erkennen (Tabelle 3). So sank z. B. die Abrechnungshäufigkeit der per Video durchgeführten Einzeltherapien um fast 1,5 Mio. Abrechnungen und damit der Anteil der per Video gehaltenen Therapiesitzungen an allen Therapiesitzungen von 11,7 % im Jahr 2021 auf 4,2 % im Jahr 2023. Auch bei den nicht antragspflichtigen Psychotherapie-

Leistungen war ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Hier sank der Anteil von 1,1 % im Jahr 2021 auf 0,4 % im Jahr 2023. Die per Video durchgeführten Gesprächsleistungen zeigten hingegen einen Rückgang von 0,8 % im Jahr 2021 auf 0,5 % im Jahr 2023.

Eine kontinuierliche Steigerung bei den absoluten Zahlen lässt sich u. a. bei den Versicherten, Grund- und Konsiliarpauschalen erkennen, die im Rahmen eines ausschließlichen Videokontakts abgerechnet wurden: Hier kam es zu einem Anstieg von ca. 350.000 Abrechnungen im Jahr 2021 auf über 630.000 Abrechnungen im Jahr 2023. Nichtsdestotrotz stellt sich in Anbetracht der hohen Zahl an Pauschalen der Anteil an per Video abgerechneten Pauschalen mit insgesamt 0,1 % weiterhin sehr niedrig dar (s. hierzu Kapitel 2.10.2 des Berichts). Eine gleiche Beobachtung lässt sich bei Notfallleistungen (GOP 01210 und 01212) machen – auch wenn hier mit ca. 3.800 Abrechnungen im Jahr 2023 nochmals deutlich weniger Abrechnungen erfolgten.

Im Anhang ist die Abrechnungshäufigkeit sämtlicher Gebührenordnungspositionen einzeln dargestellt, die im Jahr 2023 im Rahmen einer Videosprechstunde durchgeführt werden konnten (Tabelle 56).

2.6 Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit

Um einen Vergleich zwischen den regionalen Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) hinsichtlich ihrer Leistungsmengen ziehen zu können, wird in Abbildung 3 die auf 100.000 Versicherte bezogene normierte Abrechnungshäufigkeit der GOP 01450 betrachtet. Die absoluten Abrechnungshäufigkeiten sind in Tabelle 57 im Anhang ersichtlich.

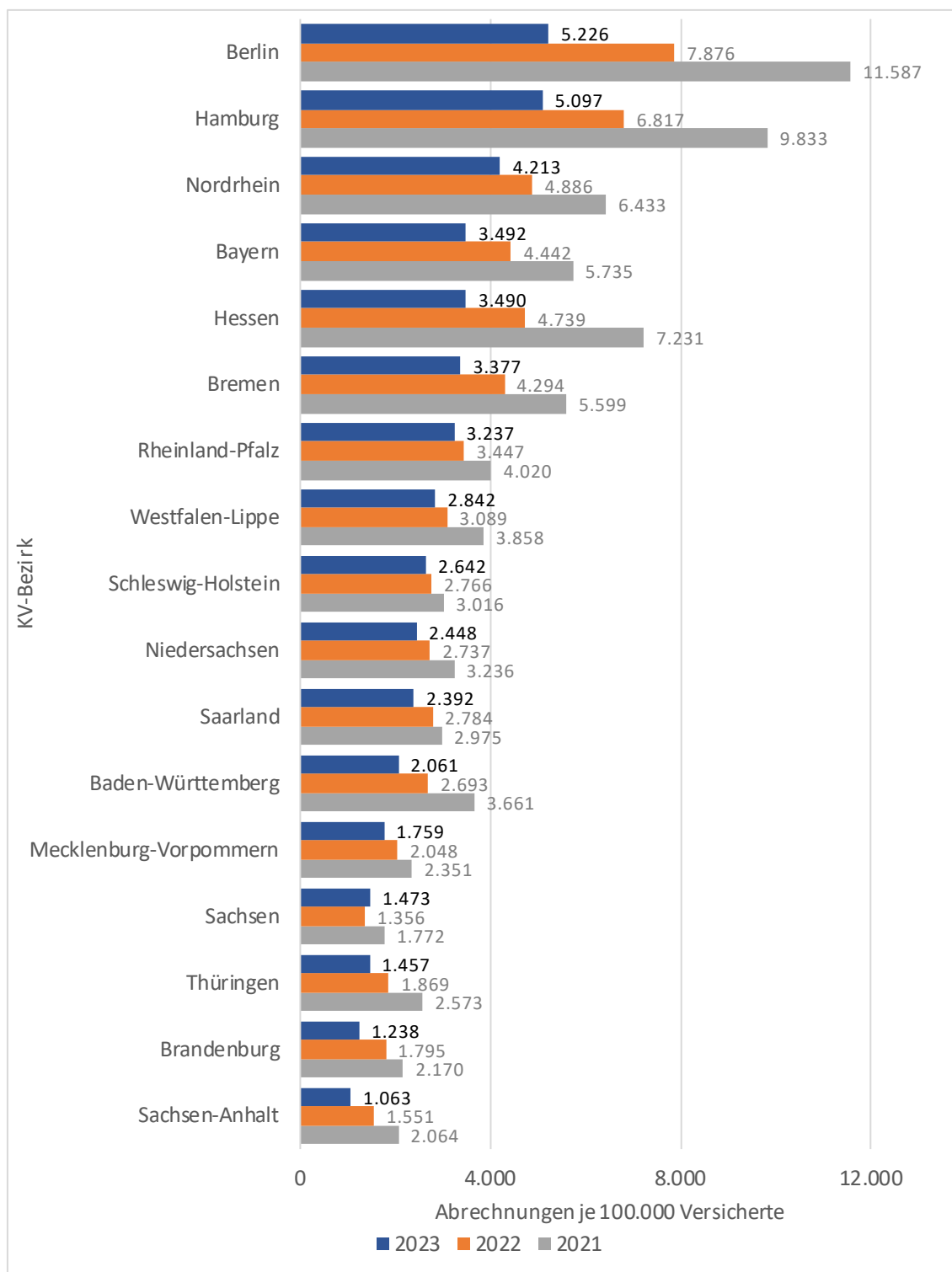


Abbildung 3 Regionale Abrechnungshäufigkeit des Technikzuschlags Videosprechstunde (GOP 01450) nach KV-Bezirken. Dargestellt ist die normierte Abrechnungshäufigkeit je 100.000 Versicherte in den Jahren 2021-2023, sortiert nach dem Jahr 2023.

Betrachtet man die in Abbildung 3 dargestellten normierten Abrechnungen der Videosprechstunde (GOP 01450), ist der in Kapitel 2.4 des Berichts beschriebene kontinuierliche Rückgang der Abrechnungshäufigkeit vom Jahr 2021 auf das Jahr 2023 in fast allen KV-Bezirken erkennbar. In Bezug auf ihre Größe werden insbesondere in den KV-Bezirken der Stadtstaaten Berlin und

Hamburg verhältnismäßig viele Videosprechstunden durchgeführt (>5.000 Videosprechstunden pro 100.000 Versicherte). In der absoluten Abrechnungshäufigkeit befanden sich diese beiden KV-Bezirke dabei an der 7. bzw. 9. Stelle (siehe Tabelle 57 im Anhang). Die fünf Flächenland-KV-Bezirke (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern) hatten die geringsten normierten Abrechnungszahlen (Abbildung 3).

2.7 Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Einrichtungenformen

Abbildung 4 illustriert die Verteilung der abgerechneten Videosprechstunden (GOP 01450) in Bezug auf die Einrichtungform für das Jahr 2023.

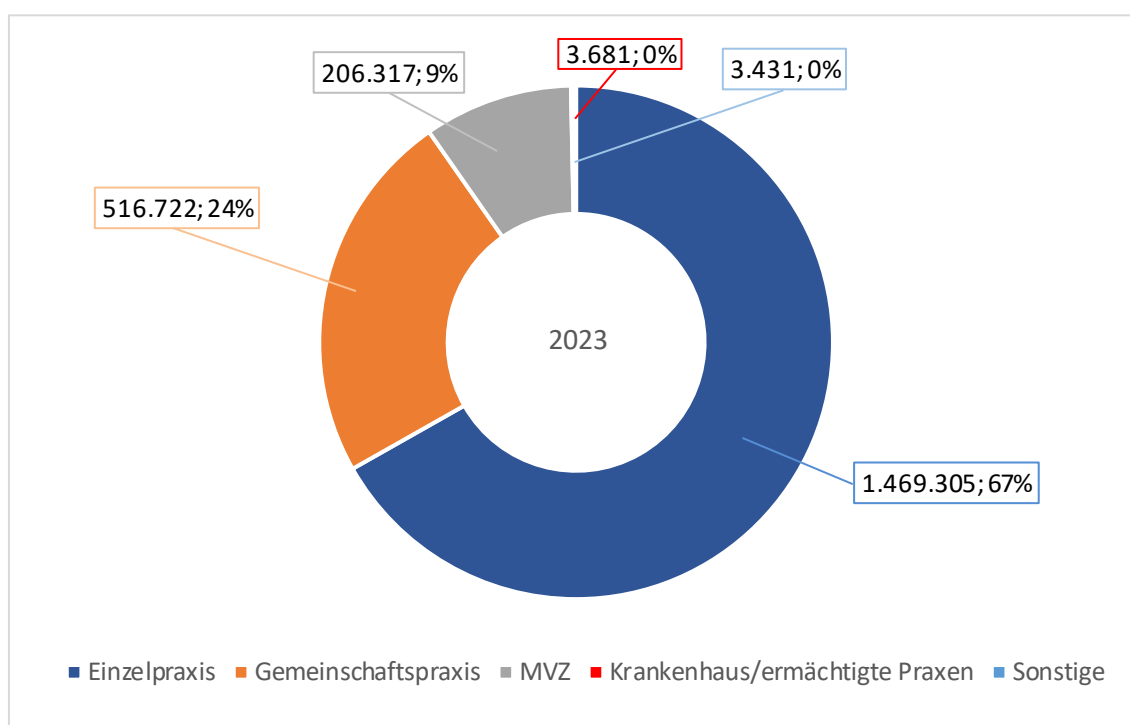


Abbildung 4 Verteilung der abgerechneten Videosprechstunden (GOP 01450) auf die Einrichtungenformen im Jahr 2023.

In Abbildung 4 ist für das Jahr 2023 ersichtlich, dass 91 % der als Videosprechstunde durchgeführten ambulanten Leistungen von Einzel- oder Gemeinschaftspraxen durchgeführt wurden (Jahr 2022: 94 %); 9 % der Videosprechstundenleistungen wurden von MVZ durchgeführt (Jahr 2022: 6 %). Krankenhäuser und Ermächtigte Praxen hatten keinen nennenswerten Anteil. Tabelle 4 zeigt die Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit über die Jahre 2020 bis 2023 und die mittlere Abrechnungshäufigkeit je Einrichtung.

Tabelle 4 Abrechnungshäufigkeit der Videosprechstunde (GOP 01450) nach Einrichtungsformen in den Jahren 2020 bis 2023. In Klammern ist die mittlere Abrechnungshäufigkeit pro abrechnende Einrichtung angegeben.

Einrichtungsform	Abrechnungshäufigkeit GOP 01450 (durchschnittliche Abrechnungen je Einrichtung)			
	2020	2021	2022	2023
Einzelpraxis	2.227.388 (90)	2.899.272 (123)	2.037.052 (88)	1.469.305 (68)
Gemeinschaftspraxis	380.899 (79)	443.840 (120)	485.442 (148)	516.722 (165)
MVZ	115.850 (172)	169.365 (280)	151.165 (225)	206.317 (277)
Krankenhaus/Ermächtigte Praxen	8.990 (46)	10.664 (56)	5.986 (34)	3.681 (26)
Sonstige	2.137 (59)	2.969 (85)	1.513 (50)	3.431 (54)

Tabelle 4 zeigt, dass der Rückgang der Abrechnungshäufigkeit der Videosprechstunde insbesondere durch Einzelpraxen bedingt war, die deutlich weniger Videosprechstunden pro Jahr und pro Praxis durchführten. Der Rückgang war dabei weniger durch eine Reduktion an Praxen bedingt, die Videosprechstunden durchführten, als vielmehr durch die durchschnittliche Häufigkeit, mit der Praxen diese durchführten. So sank die durchschnittliche Abrechnungshäufigkeit von Videosprechstunden bei Einzelpraxen von 123 im Jahr 2021 auf 68 im Jahr 2023. Gemeinschaftspraxen hingegen führten im Jahr 2023 mit durchschnittlich 165 Abrechnungen deutlich mehr Videosprechstunden durch als im Jahr 2021 (120 Abrechnungen).

2.8 Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Fachgruppen und Anteil der Fachgruppen an allen abgerechneten Videosprechstunden

Bei dem Anteil, den die verschiedenen Fachgruppen an der Gesamt-Abrechnungshäufigkeit der Videosprechstunde (GOP 01450) leisteten, hat sich über die letzten Jahre eine deutliche Verschiebung ergeben (Abbildung 5).

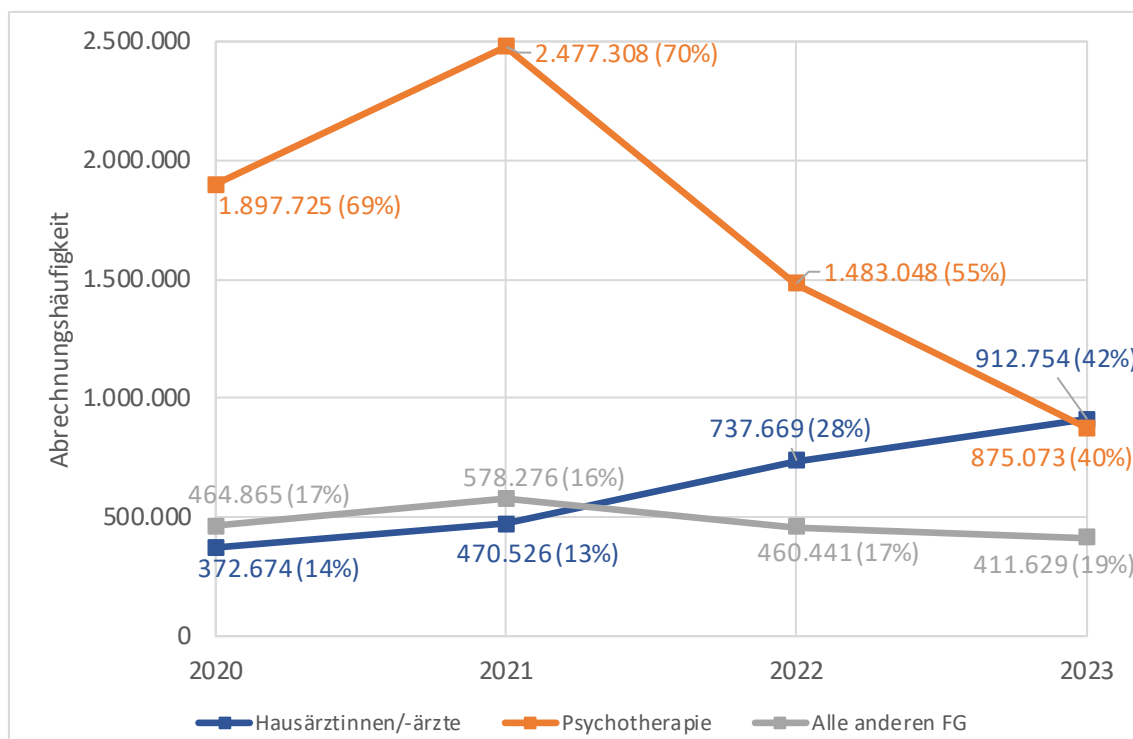


Abbildung 5 Abrechnungshäufigkeit (AH) der GOP 01450 nach Fachgruppen (FG) absolut und Anteil der Fachgruppen in % an den Abrechnungen von Videosprechstunden (GOP 01450) im Jahresverlauf. Dargestellt sind die hinsichtlich der Abrechnung dominanten Fachgruppen Psychotherapie (orange) und Hausärztinnen/-ärzte (blau) gegenüber allen anderen Fachgruppen zusammengefasst (grau).

Die Verteilung der Anteile der Fachgruppen an der Gesamtdurchführung der Videosprechstunde spiegelt die Dominanz der sprechenden Medizin für das Thema Videosprechstunde wider. Die Psychotherapeutinnen/-therapeuten und Hausärztinnen/-ärzten führten im Jahr 2023 allein fast 81 % an allen abgerechneten Videosprechstunden (Abbildung 5) durch. Nach dem Jahr 2021 stieg der Anteil an Videosprechstunden, die von Hausärzten/-ärztinnen durchgeführt wurden, kontinuierlich von 13 % im Jahr 2021 auf 42 % bzw. ca. 913.000 Abrechnungen im Jahr 2023 an, womit diese Fachgruppe erstmalig den höchsten Anteil an den durchgeführten Videosprechstunden leistete. Grund hierfür war insbesondere der Rückgang der durchgeführten Videosprechstunden durch Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten von fast 2,5 Millionen Videosprechstunden im Jahr 2021 auf knapp 900.000 Videosprechstunden im Jahr 2023, womit der Anteil der von Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten durchgeführten Videosprechstunden von 70 % im Jahr 2021 auf 40 % im Jahr 2023 abfiel.

Tabelle 5 stellt die Ergebnisse für das Jahr 2023 nochmals differenziert für alle Fachgruppen unter Berücksichtigung der Anzahl an abrechnenden Ärzten dar:

*Tabelle 5 Abrechnungshäufigkeit der Videosprechstunde (GOP 01450) nach Fachgruppen und Anteil an allen abgerechneten Videosprechstunden in % für das Jahr 2023. Angegeben ist auch die Anzahl abrechnender Ärztinnen und Ärzte der Fachgruppe und die durchschnittliche Abrechnung pro Ärztin/Arzt der Fachgruppe (Definition der Fachgruppen siehe Fußnote 3, S. 21). *Die Gesamt-Arztzahl entspricht ggf. nicht der Summe der Ärztinnen/Ärzte über alle Fachgebiete, da Doppelzählungen durch Zugehörigkeit einzelner Ärztinnen/Ärzte zu mehreren Fachgebieten enthalten sein können.*

Fachgruppe	Anzahl Videosprechstunden (GOP 01450)	Anteil an allen Videosprechstunden (%)	Anzahl abrechnende Ärztinnen/Ärzte	Durchschnittliche Abrechnungen pro abrechnende/n Ärztin/Arzt
Hausärztinnen/-ärzte	912.754	41,5%	5.726	159
Psychotherapie	875.073	39,8%	19.986	44
Gynäkologie	64.772	2,9%	620	104
Orthopädie	53.771	2,4%	335	161
Psychosomatische Medizin	49.925	2,3%	962	52
Psychiatrie	46.232	2,1%	804	58
Kinder- und Jugendmedizin	40.831	1,9%	717	57
HNO und Phoniatrie	29.933	1,1%	177	169
Innere Medizin	24.404	1,1%	368	66
Neurologie und Nervenheilkunde	22.932	1,0%	427	54
Sonstige	17.091	0,8%	350	49
Dermatologie	16.642	0,8%	186	89
Urologie	11.634	0,5%	126	92
Chirurgie	11.287	0,5%	133	85
Anästhesiologie	8.178	0,4%	136	60
Augenheilkunde	7.113	0,3%	42	169
Physikalische und Rehabilitative Med.	5.011	0,2%	30	167
Humangenetik	1.857	0,1%	54	34
Strahlentherapie	16	0,0%	6	3
Gesamt	2.199.456	100%	31.185*	71*

In Tabelle 5 ist ersichtlich, dass im Jahr 2023 insgesamt 31.185 abrechnende Ärztinnen und Ärzte rund 2,2 Mio. Videosprechstunden geleistet haben (Jahr 2022: 2.681.158). Dabei wurden pro abrechnende/n Ärztin/Arzt durchschnittlich ca. 71 Videosprechstunden pro Jahr durchgeführt (Jahr 2022: 81).

Im Bereich der Psychotherapie wurde zwar mit knapp 40 % ein etwas kleinerer Anteil an Videosprechstunden abgerechnet als von Hausärztinnen (ca. 42 %), dieser verteilte sich jedoch auf eine sehr große Anzahl von abrechnenden Psychotherapeutinnen/-therapeuten (n = 19.986). Daraus resultierte eine geringere Anzahl von 44 durchschnittlich durchgeführten Videosprechstunden pro abrechnende/n Psychotherapeutin/-therapeut als z. B. bei den Hausärztinnen/-ärzten mit durchschnittlich 159 Videosprechstunden pro abrechnende/n Ärztin/Arzt. Die hohe Anzahl an Videosprechstunden abrechnenden Psychotherapeuten spricht dafür, dass die Durchführung einer Videosprechstunde in der Breite der Fachgruppe Psychotherapie angekommen ist (siehe hierzu auch Kapitel 2.9 des Berichts).

In Tabelle 58 im Anhang ist die Abrechnungshäufigkeit der Videosprechstunde (GOP 01450) nach Fachgruppen im Jahresverlauf einsehbar.

2.9 Anzahl Ärztinnen/Ärzte, die Videosprechstunden abrechnen, im Verhältnis zu allen Ärztinnen/Ärzten einer Fachgruppe

Ein wichtiger Parameter für die Verbreitung der Videosprechstunde, insbesondere auch hinsichtlich der Akzeptanz der Videosprechstunden unter Ärztinnen und Ärzten, ist der Anteil der Ärztinnen/Ärzte, die Videosprechstunden abrechneten, an allen Ärztinnen/Ärzten. Tabelle 6 gibt Aufschluss über die Anzahl der Ärztinnen/Ärzte, die mindestens einmal im Jahr eine Videosprechstunde (GOP 01450) abgerechnet haben, unter Berücksichtigung der Fachgruppenzugehörigkeit.

Tabelle 6 Anzahl Ärztinnen/Ärzte/Psychotherapeutinnen/-therapeuten (n Ä), die mind. einmal im Jahr eine Videosprechstunde (GOP 01450) abrechneten, und Gesamtanzahl der Ärztinnen/Ärzte/Psychotherapeutinnen/-therapeuten in den jeweiligen Fachgruppen (N Ä) in den Jahren 2021-2023.

Fachgruppe	Gesamtzahl Ärztinnen/Ärzte (N Ä) und Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte (n Ä) GOP 01450					
	2021		2022		2023	
	N Ä	n Ä	N Ä	n Ä	N Ä	n Ä
Psychotherapie	34.915	21.309	36.297	21.568	37.442	19.986
Hausärztinnen/-ärzte	62.755	5.690	63.390	5.319	63.549	5.726
Psychosomatische Medizin	2.362	1.168	2.319	1.145	2.235	962
Psychiatrie	3.460	1.034	3.573	971	3.647	804
Kinder- und Jugendmedizin	8.837	971	8.954	786	9.133	717
Gynäkologie	13.448	707	13.500	631	13.530	620
Neurologie und Nervenheilkunde	5.204	505	5.289	459	5.330	427
Innere Medizin	14.080	456	14.185	370	14.420	368
Sonstige	17.556	382	17.730	339	23.516	350
Orthopädie	8.756	416	9.007	348	9.190	335
Dermatologie	4.290	320	4.318	243	4.334	186
HNO und Phoniatrie	4.796	248	4.865	204	4.861	177
Anästhesiologie	4.091	169	4.172	151	4.165	136
Chirurgie	8.038	154	7.988	142	7.965	133
Urologie	3.866	146	3.893	120	3.963	126
Humangenetik	327	46	337	45	353	54
Augenheilkunde	6.840	57	6.920	41	7.014	42
Physikalische und Rehabilitative Medizin	662	36	655	30	640	30
Strahlentherapie	6.869	12	6.958	≤5	7.025	6
Labor	1.620	≤5	1.628	0	1.633	0

Die höchsten absoluten Anzahlen der Ärztinnen/Ärzte, die Videosprechstunden abrechneten, wiesen die Fachgruppen der Psychotherapie und der Hausärztinnen/-ärzte auf (Tabelle 6). Berücksichtigt man die Gesamtanzahl der Ärzte/Ärztinnen bzw. Psychotherapeutinnen/-therapeuten einer Fachgruppe, kann der Anteil an Ärzten/Ärztinnen/Psychotherapeuten/-therapeuten einer Fachgruppe bestimmt werden, die grundsätzlich in dem Abrechnungsjahr mindestens eine Videosprechstunde durchgeführt und die GOP 01450 abgerechnet haben. Die prozentualen Anteile für die 10 Fachgruppen mit dem höchsten Anteil in den Jahren 2022 und 2023 liefert Abbildung 6.

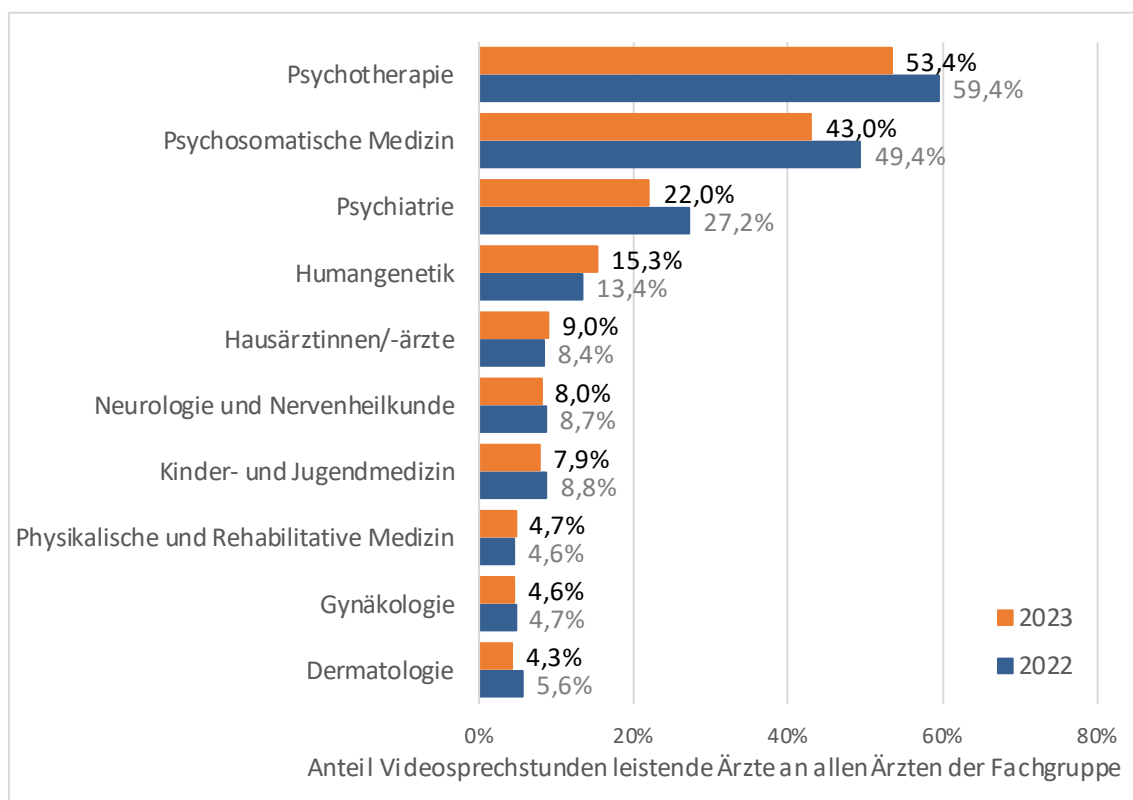


Abbildung 6 Anteil der Ärztinnen/Ärzten und Psychotherapeutinnen/-therapeuten, die mindestens eine Videosprechstunde (GOP 01450) abrechneten, an allen Ärztinnen/Ärzten der jeweiligen Fachgruppe. Dargestellt sind die 10 Fachgruppen mit dem höchsten Anteil in den Jahren 2022 (blau) und 2023 (orange).

Unter Berücksichtigung der Gesamtanzahl aller Ärztinnen/Ärzte/Psychotherapeutinnen/-therapeuten einer Fachgruppe zeigt sich, dass insbesondere in der Psychotherapie, Psychosomatik und Psychiatrie die Videosprechstunde von einem signifikanten Anteil der Ärztinnen/Ärzten/Psychotherapeutinnen/-therapeuten prinzipiell praktiziert wird. So führten mehr als die Hälfte aller Psychotherapeutinnen/-therapeuten mindestens eine Videosprechstunde im Jahr 2023 durch. Die Fachgruppe der Hausärztinnen/-ärzte findet sich unter dieser Betrachtungsweise erst auf dem 5. Platz und mit 9 % im einstelligen Bereich wieder (Abbildung 6). Die Hausärztinnen/-ärzte gehörten allerdings zu den wenigen Fachgruppen, die einen Anstieg des Anteils aufweisen – von 8,4 % im Jahr 2022 auf 9,0 % im Jahr 2023.

2.10 Versicherte und Behandlungsfälle mit Videosprechstunden

2.10.1 Gesamtanzahl von Versicherten und Behandlungsfällen mit Videosprechstunden

Durch Identifikation der Abrechnung von mindestens einer GOP 01450 in einem Behandlungsfall kann die Gesamtanzahl an Behandlungsfällen und Versicherten mit Inanspruchnahme einer Videosprechstunde ermittelt werden. Diese enthält sowohl ausschließliche Videobehandlungsfälle (s. 2.10.2) als auch Fälle mit vorliegendem kombinierten persönlichen und per Videosprechstunde erfolgten Kontakt.

Die Anzahl aller Behandlungsfälle und aller Versicherten, bei denen im Jahr mindestens eine Videosprechstunde durchgeführt wurde, zeigt Tabelle 7.

Tabelle 7 Anzahl Versicherte und Behandlungsfälle mit Inanspruchnahme mindestens einer Videosprechstunde (GOP 01450) in den Jahren 2020-2023 (hochgerechnet). In Klammern ist die Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert angegeben. Angegeben ist auch das rechnerische Verhältnis von BHF zu Versicherten und die durchschnittliche Anzahl an Videosprechstunden pro BHF.

	2020	2021	2022	2023
Anzahl Versicherte mit Videosprechstunde	846.411	922.197 (+9%)	996.340 (+8%)	901.154 (-10%)
Anzahl Behandlungsfälle mit Videosprechstunde	1.213.430	1.485.021 (+22%)	1.515.058 (+2%)	1.497.008 (-1,1%)
Anzahl Behandlungsfälle mit Videosprechstunde pro Versicherte/n	1,4	1,6	1,5	1,7
Videosprechstunden pro Video-Behandlungsfall (BHF)	2,25	2,37	1,77	1,47

Wie in Tabelle 7 ersichtlich, unterlag die (hochgerechnete) Anzahl der Versicherten mit Inanspruchnahme mindestens einer Videosprechstunde im Jahr seit 2020 einer stetigen Steigerung von 9 % (2021) bzw. 8 % (2022) jeweils gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2022 wurden annähernd 1 Million Versicherte (auch) mittels Videosprechstunde behandelt. Zum Jahr 2023 zeigte sich erstmals ein deutlicher Rückgang der Versichertenanzahl um 10 % auf ca. 900.000 Versicherte.

Die Anzahl der Behandlungsfälle zeigte zum Jahr 2021 ein kräftiges Wachstum von über 22 %, während im Jahr 2022 lediglich ein Zuwachs von 2 % und im Jahr 2023 ein geringer Rückgang um 1,1 % zu verzeichnen war. Der Rückgang der Behandlungsfälle im Jahr 2023 war damit deutlich geringer als der Rückgang der Versichertenanzahl, da auf einen Versicherten mit Videosprechstunde wieder etwas mehr Behandlungsfälle (1,7) mit Videokontakt entfielen als im Jahr 2022 (1,5).

Betrachtet man die Anzahl an durchgeführten Videosprechstunden pro BHF ist ebenfalls ein deutlicher Abfall von 1,77 Videosprechstunden/BHF im Jahr 2022 auf 1,47 Videosprechstunden/BHF im Jahr 2023 erkennbar. Zusammenfassend war im Jahr 2023 der Rückgang der Abrechnungshäufigkeit der Videosprechstunde durch eine Kombination aus Wegfall an Versicherten (-10 %) und Rückgang an durchgeführten Videosprechstunden pro Versicherte/n mit

Videosprechstunde bedingt. Die Videosprechstunden verteilten sich jedoch etwas mehr über die Behandlungsfälle und damit über das Versicherungsjahr.

2.10.2 Ausschließliche Video-Behandlungsfälle

Durch die Kennzeichnung von Grund-/Versicherten-/Konsiliarpauschalen mit einem Suffix sind die Behandlungsfälle zu identifizieren, in denen ausschließlich ein Kontakt per Video (d. h. ohne persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt) stattfand (Tabelle 8):

Tabelle 8 Ausschließliche Videobehandlungsfälle (ohne persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt) auf Grundlage der Abrechnungshäufigkeit der gekennzeichneten Versicherten-/Grund-/Konsiliarpauschalen (Daten bereits in Tabelle 3 gezeigt). In Klammern ist die Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert angegeben.

	2020	2021	2022	2023
Versicherten-/Grund-/Konsiliarpauschalen	233.452	349.804 (+49,8%)	412.931 (+18%)	632.801 (+53,2%)

Tabelle 8 zeigt einen durchgängig positiven Anstieg an ausschließlichen Videobehandlungsfällen. Setzt man die ausschließlichen Videobehandlungsfälle mit der Anzahl der Behandlungsfälle mit Videokontakt (Tabelle 7) ins Verhältnis, zeigt sich, dass im Jahr 2023 von den 1.497.008 Behandlungsfällen mit Videosprechstunde 42 % (n=632.801 BHF) ausschließlich mittels Videosprechstunde behandelt wurden. Im Jahr 2022 betrug dieses Verhältnis noch 27 % - damit zeigt sich der Anteil an ausschließlichen Video-Behandlungsfällen gegenüber allen Videobehandlungsfällen deutlich ansteigend.

2.10.3 Anteil Video-Behandlungsfälle an allen Behandlungsfällen

Tabelle 9 setzt die ausschließlichen Video-Behandlungsfälle und kombinierten Video-Behandlungsfälle mit allen Behandlungsfällen für das Jahr 2023, aufgeschlüsselt nach Fachgruppen, ins Verhältnis:

Tabelle 9 Verhältnis von ausschließlichen und kombinierten Video-Behandlungsfällen zu ausschließlich persönlichen Behandlungsfällen im Jahr 2023, aufgeschlüsselt nach Fachgruppen. Sortiert nach dem Anteil der Behandlungsfälle im rein persönlichen Kontakt.

Fachgruppe	Anteil Behandlungsfälle 2023 ausschließlich persönlich in %	Anteil Behandlungsfälle 2023 mit Videoleistung und persönlichem Kontakt in %	Anteil ausschließlicher Video-Behandlungsfälle 2023 in %
Psychotherapie	94,43%	5,00%	0,57%
Psychosomatische Medizin	95,65%	3,87%	0,48%
Humangenetik	98,74%	0,58%	0,68%
Psychiatrie	99,35%	0,54%	0,11%
Hausärztinnen/-ärzte	99,54%	0,22%	0,24%
Sonstige	99,70%	0,24%	0,06%
Physikalische/Rehab. Medizin	99,72%	0,12%	0,16%
Anästhesiologie	99,73%	0,22%	0,06%
Labor	99,81%	0,18%	0,01%
Neurologie/Nervenheilkunde	99,82%	0,12%	0,06%
Gynäkologie	99,83%	0,09%	0,08%
Orthopädie	99,83%	0,05%	0,12%
Kinder- und Jugendmedizin	99,86%	0,12%	0,02%
HNO und Phoniatrie	99,87%	0,02%	0,10%
Urologie	99,91%	0,04%	0,05%
Chirurgie	99,92%	0,04%	0,04%
Dermatologie	99,92%	0,03%	0,05%
Innere Medizin	99,92%	0,05%	0,03%
Strahlentherapie	99,97%	0,03%	0,00%
Augenheilkunde	99,98%	0,00%	0,02%

Im Bereich der Psychotherapie wurden im Jahr 2023 in ca. 5 % der Behandlungsfälle die Versicherten (Jahr 2022: 7,7 %) mittels Videosprechstunde (GOP 01450) in Kombination mit einem persönlichen Kontakt und in 0,57 % (Jahr 2022: 1,1 %) der Behandlungsfälle ausschließlich über die Videosprechstunde behandelt (Tabelle 9). Der in Kapitel 2.8 des Berichts erkennbare Rückgang der Abrechnungshäufigkeit der Videosprechstunde im Bereich der Psychotherapie lässt sich damit auch anhand des Rückganges der Anzahl der Behandlungsfälle nachvollziehen. Insbesondere der Anteil an ausschließlichen Videobehandlungsfällen hat sich hier fast halbiert. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei der Psychosomatik mit einem Rückgang der „kombinierten“ Behandlungsfälle auf ca. 3,87 % (Jahr 2022: 6,12 %) und einem Rückgang der ausschließlich per Video durchgeführten Behandlungsfälle auf 0,48 % (Jahr 2022: 0,9 %).

Bei allen anderen Fachgruppen liegt der Anteil der Behandlungsfälle mit einem Videokontakt oder der Anteil der ausschließlichen Videobehandlungsfälle weiterhin deutlich unter 1 %. Selbst bei Fachgruppen wie der Psychotherapie oder Psychosomatik – bei denen, wie in Kapitel 2.8 des Berichts ausgeführt, ca. 40-50 % der Ärztinnen/Ärzte bzw. Therapeutinnen/Therapeuten Videosprechstunden prinzipiell durchführen – wird damit der weit überwiegende Anteil der Behandlungsfälle weiterhin im persönlichen Kontakt durchgeführt.

Bemerkenswert ist das Verbleiben der „kombinierten“ Behandlungsfälle (persönlicher- und Video-Kontakt) bei den Hausärztinnen/-ärzten auf einem ähnlichen Niveau um 0,22 % wie im Vorjahr 2022 (0,23 %). Die ausschließlichen Videobehandlungsfälle bei Hausärzten/-ärztinnen verdoppelten sich auf 0,24 % (Jahr 2022: 0,12 %). Durch die hohe Anzahl an Behandlungsfällen bei Hausärztinnen/-ärzten wirkt sich dies deutlich in absoluten Zahlen aus und hat wesentlich zu dem Anstieg der ausschließlichen Videobehandlungsfällen im Jahr 2023 beigetragen – trotz des erfolgten Rückganges in anderen Fachgruppen.

2.11 Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten mit Inanspruchnahme von Leistungen im Rahmen der Videosprechstunde

Betrachtet man die Alters- und Geschlechtsstruktur des Versichertenkollektivs, für das die Videosprechstunde (GOP 01450) im Jahr 2023 abgerechnet wurde, zeigt sich folgende Verteilung (Abbildung 7):

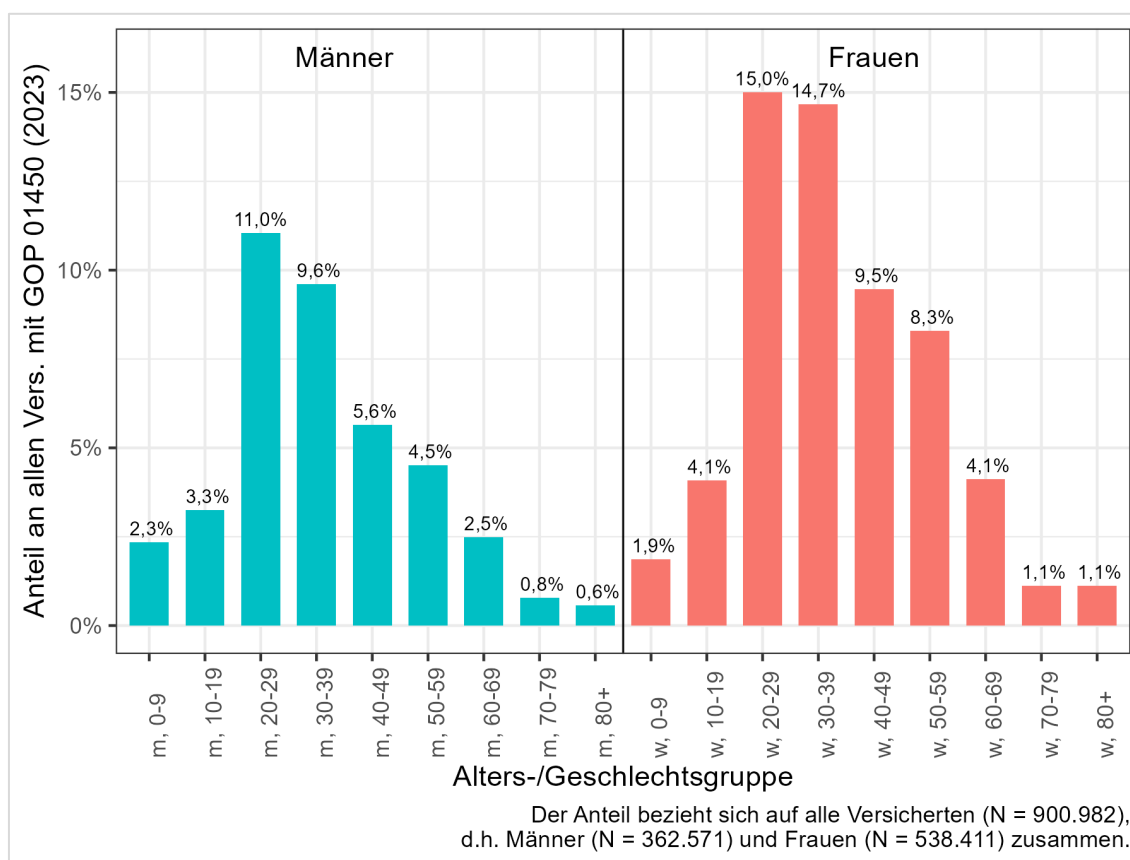


Abbildung 7 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten, bei denen die Videosprechstunde (GOP01450) im Jahr 2023 abgerechnet wurde; m = männlich, w = weiblich.

Abbildung 7 zeigt, dass die Videosprechstunde relativ häufig von Versicherten im jungen bis mittleren Erwachsenenalter (20 bis 59 Jahre) in Anspruch genommen wird und dass der Anteil

der Frauen in diesen Altersgruppen durchgängig höher ausfällt als der Anteil der männlichen Versicherten. So wurden fast 30 % der Videosprechstunden im Rahmen der Behandlung von weiblichen Versicherten zwischen einem Alter von 20 und 39 Jahren durchgeführt.

Gegenüber dem Jahr 2022 stellten sich die Anteile der Versicherten mit erhaltener Videosprechstunde in den höheren Altersgruppen ab einem Alter von 60 Jahren bei beiden Geschlechtern faktisch unverändert dar. Eine Zunahme des Anteils zeigten hingegen die Gruppen der Frauen im Alter von 20 bis 29 Jahren mit 15 % (2022: 14 %), die Gruppe der Männer im Alter vom 20 bis 29 Jahren mit 11 % (2022: 9 %) und der Männer im Alter von 30 bis 39 Jahren mit ca. 10 % (2022: ca. 9 %). Insgesamt stieg der Anteil der Männer von ca. 38 % im Jahr 2022 auf ca. 40 % im Jahr 2023 an.

2.11.1 Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten in Bezug auf einzelne Leistungsbereiche der Videosprechstunde

Die Alters- und Geschlechtsverteilung der Versicherten auf die verschiedenen Leistungsbereiche der Videosprechstunde zeigen die folgenden Auswertungen in Abbildung 8 bis Abbildung 11. Alle Versicherten mit Inanspruchnahme einer Videosprechstunde aus einem der Leistungsbereiche wurden hinsichtlich ihres Alters und Geschlechtes eingruppiert. Der Anteil der jeweiligen Alters- und Geschlechtsgruppe an allen Videosprechstunden wird dabei mit einem türkisfarbenen Balken, während der Anteil der betreffenden Alters- und Geschlechtsgruppe an allen Leistungen dieses Leistungsbereiches (unabhängig von der Durchführung als Videosprechstunde) als graue Säule dargestellt ist. Durch Vergleich der beiden Verhältnisse zueinander lassen sich Rückschlüsse auf die Möglichkeit und Präferenz der Inanspruchnahme einer Leistung im persönlichen Kontakt oder im Rahmen einer Videosprechstunde bei verschiedenen Alters- und Geschlechtsgruppen ziehen. Die Analysen ergänzen damit die Analyse zu der Videosprechstunde (GOP 01450) im Allgemeinen.

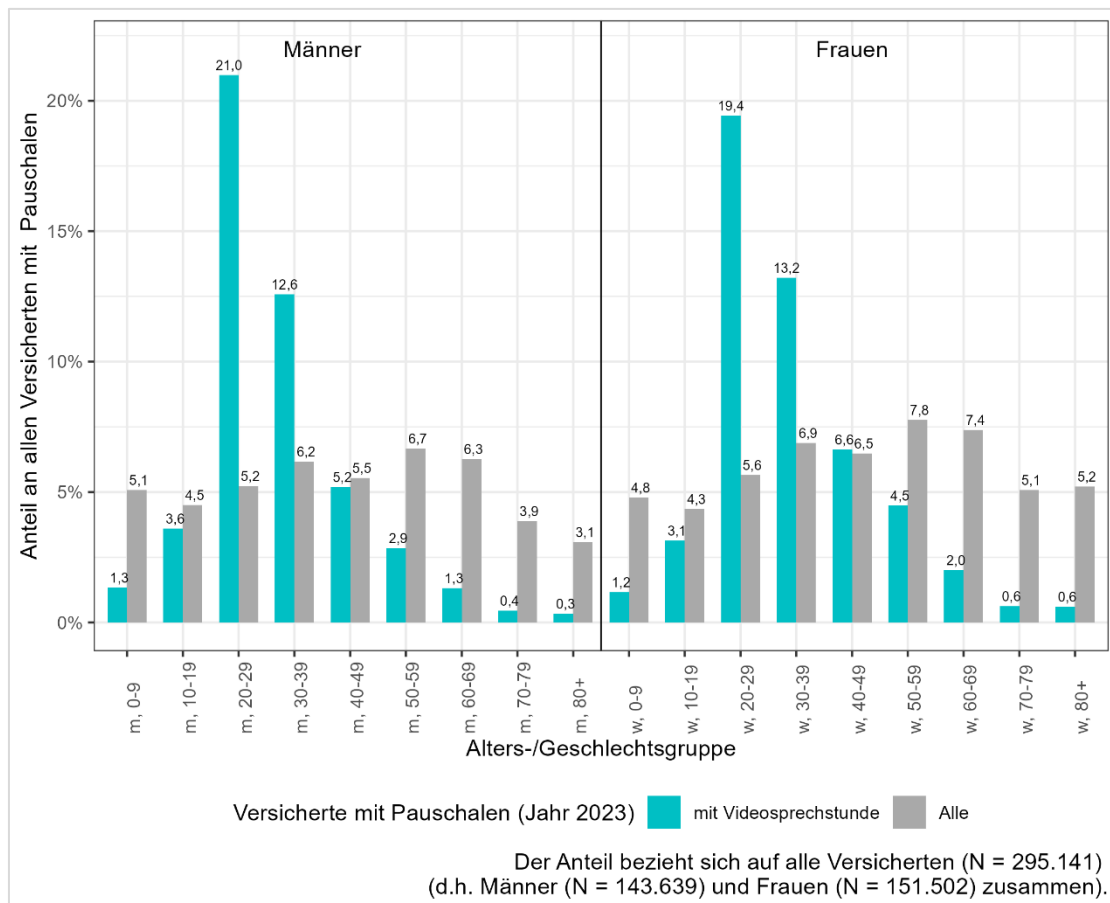


Abbildung 8 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten bei den Versicherten-, Grund- und Konsiliarpauschalen. Die türkisfarbenen Balken zeigen den Anteil, den diese Altersgruppe dieses Geschlechts an allen Pauschalen hatte, die ausschließlich per Video erbracht wurden. Die grauen Balken zeigen den entsprechenden Anteil bei allen erbrachten Pauschalen (unabhängig von der Durchführung als Videosprechstunde).

In Abbildung 8 ist für das Jahr 2023 ersichtlich, dass 295.141 Versicherte ausschließlich mittels Video behandelt wurden – eine Steigerung von ca. 15 % gegenüber dem Jahr 2022 (257.619 Versicherte). Wie im Jahr 2022 fanden – sowohl bei Männern als auch bei Frauen – weiterhin in den jüngeren Altersklassen (20 bis 29 Jahre und 30 bis 39 Jahre) im Verhältnis überdurchschnittlich viele ausschließliche Videobehandlungen statt. Mit dem Anstieg an Versicherten war eine Verschiebung der Anteile in den Altersgruppen der Versicherten erkennbar:

So sank z. B. der Anteil der Gruppe der männlichen Versicherten im Alter von 50 bis 59 Jahren von 3,9 % im Jahr 2022 auf 2,9 % im Jahr 2023. Auch der Anteil der weiblichen Versicherten im Alter von 50 bis 59 Jahren sank auf 4,5 % ab – im Jahr 2022 entfielen noch ca. 7 % aller Videosprechstunden auf diese Gruppe. Die Gruppe der Männer im Alter von 20 bis 29 Jahren und 30 bis 39 Jahren steigerten ihren ungefähren Anteil hingegen von 16 % bzw. 12 % im Jahr 2022 auf 21 % bzw. 13 % im Jahr 2023. Auch die Gruppe der Frauen im Alter von 20 bis 29 Jahren nahm verhältnismäßig von ca. 17 % im Jahr 2022 auf ca. 19 % im Jahr 2023 zu. Mit der gestiegenen Anzahl an ausschließlichen Videobehandlungsfällen vom Jahr 2022 auf das Jahr 2023 wurde somit ein im Verhältnis jüngeres Patientenkollektiv versorgt.

Weitere durchgeführte Analysen zeigen Abbildung 9 bis Abbildung 11:

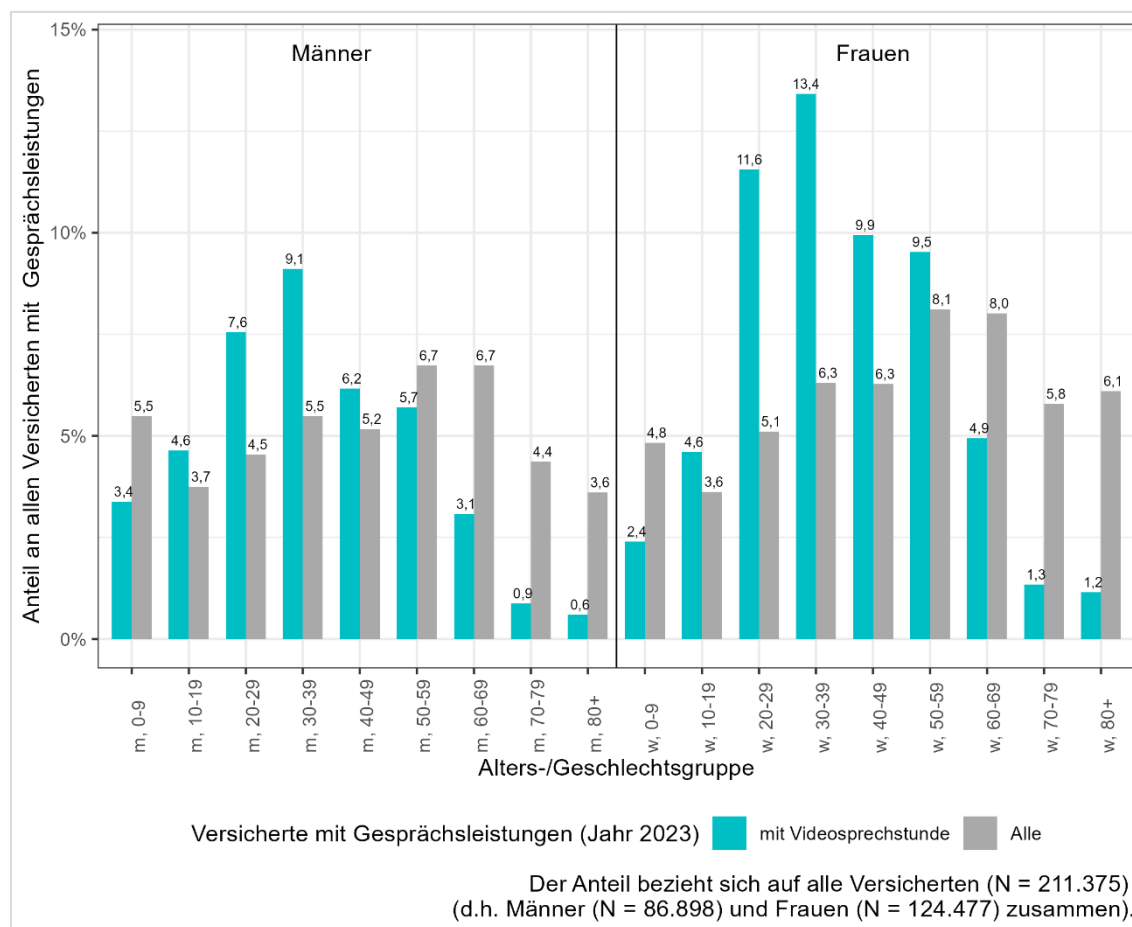


Abbildung 9 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten bei der Inanspruchnahme von Gesprächsleistungen. Die türkisfarbenen Balken zeigen den Anteil, den diese Altersgruppe dieses Geschlechtes an allen Gesprächsleistungen hatte, die per Video durchgeführt wurden. Die grauen Balken zeigen den entsprechenden Anteil bei allen durchgeführten Gesprächsleistungen (unabhängig von der Durchführung als Videosprechstunde).

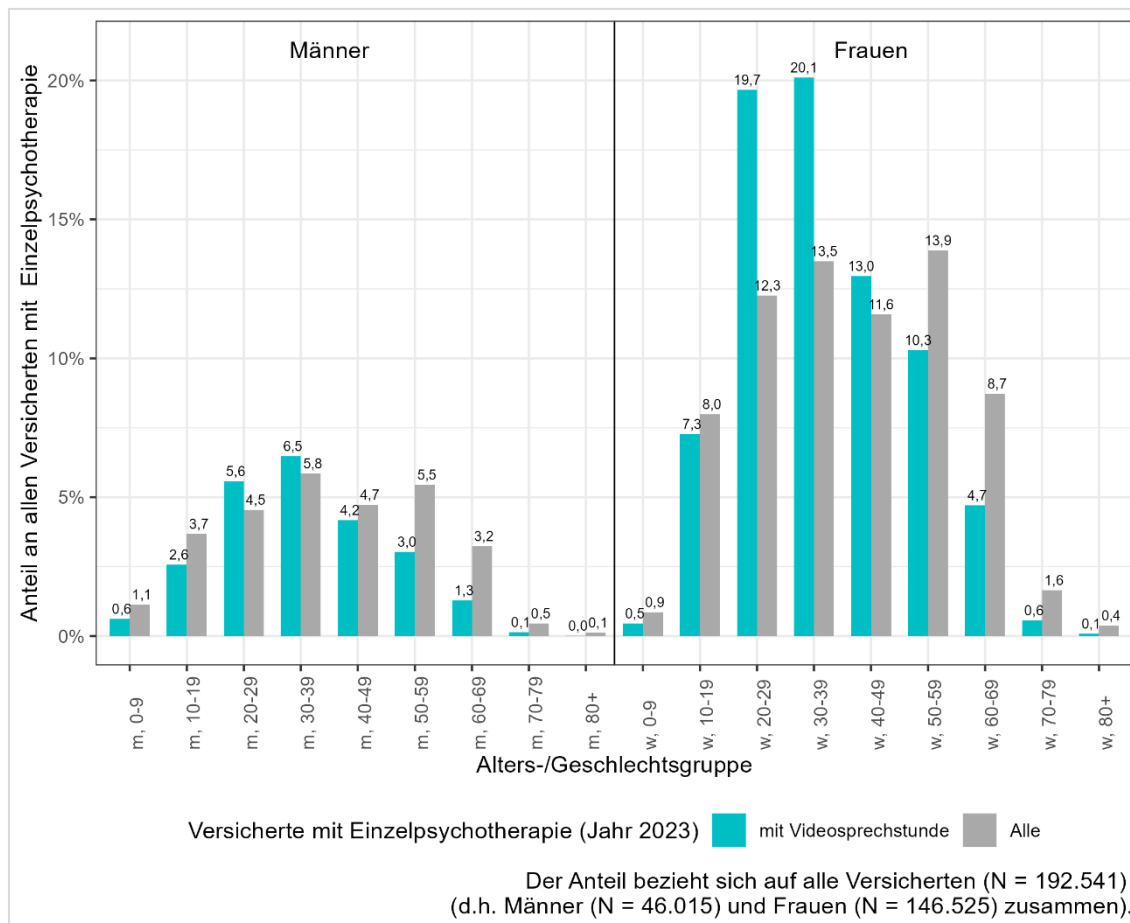


Abbildung 10 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten bei der Inanspruchnahme von Einzelpsychotherapien (antragspflichtige Psychotherapie). Die türkisfarbenen Balken zeigen den Anteil, den diese Altersgruppe dieses Geschlechtes an allen Einzelpsychotherapien hatte, die per Video erbracht wurden. Die grauen Balken zeigen den entsprechenden Anteil bei der Einzelpsychotherapie (unabhängig von der Durchführung als Videosprechstunde).

Sowohl bei den Gesprächsleistungen (Abbildung 9) als auch bei der Einzelpsychotherapie (Abbildung 10) und der Gruppenpsychotherapie (Abbildung 11) lässt sich folgendes feststellen:

Die Gruppe der weiblichen Versicherten weist bei den betrachteten Leistungen häufig einen höheren Anteil an der Inanspruchnahme insgesamt auf. In den Altersgruppen im Alter von 20 bis 39 Jahren zeigt sich bei beiden Geschlechtern eine überdurchschnittliche Inanspruchnahme der Videosprechstunde gegenüber ihrem Anteil bei der Inanspruchnahme im persönlichen Kontakt – bei weiblichen Versicherten ist dieser Befund sogar häufig bis in höhere Altersklassen (bis zum Alter von 49 oder sogar bis zu 59 Jahren) erkennbar.

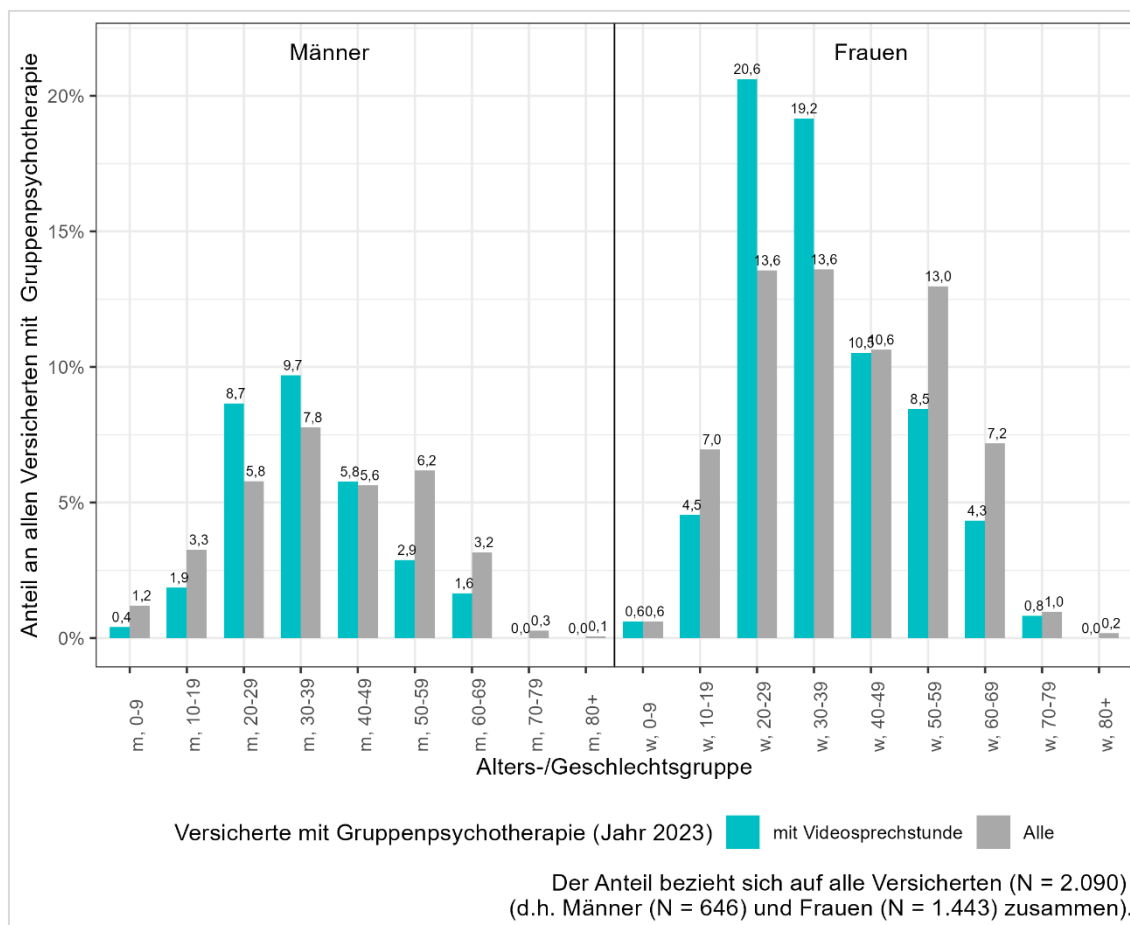


Abbildung 11 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten bei der Inanspruchnahme der Gruppenpsychotherapie. Die türkisfarbenen Balken zeigen den Anteil, den diese Altersgruppe dieses Geschlechtes an allen Gruppenpsychotherapien, die per Video erbracht wurden, hatte. Die grauen Balken zeigen die entsprechende Verteilung bei der Gruppenpsychotherapie (unabhängig von der Durchführung als Videosprechstunde).

Absolute Inanspruchnahme einzelner Leistungsbereiche der Videosprechstunde

Es wurden für die o. g. Gruppen an Leistungen auch Analysen zur direkten Betrachtung des Anteils von Versicherten mit (mindestens einmaliger) Inanspruchnahme der Videosprechstunde bezüglich der betreffenden Leistung durchgeführt (z. B. im Sinne des Quotienten von Versicherten mit (mindestens einmaliger) Gesprächsleistung per Video/alle Versicherten mit Gesprächsleistungen). Da die Videosprechstunde weiterhin oft nur in einem Bruchteil aller Leistungsfälle genutzt wird, ergaben sich hier je nach Subgruppe zumeist sehr geringe Zahlen. Einen prozentual erfassbaren Anteil stellten im Jahr 2023 jedoch z. B. die 20- bis 29-jährigen und 30- bis 39-jährigen Versicherten bei den Gesprächsleistungen:

In diesen Altersgruppen lag der Anteil von Versicherten mit Inanspruchnahme mind. einer per Videosprechstunde durchgeführten Gesprächsleistung bei ca. 1 %. Der Prozentsatz bei den weiblichen Versicherten lag dabei leicht höher (20 bis 29 Jahre: 1,2 %, 30 bis 39 Jahre: 1,1 %) als bei männlichen Versicherten (20 bis 29 Jahre und 30 bis 39 Jahre: jeweils 0,9 %). Ein noch höherer Anteil ergab sich bei den Gruppentherapien – hier nahmen ca. 2,5 % der Versicherten mit

Gruppentherapie in den Altersgruppen 20 bis 49 Jahre an mindestens einer Gruppentherapie-Sitzung per Videosprechstunde teil. Im Jahr 2022 betrug dieser Anteil noch 4-5 %.

Die höchsten Werte ergaben sich jedoch bei den (antragspflichtigen) Psychotherapien (Abbildung 12):

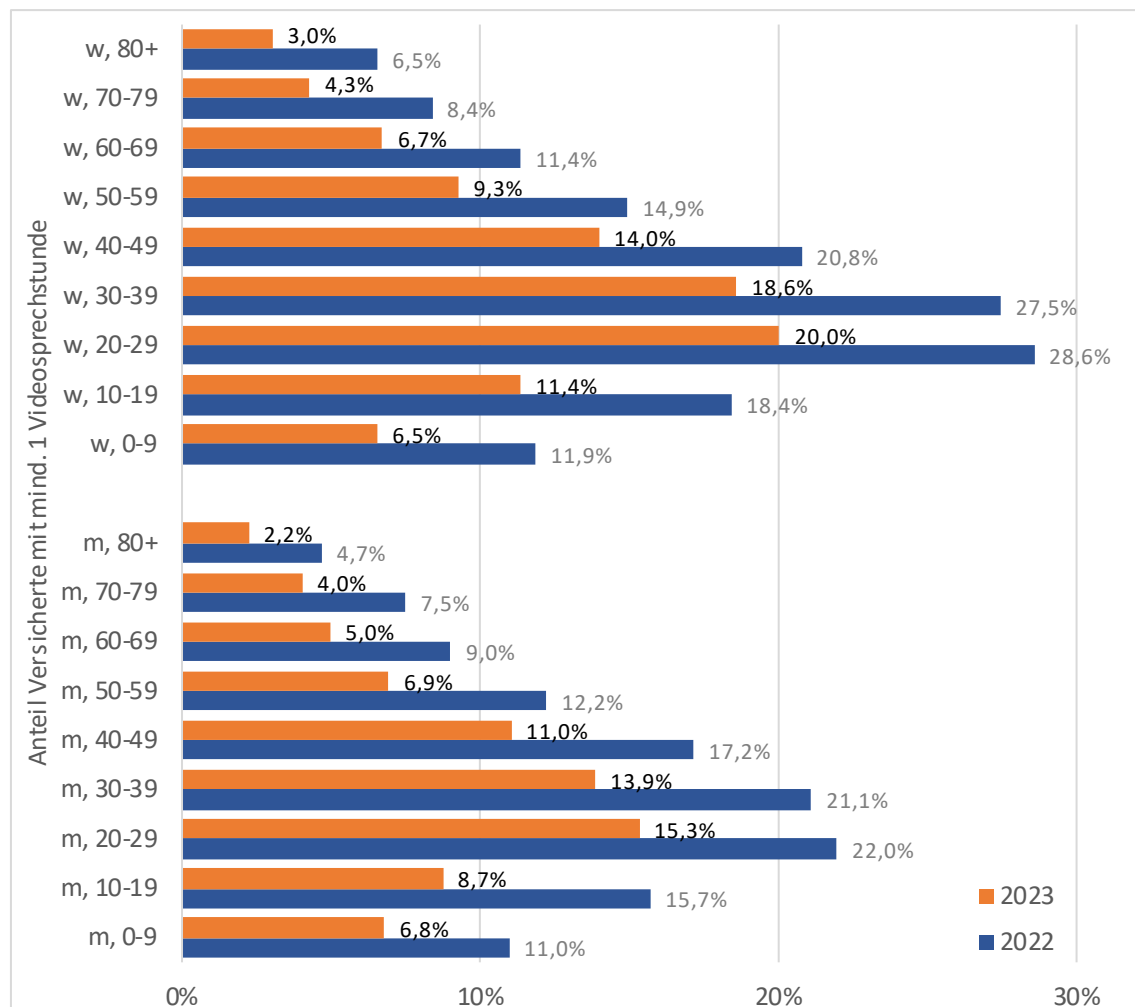


Abbildung 12 Anteil der Versicherten mit Inanspruchnahme von mindestens einer Videosprechstunde im Rahmen einer Psychotherapie an allen Versicherten mit Inanspruchnahme einer Psychotherapie im Jahr 2022 und 2023. m=männlich, w=weiblich.

Nach Abbildung 12 nahmen im Jahr 2023 im Rahmen ihrer (antragspflichtigen) Psychotherapie 20 % aller weiblichen Versicherten zwischen 20 und 29 Jahren an Psychotherapiesitzungen per Videosprechstunde teil. Diese Werte unterstreichen die Bedeutung des Mediums Videosprechstunde im Rahmen von schwerpunktmäßig gesprächsbasierten (Psycho-)Therapien, insbesondere in der Gruppe der jüngeren Erwachsenen. Die Werte des Jahres 2023 (orangefarben) zeigen sich jedoch in allen Alters- und Geschlechtergruppen deutlich reduziert gegenüber dem Jahr 2022. Damit scheinen ausschließliche Therapie-Sitzungen in Präsenz mit dem Wegfall der Corona-Sonderregeln nach dem 1. Quartal 2022 wieder eine starke Bedeutung erhalten zu haben.

2.11.2 Betrachtung der Morbidität von Versicherten für ausgewählte Inanspruchnahmen der Videosprechstunde

Über Morbiditätsanalysen kann die Bedeutung und die Funktion der Videosprechstunde im Versorgungsprozess von Patientinnen und Patienten genauer eingeordnet werden. Mit den zur Verfügung stehenden Daten unterliegen diese jedoch deutlichen Einschränkungen. So liegen keine direkten Daten zu Inhalt oder Anlass einer Videosprechstunde vor. Die Daten über Leistungen und Diagnosen sind stattdessen auf Ebene eines Behandlungsfalls – und damit eines Quartals – aggregiert. Durchgeführte Leistungen und Diagnosen können damit insbesondere bei fehlender Kennzeichnung der Videosprechstunde und bei mehrfachem Patientenkontakt in einem Quartal nicht verlässlich dem Behandlungsinhalt einer Videosprechstunde zugeordnet werden.

Allgemeingültige Ergebnisse sind bei einer Analyse der Videosprechstunde insgesamt auch dadurch erschwert, dass die Gruppe der Versicherten mit Inanspruchnahme einer Videosprechstunde eine große Heterogenität von vielen jüngeren Erwachsenen zu wenig Älteren einerseits und vielen Gesprächsleistungen zu wenig somatischen Leistungen andererseits aufweist. Daher wird auf Subgruppen-Analysen zurückgegriffen, z. B. auf Ebene der (fachgruppenspezifischen) Behandlungsfälle. Bei Analysen von insbesondere kleinen Subgruppen muss bedacht werden, dass die Unschärfe durch die Verwendung einer (Geburtsjahrs-)Stichprobe mit lediglich ca. 23 % der Versicherten – von welcher auf die Grundgesamtheit hochgerechnet wird – zunimmt.

Für die Morbiditätsanalyse wurde folgendermaßen vorgegangen: Für alle Versicherten mit Abrechnung einer Videosprechstunde (GOP 01450) wurden die Diagnosen für den Behandlungsfall erhoben, in dessen Rahmen die Videosprechstunde erfolgte. Anschließend wurden die Diagnosenlisten um die Diagnosen bereinigt, die in einem ähnlich hohen Anteil auch bei der Gesamtheit der Behandlungsfälle verschlüsselt werden. Die häufigsten 10 Diagnosen, deren Anteil bei den Behandlungsfällen mit Videokontakt mehr als doppelt so häufig wie bei der Gesamt-Vergleichsgruppe auftraten, wurden berücksichtigt.

Die genauen Ergebnisse sind in Tabelle 59 im Anhang ersichtlich. Diese enthält viele überproportional angegebene ICD-Kodes für akute Infektionserkrankungen, wie Rhinitiden, Infektionen der oberen Atemwege/COVID-19 oder Gastroenteritiden bei Versicherten mit Videosprechstunde. Diese Angaben traten auch bei Fachgruppen auf, die diese Erkrankungen nicht schwerpunktmäßig behandeln. Eine z. B. vorliegende akute Erkältung/Infektion mit ggf. vorliegender häuslicher Isolation des Versicherten war dabei mutmaßlich Ursache, aber nicht der Grund für die Inanspruchnahme einer Leistung per Videosprechstunde.

Tabelle 10 gibt die Ergebnisse der Tabelle 59 in manuell grob abstrahierter Form für die wichtigsten Fachgruppen an. Dabei wurden o.g. typische Erkältungsangaben bei Fachgruppen, die diese nicht primär behandeln, nicht berücksichtigt.

Tabelle 10 Krankheitsspektrum auf Grundlage von überproportional häufig vorliegenden ICD-Diagnosen im Behandlungsfall bei Versicherten mit Inanspruchnahme einer Videosprechstunde.

Fachgruppe	Überproportional häufige Diagnosen
Psychotherapie	normales Behandlungsspektrum/kein Unterschied
Psychiatrie	Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen, Lese/Rechtsschreibschwäche, soziale Phobien
Psychosomatik	Panikstörung, posttraumatische Belastungsstörung
Hausärztinnen/-ärzte	Infektion obere Atemwege, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen
Kinder-/Jugendm.	Infektionen obere Atemwege, atopisches Ekzem, Dermatitis, Konjunktivitis
Innere Medizin	chronische Schmerzen, Infektionen obere Atemwege, Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom, Chemotherapie, Polyarthrit
Gynäkologie	Sterilität, Fertilitätsberatungen, Harnwegsinfekt, Menstruationsbeschwerden, Kopfschmerzen
Neurologie/ Nervenheilkunde	Migräne/Kopfschmerz, Anpassungsstörungen, depressive Episode, Multiple Sklerose, chronische Schmerzen
Orthopädie	Kopfschmerzen, Rückenschmerzen; Myalgien, Migräne
Urologie	Akute Zystitis/Harnwegsinfekt, Impotenz, Fertilisationsberatung
HNO/Phoniatrie	Infektion obere Atemwege, Hals-/Kopfschmerzen, Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom
Dermatologie	Akne, seborrhoisches Ekzem, Periorale Dermatitis, Rosazea, Lipödem, Allergie
Chirurgie	Karpaltunnel-Syndrom, Malabsorptionssyndrom, Vorhauthypertrophie, Phimose
Augenheilkunde	Glaukom, Spannungskopfschmerz, Migräne, Konjunktivitis

Insbesondere im Fachgebiet der Psychotherapie ließen sich keine oder nur geringe Unterschiede zwischen dem Diagnosespektrum von Versicherten mit Inanspruchnahme einer Videosprechstunde im Behandlungsfall und dem üblichen Diagnosespektrum aller Behandlungsfälle eruieren (Tabelle 10). Bei allen anderen Fachgruppen ist die Behandlung der extrahierten überproportional verschlüsselten ICD-Erkrankungen im Rahmen einer Videosprechstunde durchaus plausibel.

2.12 Authentifizierungen im Rahmen von Videosprechstunden

Zur Feststellung der Identität der Versicherten erfolgt bei Versicherten, die der Einrichtung unbekannt sind, vor einer Videosprechstunde eine Authentifizierung (siehe hierzu Kapitel 2.2 des Berichts). Der Aufwand dieser bisher händisch durchgeführten Authentifizierung mittels in die Kamera gehaltener Versichertenkarte wird seit Ende 2019 mit der GOP 01444 vergütet. Die jährliche Entwicklung dieser Leistung zeigt Abbildung 13.

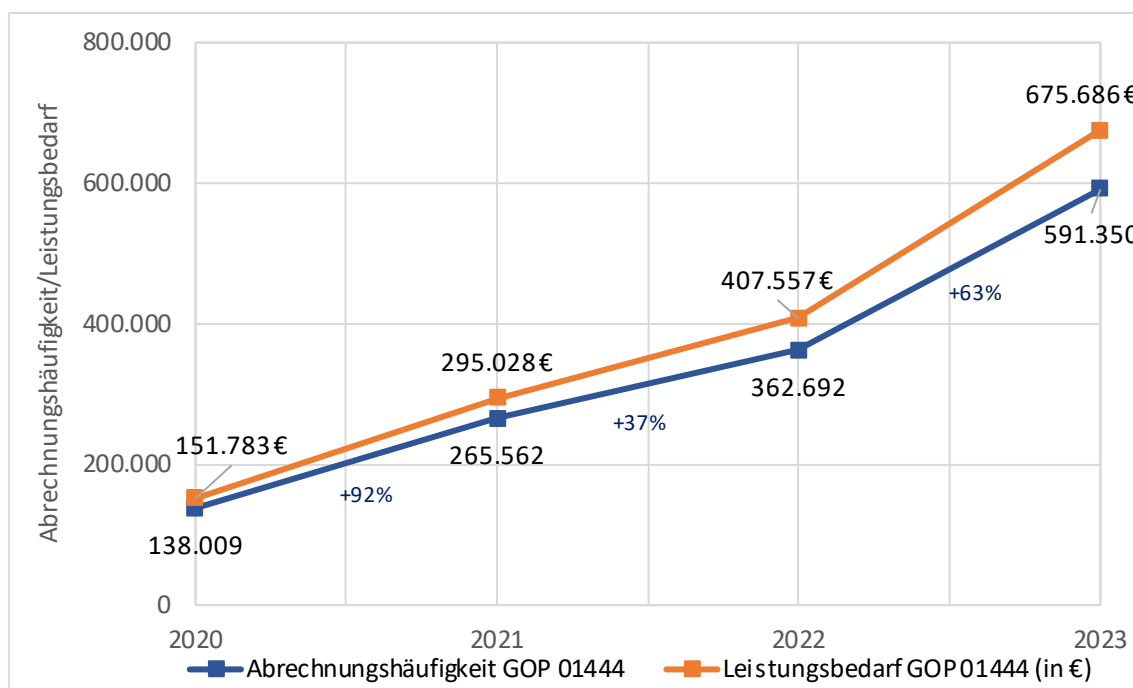


Abbildung 13 Abrechnungshäufigkeit (AH) und Leistungsbedarf in € (LB) der Authentifizierung eines unbekannten Versicherten im Rahmen der Videosprechstunde über die GOP 01444. Dargestellt sind die Jahre 2020-2023.

Die Authentifizierungsleistung zeigte eine kontinuierliche Steigerung der Abrechnungshäufigkeit über die Jahre (Abbildung 13). Im Jahr 2023 wurden ca. 591.000 Authentifizierungen durchgeführt – ein Anstieg von 63 % gegenüber dem Jahr 2022 (ca. 363.000).

Der Leistungsbedarf der GOP 01444 zeigte einen sehr ähnlichen Verlauf und ähnliche Dimensionen, da er mit 10 Punkten bei etwas mehr als 1 € pro Authentifizierung bewertet ist.

Auf eine graphische Darstellung der Abrechnungshäufigkeit pro Quartal wurde verzichtet; die Werte finden sich in Tabelle 53 im Anhang.

Anteil der notwendigen Authentifizierungen bei einem Videokontakt

Das prozentuale Verhältnis der Abrechnung der GOP 01444 zur Abrechnung der GOP 01450 liefert den prozentualen Anteil der Videosprechstunden, bei denen eine Authentifizierung eines Versicherten notwendig ist (Abbildung 14).

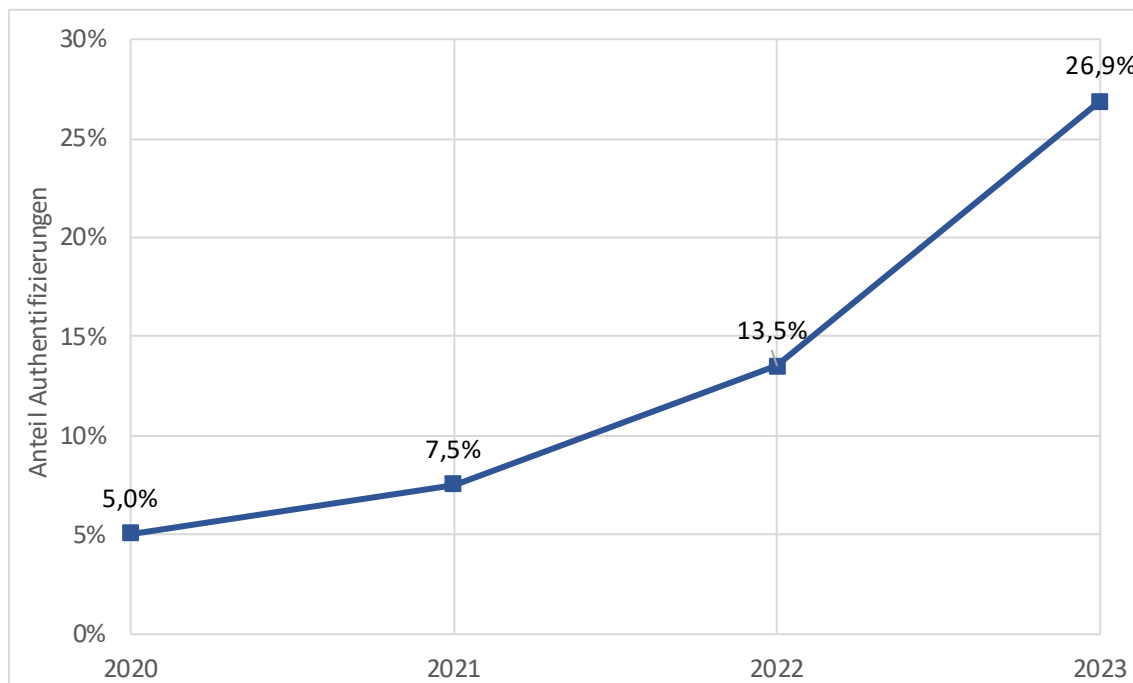


Abbildung 14 Verhältnis von Authentifizierung zur Videosprechstunde. Dargestellt ist der prozentuale Anteil der Abrechnungshäufigkeit der GOP 01444 an der Abrechnungshäufigkeit der GOP 01450 in den Jahren 2020-2023.

Abbildung 14 zeigt, dass bei einem wachsenden Anteil der Videosprechstunden eine vorangehende Identifizierung des Versicherten notwendig war. So war im Jahr 2023 bei ca. 27 % der Videosprechstunden eine vorangehende Authentifizierung vonnöten. Von einer Substitution durch andere Authentifizierungsmöglichkeiten ist auch im Jahr 2023 noch nicht auszugehen.

Der Anstieg der Authentifizierung über die – in die Kamera gehaltene – Versichertenkarte sprach im Jahr 2023 eher weniger für eine sich bereits etablierende digitale Authentifizierung der Versicherten.

Die Authentifizierungsleistung der GOP 01444 wurde mit dem Beschluss aus der 669. Sitzung des BA bis Ende 2025 verlängert – bis digitale Identitäten als Versicherungsnachweis ab dem 1. Januar 2026 flächendeckend dienen können.

Die Abrechnungshäufigkeit der Authentifizierung in Bezug auf die unterschiedlichen KV-Bezirke in absoluten und in normierten Zahlen (je 100.000 Versicherte) ist im Anhang in Tabelle 60 ersichtlich.

3 Videofallkonferenzen

3.1 Allgemeine Erläuterungen

Begrifflichkeiten

Abzugrenzen von der Videosprechstunde sind Videofallkonferenzen. Diese dienen funktional als Besprechungen zwischen mehreren Ärztinnen und Ärzten oder zwischen Ärztinnen oder Ärzten und Pflegekräften bzw. nichtärztlichem Fachpersonal, mit oder ohne Anwesenheit der/des Versicherten.

3.2 Regelungen und Vergütung im EBM

Mit dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 435. Sitzung wurde die Durchführung von Fallkonferenzen zwischen Vertragsärztinnen oder Vertragsärzten und Pflegekräften im Rahmen der Versorgung von Pflegebedürftigen ab dem zweiten Quartal 2019 erstmalig auch als Videokonferenz ermöglicht. Die entsprechenden Gebührenordnungspositionen (GOP 37120: Fallkonferenz im Pflegeheim; GOP 37320: Fallkonferenz Palliativversorgung) wurden hierfür angepasst. Im Verlauf wurden weitere Fallkonferenzen um diese Möglichkeit erweitert (Tabelle 11):

Tabelle 11 Durchführbarkeit von Fallkonferenzen per Video; MRSA = methicillinresistenter Staphylococcus aureus. Die grau gefärbte GOP 37550 betrifft den intersektoralen Versorgungsbereich und ist der Vollständigkeit halber aufgeführt.

GOP	Bezeichnung	Beschluss	Ab	Bewertung
37120	Fallkonferenz im Pflegeheim	435. BA	2/2019	64 Punkte; ab 2/2020: 86 Punkte
37320	Fallkonferenz in der Palliativversorgung	435. BA	2/2019	64 Punkte; ab 2/2020: 86 Punkte
01442	Videofallkonferenzen zwischen Pflegekräften von chronisch pflegebedürftigen Versicherten und koordinierenden Ärztinnen/Ärzten/Psychotherapeutinnen/-therapeuten	453. BA	4/2019	64 Punkte; ab 2/2020: 86 Punkte
30210	Multidisziplinäre Fallkonferenz zur Indikationsüberprüfung einer hyperbaren Sauerstofftherapie bei Versicherten mit diabetischem Fußsyndrom	453. BA	4/2019	64 Punkte; ab 2/2020: 86 Punkte
30706	Schmerztherapeutische Fallkonferenz	453. BA	4/2019	60 Punkte; ab 2/2020: 86 Punkte
30948	MRSA-Fall- und/oder regionale Netzwerkkonferenz	453. BA	4/2019	46 Punkte; ab 2/2020: 86 Punkte
37400	Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase	453. BA	4/2019	100 Punkte
37720	Fallkonferenz gemäß § 12 Abs. 2 der AKI-RL	617. BA	4/2022	86 Punkte
01682	Fallbesprechung Kinder- und Jugendschutz	702. BA	1/2024	128 Punkte (je vollendete 10 min)
37550	Fallbesprechung gemäß § 6 KSVPsych-RL	6. ergEBA	4/2022	128 Punkte (je vollendete 10 min)

In Tabelle 11 sind viele Fallkonferenzen ersichtlich, die im Jahr 2019 für die Durchführung per Video geöffnet wurden. Darüber hinaus wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 (453. Sitzung des BA) mit der GOP 01442 die Abrechnung einer Videofallkonferenz mit Pflegekräften von Pflegebedürftigen, die in der Häuslichkeit oder in beschützenden Einrichtungen versorgt werden, ermöglicht. Bei fast allen Fallkonferenzen wurde mit dem 2. Quartal 2020 eine Bewertungsanpassung auf 86 Punkte vorgenommen. Zuletzt kamen mit einem Beschluss aus der 617. Sitzung des BA¹⁷ eine Fallkonferenz im Rahmen der AKI-RL, mit dem Beschluss aus der 6. Sitzung des ergEBA¹⁸ eine Fallbesprechung gemäß § 6 KSVPsych-RL (GOP 37550) und mit dem Beschluss aus der 702. Sitzung des BA¹⁹ eine Fallbesprechung im Kinder- und Jugendschutz hinzu (GOP 01682). Die Fallbesprechung nach GOP 37550 wird als prinzipiell sektorenübergreifende Fallbesprechung in Teil B des Berichts behandelt (siehe Kapitel 16 des Berichts).

Der im Rahmen einer Videofallkonferenz ebenfalls berechnungsfähige Technikzuschlag (GOP 01450) darf nur von der Ärztin oder dem Arzt bzw. der Psychotherapeutin oder dem Psychotherapeuten abgerechnet werden, die/der die Videofallkonferenz initiiert. Eine Videofallkonferenz darf ebenso wie eine Videosprechstunde nur mithilfe eines nach Anlage 31b zum BMV-Ä²⁰ zertifizierten Videodienstanbieters durchgeführt werden.

Beschlüsse zu Videofallkonferenzen im Berichtszeitraum

Im Berichtsjahr 2023 wurden hinsichtlich der Videofallkonferenzen folgende Beschlüsse gefasst (Tabelle 12):

Tabelle 12 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zu Videofallkonferenzen, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden. MGv = morbiditätsbedingte Gesamtvergütung.

Kategorie	Beschluss	Inkrafttreten	Inhalt/GOP	Laufzeit/Befristung
Finanzierung	617. BA	01.01.2023	Vergütung GOP 01442 außerhalb der MGv (aufbauend auf 453., 570., 610. BA)	31.12.2023
Finanzierung	664. BA	01.01.2024	Vergütung Videofallkonferenz GOP 01442 außerhalb der MGv	31.12.2024
Neue Leistung	702. BA	01.01.2024	Neue Leistung GOP 01682 (Fallbesprechung mit dem Jugendamt (Kinder- und Jugendschutz)) per Video berechnungsfähig	Nein

¹⁷ Siehe [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 617. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

¹⁸ Siehe [Beschluss](#) des ergänzten Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 6. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

¹⁹ Siehe [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 702. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

²⁰ Siehe [Vereinbarung](#) über die Anforderungen an die technischen Verfahren zur Videosprechstunde (BMV-Ä Anlage 31b): Anforderungen an die technischen Verfahren zur Videosprechstunde vom 21. Oktober 2016 in der Fassung vom 15. Juni 2022 – Kassenärztliche Bundesvereinigung (kbv.de).

Mit den Beschlüssen aus der 617. und 664. Sitzung des BA, welche die Finanzierungsregelung außerhalb der MGV zusammentragen, erfolgte die Finanzierung der Leistung nach GOP 01442 auch für das Jahr 2023 und 2024 außerhalb der MGV. Mit dem Beschluss aus der 702. Sitzung des BA wurde die GOP 01682 für eine (auch) per Video durchführbare Fallbesprechung im Kinder- und Jugendschutz geschaffen (Tabelle 12).

3.3 Leistungsentwicklung

Die Auswertung der Abrechnungshäufigkeit von Fallkonferenzen ist lediglich für die Videofallkonferenz (GOP 01442) möglich (Abbildung 15). Aussagen zu der Leistungsentwicklung der GOP 30706, 30948, 37120, 37320, 37400, 30210 und 37720 (wie sie in Tabelle 11 aufgeführt sind) als Videofallkonferenz sind nicht verfügbar, da hierzu die spezifische Kennzeichnung in den Daten fehlt.

Videofallkonferenz GOP 01442

Der deutliche Rückgang der Abrechnungshäufigkeit und des Leistungsbedarfes bei der GOP 01442 wird insbesondere in der Jahresstatistik (Tabelle 13) ersichtlich:

Tabelle 13 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € in den Jahren 2020 bis 2023 für die GOP 01442. In Klammern ist die Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit in % im Vergleich zum Vorjahr angegeben.

	2020	2021	2022	2023
Abrechnungshäufigkeit	22.508	13.803 (-39%)	10.327 (-25%)	8.760 (-15%)
Leistungsbedarf	208.138	132.126	100.082	86.511

In Abbildung 15 ist der Verlauf der Abrechnungshäufigkeit der GOP 01442 pro Quartal für das Jahr 2022 und 2023 dargestellt:

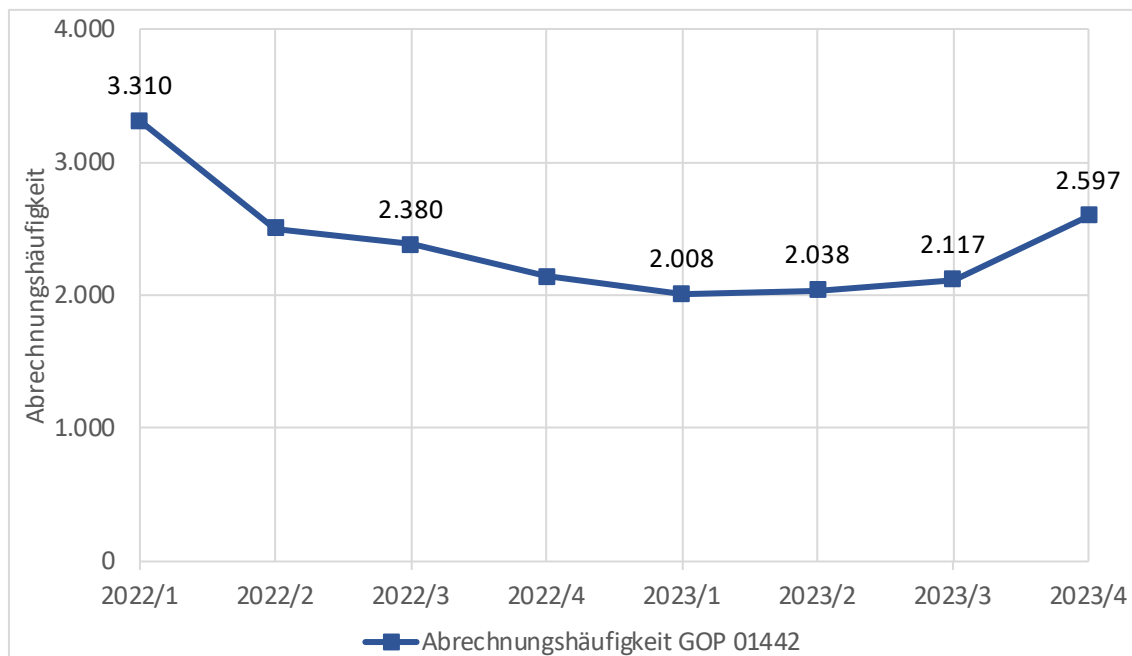


Abbildung 15 Abrechnungshäufigkeit der GOP 01442 (Videoallkonferenz) in den Jahren 2022 und 2023.

Die Abrechnungshäufigkeit der GOP 01442 zeige sich im Jahr 2023 auf einem niedrigen Niveau, ein leichter Anstieg auf ca. 2.600 Abrechnungen ist im 4. Quartal 2023 ersichtlich (Abbildung 15). Tabelle 53, Tabelle 54 und Tabelle 55 im Anhang listen neben der Abrechnungshäufigkeit auch den Leistungsbedarf je Quartal auf.

Auswertungen zur Abrechnungshäufigkeit der GOP 01442 durch die verschiedenen Fachgruppen ergaben, dass die GOP 01442 in einem weit überwiegenden Anteil (~75 %) von der Fachgruppe der Hausärzte/-ärztinnen abgerechnet wird (siehe auch die fachgruppenspezifischen Abrechnungen im Anhang, Tabelle 63). Im Anhang sind darüber hinaus die Verlaufswerte zu regionalen Abrechnungen (nach KV-Bezirken) der GOP 01442 sowie nach Einrichtungenformen ersichtlich (siehe Anhang, Tabelle 61, Tabelle 62).

4 Telemonitoring bei Versicherten mit Herzinsuffizienz

4.1 Allgemeine Erläuterungen

Begrifflichkeiten

Bei Patienten und Patientinnen mit Herzinsuffizienz ist das Herz nicht mehr in der Lage, sich ausreichend mit Blut zu füllen oder dieses wieder herauszupumpen. Eine Herzinsuffizienz kann chronisch oder akut auftreten. Kennzeichnend ist, dass der Körper nicht genug Sauerstoff erhält, um die Versorgung unter Belastungs- bzw. im fortgeschrittenen Stadium unter Ruhebedingungen zu gewährleisten. Der Stoffwechsel und der Transport (beispielsweise von Gewebswasser) sind beeinträchtigt oder kommen zum Erliegen. Eine chronische Herzinsuffizienz tritt in der älteren Bevölkerung häufig auf und zählt auch zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland.

Da das Herz in einen komplexen Regelungsvorgang eingebunden ist, neigt eine Herzinsuffizienz zu einem schwankenden Verlauf, der sich typischerweise bei Überschreitung eines Kippunktes schnell und lebensbedrohlich verschlechtern kann. Eine engmaschige Kontrolle des Gesundheitszustands ermöglicht es, Verschlechterungen frühzeitig zu erkennen, bevor ein solcher Kippunkt überschritten wird. Dabei kann das Telemonitoring mit Übermittlung und Überwachung der physiologischen Daten (etwa Herzfrequenz und -rhythmus, Gewicht und Blutdruck) oder Einschätzungen des Gesundheitszustandes durch den Versicherten einen Beitrag leisten.

Ablauf Telemonitoring Herzinsuffizienz

Grundsätzlich werden bei dieser Methode im Sinne einer Fernüberwachung regelmäßig (z. B. täglich) klinische Daten (Gewicht, Blutdruck, Befinden) oder technische Daten (z. B. Batteriestatus, Impedanzen) von Patienten und Patientinnen mit Herzinsuffizienz an ein spezifisches TMZ übermittelt und ausgewertet. Bei Überschreiten von vordefinierten Grenzwerten oder detektierten Auffälligkeiten können die Betroffenen gezielt außerhalb der geplanten Nachsorgeintervalle einbestellt oder sogar sofort diagnostische und/oder therapeutische Maßnahmen eingeleitet werden. Der Erfolg des Telemonitorings hängt dabei entscheidend vom Informationsfluss und der im Voraus definierten Aufgabenverteilung zwischen dem TMZ und dem PBA ab. Abbildung 16 demonstriert die wesentliche Struktur und den Ablauf des Telemonitorings bei Herzinsuffizienzpatientinnen und -patienten mit Schweregrad NYHA II oder III nach der Anlage I Nr. 37 der Richtlinie Methoden vertragsärztliche Versorgung (MVB-RL):

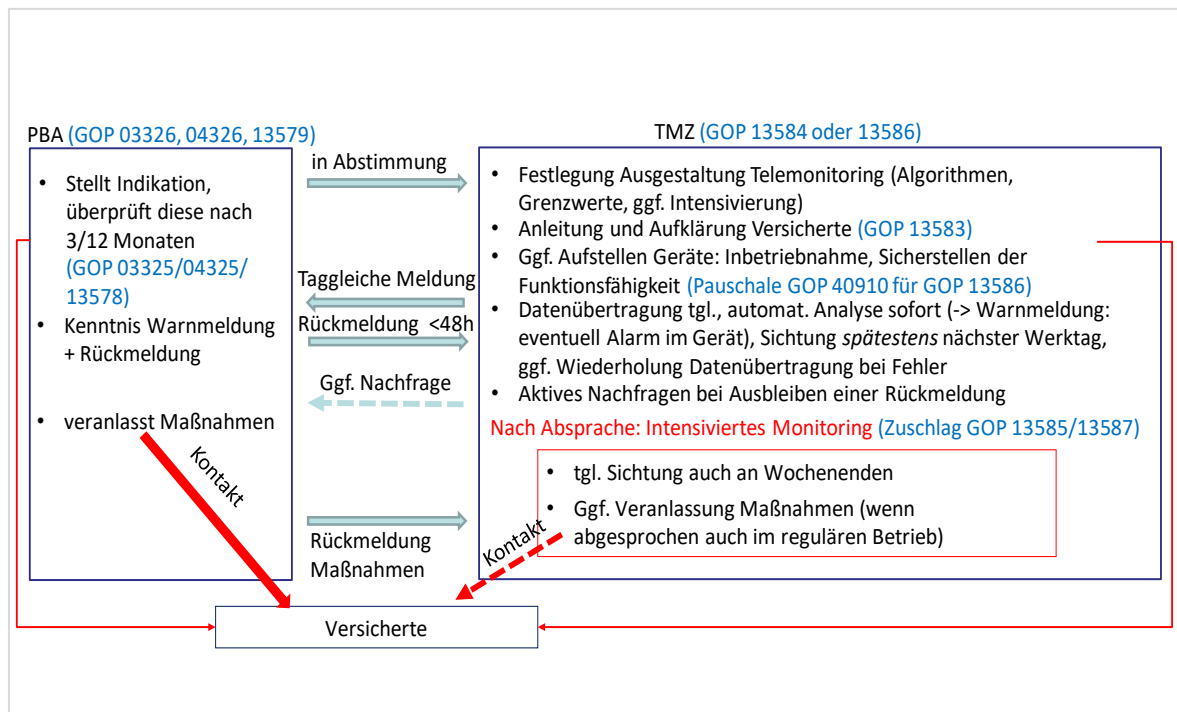


Abbildung 16 Schematische Darstellung des Telemonitorings bei Versicherten mit Herzinsuffizienz (Darstellung InBA). PBA=primär behandelnder Arzt/Ärztin; TMZ=telemedizinisches Zentrum.

Der primär behandelnde Arzt oder die Ärztin (PBA) stellt die Indikation für das Telemonitoring und arbeitet eng mit dem telemedizinischen Zentrum (TMZ) zusammen (Abbildung 16). PBA und TMZ sind im Regelfall getrennte Institutionen. Falls der/die PBA die strukturellen und prozessualen Voraussetzungen für ein TMZ erfüllt oder wenn bereits ein Behandlungsvertrag zwischen Versicherten und der Ärztin oder dem Arzt vorbestand, dürfen die Aufgaben von PBA und TMZ auch von einer Abrechnungseinheit wahrgenommen werden. Die TMZ sind im Wesentlichen für die Geräteversorgung, Anleitung der Versicherten, Dokumentation und Überwachung verantwortlich und geben bei Auffälligkeiten eine Meldung an die PBA, die ihrerseits die daraufhin von ihnen veranlassten Maßnahmen zurückmelden. Die Behandlung bleibt so in den Händen der PBA. Die Überwachung kann grundsätzlich – wenn bei den Versicherten vorhanden – mittels der Übertragungsfunktionen von implantierten kardialen Aggregaten (ICD, CRT) stattfinden und/oder mittels externer Geräte (EKG, Waage, Tablet etc.).

Für Versicherte, die eine intensive Überwachung benötigen, gibt es nach Absprache ein intensiviertes Monitoring mit Überwachung auch am Wochenende und an Feiertagen. Bei diesen Versicherten können TMZ auch unter Umständen direkt mit den Versicherten Kontakt aufnehmen und nach vorheriger Absprache mit den PBA auch Maßnahmen initiieren (Abbildung 16).

Ersichtlich sind in Abbildung 16 auch die eingeführten Gebührenordnungspositionen, die in Kapitel 4.2 des Berichts näher erläutert werden.

4.2 Regelungen und Vergütung im EBM

Die Implementierung des G-BA-Beschlusses²¹ in der Vergütungsstruktur erfolgte mit dem Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 76. Sitzung²² mit Wirkung zum 1. Januar 2022. Mit dem Beschluss des 76. EBA wurden folgende Leistungen zum Telemonitoring bei Herzinsuffizienz für PBA sowie für TMZ in den EBM aufgenommen (Tabelle 14):

Tabelle 14 Neue Gebührenordnungspositionen mit dem Beschluss des EBA in seiner 76. Sitzung, getrennt nach PBA/TMZ (PBA = primär behandelnder Arzt/Ärztin; TMZ = telemedizinisches Zentrum). HA = Hausärztinnen/-ärzte; FA = Fachärzte/-ärztinnen.

	GOP	Abrechnungsbestimmungen	Punkte	€ (2023)	Anmerkungen
PBA (HA, FA Kinder-/Jugendmedizin oder Innere Medizin)	Indikationsstellung inkl. Aufklärung und Beratung				
	03325/04325/13578	3x/KHF	65 Pkt.	7,47 €	Je vollendete 5 Minuten
	Zusatzpauschale Betreuung von Versicherten im Telemonitoring bei Herzinsuffizienz				
	03326/04326/13579	1x/BHF	128 Pkt.	14,71 €	
TMZ	Anleitung und Aufklärung des Versicherten				
	13583	1x/KHF	95 Pkt.	10,92 €	
	Telemonitoring mit implantiertem kardialen ICD/CRT-System				
	13584	1x/BHF	1100 Pkt.	126,41 €	
	13585	1x/BHF	235 Pkt.	27,01 €	Zuschlag intensiviertes Monitoring
	Telemonitoring mittels externer Messgeräte				
	13586	1x/BHF	2100 Pkt.	241,31 €	
	13587	1x/BHF	235 Pkt.	27,01 €	Zuschlag intensiviertes Monitoring
	40910	1x/BHF	-	68,00 €	Kostenpauschale Geräteausstattung Versicherten im Zusammenhang mit der/den GOP 13586 und/oder 13587

In Tabelle 14 sind die für PBA berechnungsfähigen Gebührenordnungspositionen für die Indikationsstellung und die Betreuung der Versicherten dargestellt. Diese sind jeweils für Ärztinnen und Ärzte aus dem Fachgebiet Allgemeinmedizin/hausärztliche Internisten, Kinder- und Jugendmedizin und Innere Medizin²³ gespiegelt.

Das TMZ erhält neben der Vergütung für die Aufklärung des Versicherten (GOP 13583) eine Vergütung für das telemedizinische Monitoring von Versicherten mittels eines kardialen Aggregates

²¹ Die Methode Telemonitoring bei Herzinsuffizienz wurde am 17. Dezember 2020 in einem Beschluss des G-BA zur Aufnahme der Methode Telemonitoring bei Herzinsuffizienz als Nr. 37 in die Anlage I der [Mw-Richtlinie](#) übernommen.

²² [Beschluss](#) des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 76. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de)

²³ Berechtigt zur Abrechnung sind nur Vertragsärzte/-ärztinnen und Fachärzte/-ärztinnen für Innere Medizin in Funktion als PBA und mit Schwerpunkt Kardiologie, Nephrologie, Pneumologie und ohne Schwerpunkt.

(GOP 13584) oder für das Telemonitoring von Versicherten, bei denen das telemedizinische Monitoring mit externen Geräten erfolgt (GOP 13586). Da bei der Überwachung mit externen Geräten regelhaft ein höherer Aufwand vorliegt, ist diese Gebührenordnungsposition höher bewertet. Sowohl bei dem Monitoring mittels kardialer Aggregate als auch mittels externer Geräte kann bei Bedarf ein Zuschlag für das intensivierte Monitoring abgerechnet werden (GOP 13585 bzw. GOP 13587). Die GOP für das intensivierte Monitoring vergüten dabei eine ggf. notwendige engmaschigere Untersuchung, z. B. auch am Wochenende und Feiertagen.

Wenn Versicherte mit externen Geräten in das Telemonitoring eingebunden sind, kann darüber hinaus einmal pro Behandlungsfall die Kostenpauschale für die erforderliche Geräteausstattung der Versicherten abgerechnet werden (Kostenpauschale 40910).

Berechtigt zur Abrechnung von GOP des Telemonitoring Herzinsuffizienz für TMZ sind Fachärztinnen/-ärzte für Innere Medizin und Kardiologie mit vorliegenden Genehmigungen der KV nach den Qualitätssicherungsvereinbarungen QS-V TmHI und QS-V Rhythmusimplantat-Kontrolle (s. u.).

Bezüglich des Telemonitorings Herzinsuffizienz erfolgte zum 1. Januar 2023 mit dem Beschluss in der 625. Sitzung des BA²⁴ noch eine geringfügige Anpassung hinsichtlich des Zusammenspiels zwischen Funktionsanalysen einerseits und dem Telemonitoring Herzinsuffizienz andererseits. Mit Wirkung zum oder im Berichtszeitraum wurden vom 603. bzw. 664. BA zwei Beschlüsse gefasst, welche die Finanzierungsregelung außerhalb der MGV zusammentragen und die Vergütung der GOP des Telemonitoring Herzinsuffizienz außerhalb der MGV stellen (Tabelle 21).

Tabelle 15 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zum Telemonitoring bei Herzinsuffizienz, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden. MGV = morbiditätsbedingte Gesamtvergütung.

Kategorie	Beschluss	Inkrafttreten	Inhalt/GOP	Laufzeit/Befristung
Finanzierung	603. BA	01.01.2023	Regelungen zur Finanzierung außerhalb der MGV	31.12.2023
Detailänderung	625. BA	01.01.2023	Aufhebung Berechnungsausschlüsse GOP 13584 zu Funktionsanalysen (GOP 04411, 04413, 04415, 13571, 13573 und 13575) und Neuregelung	Nein
Finanzierung	664. BA	01.01.2024	Regelungen zur Finanzierung außerhalb der MGV	31.12.2024

Vereinbarungen

Zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Versorgung werden die neu eingeführten Gebührenordnungspositionen von einer Qualitätssicherungsvereinbarung (QS-V TmHi)²⁵ zwischen Kassenärztlicher Bundesvereinigung und GKV-Spitzenverband flankiert. Diese trat zum

²⁴ [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 625. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

²⁵ Siehe [QS-Vereinbarung](#) Telemonitoring bei Herzinsuffizienz (QS-V TmHi); Inkrafttreten am 1.4.2022 – Kassenärztliche Bundesvereinigung (kbv.de).

1. April 2022 in Kraft. Neben der Definition der Teilnehmer in Bezug auf Anforderungen und Qualifikation werden hier vor allem auch technische Standards bezüglich der Infrastruktur des TMZ und der Geräte/Sensoren definiert, die bei den Versicherten zum Einsatz kommen. Nur TMZ, die die Anforderungen an die technische Ausstattung gemäß der QS-V TmHi nachweislich erfüllen, erhalten von der Kassenärztlichen Vereinigung eine Genehmigung, TMZ-Leistungen durchzuführen. Regulär war eine Abrechnung des Telemonitorings Herzinsuffizienz erst mit dem Inkrafttreten der QS-Vereinbarung möglich.²⁶

Neben der geschlossenen QS-Vereinbarung befinden sich der GKV-Spitzenverband und die Kassenärztliche Bundesvereinigung noch in Beratungen zur Abstimmung einer – nach Beanstandung durch das BMG – angepassten Vereinbarung über die Anforderungen an die technischen Verfahren zum telemedizinischen Monitoring gemäß § 367a Absatz 1 SGB V. Die Anlage 36 BMV-Ä wird im Benehmen mit der oder dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. und der gematik GmbH geschlossen. Ziel der Vereinbarung ist die Festlegung von technischen Anforderungen an die einzusetzenden Anwendungen. Zudem soll sie Vorgaben für die Interoperabilität der einzusetzenden Anwendungen und Anforderungen an den Datenschutz und die Informationssicherheit enthalten sowie die Verwendung von Diensten und Anwendungen der Telematikinfrastruktur für das Telemonitoring definieren. Die Vereinbarung soll auch vorsehen, dass den in das Telemonitoring eingeschlossenen Versicherten therapierelevante Daten in einem interoperablen Format zur Verfügung gestellt werden.

4.3 Leistungsentwicklung

Die Voraussetzungen für eine reguläre Abrechnung des Telemonitoring Herzinsuffizienz waren ab dem 2. Quartal 2022 gegeben – die Auswertung für das Jahr 2022 erfolgt daher für das 2. – 4. Quartal. Die vorhandenen 12 Leistungen werden zum besseren Verständnis im Folgenden nach Kategorien gruppiert dargestellt – abhängig von ihrer Funktion im Ablauf des Telemonitorings Herzinsuffizienz.

Sämtliche Ergebnisse, auch die Daten zur Entwicklung des Leistungsbedarfes (in €), sind in Tabelle 64 und Tabelle 65 im Anhang wiedergegeben. Dort sind ebenfalls die Jahreswerte angegeben.

²⁶ Vor Inkrafttreten der QS-Vereinbarung konnten zwischen 1. Januar und 31. März 2022 übergangsweise nur Ärztinnen und Ärzte, denen bereits von ihrer Kassenärztlichen Vereinigung eine Rhythmusimplantat-Kontrolle genehmigt wurde, TMZ-Leistungen zum Telemonitoring bei Herzinsuffizienz durchführen und abrechnen.

Abrechnungshäufigkeit für die Indikationsstellung bei Versicherten mit Telemonitoring Herzinsuffizienz durch den PBA

Die Indikationsstellung für das Telemonitoring Herzinsuffizienz (GOP 03325/04325/13578) wurde von den PBA in folgender Häufigkeit abgerechnet (Abbildung 17):

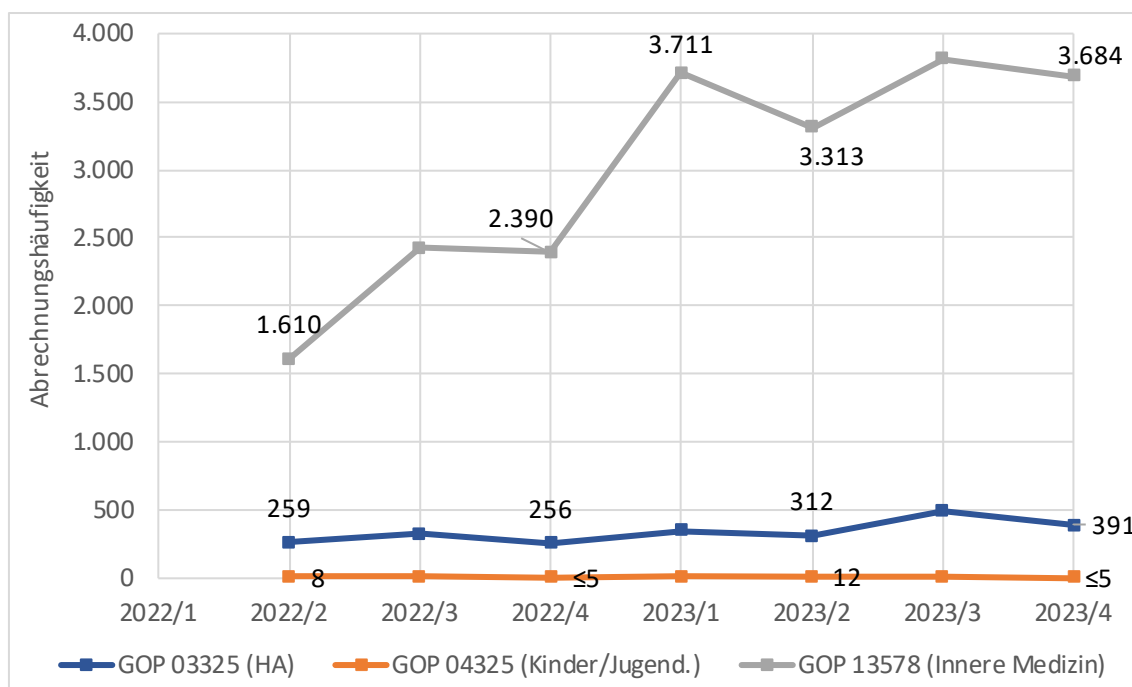


Abbildung 17 Abrechnungshäufigkeiten für die Indikationsstellung bei Versicherten für Telemonitoring Herzinsuffizienz für die primär behandelnden Ärztinnen/Ärzte (HA=Hausärztin/-arzt, Kinder/Jugendmedizin oder Innere Medizin) vom 2. Quartal 2022 bis 4. Quartal 2023.

In Abbildung 17 ist eine deutliche Steigerung der Indikationsstellung für das Telemonitoring Herzinsuffizienz über die vergangenen Quartale erkennbar. Diese ist insbesondere auf die gesteigerten Abrechnungen durch berechnete Internistinnen/Internisten zurückzuführen (graue Kurve); die Abrechnung durch diese Gruppe war mit 84-90 % der Abrechnungen über alle Quartale hinweg der Regelfall. Durch den starken Zuwachs der Indikationsstellungen bei den Internistinnen und Internisten sank der Anteil der Indikationsstellungen durch Hausärztinnen/Hausärzte kontinuierlich von rund 16 % im 2. Quartal 2022 auf ca. 10 % im 4. Quartal 2023 ab.

Der gesamte Leistungsbedarf der von PBA abgerechneten Leistungen für die Indikationsstellung bei Versicherten mit Telemonitoring betrug im Jahr 2023 ca. 120.000 € (s.a. Tabelle 65 im Anhang).

Abrechnungshäufigkeit der Zusatzpauschalen für PBA für die Betreuung von Versicherten mit Telemonitoring Herzinsuffizienz

Die Abrechnungshäufigkeit der Pauschalen für die Betreuung von Versicherten mit Herzinsuffizienz durch den PBA (GOP 03326/04326/13579) zeigt Abbildung 18. Der oder die PBA kann dabei – je nach Zugehörigkeit – über das EBM-Kapitel der Hausärzte/-ärztinnen (HA), der Kinder-/Jugendmedizin oder der Inneren Medizin abrechnen.

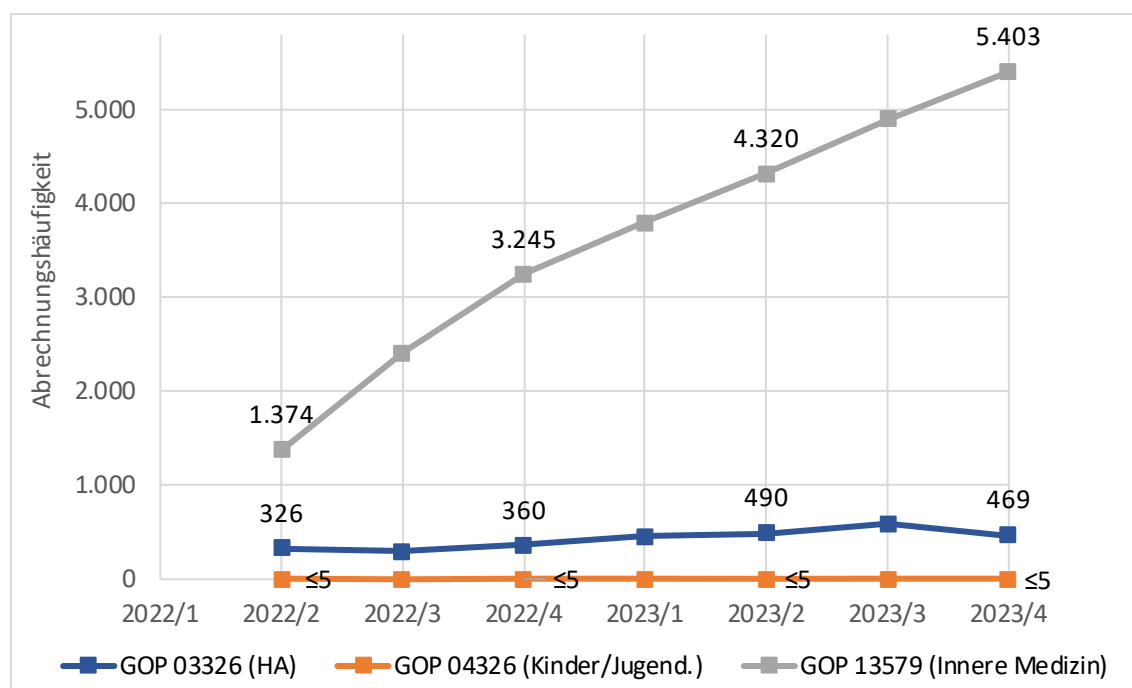


Abbildung 18 Abrechnungshäufigkeiten der Zusatzpauschalen für primär behandelnde Ärztinnen/Ärzte (PBA) vom 2. Quartal 2022 bis 4. Quartal 2023 für die Betreuung von Versicherten mit Telemonitoring Herzinsuffizienz.

Wie bei der Indikationsstellung erfolgte auch die Betreuung von Versicherten mit Telemonitoring Herzinsuffizienz im Wesentlichen durch PBA aus der Fachgruppe der Inneren Medizin. Im 4. Quartal 2023 wurden 5.403 Versicherte von Internistinnen/Internisten in Funktion eines PBA betreut – entsprechend einem Anteil von 92 %. Hausärztliche PBA führten hingegen mit 469 Abrechnungen nur ca. 8 % der Abrechnungen bzw. Betreuungen durch, während Ärztinnen/Ärzte aus der Fachgruppe der Kinder-/Jugendmedizin nur in Einzelfällen eine Betreuung abrechneten.

Der gesamte Leistungsbedarf der von PBA abgerechneten Leistungen für die Betreuung von Versicherten im Telemonitoring betrug im Jahr 2023 ca. 301.000 € (s.a. Tabelle 65 im Anhang).

Abrechnungshäufigkeit für die Anleitung/Aufklärung und Behandlung von Versicherten mittels Telemonitoring Herzinsuffizienz für TMZ

Die in Abbildung 19 und Abbildung 20 dargestellten Verläufe der Abrechnungshäufigkeit beziehen sich auf die Leistungen, die von TMZ für das Telemonitoring Herzinsuffizienz berechnet werden können.

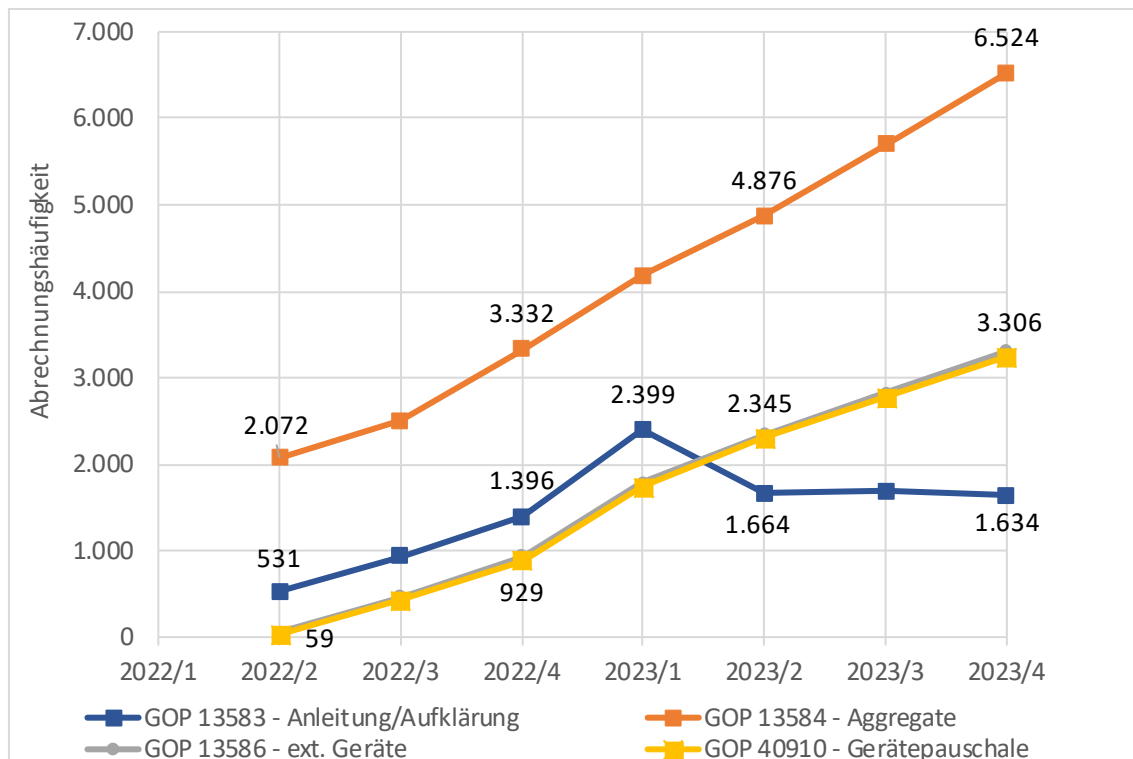


Abbildung 19 Abrechnungshäufigkeiten der zentralen Behandlungs-GOP für telemedizinische Zentren (TMZ) vom 2. Quartal 2022 bis 4. Quartal 2023 für die Behandlung von Versicherten mit Telemonitoring Herzinsuffizienz.

Die Abrechnungshäufigkeit für Versicherte mit Aggregatsystemen (GOP 13584, orangefarbene Kurve) dominiert die Abrechnungshäufigkeiten in Abbildung 19. Im 4. Quartal 2023 wurde diese ca. 6.500-mal abgerechnet. Deutlich seltener wird die GOP 13586 für die Überwachung von Versicherten mit externer Geräteversorgung abgerechnet (3.306 Abrechnungen, graue Kurve). Im 4. Quartal 2023 wurden damit insgesamt ca. 9.800 Versicherte durch TMZ überwacht (GOP 13584 + GOP 13586).

Betrachtet man den Verlauf der Abrechnungshäufigkeiten, ist erkennbar, dass die Abrechnung der GOP 13586 verzögert und von einem sehr niedrigen Niveau aus startete, über die Quartale jedoch eine deutliche Steigerung aufwies. Dies spiegelt die kontinuierliche Erhöhung des Anteils von Versicherten wider, die mittels externer Geräte überwacht werden. So stellten Versicherte, die über externe Geräte überwacht werden, im 4. Quartal 2022 einen Anteil von ungefähr 22 % an allen überwachten Versicherten im Telemonitoring Herzinsuffizienz. Im 4. Quartal 2023 betrug dieser Anteil ca. 34 %.

Die Abrechnungshäufigkeit der Sachkostenpauschale 40910 für externe Geräte (gelbe Kurve) war erwartungsgemäß annähernd gleich groß wie die Abrechnungshäufigkeit der GOP 13586 (graue Kurve) für die Überwachung von Versicherten mit externen Geräten, da die externen Geräte eine technische Voraussetzung für diese Form der Überwachung darstellen.

Die Leistung für die Aufklärung/Anleitung von Versicherten durch das TMZ (GOP 13583)²⁷ zeigte zunächst einen Anstieg auf etwa 2.400 Abrechnungen im 1. Quartal 2023 und danach einen Rückgang auf ein stabiles Niveau um ca. 1.600 Abrechnungen.

Der gesamte Leistungsbedarf der von TMZ abgerechneten Leistungen für die Überwachung von Versicherten im Telemonitoring betrug im Jahr 2023 ca. 6,1 Mio. € (s. Tabelle 65 im Anhang). Ca. 212.000 € entfielen dabei auf die intensivierte Überwachung (s. unten).

Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit der Zuschläge für die intensivierte Überwachung von Versicherten für TMZ

Abbildung 20 illustriert die Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit der Zuschläge für die intensivierte Überwachung im Telemonitoring Herzinsuffizienz von Versicherten mit Aggregaten (GOP 13585, orangefarbene Balken) und Versicherten mit externen Geräten (GOP 13587, gelbe Balken) im Verhältnis zu den Abrechnungshäufigkeiten der zugehörigen Haupt-Leistung für das Telemonitoring mit Aggregaten (GOP 13584, blaue Balken) und externen Geräten (GOP 13586, graue Balken) ohne intensivierte Überwachung.

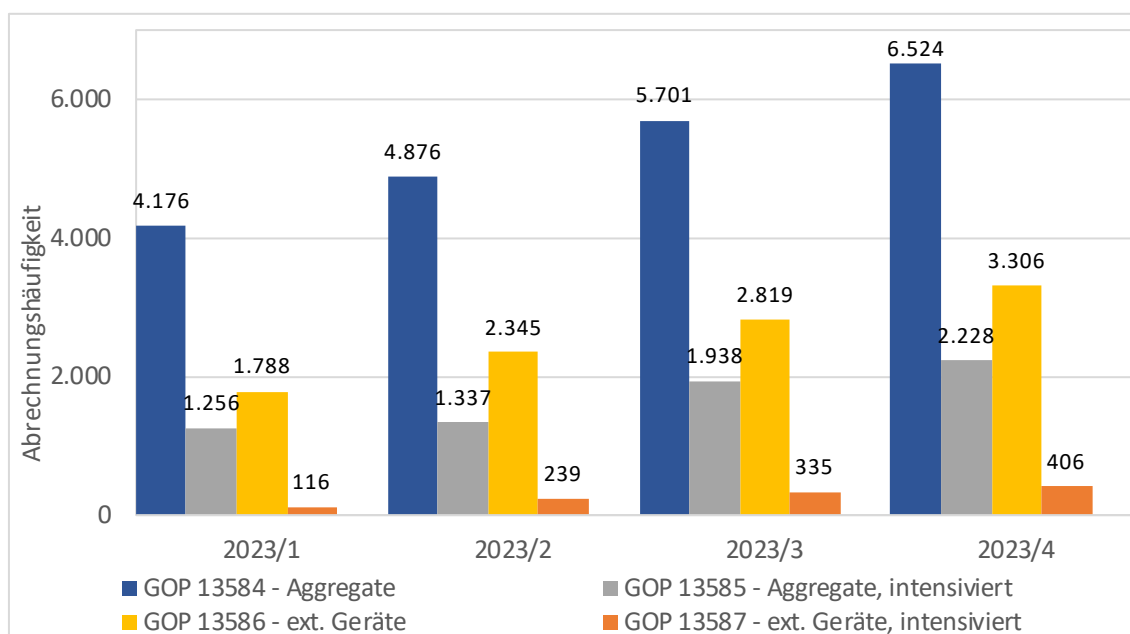


Abbildung 20 Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit der Zuschläge (GOP 13585 und 13587) für die intensivierte Überwachung von Versicherten im Verhältnis zu den assoziierten Haupt-Leistungen GOP 13584 (Aggregate) und GOP 13586 (ext. Geräte) im 1. bis 4. Quartal 2023.

²⁷ Die GOP 13583 kann einmal im Krankheitsfall abgerechnet werden.

In Abbildung 20 ist die bereits beschriebene Zunahme der Abrechnungshäufigkeiten aller Leistungen vom 1. zum 4. Quartal 2023 erkennbar. Betrachtet man die Verhältnisse von intensivierter Überwachung zur nicht-intensivierten Überwachung zeigt sich, z. B. im 4. Quartal bei den 6.524 Versicherten mit Überwachung über Aggregate (blauer Balken), dass bei 2.228 der Versicherten eine intensivierte Überwachung (grauer Balken) erfolgte. Dies entspricht einem Anteil von 34 %. Bei den ungefähr 3.300 Versicherten, die mittels externer Geräte überwacht wurden, erfolgte eine intensivierte Überwachung bei 406 Versicherten (orangefarbener Balken) bzw. 12 %.

Vom 1. auf das 4. Quartal 2023 hat das Verhältnis der intensivierten Überwachung gegenüber der nicht intensivierten Überwachung dabei sowohl bei der Überwachung mittels Aggregaten, als auch bei der Überwachung mittels externen Geräten von 30 % auf 34 % bzw. von 6 % auf 12 % kontinuierlich zugenommen. Bezüglich der intensivierten Überwachung mittels externer Geräte gegenüber der intensivierten Überwachung mittels Aggregatsystemen bestand allerdings hinsichtlich des Anteils weiterhin ein deutlicher Niveauunterschied.

Mutmaßlich könnte diese unterschiedliche Notwendigkeit der intensiven Überwachung durch ein durchschnittlich gesünderes bzw. stabileres Versichertenkollektiv bei Versicherten in der Geräteüberwachung verursacht werden. So empfehlen die Leitlinien die Implantation eines CRT-Aggregates regelhaft erst ab einer LV-EF²⁸ $\leq 35\%$ und ab einer QRS-Dauer >130 ms, was ggf. auf eine funktionell/morphologisch fortgeschrittenere und bereits länger bestehende Herzinsuffizienz zutrifft im Vergleich zu den Eingangskriterien für die Indikation zum Telemonitoring Herzinsuffizienz für Patienten ohne Aggregatsystem (LV-EF $<40\%$ und im zurückliegenden Jahr stationär behandelte kardiale Dekompensation).

4.4 Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit sowie nach Einrichtungsformen und Fachgruppen

Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit

Aufgrund der hohen Anzahl von verschiedenen Leistungen werden an dieser Stelle nur die normierte regionale Abrechnungshäufigkeit der für das Telemonitoring zentralen drei Leistungen Aufklärung und Beratung (GOP 13583), Telemonitoring mit Aggregaten (GOP 13584) und Telemonitoring mit externen Geräten (GOP 13586) für das Jahr 2023 grafisch dargestellt (Abbildung 21). Tabelle 66 und Tabelle 67 im Anhang listen für sämtliche Leistungen die Häufigkeiten in Bezug auf die KV-Bezirke auf.

²⁸ Die Linksventrikuläre-Ejektionsfraktion (LV-EF) kann als Ausdruck der (Links-)Herzleistung aufgefasst werden.

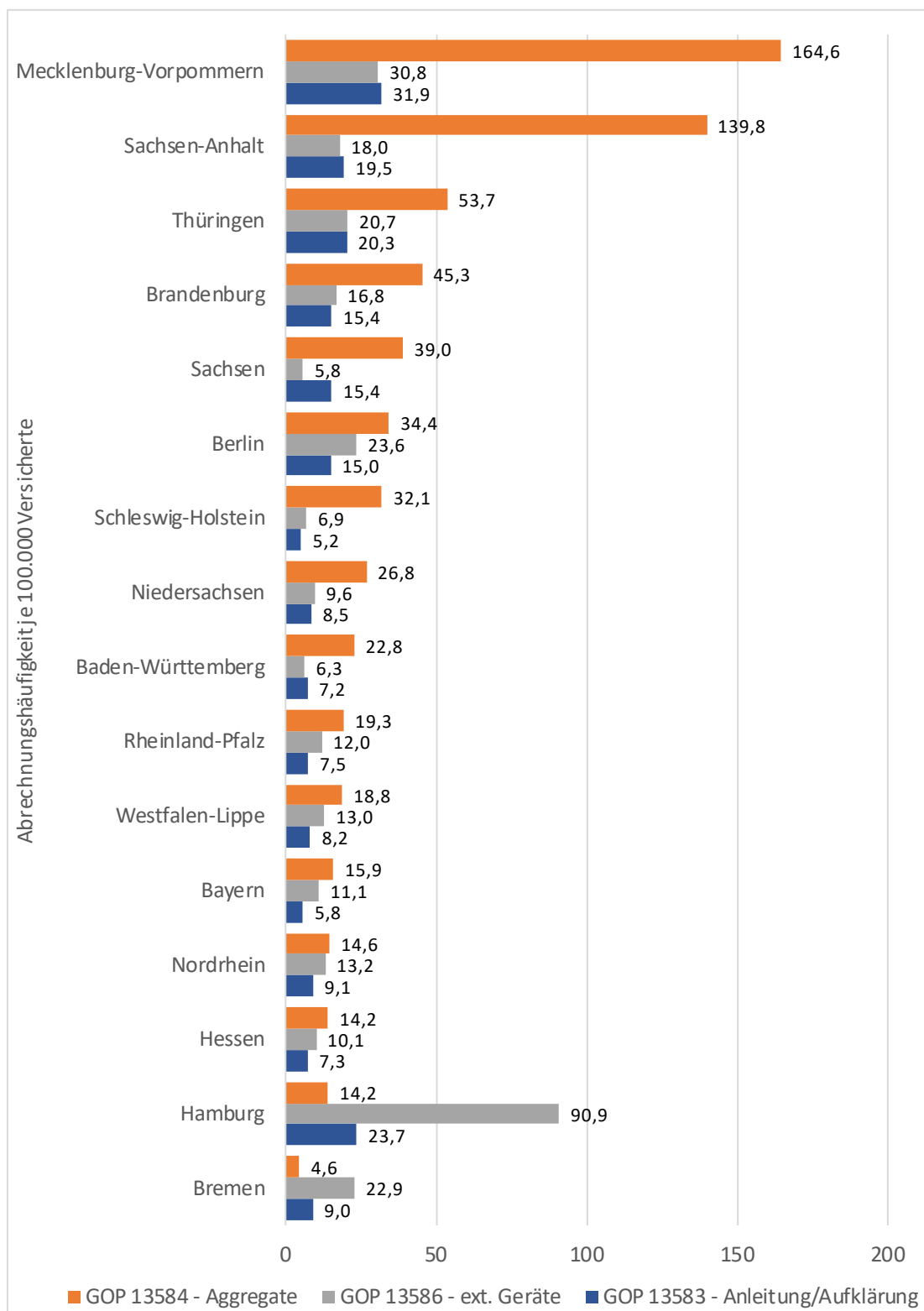


Abbildung 21 Regionale Abrechnungshäufigkeit der GOP 13583, 13584 und 13586 nach KV-Bezirken im Jahr 2023. Dargestellt ist die normierte Abrechnungshäufigkeit je 100.000 Versicherte. Sortierung nach Abrechnungshäufigkeit der GOP 13584.

Der Abbildung 21 ist zu entnehmen, dass in Relation zu ihrer Größe insbesondere in den KV-Bezirken vieler dünn besiedelter Flächenländer – in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-

Anhalt, Thüringen und Brandenburg – in hohem Maße Telemonitoring Herzinsuffizienz über Aggregate praktiziert wurde (orangefarbener Balken). Dieser Fakt war bereits im Jahr 2022 zu sehen. Die KV-Bezirke Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt nahmen hierbei mit weit über 100 Überwachungen über Aggregate pro 100.000 Versicherte einen Spitzenwert ein. Das Telemonitoring mit externen Geräten (grauer Balken) erfolgte in fast allen KV seltener als mit externen Geräten – lediglich in der KV Bremen und insbesondere in der KV Hamburg wurde vermehrt ein Telemonitoring mittels externer Geräte durchgeführt.

Die normierte Abrechnungshäufigkeit der Anleitung und Aufklärung (GOP 13583) schwankt zwischen den KV-Bezirken zwischen 5 und 32 Abrechnungen je 100.000 Versicherte.

Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Einrichtungsformen

Die Verteilung der Einrichtungsformen von abrechnenden PBA (Tabelle 16) und TMZ (Tabelle 17) und die durchschnittliche Abrechnungshäufigkeit je Praxis stellt sich für das Jahr 2023 wie folgt dar:

Tabelle 16 Abrechnungshäufigkeit von Leistungen, die von primär behandelnden Ärztinnen/Ärzten (PBA) im Telemonitoring Herzinsuffizienz berechnungsfähig sind, nach Einrichtungsformen im Jahr 2023. In Klammern ist die mittlere Abrechnungshäufigkeit pro abrechnende Einrichtung angegeben.

Praxisform	Abrechnungshäufigkeit (durchschnittliche Abrechnungen je Einrichtung)					
	GOP 03325 - Indikation PBA (HA)	GOP 04325 - Indikation PBA (Pädiatrie)	GOP 13578 - Indikation PBA (Kardi- ologie)	GOP 03326 - Betreuung PBA (HA)	GOP 04326 - Betreuung PBA (Pädi- atrie)	GOP 13579- Betreuung PBA (Kardio- logie)
Einzelpraxis	1.012 (7)	20 (1)	6.728 (112)	1.409 (3)	≤5 (1)	5.516 (125)
Gemeinschafts- praxis	425 (4)	11 (1)	6.284 (63)	460 (1)	≤5 (1)	11.010 (127)
MVZ	102 (5)	7 (1)	1.456 (36)	136 (3)		1.728 (47)
Sonstige	2 (1)	1 (1)	50 (12)	1 (1)		165 (41)

Aus Tabelle 16 kann bei Betrachtung der GOP 03325 (Indikation PBA) und GOP 03326 (Betreuung PBA) abgeleitet werden, dass abrechnende hausärztliche PBA – wie bereits im Jahr 2022 – mehrheitlich in Einzelpraxen organisiert waren, während Ärztinnen und Ärzte aus der Fachgruppe der Inneren Medizin (GOP 13578 und GOP 13579) mit einem höheren Anteil in Gemeinschaftspraxen verortet waren. Betreuende internistische Gemeinschaftspraxen betreuten dabei fast doppelt so viele Versicherte wie Einzelpraxen (GOP 13579: ca. 11.000 gegenüber 5.500), die durchschnittliche Abrechnung pro abrechnende Einrichtung stellte sich hingegen bei beiden Praxisformen mit 125 bzw. 127 ähnlich dar.

Bei den TMZ, welche die GOP 13584 und 13586 abrechneten (s. Tabelle 17), dominierten – ebenfalls wie bereits im Jahr 2022 – die Gemeinschaftspraxen mit beispielsweise ca. 11.500 Abrechnungen gegenüber ca. 7.100 Abrechnungen in Einzelpraxen (GOP 13584).

Tabelle 17 Abrechnungshäufigkeit von Leistungen, die von telemedizinischen Zentren (TMZ) im Telemonitoring Herzinsuffizienz berechnungsfähig sind, nach Einrichtungsformen im Jahr 2023. In Klammern ist die mittlere Abrechnungshäufigkeit pro abrechnende Einrichtung angegeben.

Praxisform	Abrechnungshäufigkeit (durchschnittliche Abrechnungen je Einrichtung)					
	GOP 13583 Aufkl./An- leitung TMZ	GOP 13584 Betreuung (Aggregate)	GOP 13585 Intensivzus. (Aggregate)	GOP 13586 Betreuung (ext. Geräte)	GOP 13587 Intensivzus. (ext. Geräte)	40910 Gerä- tepauschale ext. Geräte
Einzelpraxis	1.787 (30)	7.062 (136)	2.096 (131)	1.681 (37)	466 (25)	1.615 (37)
Gemein- schaftspraxis	3.872 (39)	11.549 (152)	4.523 (197)	5.910 (75)	598 (46)	5.834 (78)
MVZ	1.391 (46)	1.934 (92)	140 (35)	2.520 (126)	21 (10)	2.492 (125)
Sonstige	333 (48)	732 (105)		147 (37)	11 (11)	123 (31)

Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Fachgruppen und Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte

Zum besseren Verständnis erfolgt in Tabelle 18 die Darstellung der Abrechnungshäufigkeit erneut gruppiert nach der Funktion der Leistung im Versorgungsprozess und nach der Zugehörigkeit der/des Abrechnenden (PBA/TMZ), aber ergänzt um die Anzahl an abrechnenden Ärztinnen/Ärzten.

*Tabelle 18 Abrechnungshäufigkeit (AH) der Indikationsprüfung und der Betreuung von Versicherten im Telemonitoring durch primär behandelnde Ärztinnen/Ärzte (PBA) sowie für die Betreuung von Versicherten mit Aggregaten/mit externen Geräten durch telemedizinische Zentren (TMZ). Dargestellt sind die Abrechnungshäufigkeit und die Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte (n Ä) nach Fachgruppen im Jahr 2023. * Zur Abrechnung berechtigt sind lediglich einige Ärztinnen/Ärzte der Fachgruppe, abhängig vom fachärztlichen Schwerpunkt und vorliegender Genehmigungen der KV nach den Qualitätssicherungsvereinbarungen QS-V TmHI und der QS-V Rhythmusimplantat-Kontrolle (s. hierzu 4.2).*

Funktion im Telemonitoring	Fachgruppe	Abrechnungshäufigkeiten (AH) und Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte (n Ä)*					
		GOP 03325		GOP 04325		GOP 13578	
		AH	n Ä	AH	n Ä	AH	n Ä
PBA: Indikationsprüfung	Hausärztinnen/-ärzte (n)	1.541	296	.	.	.	.
	Kinder-/ Jugendmedizin	.	.	39	34	.	.
	Innere Medizin*	.	.	.	.	14.518	393
		GOP 03326		GOP 04326		GOP 13579	
		AH	n Ä	AH	n Ä	AH	n Ä
PBA: Betreuung Versicherte Telemonitoring	Hausärztinnen/-ärzte	2.006	847	.	.	.	.
	Kinder-/ Jugendmedizin	.	.	10	10	.	.
	Innere Medizin*	.	.	.	.	18.419	344
		GOP 13583		GOP 13584		GOP 13585	
		AH	n Ä	AH	n Ä	AH	n Ä
TMZ: Anleitung/ Aufkl. + Betreuung Aggregate	Innere Medizin – SP Kardiologie*	7.383	339	21.227	259	6.759	72
		GOP 13586		GOP 13587		GOP 40910	
		AH	n Ä	AH	n Ä	AH	n Ä
TMZ: Betreuung ext. Geräte	Innere Medizin – SP Kardiologie*	10.258	253	1.096	56	10.064	247

Betrachtet man Tabelle 18, können folgende Sachverhalte abgeleitet werden:

- **Primär behandelnde/r Arzt/Ärztin - PBA:** Die Abrechnung der Indikationsprüfung bzw. der Betreuung von Versicherten im Telemonitoring Herzinsuffizienz erfolgte im Jahr 2023 zu ca. 90 % (2022: 88 %) durch die Fachgruppe der Inneren Medizin (14.518 bzw. 18.419 Abrechnungen) und nur zu ca. 10 % durch Hausärztinnen/-ärzte (1.541 bzw. 2.006 Abrechnungen). Unter Zuhilfenahme des Quotienten aus Abrechnungshäufigkeit und Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte: eine Ärztin/ein Arzt aus der Fachgruppe der Inneren Medizin stellte bei durchschnittlich 37 BHF die Indikation zum Telemonitoring (GOP 13578) bzw. betreute 54 BHF (GOP 13579), während eine Hausärztin/ein Hausarzt lediglich bei durchschnittlich 5,2 BHF die Indikation stellte (GOP 03325) bzw. 2,4 BHF (GOP 03326) betreute²⁹. Eine

²⁹ Auf einen Bezug zum Vorjahr wird an dieser Stelle verzichtet, da für das Jahr 2022 lediglich das 2. bis 4. Quartal ausgewertet wurden.

Versorgung durch Fachärztinnen/-ärzte der Kinder-/Jugendmedizin erfolgte generell nur in wenigen Einzelfällen.

- **Telemedizinisches Zentrum - TMZ:** Die Abrechnung erfolgte gemäß den Abrechnungsbestimmungen faktisch nur durch die Fachärzte/-ärztinnen der Inneren Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie.

Ungefähr 260 kardiologische Fachärztinnen/-ärzte betreuten ca. 21.200 Behandlungsfälle im Telemonitoring Herzinsuffizienz mit Aggregaten (GOP 13584) und ungefähr 255 Fachärztinnen/-ärzte betreuten ca. 10.300 BHF im Telemonitoring Herzinsuffizienz mit externen Geräten (GOP 13586). Dies entsprach einer durchschnittlichen Versorgung von ca. 82 BHF mit Aggregatsystem pro Ärztin/Arzt, bzw. 41 Versicherten mit externen Geräten pro Ärztin/Arzt. Im Vorjahreszeitraum 2. – 4. Quartal 2022 ergaben sich noch 15 BHF mit externen Geräten pro Ärztin/Arzt. Auch unter der Berücksichtigung des Aspektes, dass in der Auswertung 2022 ein ausgewertetes Quartal fehlte, zeigte sich hier eine deutliche Steigerung an BHF mit externen Geräten pro Arzt/Ärztin.

4.5 Anzahl zugelassener Ärztinnen und Ärzte zum Telemonitoring Herzinsuffizienz nach KV-Bezirken

Die Anzahl der zur Durchführung des Telemonitoring zugelassenen Ärztinnen und Ärzte zeigt Abbildung 22 als Ausschnitt aus dem KBV-Qualitätsbericht 2024 (Berichtsjahr 2023).

Kassenärztliche Vereinigungen	BW	BY	BE	BB	HB	HH	HE	MV	NI	NO	RP	SL	SN	ST	SH	TH	WL	ALLE
	5)		6)				7)				6)		6)					
✓ GENEHMIGUNGEN § 4 und § 8																		
Ärzte ¹⁾ mit Genehmigung, Stand 31.12.2022	88	107	24	7	8	37	40	10	22	56	11	2	41	14	8	18	20	513
Ärzte mit Genehmigung, Stand 31.12.2023	103	132	29	12	36	30	60	17	40	83	18	1	49	17	18	24	44	713
– abrechnende Ärzte (3. Quartal 2023)	38	29	15	11	4	17	25	13	21	83	15	0	18	17	10	12	17	345
beschiedene Anträge ²⁾	21	49	9	6	4	3	20	7	25	34	7	0	11	3	11	6	28	244
– davon Genehmigungen	21	44	8	6	4	1	20	7	25	34	7		10	3	11	6	28	235
– davon Ablehnungen	0	5	1	0	0	2	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	9

Abbildung 22: Anzahl der Ärztinnen/Ärzte mit Genehmigung zur Durchführung des Telemonitoring Herzinsuffizienz zum 31.12.2023 (erste Zeile) nach KV-Bezirken. Auszug aus dem KBV-Qualitätsbericht 2024 (Seite 114).³⁰

Nach Abbildung 22 waren Ende des Jahres 2023 gemäß § 4 und § 8 der Qualitätssicherungsverordnung Telemonitoring bei Herzinsuffizienz (QS-V TmHi) 713 Ärztinnen und Ärzte berechtigt, Leistungen eines TMZ im Rahmen des Telemonitoring bei Herzinsuffizienz abzurechnen (siehe Zeile 2). Nur 345 der berechtigten Ärztinnen und Ärzte rechneten jedoch Leistungen im Rahmen des Telemonitorings bei Herzinsuffizienz auf Ebene eines TMZ ab (Zeile 3). Diese Zahlen decken sich mit der in der Auswertung nach Fachgruppen in Kapitel 4.4 in diesem Bericht ermittelten Zahl von durchschnittlich 339 abrechnenden Ärztinnen/Ärzten pro Quartal im Jahr 2023.

³⁰Siehe [KBV-Qualitätsbericht 2024](#) (Berichtsjahr 2023) – Kassenärztliche Bundesvereinigung (kbv.de).

Eine Erhebung der Zulassung/Genehmigung auf Ebene von TMZ als physische Einrichtung liegen der KBV nicht vor. Den Stand der aktiv an der Versorgung durch Telemonitoring bei Herzinsuffizienz teilgenommenen Einrichtungen liefert Kapitel 4.6 des Berichts.

4.6 Stand der Versorgungseinrichtungen im 4. Quartal 2023

Neben den bei der KBV gemeldeten TMZ werden an dieser Stelle auf Grundlage der AST-Daten die Anzahl der im 4. Quartal 2023 abrechnenden PBA Betriebsstätten und TMZ-Einheiten angegeben. Durch die Abrechnungsbegrenzungen der von TMZ berechnungsfähigen Leistungen für die Betreuung von Patienten im Telemonitoring Herzinsuffizienz auf einmal je Behandlungsfall entsprechen die pro TMZ abgerechneten Leistungen der Anzahl an Behandlungsfällen eines jeweiligen TMZ. Je nachdem welche GOP ein TMZ abgerechnet hat, kann die Art der in diesem TMZ praktizierten Überwachung (nur Versicherte mit Aggregaten, Versicherte mit Aggregaten und Versicherte mit externen Geräten sowie nur Versicherte mit externen Geräten) und die Größe des betreuten Versichertenkollektivs eines TMZ bestimmt werden (Abbildung 23):

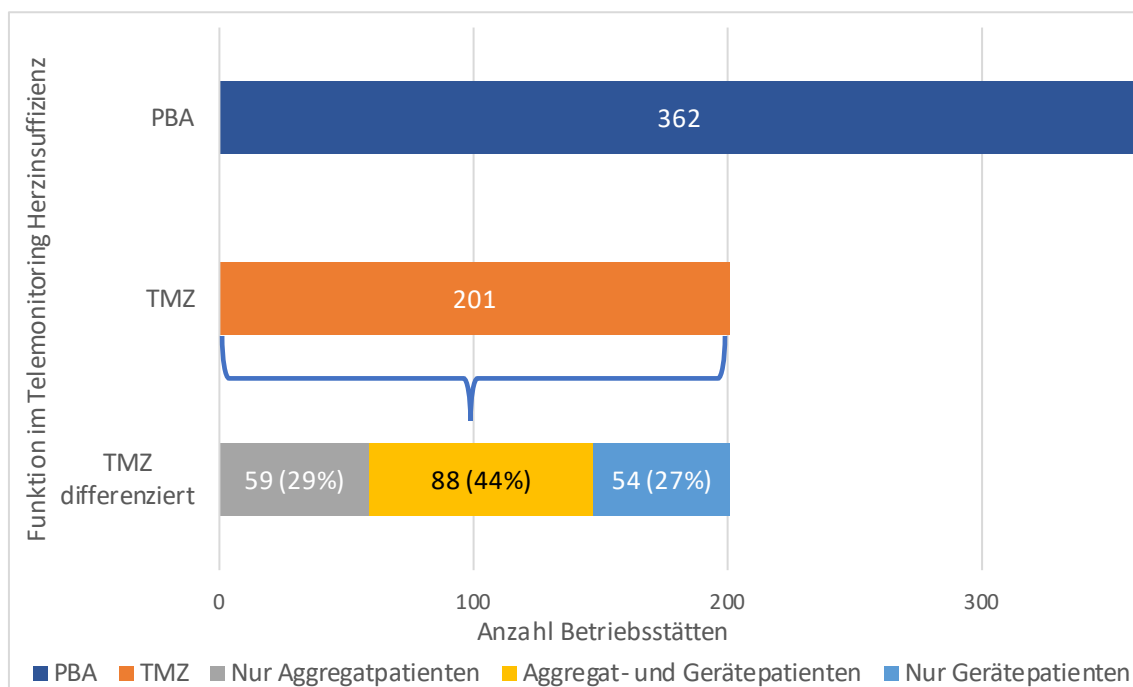


Abbildung 23 Anzahl der abrechnenden Betriebsstätten von primär behandelnden Ärztinnen/Ärzten (PBA) und telemedizinischen Zentren (TMZ) im 4. Quartal 2023. PBA: alle Einrichtungen mit mind. einer Abrechnung der GOP 03326 und/oder 04326 und/oder 13579. TMZ: alle Einrichtungen mit mind. einer Abrechnung der GOP 13584 (Aggregate) und/oder 13586 (ext. Geräte). TMZ differenziert: TMZ, die ausschließlich GOP 13584 oder 13586 abrechneten oder mind. eine Abrechnung der GOP 13584 und 13586 kombiniert abrechneten.

Abbildung 23 zeigt, dass im 4. Quartal 2023 Ärztinnen/Ärzte aus 362 Einrichtungen/Praxen Versicherte im Telemonitoring Herzinsuffizienz in Funktion als PBA betreut haben (ca. +10 %

gegenüber 4/2022). Die Anzahl an abrechnenden TMZ hingegen stieg deutlich von 113 TMZ im 4. Quartal 2022 auf 201 TMZ im 4. Quartal 2023 (ca. + 80 %).

Eine Anzahl von 59 der abrechnenden TMZ (ca. 29 %) überwachten lediglich Versicherte mit implantierten Aggregaten. Dieser Anteil hat sich gegenüber dem Vorjahresquartal 4/2022 (ca. 45 %) sichtbar vermindert. Einen deutlichen Zuwachs hinsichtlich der Anzahl und des Anteils war bei den TMZ, die sowohl Versicherte mit Aggregaten als auch mit externen Geräten überwachen, zu verzeichnen. Im 4. Quartal 2023 praktizierten 88 TMZ oder ca. 44 % beide Überwachungsformen (4. Quartal 2022: 34 TMZ (ca. 30 %)). Die Anzahl an TMZ, die ausschließlich Versicherte mit externen Geräten überwachten stieg zwar ebenfalls deutlich von 28 TMZ im 4. Quartal 2022 auf 54 TMZ im 4. Quartal 2023, jedoch blieb der Anteil mit ca. 27 % annähernd konstant gegenüber dem 4. Quartal 2022 (Anteil= ca. 25 %).

Die Verteilung der in Abbildung 23 am Telemonitoring Herzinsuffizienz teilnehmenden TMZ (blauer Balken) und PBA (orangefarbener Balken) auf die verschiedenen KV-Bezirke ist in Tabelle 68a bzw. Tabelle 68b im Anhang aufgeführt.

Größe von TMZ (Anzahl überwachter Versicherte) in Abhängigkeit von der Ausrichtung

Wie oben beschrieben praktizieren TMZ alle oder nur bestimmte Überwachungsformen in ihrer Einrichtung. Betrachtet man die durchschnittliche Menge an abgerechneten GOP und damit entsprechend die durchschnittliche Anzahl an Behandlungsfällen eines TMZ, können die durchschnittlichen Leistungshäufigkeiten des TMZ in Abhängigkeit von seiner praktizierten Überwachungsform bestimmt werden (Tabelle 19).

Tabelle 19 Durchschnittliche Leistungshäufigkeiten von telemedizinischen Zentren (TMZ) im 4. Quartal 2023 insgesamt und in Abhängigkeit von ihrer Ausrichtung auf die Art der Überwachung ihrer Versicherten. In Klammern sind die durchschnittlichen Abrechnungen - die der durchschnittlichen Anzahl an überwachten Versicherten entsprechen – angegeben.

	Anzahl TMZ	Anzahl GOP 13584 für Aggregate (Durchschnittliche Abrechnungen pro TMZ)	Anzahl GOP 13586 für ext. Geräte (Durchschnittliche Abrechnungen pro TMZ)
TMZ – alleinige Betreuung von Versicherten mit Aggregaten	59	2.832 (48)	---
TMZ – gemischte Betreuung von Versicherten mit Aggregaten und ext. Geräten	88	3.692 (42)	1.807 (21)
TMZ - alleinige Betreuung von Versicherten mit ext. Geräten	54	---	1.499 (28)
Anzahl Abrechnungen alle TMZ	201	6.524	3.306

Tabelle 19 zeigt, dass jedes von den 59 TMZ mit reiner Betreuung von Versicherten mit Aggregaten im Durchschnitt 48 Versicherte pro Quartal betreute (48-mal die GOP 13584 abrechnete). Dies ist eine deutliche Steigerung gegenüber der durchschnittlichen Betreuung von 36 Versicherten in TMZ dieser Art der Ausrichtung im 4. Quartal 2022. TMZ, die Patienten alleinig über

ihr Aggregatsystem überwachen, haben damit erkennbar bezüglich ihrer „Größe“ bzw. der Anzahl an betreuten Versicherten zugenommen.

54 TMZ überwachten ihre Versicherten im Telemonitoring ausschließlich mittels externer Geräte. Im Durchschnitt betreute ein solches TMZ dabei 28 Versicherte. Im 4. Quartal 2022 betrug dieser Durchschnitt noch 23 Abrechnungen pro TMZ – auch hier hat gegenüber dem Vorjahr ein Größenwachstum stattgefunden, allerdings betreuen diese TMZ damit weiterhin weniger Versicherte als TMZ, die Versicherte lediglich über ihr Aggregat überwachen.

Die Anzahl an TMZ mit gemischtem Versichertenkollektiv – d. h. TMZ die Versicherte sowohl mittels externer Geräte als auch mittels Aggregaten überwachen – stieg gegenüber dem Jahr 2022 deutlich auf aktuell 88 TMZ an. TMZ aus dieser Gruppe überwachten im 4. Quartal 2023 durchschnittlich 42 Versicherte über Aggregate und 21 Versicherte über externe Messgeräte. Damit erfolgte in diesen TMZ bei 2/3 der Versicherten (67 %) die Überwachung über Aggregate und bei einem Drittel (33 %) über externe Geräte. Im 4. Quartal 2022 betrug das Verhältnis noch 84 % zu 16 %. Damit hat sich der Anteil an Versicherten mit externen Messgeräten, die in TMZ mit gemischtem Versichertenkollektiv betreut werden, gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich erhöht.

Diese dargestellte Entwicklung hatte sich schon in der vom BA durchgeführten ersten Befragung aller bundesdeutschen TMZ im März 2023 abgezeichnet. Eine nennenswerte Anzahl an TMZ gab damals an, mit der Überwachung von Patienten über Aggregate und ggf. einigen Versicherten über externe Geräte zu beginnen, um dann den Anteil der letztgenannten Überwachungsform – nach Etablierung der Strukturen – im Verlauf zu steigern.

4.7 Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten im Telemonitoring Herzinsuffizienz

Die Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten mit Inanspruchnahme des Telemonitorings Herzinsuffizienz mittels implantierter Aggregate (GOP 13584) und mittels externer Geräte (GOP 13586) für das Jahr 2023 zeigen Abbildung 24 und Abbildung 25.

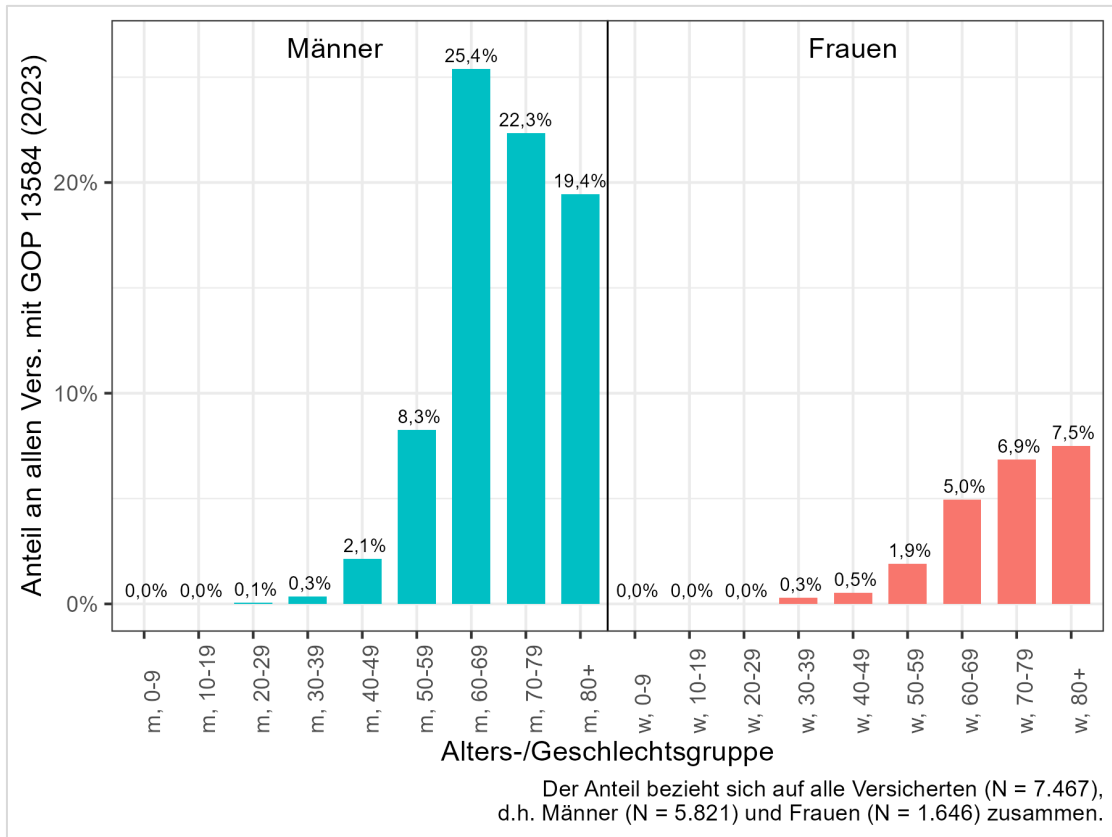


Abbildung 24 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten im Telemonitoring Herzinsuffizienz mittels implantierter Aggregate (GOP 13584); m = männlich, w = weiblich.

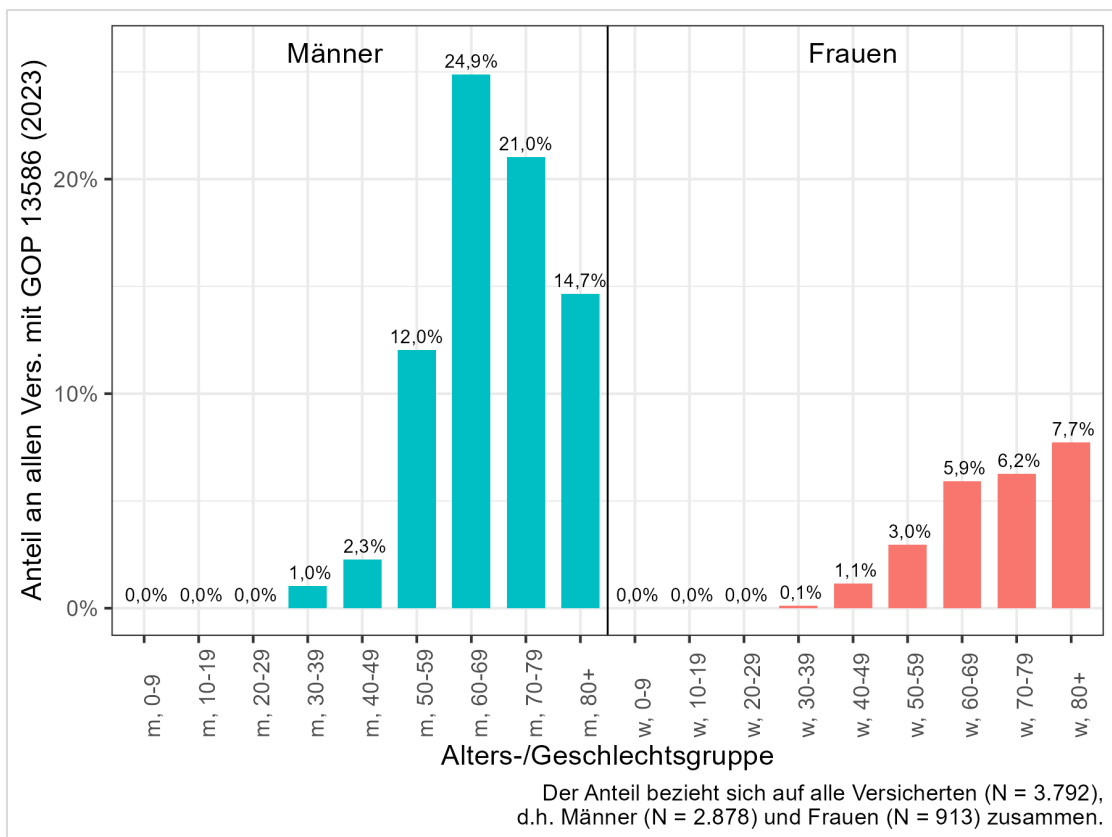


Abbildung 25 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten im Telemonitoring Herzinsuffizienz mittels externer Geräte (GOP 13586).

Unten in der Abbildung 24 und der Abbildung 25 ist ersichtlich, dass im gesamten Jahr 2023 ca. 11.000 Versicherte mittels Telemonitoring Herzinsuffizienz behandelt wurden – 7.500 davon mittels implantierter Aggregate (Abbildung 24) und 3.800 mittels externer Geräte (Abbildung 25). Bezüglich der abgebildeten Alters- und Geschlechtsverteilung im Telemonitoring Herzinsuffizienz ergaben sich keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Jahr 2022. Die Altersklasse der 60- bis 69-jährigen Männer wies – wie bereits im Jahr 2022 – sowohl bei Telemonitoring mit Aggregaten (Abbildung 24) als auch mit externen Geräten (Abbildung 25) mit jeweils ca. 25 % der Überwachungen den höchsten Anteil auf. Auch insgesamt war sowohl bei Versicherten im Telemonitoring Herzinsuffizienz mit Aggregatsystemen als auch bei Versicherten mit externen Geräten absolut und in allen Altersgruppen ein deutlich höherer Anteil an männlichen Versicherten vorzufinden (Abbildung 24, Abbildung 25). Insgesamt waren 76 % aller Versicherten im Telemonitoring Männer; in den Altersklassen schwankte das Verhältnis von Männern zu Frauen dabei von knapp 2:1 in der Gruppe der über 80-Jährigen bis fast 5:1 in der Altersgruppe von 60 bis 69 Jahren im Telemonitoring mittels Aggregaten. Mit zunehmendem Alter in den Gruppen stieg der Anteil der weiblichen Versicherten leicht an, passend zu einer erstens erhöhten Lebenserwartung und zweitens zu einer späteren Inzidenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei weiblichen Versicherten, der Hauptursache einer Herzinsuffizienz. Generell lässt sich darüber hinaus eine leichte Verschiebung der Verteilung von Versicherten mit externen Geräten in den jüngeren Altersgruppen bis 59 Jahren im Vergleich zur Verteilung der Versicherten mit implantiertem Aggregatsystem erkennen.

5 Telemedizinische Funktionsanalysen von ICD- und CRT-Geräten

5.1 Allgemeine Erläuterungen

Begrifflichkeiten

Für die Behandlung von schwerwiegenden Rhythmusstörungen der Herzkammern (ventrikulären Tachyarrhythmien) und Formen der Herzschwäche (Herzinsuffizienz) können aktive kardiale implantierbare Aggregate eingesetzt werden. Man unterscheidet dabei zwischen implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren (ICD) und Aggregaten zur kardialen Resynchronisationstherapie (CRT-P). CRT-Systeme können darüber hinaus zusätzlich mit einer Defibrillator-Funktion kombiniert werden (sog. CRT-D).

Bei jedem Implantat-Typus ist eine regelmäßige ärztliche Nachsorge erforderlich, die auch als Fernnachsorge telemedizinisch erfolgen kann. Primäres Ziel bei der Fernnachsorge ist die Kontrolle in Form einer routinemäßigen Übertragung von Daten zu definierten Zeitpunkten. Dadurch kann ein persönlicher Arztkontakt unter Umständen überflüssig werden.

Bei der Nachsorge wird die technische Funktionsfähigkeit des Gerätes überprüft, aber auch gespeicherte Ereignisse ausgelesen. Das Kontrollintervall ist dabei abhängig von der (Schwere der) Erkrankung und Geräteart. Durch ein für den Versicherten hörbares akustisches Signal kann das implantierte Aggregat aber auch zu einer außerplanmäßigen Kontrolle alarmieren. Mit der Möglichkeit der Nutzung eines Transmitters für die Datenübertragung bieten viele Geräte-Hersteller eine Cloud zum Upload der Daten an. Diese Daten sind dann für die Ärztin oder den Arzt bei Inanspruchnahme des Cloud-Dienstes zugänglich.

Rechtlicher Hintergrund

Im Rahmen der Umsetzung des gesetzlichen Auftrags aus dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz³¹ gemäß § 87 Abs. 2a SGB V zur Überprüfung der Durchführbarkeit telemedizinischer Leistungen und des daraus resultierenden Anpassungsbedarfs des EBM werden telemedizinische Funktionsanalysen von ICD- und CRT-Geräten seit dem 2. Quartal 2016 vergütet.

5.2 Regelungen und Vergütung im EBM

Seit dem 1. Oktober 2017 ist die telemedizinische Funktionsanalyse nicht mehr durch eine einzelne Gebührenordnungsposition berechnungsfähig, sondern in folgenden Leistungen getrennt nach den Aggregattypen ICD und CRT, jeweils für Fachärztinnen/-ärzte der Inneren Medizin und Kardiologie (s.u.) und für Ärzte/Ärztinnen der Kinder- und Jugendmedizin (Tabelle 20):

³¹ Siehe [GKV-Versorgungsstrukturgesetz](#) vom 22. 12. 2011 – Bundesgesetzblatt I S. 2983 (bgbl.de).

Tabelle 20 Gebührenordnungspositionen für die telemedizinischen Kontrollen (Funktionsanalysen) von ICD- und CRT-Geräten für Kardiologinnen/Kardiologen (GOP 13574; GOP 13576) und die Kinder- und Jugendmedizin (GOP 04414; GOP 04416).

GOP	Bezeichnung	Punkte	€ (2023)
04414	Telemedizinische Funktionsanalyse eines implantierten Kardioverters bzw. Defibrillators bei Kindern	732	84,12
04416	Telemedizinische Funktionsanalyse eines implantierten Systems zur kardialen Resynchronisationstherapie (CRT-P, CRT-D) bei Kindern	901	103,54
13574	Telemedizinische Funktionsanalyse eines implantierten Kardioverters bzw. Defibrillators bei Erwachsenen	400	45,97
13576	Telemedizinische Funktionsanalyse eines implantierten Systems zur kardialen Resynchronisationstherapie (CRT-P, CRT-D) bei Erwachsenen	492	56,54

Die telemedizinischen Gebührenordnungspositionen sind mit den Gebührenordnungspositionen zur konventionellen – d. h. im persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt stattfindenden – Funktionsanalyse in ihrer Abrechnungshäufigkeit verknüpft und dürfen gemeinsam mit ihrer gespiegelten konventionellen Gebührenordnungsposition in Summe fünfmal im Krankheitsfall³² abgerechnet werden. Einmal im Krankheitsfall soll davon mindestens eine Funktionsanalyse im persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt erfolgen. Die letzte Vergütungsanpassung dieser Gebührenordnungspositionen erfolgte zum 1. Januar 2019.³³ Die Historie der Anpassungen ist im Vorbericht aus dem Jahr 2020 detailliert dargestellt. Die Abrechnung sämtlicher Funktionsanalysen setzt eine Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung nach der Qualitätssicherungsvereinbarung zur Rhythmusimplantat-Kontrolle³⁴ voraus. Abrechnungsberechtigt sind nach dieser Fachärztinnen/Fachärzte für Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie bzw. der Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunktbezeichnung Kinder-Kardiologie oder für Innere Medizin bzw. für Kinder/Jugendmedizin, wenn zusätzliche, spezifische Qualifikationen nach der QS-V Rhythmusimplantat-Kontrolle bestehen.

Für eine im Rahmen der telemedizinischen Fernüberwachung notwendige (telefonische) Kontaktaufnahme mit dem Versicherten kann die GOP 01438 bis zu dreimal im Krankheitsfall berechnet werden, diese ist allerdings nicht Gegenstand des Berichts.

Im Berichtszeitraum wurden keine neuen Beschlüsse zur Telemedizinischen Funktionsanalyse gefasst.

³² Ein Krankheitsfall umfasst das aktuelle sowie die drei nachfolgenden Quartale, die der Berechnung der krankheitsfallbezogenen Gebührenordnungsposition folgen.

³³ [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 435. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de); rückwirkend zum 1. Januar 2019.

³⁴ [QS-Vereinbarung](#) Rhythmusimplantat-Kontrolle; Inkrafttreten: 01.10.2018 – Kassenärztliche Bundesvereinigung (kbv.de).

5.3 Leistungsentwicklung

In diesem Kapitel des Berichts wird die Leistungsentwicklung der Leistungen zur telemedizinischen Funktionsanalyse für Erwachsene (GOP 13574 und GOP 13576) dargestellt. Die Gebührenordnungspositionen im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin (GOP 04414 und GOP 04416) wurden mit jährlich weniger als 15 Abrechnungen in Deutschland sehr selten abgerechnet. Die Ergebnisse sind daher an dieser Stelle nicht gesondert dargestellt, sind allerdings immer den zugehörigen Tabellen im Anhang zu entnehmen (Tabelle 69 bis Tabelle 73).

Abrechnungshäufigkeit

Abbildung 26 zeigt die jährliche Abrechnungshäufigkeit der GOP 13574 und GOP 13576 für die telemedizinische Funktionsanalyse bei Erwachsenen:

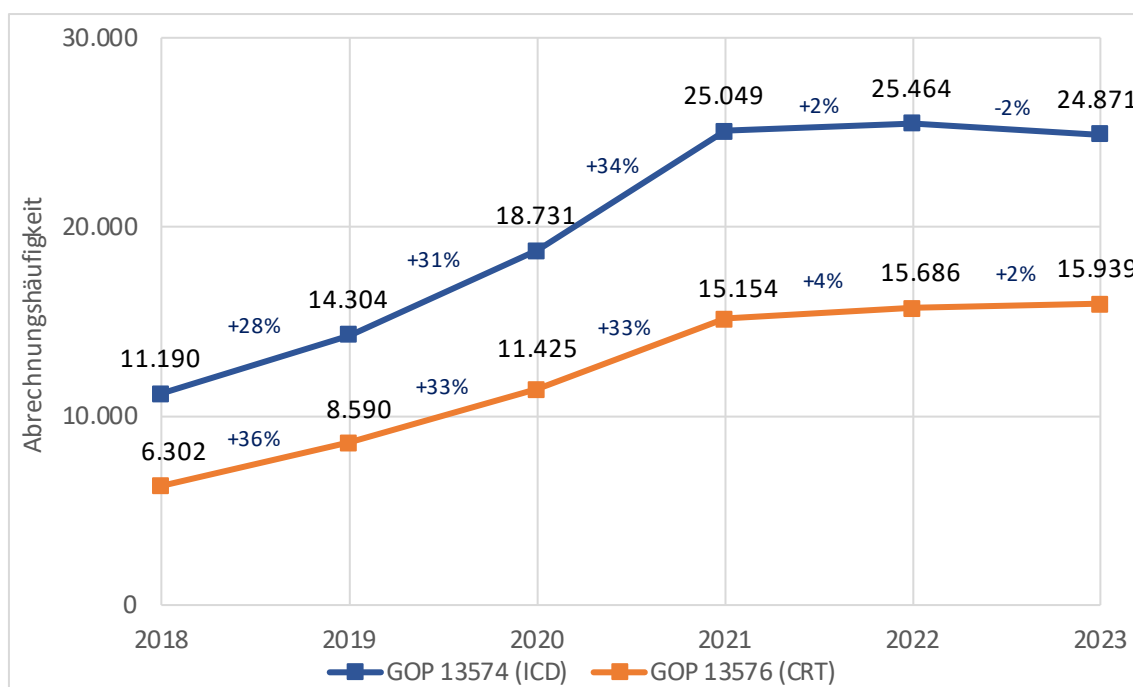


Abbildung 26 Abrechnungshäufigkeit der telemedizinischen Funktionsanalyse von ICD- (GOP 13574) und CRT-Aggregaten (GOP 13576) bei Erwachsenen in den Jahren 2018 bis 2023.

Beide Gebührenordnungspositionen der telemedizinischen Funktionsanalyse für Erwachsene (GOP 13574 für ICD-Aggregate und GOP 13576 für CRT-Aggregate) zeigten in den Jahren 2018 bis 2021 einen kontinuierlichen deutlichen Anstieg der Abrechnungshäufigkeit. Nach dem Jahr 2021 war eine deutliche Abschwächung des Anstiegs zu verzeichnen. Stieg die Abrechnungshäufigkeit bei beiden Leistungen vom Jahr 2020 auf das Jahr 2021 noch um 34 % bzw. 33 %, war in den letzten beiden Jahren lediglich Steigerungen im unteren einstelligen Prozentbereich zu verzeichnen. Die Abrechnungshäufigkeit der GOP 13576 ging vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 sogar um 2 % zurück (s.a. Tabelle 67 im Anhang). Das Verhältnis der beiden telemedizinischen Funktionsanalysen zueinander blieb dabei weitestgehend konstant: Im Jahr 2023

erfolgten ungefähr 39 % der gesamten telemedizinischen Funktionsanalysen im Rahmen von CRT-Kontrollen und ca. 61 % im Rahmen von ICD-Kontrollen.

Die Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit bei den telemedizinischen Funktionsanalysen setzte sich in den Vorjahren insgesamt sichtbar von der Entwicklung der im persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt, also nicht-telemedizinisch, durchgeführten Funktionsanalysen (GOP 13573 und GOP 13575) ab. Im Jahr 2023 sind dagegen sehr ähnliche Wachstumsraten zu verzeichnen (Tabelle 21).

*Tabelle 21 Abrechnungshäufigkeit pro Jahr der Funktionsanalyse im **persönlichen** Arzt-Patienten-Kontakt bei Erwachsenen für ICD- und CRT-Aggregate. In Klammern ist die Entwicklung in % im Vergleich zum Vorjahr angegeben.*

Jahr	AH GOP 13573 (ICD-Aggregate, persönlicher Kontakt)	AH GOP 13575 (CRT-Aggregate, persönlicher Kontakt)
2018	214.182	111.615
2019	210.151 (–2%)	119.098 (+7%)
2020	198.366 (–6%)	122.299 (+3%)
2021	201.209 (+1%)	129.457 (+6%)
2022	191.454 (–5%)	126.819 (–2%)
2023	190.874 (0%)	129.927 (+2%)

Leistungsbedarf

Der Leistungsbedarf der Leistungen für die telemedizinische Funktionsanalyse zeigte eine gleichsinnige Entwicklung zur Abrechnungshäufigkeit (Abbildung 27).

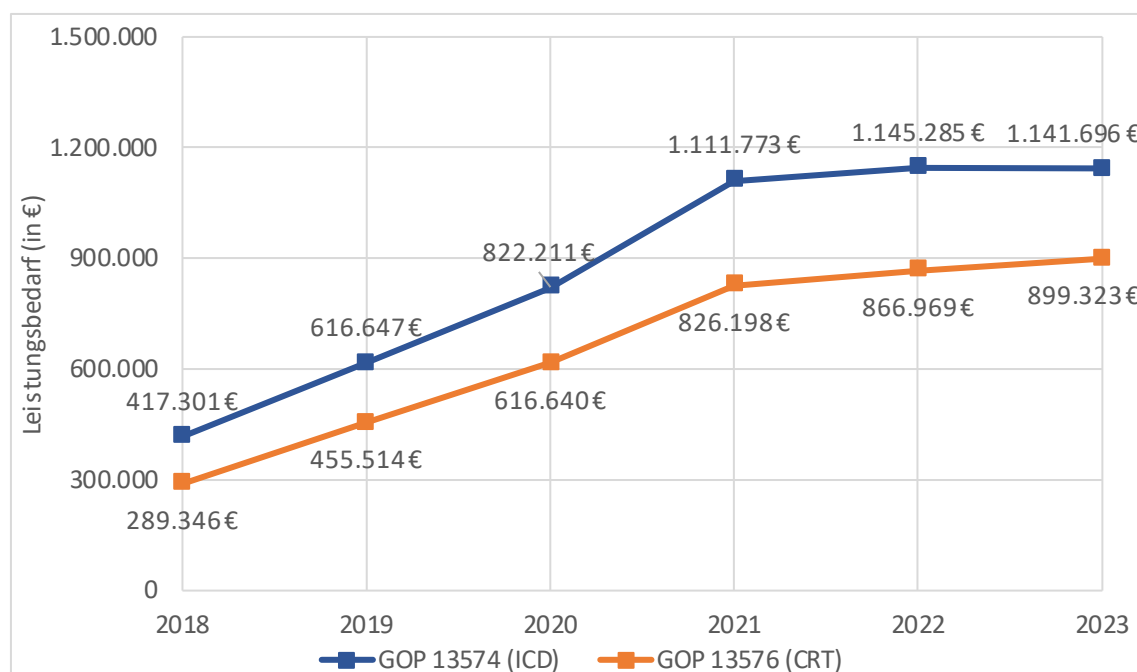


Abbildung 27 Leistungsbedarf in € der telemedizinischen Funktionsanalyse von ICD-Aggregaten (GOP 13574) und CRT-Aggregaten (GOP 13576) bei Erwachsenen in den Jahren 2018 bis 2023.

Da keine Finanzierungsanpassungen der Leistungen erfolgten, folgte der Verlauf des Leistungsbedarfes in Abbildung 27 im Wesentlichen dem der Abrechnungshäufigkeit. Im Jahr 2023 betrug der Bedarf der telemedizinischen Funktionsanalyse für ICD-Aggregate über 1,1 Mio. €, für CRT-Aggregate ca. 900.000 €.

Tabelle 69 und Tabelle 70 im Anhang weisen die Quartalswerte für die Abrechnungshäufigkeit und den Leistungsbedarf (€) für die GOP 13574, GOP 13576 (Erwachsene) und für die GOP 04414, GOP 04416 (Kinder) aus. Die Jahresverlaufswerte sind auch der Tabelle 71 im Anhang zu entnehmen.

5.4 Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit sowie nach Fachgruppen und Einrichtungen

Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit

Die Leistungen zur telemedizinischen Funktionsanalyse bei Erwachsenen wurden unterschiedlich häufig in verschiedenen KV-Bezirken abgerechnet. Abbildung 28 zeigt diese Abrechnungshäufigkeit pro 100.000 Versicherte eines KV-Bezirk für das Jahr 2023.

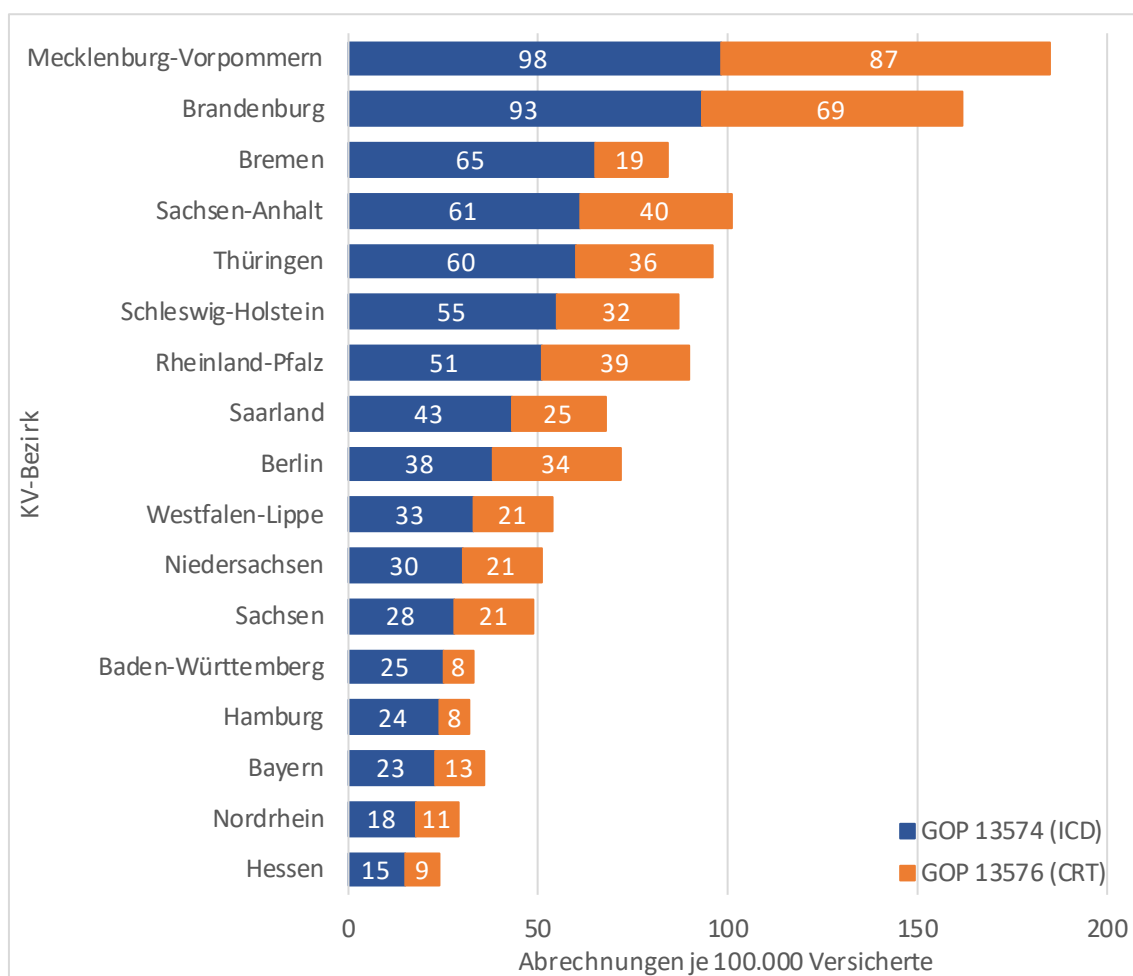


Abbildung 28 Regionale Abrechnungshäufigkeit der GOP 13574 (ICD) und GOP 13576 (CRT) nach KV-Bezirken im Jahr 2023. Dargestellt ist die normierte Abrechnungshäufigkeit je 100.000 Versicherte. Sortiert nach der Abrechnungshäufigkeit der GOP 13574.

Abbildung 28 zeigt, dass insbesondere in den Flächenländern Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg mit mehr als 160 Abrechnungen pro 100.000 Versicherte in dem KV-Bezirk vergleichsweise häufig auf die telemedizinische Funktionsanalyse zurückgegriffen wurde. In anderen Flächenländern, wie z. B. Bayern, Nordrhein und Hessen wurden im Verhältnis wesentlich weniger Funktionsanalysen telemedizinisch durchgeführt.

Insgesamt haben sich im Jahr 2023 bei der regionalen Abrechnungshäufigkeit gegenüber dem Vorjahr 2022 keine wesentlichen Änderungen ergeben.

Die absolute Abrechnungshäufigkeit der KV-Bezirke – also ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Versichertenzahlen – sind der Tabelle 72 im Anhang zu entnehmen.

Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Fachgruppen

Die GOP 13574 (ICD) und GOP 13576 (CRT) können nur von Kardiologinnen/Kardiologen oder Internisten bei vorliegender Genehmigung der KV nach der QS-V Rhythmusimplantat-Kontrolle berechnet werden. Tabelle 22 zeigt die Abrechnungshäufigkeit und die Anzahl der abrechnenden Ärztinnen und Ärzte.

Tabelle 22 Abrechnungshäufigkeit und Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte der telemedizinischen Funktionsanalyse bei Erwachsenen im Jahr 2023.

	Abrechnungshäufigkeit (AH) und Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte (n Ä) im Jahr 2022			
	GOP 13574 (ICD)		GOP 13576 (CRT)	
	AH	n Ä	AH	n Ä
Fachärzte der Inneren Medizin (berechtigt nach QS-V Rhythmusimplantat-Kontrolle)	24.871	644	15.939	505

Die Leistungen zur telemedizinischen Funktionsanalyse wurden im Jahr 2023 von 644 (GOP 13574) bzw. 505 (GOP 13576) berechtigten Internistinnen/Internisten durchgeführt. Dies entsprach einer durchschnittlichen Abrechnungshäufigkeit von ~38 Abrechnungen der GOP 13574 bzw. ~32 Abrechnungen der GOP 13576 je Arzt/Ärztin – hierbei gab es gegenüber dem Jahr 2022 keine nennenswerte Änderung.

In der Kinder- und Jugendmedizin rechneten jeweils weniger als 5 Ärzte/Ärztinnen eine GOP 04414 oder 04416 ab. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 73 im Anhang. Dort ist auch eine Aufteilung nach Fachgruppen vorgenommen worden.

Auswertung nach Einrichtungsform

Die Auswertung nach der Form der Einrichtung für das Jahr 2023 zeigt Tabelle 23.

Tabelle 23 Abrechnungshäufigkeit der telemedizinischen Funktionsanalyse im Jahr 2023 nach Einrichtungsform und mittlere Abrechnungshäufigkeit pro abrechnende Einrichtung.

Einrichtungsform	Abrechnungshäufigkeit im Jahr 2023 (durchschnittliche Abrechnungen je Einrichtung)			
	GOP 04414 (ICD)	GOP 04416 (CRT)	GOP 13574 (ICD)	GOP 13576 (CRT)
Gemeinschaftspraxis	12 (6)	.	10.319 (65)	6.799 (54)
Einzelpraxis	.	.	7.728 (47)	4.515 (33)
Sonstige	.	.	3.759 (102)	2.586 (89)
MVZ	.	≤5 (1)	3.065 (44)	2.039 (35)

Die Anteile der Funktionsanalysen in Tabelle 23 waren bei den telemedizinischen ICD-Kontrollen und CRT-Kontrollen ähnlich verteilt. Ungefähr 41-43 % der Kontrollen erfolgten in Gemeinschaftspraxen und 28-31 % in Einzelpraxen. Immerhin 15-16 % der telemedizinischen Kontrollen erfolgten durch „sonstige Einrichtungen“. Darunter fallen z. B. stationäre Einrichtungen, die ermächtigt sind, über den ambulanten Bereich abzurechnen. Hier erfolgten mit durchschnittlich über 100 bzw. 89 Abrechnungen auch die meisten Abrechnungen pro abrechnende Einrichtung.

5.5 Anteil telemedizinischer Funktionsanalysen an allen ICD- und CRT-Funktionsanalysen

Betrachtet man den Anteil der Abrechnungshäufigkeit der telemedizinischen Funktionsanalysen an allen Funktionsanalysen, zeigt sich folgendes Bild (Abbildung 29):

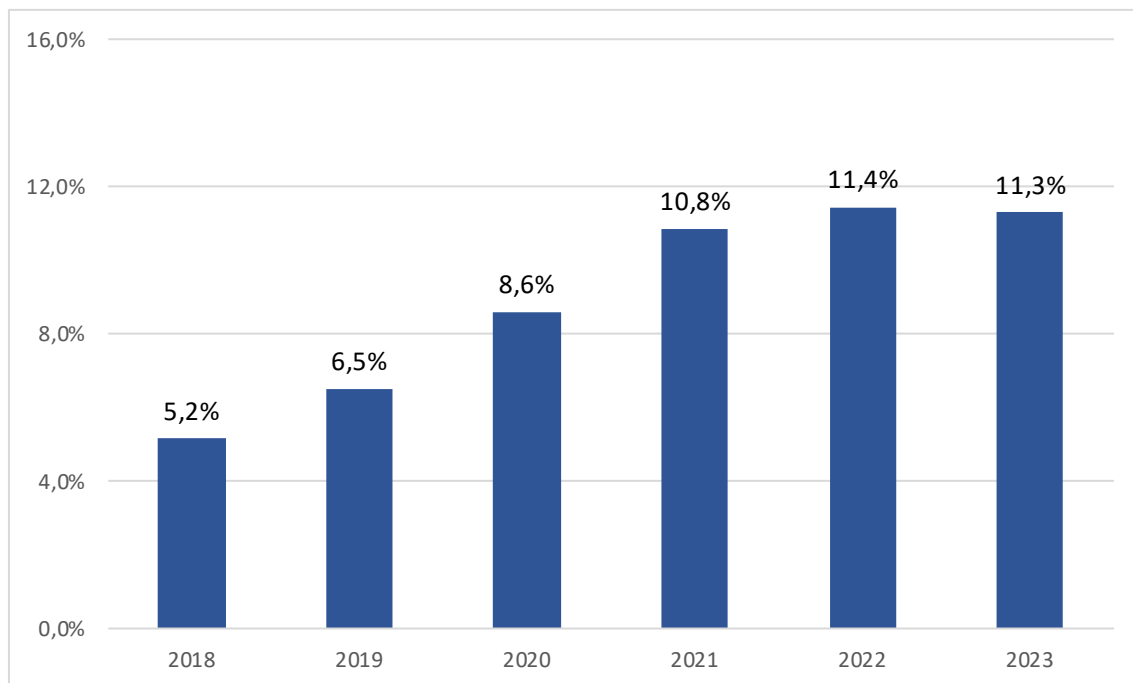


Abbildung 29 Anteil telemedizinischer Funktionsanalysen (GOP 04414, 04416, 13574, 13576) an allen ICD- und CRT-Funktionsanalysen (persönlich und/oder telemedizinisch).

In Abbildung 29 ist die in Kapitel 5.3 des Berichts gezeigte überproportionale Steigerung der Abrechnungshäufigkeit telemedizinischer Funktionsanalysen (GOP 04414, 04416, 13574, 13576) gegenüber allen ICD- und CRT-Funktionsanalysen direkt an dem wachsenden Anteil telemedizinischer Funktionsanalysen auf bis zu 10,8 % im Jahr 2021 zu erkennen. Mit der Abschwächung der Steigerung der Abrechnungshäufigkeit zum Jahr 2022 bzw. dem leichten Rückgang zum Jahr 2023 hin stagniert bzw. sinkt der aktuelle Anteil an telemedizinischen Funktionsanalysen an allen Funktionsanalysen in der aktuellen Auswertung.

Die konventionelle Funktionsanalyse stellt sich damit weiterhin als dominierende Praktik dar. Dieser Umstand ist nicht verwunderlich, da notwendige Umprogrammierungen von Geräteparametern im persönlichen Kontakt erfolgen müssen und zusätzlich auch außerhalb des Kontrollintervalls Funktionsanalysen im persönlichen Kontakt erfolgen, beispielsweise wenn sich Versicherte mit akuten Beschwerden oder Problemen an die Ärztin oder den Arzt wenden.

Die Veränderungen der Abrechnungshäufigkeit von telemedizinischen Funktionsanalysen spiegelt nicht zwangsläufig eine gleichsinnige Veränderung bezüglich der Versichertenanzahl in der telemedizinischen Funktionsanalyse wider, da pro Jahr/Krankheitsfall mehrere Funktionsanalysen pro Versicherte/r und ggf. auch pro Behandlungsfall durchgeführt werden können. Die in Kapitel 5.6.1 des Berichts dargestellte Analyse auf der Ebene von Behandlungsfällen untersucht diesen Umstand.

5.6 Behandlungsfälle und Versicherte mit Telemedizinischer Funktionsanalyse

Die Anzahl an Behandlungsfällen mit mindestens einer telemedizinischen Funktionsanalyse und die entsprechende Anzahl an Versicherten zeigt Tabelle 24.

Tabelle 24 Anzahl der BHF und Versicherten mit mindestens einer durchgeführten telemedizinischen Funktionsanalyse

	2020	2021	2022	2023
Anzahl BHF	29.331	38.879	39.860	39.792
Anzahl Versicherte	12.270	15.625	15.796	15.258
BHF/Versicherten	2,4	2,5	2,5	2,6

Im Jahr 2023 wurde in ca. 40.000 Behandlungsfällen mindestens eine telemedizinische Funktionsanalyse durchgeführt, die sich auf ca. 15.300 Versicherte verteilten. Rechnerisch wurde damit bei einem Versicherten mit telemedizinischer Funktionsanalyse diese in ca. 2,6 BHF bzw. Quartalen im Jahr 2023 durchgeführt.

5.6.1 Anteil telemedizinischer Funktionsanalysen an allen ICD- und CRT-Funktionsanalysen auf Behandlungsfallebene

Analog der in Kapitel 5.5 des Berichts erstellten Analyse zum Anteil telemedizinischer Funktionsanalysen an allen Funktionsanalysen auf Basis der Abrechnungshäufigkeit kann auch auf Ebene von Behandlungsfällen geprüft werden, bei welchem Anteil an Behandlungsfällen mindestens einmal in dem betreffenden Quartal eine telemedizinische Funktionsanalyse durchgeführt wurde.

Abbildung 30 bildet die Verteilung des Anteils von Behandlungsfällen in der telemedizinischen Funktionsanalyse unter regionaler KV-Zugehörigkeit ab.

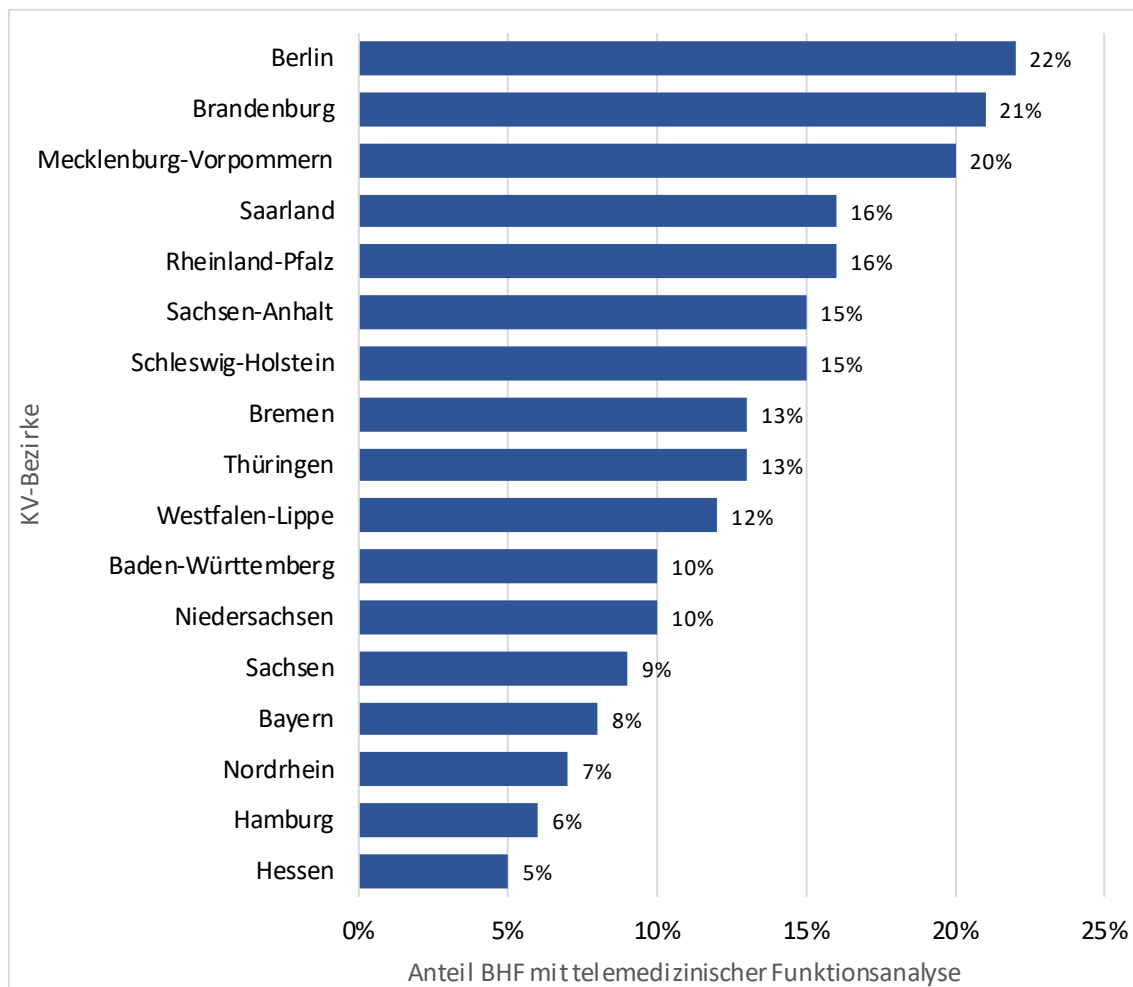


Abbildung 30 Anteile in % der Behandlungsfälle, die mind. eine telemedizinische Funktionsanalyse erhalten haben, an allen Behandlungsfällen mit einer erfolgten Funktionsanalyse in den KV-Bezirken im Jahr 2023.

Die in Abbildung 30 dargestellten hohen Anteile der Behandlungsfälle mit telemedizinischer Funktionsanalyse zeigen, dass die Abrechnungshäufigkeit der telemedizinischen Funktionsanalyse nicht nur auf eine (mögliche) höhere Kontrolldichte/Abrechnungshäufigkeit bei einem telemedizinisch kontrollierten Versichertenkollektiv zurückzuführen ist, sondern real durch eine nennenswerte Anzahl Versicherte bedingt ist, die eine telemedizinische Funktionsanalyse erhalten. Auffallend ist die hohe Schwankungsbreite der Anteile von Behandlungsfällen mit telemedizinischer Funktionsanalyse zwischen den KV-Bezirken: So wurde in den KV-Bezirken Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bei ungefähr jedem fünften BHF mit abgerechneten Funktionsanalysen mindestens eine telemedizinische Funktionsanalyse durchgeführt, gegenüber einem Anteil von 5 % im KV-Bezirk Hessen.

Gegenüber dem Jahr 2022 zeigten insbesondere die KV-Bezirke Berlin und Saarland eine Steigerung des Anteils an BHF mit telemedizinischer Funktionsanalyse um 4 bzw. 3 Prozentpunkte. Der höchste Rückgang war im KV-Bezirk Brandenburg zu verzeichnen: Wurde im Jahr 2022 noch bei 26 % der BHF mit telemedizinischer Funktionsanalyse mindestens eine davon telemedizinisch durchgeführt, war dieses im Jahr 2023 lediglich bei 21 % der BHF der Fall.

6 Telekonsiliarische Befundbeurteilung radiologischer Aufnahmen

6.1 Allgemeine Erläuterungen

Begrifflichkeiten

Radiologische Telekonsilien, oder auch radiologische telemedizinische Konsilien, können zwischen Fachärztinnen und Fachärzten genutzt werden, um sich auf elektronischem Weg über eine patientenbezogene medizinische Fragestellung auszutauschen.

Das radiologische Telekonsilium bietet Vertragsärztinnen/Vertragsärzten dabei die Möglichkeit, Röntgenbilder oder CT-Bilder anderen Ärztinnen/Ärzten datentechnisch sicher, zuverlässig und zeitversetzt zur Verfügung zu stellen. Dadurch können untersuchungsbezogene medizinische Fragestellungen außerhalb des Fachgebiets des behandelnden Arztes bzw. der behandelnden Ärztin oder besonders komplexe medizinische Fragestellungen, die die Befundung einer zweiten Ärztin oder eines zweiten Arztes erfordern, erörtert werden.

Rechtlicher Hintergrund

Im Zuge seines gesetzlichen Auftrages nach § 87 Abs. 2a Satz 14 SGB V schuf der Bewertungsausschuss mit Beschluss in seiner 386. Sitzung³⁵ die Abrechnungsvoraussetzungen im EBM für die konsiliarische Befundbeurteilung von Röntgen- und CT-Aufnahmen in der vertragsärztlichen Versorgung. Die technischen Anforderungen hierzu fußen dabei auf der Anlage 31a zum BMV-Ä.³⁶

6.2 Regelungen und Vergütung im EBM

Zur Abbildung telekonsiliarischer Befundbeurteilungen von Röntgen- und CT-Aufnahmen im EBM wurde mit dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 386. Sitzung ein neuer Abschnitt 34.8 (Telekonsiliarische Befundbeurteilungen von Röntgenaufnahmen und CT-Aufnahmen) zum 1. April 2017 mit den folgenden neuen Gebührenordnungspositionen in den EBM aufgenommen (Tabelle 25):

³⁵ [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 386. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

³⁶ [Vereinbarung](#) Radiologische Telekonsilien; Stand: 01.07.2016 – Kassenärztliche Bundesvereinigung (kbv.de).

Tabelle 25 Gebührenordnungspositionen für die Beauftragung und Durchführung einer telekonsiliarischen Befundbeurteilung.

GOP	Bezeichnung	Punkte	€ (2023)
34800	Beauftragung konsiliarische Befundbeurteilung	91	10,46
34810	Telekonsiliarische Befundbeurteilung Röntgen	110	12,64
34820	Telekonsiliarische Befundbeurteilung CT I	276	31,72
34821	Telekonsiliarische Befundbeurteilung CT II Für komplexere CT-Untersuchungen, wie des Gehirns, der Wirbelsäule oder des Bauchraumes	389	44,70

Mit der GOP 34800 werden sowohl die ärztliche Leistung im Zusammenhang mit der Einholung einer telekonsiliarischen Befundbeurteilung als auch die beim elektronischen Versand der Aufnahmen entstehenden Kosten der Übermittlung vergütet. Die Vergütung ist auf höchstens 3,75 % der Behandlungsfälle mit mindestens einer Röntgenleistung begrenzt.

Mit den GOP 34810, GOP 34820 und GOP 34821 werden die ärztlichen Leistungen der Konsiliarärztin oder des Konsiliararztes im Zusammenhang mit der telekonsiliarischen Befundung von Röntgen- und CT-Aufnahmen sowie die beim elektronischen Versand des Konsiliarberichts entstehenden Kosten der Übermittlung vergütet.

Radiologische Telekonsilien dürfen nur Vertragsärztinnen und Vertragsärzte durchführen oder veranlassen, die über eine entsprechende Genehmigung für Röntgen- und/oder CT-Untersuchungen verfügen und die Anforderungen gemäß Röntgenverordnung erfüllen. MRT-Untersuchungen und dynamische Untersuchungen sind im Rahmen dieser telekonsiliarischen Befundung nach den vorgenannten Gebührenordnungspositionen nicht umfasst. Im Zusammenhang mit der Durchführung von sektorenübergreifenden Telekonsilien (GOP 01670 bis 01672), die nicht auf bestimmte Indikationen oder Befundarten begrenzt sind, können MRT-Untersuchungen und dynamische Untersuchungen Gegenstand eines Telekonsiliums sein. Sektorenübergreifende Telekonsilien werden in Teil B dieses Berichts vorgestellt (siehe Kapitel 12 des Berichts).

Radiologische Telekonsilien können nur berechnet werden, wenn die Voraussetzungen gemäß der Anlage 31a zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) erfüllt sind.

Mit den Beschlüssen aus den Sitzungen des 603. und 664. BA, welche die Finanzierungsregelung außerhalb der MGV zusammentragen, wurde die Finanzierung der telekonsiliarischen Befundbeurteilung radiologischer Aufnahmen für das Jahr 2023 bzw. 2024 weiterhin über eine extra-budgetäre Vergütung gewährleistet.

Tabelle 26 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zur telekonsiliarischen Befundbeurteilung, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden. MGV = morbiditätsbedingte Gesamtvergütung.

Kategorie	Beschluss	Inkrafttreten	Inhalt/GOP	Laufzeit/Befristung
Finanzierung	603. BA	01.01.2023	Vergütung telekonsiliarische Befundbeurteilung außerhalb der MGV	31.12.2023
Finanzierung	664. BA	01.01.2024	Vergütung telekonsiliarische Befundbeurteilung außerhalb der MGV	31.12.2024

6.3 Leistungsentwicklung

In Tabelle 27 werden die jährliche Abrechnungshäufigkeit und der Leistungsbedarf (in €) der Gebührenordnungspositionen des Abschnitts 34.8 EBM (Telekonsiliarische Befundbeurteilungen von Röntgenaufnahmen und CT-Aufnahmen) dargestellt.

Tabelle 27 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € der Leistungen zur telekonsiliarischen Befundbeurteilung radiologischer Aufnahmen. Dargestellt sind Jahreswerte. Auf eine Darstellung der prozentualen Veränderungen zum jeweiligen Vorjahreswert wurde verzichtet.

Jahr	Abrechnungshäufigkeit				Leistungsbedarf in €			
	GOP 34800	GOP 34810	GOP 34820	GOP 34821	GOP 34800	GOP 34810	GOP 34820	GOP 34821
2018	1.190	388	18	7	1.429	4.547	529	290
2019	≤5	.	14	≤5	10	.	418	126
2020	134	≤5	94	≤5	1.340	2.850	43	.
2021	229	≤5	80	.	2.317	12	2.456	.
2022	231	.	51	≤5	2.307	.	1.586	44
2023	203	<5	21	.	2.020	13	666	.

Aufgrund der insgesamt vorliegenden sehr geringen Abrechnungszahlen stellt Tabelle 27 die Jahreswerte der Abrechnungshäufigkeit und des Leistungsbedarfes dar.

Bei der Beauftragung einer konsiliarischen Befundbeurteilung (GOP 34800) zeigte sich im Jahr 2023 ein Rückgang der Abrechnungshäufigkeit um 12 % gegenüber dem Vorjahr auf 203 Abrechnungen. Bei der Leistung telekonsiliarische Befundbeurteilung CT I (GOP 34820) setzt sich der seit dem Jahr 2020 bestehende Rückgang der Abrechnungshäufigkeit auf zuletzt 21 Abrechnungen fort (-59 % gegenüber 2022). Bezüglich der telekonsiliarischen Befundbeurteilung Röntgen (GOP 34810) und der telekonsiliarischen Befundbeurteilung CT II (GOP 34821) sind seit dem Jahr 2019 keine relevanten Abrechnungen mehr zu verzeichnen. Die Gründe für die geringe Abrechnungshäufigkeit sind dem Bewertungsausschuss weiterhin nicht bekannt.

Im Anhang sind in Tabelle 74 und Tabelle 75 die Abrechnungszahlen und der Leistungsbedarf pro Quartal verfügbar. Aufgrund der geringen Abrechnungszahlen wurde auf weitergehende Analysen verzichtet.

7 Elektronische Patientenakte

7.1 Allgemeine Erläuterungen

Begrifflichkeiten

Mit der elektronischen Patientenakte (ePA) wurde eines der zentralen Elemente der vernetzten Gesundheitsversorgung und der Telematikinfrastruktur geschaffen. Patientendaten, die bisher an verschiedenen Orten wie Praxen und Krankenhäusern erfasst und gespeichert wurden, können mit der ePA digital gebündelt werden. Die ePA ist eine freiwillig von der Patientin oder dem Patienten geführte, individuelle und lebenslange Akte.

Versicherte haben damit potenziell (und zukünftig) all ihre relevanten medizinischen Informationen wie Befunde, Diagnosen, Therapiemaßnahmen, Behandlungsberichte, den Medikationsplan und den Notfalldatensatz vorliegen und können diese ihren Ärztinnen, Ärzten, Therapeutinnen, Therapeuten, Apothekerinnen und Apothekern – auf Wunsch auch nur befristet – zur Verfügung stellen. Der Zugriff wird dabei protokolliert und ist nur nach Berechtigungsvergabe möglich.

Krankenkassen und die Betreiber der ePA haben grundsätzlich keinen Datenzugriff. Die Hoheit über die Befüllung der Akte und die Löschung von Informationen haben die Versicherten selbst. Ärztinnen, Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sollen die Versicherten auf deren Wunsch hin bei der Nutzung der ePA unterstützen (§ 346 Abs. 1 SGB V), dürfen Daten aber niemals automatisch ohne Zustimmung der Versicherten übertragen. Die Daten in der ePA sind Kopien der Primärdaten in der Praxis. Versicherte verwalten ihre ePA in der Regel über eine App, die ihnen ihre Krankenkasse seit 1. Januar 2021 auf Wunsch zur Verfügung stellen muss.

Seit dem 1. Juli 2021 müssen laut Gesetz alle Ärztinnen, Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten die notwendige Ausstattung vorhalten, um Daten über die Telematikinfrastruktur in die ePA zu übertragen oder auszulesen, ansonsten droht eine Kürzung des Honorars. Der Anwendungsumfang der ePA wird schrittweise ausgebaut.³⁷

Rechtlicher Hintergrund

Mit dem E-Health-Gesetz³⁸ von 2015 wurden die Grundlagen für die ePA in heutiger Form gelegt. Mit der ePA sollte Versicherten ein kontinuierlicher Zugriff auf ihre Behandlungsdaten (medizinische Daten, elektronischer Arztbrief, Behandlungsberichte, Medikationsplan etc.) ermöglicht werden, der über Einrichtungen hinweg zur Verfügung gestellt wird. Die Gematik wurde dabei vom Gesetzgeber verpflichtet, die erforderlichen technischen und organisatorischen Verfahren zu erarbeiten.

³⁷ Der vorliegende Bericht bezieht sich auf das Jahr 2023, deshalb werden die Neuerungen, die ab 2025 durch die Opt-Out-Regelung gelten werden, erst in einem Folgebericht näher erläutert.

³⁸ Siehe Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen ([E-Health-Gesetz](#)) vom 28.12.2015 – Bundesgesetzblatt I S. 2408 (bgbl.de).

Mit Verabschiedung des Patientendaten-Schutz-Gesetzes (PDSG)³⁹ im Oktober 2020 wurde ein konkreter Stufenplan vom Gesetzgeber formuliert. Dabei wurde durch den Gesetzgeber auch die Vergütung, die Vertragsärztinnen und -ärzte für die sektorenübergreifende Erstbefüllung der ePA mit Informationen aus dem aktuellen Behandlungskontext erhalten, auf 10 € festgelegt, bis eine Vergütungsregelung durch den Bewertungsausschuss ab dem 1. Januar 2022 beschlossen werden sollte (§ 87 Abs. 2a SGB V).

Mit dem Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens (Digital-Gesetz), welches im März 2024 in Kraft trat, wurde die flächendeckende Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) beschlossen. Dabei wurde auf ein Opt-out-Verfahren umgestellt, womit für jede(n) gesetzlich Krankenversicherte(n) bis zum 15. Januar 2025 eine ePA eingerichtet werden sollte, es sei denn, er oder sie widerspricht.

7.2 Regelungen und Vergütung im EBM

Die vom Gesetzgeber im PDSG festgelegte Vergütung von 10 € für die sektorenübergreifende Erstbefüllung der ePA wurde mit der ePA-Erstbefüllungsvereinbarung⁴⁰ zwischen Kassenärztlicher Bundesvereinigung, Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung, GKV-Spitzenverband und Deutscher Krankenhausgesellschaft rückwirkend zum 1. Januar 2021 über die Pseudo-GOP 88270 gewährleistet. Vergütet wird die sektorenübergreifende Erstbefüllung bei einem oder einer Versicherten. Wurde diese der jeweiligen Krankenkasse bereits in Rechnung gestellt, wird diese auch bei erneuter vertragsärztlicher Befüllung, zum Beispiel bei einer leeren ePA durch von Versicherten gelöschte Daten, nicht nochmals vergütet. Stattdessen können im vertragsärztlichen Bereich Zusatzpauschalen für die ePA-Unterstützungsleistung (GOP 01647 bzw. 01631) berechnet werden (siehe unten).

Mit dem Beschluss des BA in seiner 578. Sitzung⁴¹ wurde die Pseudo-GOP 88270 mit Wirkung zum 1. Januar 2022 gestrichen und durch die befristete GOP 01648 ersetzt. Diese wird mit 89 Punkten vergütet.

Darüber hinaus wurden gemäß dem gesetzlichen Auftrag nach § 87 Abs. 2a SGB V mit Beschluss aus der 69. Sitzung des Erweiterten Bewertungsausschusses⁴² rückwirkend zum 1. Januar 2021 Zusatzpauschalen für Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der ePA – GOP 01647 und GOP 01431 – in den EBM eingeführt (Tabelle 28):

³⁹ Siehe Patientendaten-Schutz-Gesetz ([PDSG](#)) vom 14.10.2020 – Bundesministerium für Gesundheit ([bundesgesundheitsministerium.de](#)).

⁴⁰ Siehe [Vereinbarung](#) über die Abrechnungsvoraussetzungen und -verfahren zur Erstbefüllung der elektronischen Patientenakte (ePA-Erstbefüllungsvereinbarung) – Kassenärztliche Bundesvereinigung ([kbv.de](#)).

⁴¹ Siehe [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 578. Sitzung am 15. Dezember 2021, Teil A mit Wirkung vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 – Institut des Bewertungsausschusses ([institut-ba.de](#)).

⁴² Siehe [Beschluss](#) des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 69. Sitzung am 17. Februar 2021, Teil A mit Wirkung zum 1. Januar 2021 – Institut des Bewertungsausschusses ([institut-ba.de](#)).

Tabelle 28 Gebührenordnungspositionen im Zusammenhang mit der ePA. *seit 1. Januar 2022, ehemals Pseudo-GOP 88270.

GOP	Bezeichnung		Punkte	€ (2023)
01648	Zusatzpauschale ePA-Erstbefüllung*	1x/Vers.	89	10,23
01647	Zusatzpauschale ePA-Unterstützungsleistung	1x/BHF	15	1,72
01431	Zusatzpauschale elektronische Patientenakte zu den Gebührenordnungspositionen 01430, 01435 und 01820	4x/Arzt-fall	3	0,34

Die GOP 01647 ist eine Zusatzpauschale im Behandlungsfall (15 Punkte) zu den Versicherten, Grund- und Konsiliarpauschalen aller Fachgruppenkapitel des EBM, zu den Grundpauschalen für ermächtigte Ärztinnen und Ärzte, Institute und Krankenhäuser nach GOP 01320 und 01321 sowie zu der schmerztherapeutischen Grundpauschale (GOP 30700). Die GOP 01647 können Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten einmal im BHF abrechnen, wenn sie medizinische Daten aus dem aktuellen Behandlungskontext und mit erfolgten Arzt-Patienten-Kontakt (APK) im Arztfall⁴³ in der ePA erfassen, verarbeiten und/oder speichern. Zusätzlich prüfen und gegebenenfalls ergänzen sie die zu den Dokumenten gehörenden erforderlichen Metadaten, sofern sie diese Dokumente in die ePA einstellen. Diese Zusatzpauschale deckt damit den Regelfall einer ePA-Anpassung ab.

Die GOP 01431 vergütet hingegen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der ePA für Versicherte, bei denen im Arztfall kein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt oder Arzt-Patienten-Kontakt im Rahmen der Videosprechstunde erfolgte (3 Punkte). Dies ist relevant, wenn in einem Quartal keine Versicherten-, Grund- oder Konsiliarpauschale abgerechnet wird, jedoch eine vertragsärztliche ePA-Tätigkeit vorgenommen wird. Zum Beispiel, wenn ein ePA-Eintrag nach einem persönlichen Kontakt über einen Quartalswechsel erfolgt, ohne dass die/der Versicherte im neuen Quartal persönlich oder im Rahmen einer Videosprechstunde gesehen wird. Die GOP 01431 kann im Arztfall höchstens viermal abgerechnet werden und bildet eher die Ausnahmefälle der ePA-Anpassungen ab.

Mit Beschluss der 681. Sitzung des BA⁴⁴ wurde die Finanzierung der GOP 01648 außerhalb der MGV und die Fortführung der GOP bis zum 14.01.2025 (und mit dem Beschluss der 747. Sitzung bis zum 31. Dezember 2025) verlängert.

Die Zusatzpauschale für die ePA (GOP 01431) und die Zusatzpauschale ePA-Unterstützungsleistung (GOP 01647) wurden mit den Beschlüssen des Bewertungsausschusses in seiner 603. und 664. Sitzung, die die Finanzierungsregelung außerhalb der MGV zusammentragen, für das Jahr 2023 bzw. 2024 extrabudgetär vergütet. Tabelle 29 listet alle Beschlüsse bezüglich der ePA mit Wirkung zum Jahr oder im Jahr 2023 auf.

⁴³ Der Arztfall ist die Bezeichnung für die Behandlung derselben/desselben Versicherten durch dieselbe/denselben an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende/n Ärztin/Arzt in einem Quartal zu Lasten derselben Krankenkasse.

⁴⁴ Siehe [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 681. Sitzung, mit Wirkung vom 1. Januar 2024 bis zum 14. Januar 2025 – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

Tabelle 29 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zur elektronischen Patientenakte, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden. MGV= morbiditätsbedingte Gesamtvergütung.

Kategorie	Beschluss	Inkrafttreten	Inhalt/GOP	Laufzeit/Befristung
Verlängerung	79. EBA	01.01.2023	Fortführung der GOP 01648	31.12.2023
Finanzierung	603. BA	01.01.2023	Vergütung der GOP 01647, 01648 und 01431 außerhalb der MGV	31.12.2023
Finanzierung	664. BA	01.01.2023	Vergütung der GOP 01647 und 01431 außerhalb der MGV	31.12.2023
Verlängerung/ Finanzierung	681. BA	01.01.2024	Teil A: Befristete Verlängerung GOP 01648 Teil B: Vergütung der GOP 01648 außerhalb MGV	14.01.2025

7.3 Leistungsentwicklung

Die Abrechnungshäufigkeit und den Leistungsbedarf der Gebührenordnungspositionen, die die ePA betreffen, zeigen Abbildung 31 und Abbildung 32:

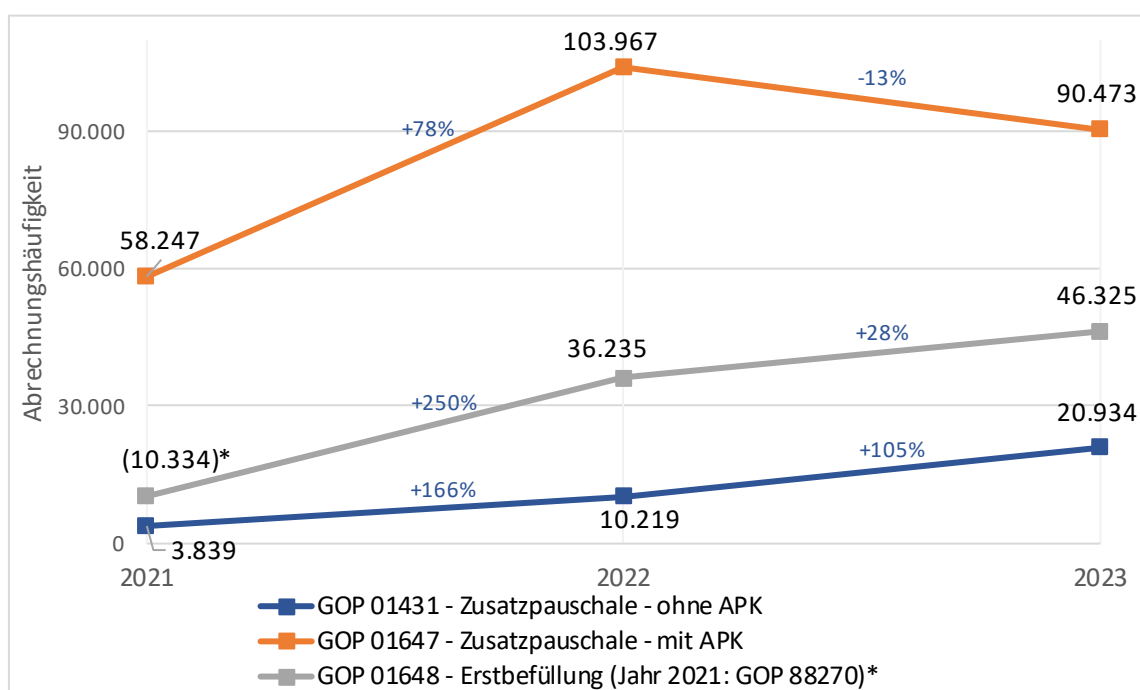


Abbildung 31 Abrechnungshäufigkeit der Gebührenordnungspositionen zur ePA in den Jahren 2021 bis 2023. *Die Pseudo-GOP 88270 wurde zum 31. Dezember 2021 gestrichen und durch die GOP 01648 ersetzt. APK = Arzt-Patienten-Kontakt.

Im Jahr 2023 wurden 46.325 ePA zum ersten Mal befüllt (GOP 01648, graue Kurve). Dieses entsprach einer Steigerung von 28 % gegenüber den ca. 36.200 erstmals befüllten ePA im Jahr 2022. Damit wurden bis Ende des Jahres 2023 insgesamt ca. 93.000 ePA insgesamt erstmals befüllt.

Die Abrechnungshäufigkeit der ePA-Zusatzpauschale mit Arzt-Patienten-Kontakt (GOP 01647, orangefarbene Kurve) sank gegenüber den ca. 104.000 Abrechnungen im Jahr 2022 um ca. 13 % auf ca. 90.500 Abrechnungen im Jahr 2023. Im Jahr 2023 standen damit ca. 90.500 Anpassungen der ePA ca. 46.300 Erstbefüllungen gegenüber (ein Verhältnis von ca. 2:1), während das Verhältnis im Jahr 2022 noch ca. 104.000 Anpassungen zu ca. 36.200 Erstbefüllungen betrug (ca. 3:1).

Die Abrechnung der Zusatzpauschale GOP 01431 steigerte sich erneut deutlich um 105 % auf 20.934 Abrechnungen (blaue Kurve).

Die Entwicklung des Leistungsbedarfes folgte der Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit (Abbildung 32).

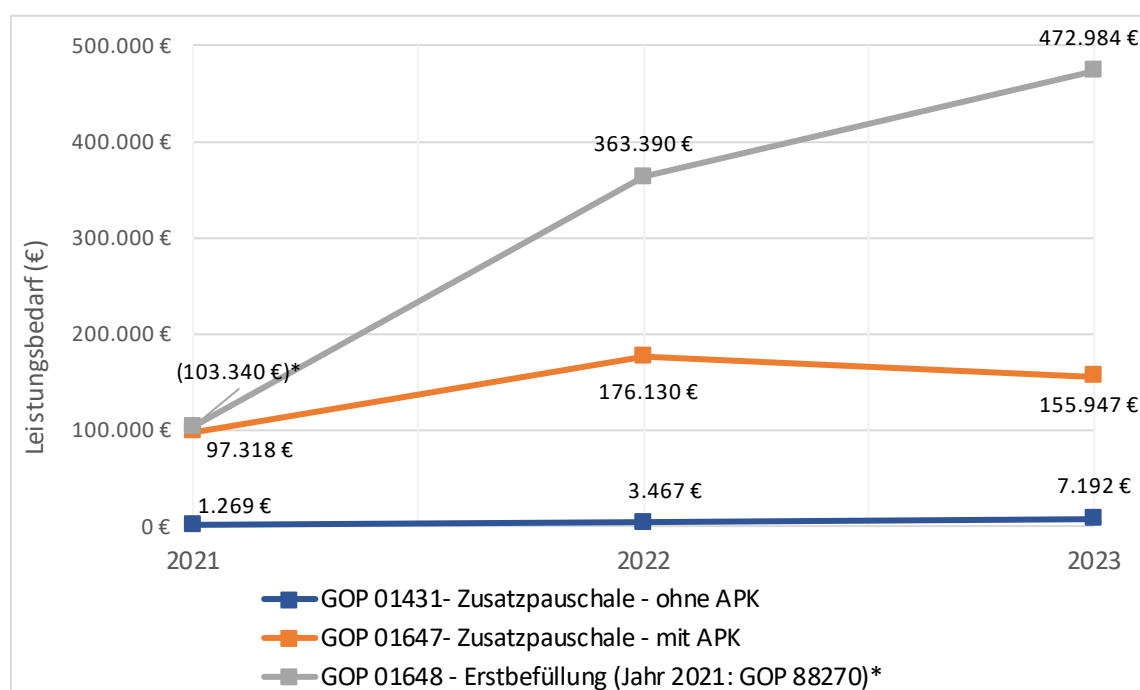


Abbildung 32 Leistungsbedarf der Gebührenordnungspositionen im Rahmen der ePA in den Jahren 2021 bis 2023. *Die Pseudo-GOP 88270 wurde zum 31. Dezember 2021 gestrichen und durch die GOP 01648 ersetzt. APK = Arzt-Patienten-Kontakt.

Durch das größere Wachstum der Erstbefüllung (GOP 01648) gegenüber der ePA-Zusatzpauschale mit Arzt-Patienten-Kontakt (GOP 01647) zeigte sich eine starke Dynamik bei dem Leistungsbedarf der GOP 01648. Aufgrund der deutlich höheren Bewertung der GOP 01648 erlangt diese bei gleichbleibenden Wachstumsverhältnissen eine zunehmend dominierende Rolle für den Gesamtleistungsbedarf für die ePA.

Dem sichtbaren hohen Wachstum auf Jahresebene kann unter Analyse der Abrechnungshäufigkeit auf Quartalsebene eine differenziertere Betrachtung entgegengesetzt werden (Abbildung 33):

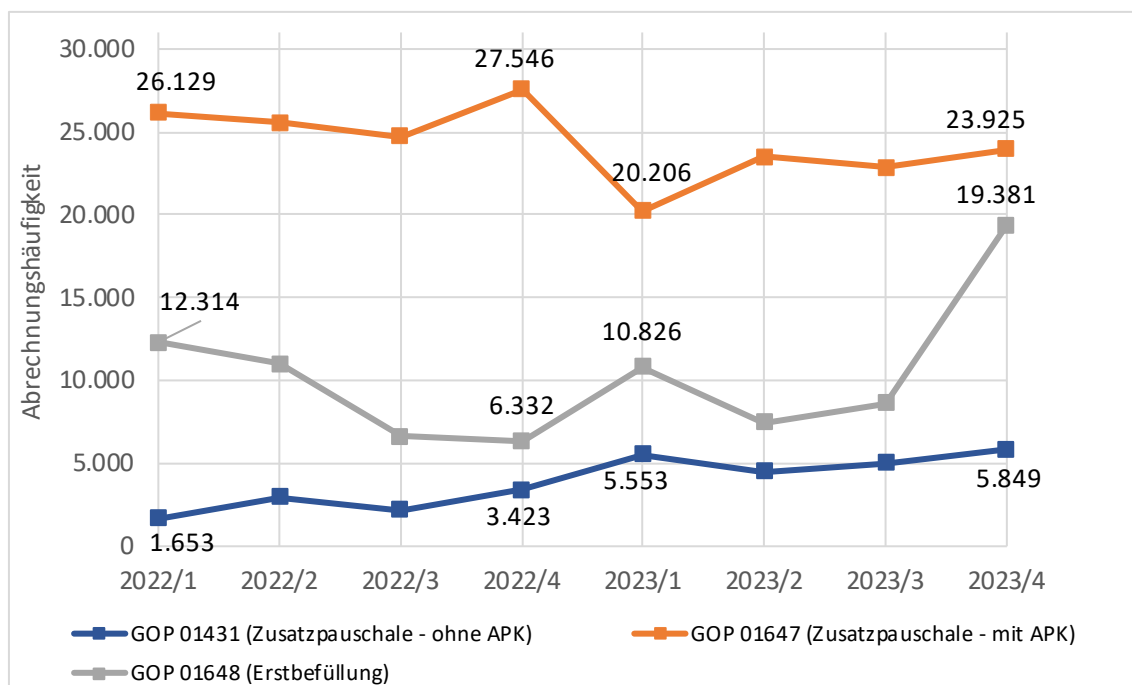


Abbildung 33 Abrechnungshäufigkeit der Leistungen zur ePA im Quartalsverlauf in den Jahren 2022 und 2023.

Abbildung 33 zeigt, dass:

- Die Entwicklung der Zusatzpauschale mit Arzt-Patienten-Kontakt (GOP 01647, orange-farbene Kurve) nach einem Abfall auf 20.206 Abrechnungen im 1. Quartal 2023 in den Folgequartalen wieder einen leicht ansteigenden Verlauf zeigte.
- Die Erstbefüllung (GOP 01648, graue Kurve) nach einem Abfall der Abrechnungshäufigkeit über die Quartale des Jahres 2022 im Jahr 2023 wieder einen insgesamt ansteigenden Verlauf zeigte; wesentlich für die Steigerung der Abrechnungshäufigkeit des Jahres 2023 gegenüber dem Jahr 2022 war der starke Anstieg von ca. 8.500 Abrechnungen im 3. Quartal 2023 auf über 19.000 Abrechnungen im 4. Quartal 2023.
- Die Zusatzpauschale ohne Arzt-Patienten-Kontakt (GOP 01431, blaue Kurve) weiterhin ein stetiges Wachstum über fast alle Quartale hinweg zeigte.

Tabelle 76 und Tabelle 77 bzw. Tabelle 78 im Anhang beinhalten nochmals die genauen Zahlen bezüglich der Abrechnungshäufigkeit pro Quartal bzw. pro Jahr und des Leistungsbedarfes.

7.4 Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit sowie nach Fachgruppen und Einrichtungenformen

Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit

Die Leistungen zur ePA werden regional unterschiedlich häufig abgerechnet. Tabelle 30 zeigt die absolute und normierte regionale Abrechnungshäufigkeit nach KV-Bezirken.

Tabelle 30 Regionale Abrechnungshäufigkeit der Leistungen zur ePA nach KV-Bezirken im Jahr 2023. Dargestellt sind die absolute und auf 100.000 Versicherte normierte Abrechnungshäufigkeit. Sortiert nach der absoluten Abrechnungshäufigkeit der GOP 01648. APK= Arzt-Patienten-Kontakt.

KV-Bezirk	Abrechnungshäufigkeit (je 100.000 Versicherte)		
	GOP 01431 (Zusatzpauschale – ohne APK)	GOP 01647 (Zusatzpauschale – mit APK)	GOP 01648 (Erstbefüllung)
Berlin	433 (13)	19.217 (572)	7.653 (228)
Baden-Württemberg	6.734 (70)	3.866 (40)	6.743 (70)
Nordrhein	1.001 (12)	5.998 (70)	6.457 (76)
Westfalen-Lippe	75 (1)	3.805 (50)	6.196 (82)
Hessen	2.079 (37)	4.281 (77)	3.969 (71)
Niedersachsen	2.918 (40)	12.487 (172)	3.700 (51)
Bayern	4.919 (43)	19.918 (172)	2.220 (19)
Rheinland-Pfalz	432 (12)	1.646 (47)	2.161 (61)
Sachsen	35 (1)	954 (25)	1.792 (47)
Schleswig-Holstein	159 (6)	21 (1)	1.562 (61)
Brandenburg	17 (1)	3.314 (140)	1.476 (63)
Thüringen	3 (0)	373 (19)	1.263 (65)
Sachsen-Anhalt	9 (0)	77 (4)	636 (31)
Hamburg	1.900 (107)	12.063 (679)	212 (12)
Bremen	2 (0)	1 (0)	202 (32)
Mecklenburg-Vorpommern	6 (0)	393 (27)	70 (5)
Saarland	212 (25)	2.059 (239)	13 (2)

Wie in Tabelle 30 erkennbar, weichen die Abrechnungszahlen der KV-Bezirke deutlich voneinander ab, insbesondere auch bei Betrachtung der normierten Werte, die in Klammern angegeben sind. An dieser Stelle werden lediglich die wichtigsten Erkenntnisse hinsichtlich der vom Volumen gesehen leistungsstärksten Leistungen zur ePA aufgelistet:

- In Bezug auf die absolute Abrechnungshäufigkeit der Erstbefüllung (GOP 01648) wurden im Jahr 2023 in dem KV-Bezirk Berlin mit 7.653 Abrechnungen ca. 17 % aller ePA Erstbefüllungen durchgeführt. Hier erfolgte eine deutliche Steigerung gegenüber dem Jahr 2022, wo Berlin einen Anteil von ca. 2 % hatte. Im KV-Bezirk Baden-Württemberg wurden mit 6.743 Abrechnungen (Anteil ~15 %) deutlich weniger ePA erstmals befüllt als im Jahr 2022 (10.848; Anteil ~30 %). Der KV-Bezirk Nordrhein folgt mit 6.457 Erstbefüllungen und einem ähnlichen Anteil.
- Auch in Bezug auf die KV-Größe (pro 100.000 Versicherte) gab es in Berlin mit 228 Erstbefüllungen pro 100.000 Versicherte die meisten Erstbefüllungen (Tabelle 30 in Klammern). Die KV-Bezirke Westfalen-Lippe und Nordrhein folgten mit 82 bzw. 76 Erstbefüllungen pro 100.000 Versicherte.
- Bei der Zusatzpauschale mit Arzt-Patienten-Kontakt (GOP 01647) wurde wie im Jahr 2022 insbesondere in vier KV-Bezirken ein sehr hoher Anteil an GOP 01647 abgerechnet:
Bayern (n= 19.918, ~22 %; Jahr 2022: ~23 %),

Berlin (n= 19.217, ~21 %; Jahr 2022: ~14 %), Niedersachsen (n= 12.487, ~14 %; Jahr 2022: ~14,5 %) und Hamburg (n= 12.063, ~13 %; Jahr 2022: ~14 %).

- Bei der normierten Abrechnungshäufigkeit pro 100.000 Versicherte der GOP 01647 dominierten insbesondere die beiden Stadtstaaten Hamburg (n = 679, Jahr 2022: 819) und Berlin (n = 572, Jahr 2022: 446) die Abrechnungsstatistik.

Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Fachgruppen

Die nach Fachgruppen differenzierte Abrechnungshäufigkeit der Leistungen zur ePA stellten sich wie folgt dar (Tabelle 31):

Tabelle 31 Abrechnungshäufigkeit der Leistungen zur ePA nach Fachgruppen im Jahr 2023. Dargestellt sind die Abrechnungshäufigkeit (AH) pro Fachgruppe, die Gesamtanzahl Ärztinnen/Ärzte pro Fachgruppe und die Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte pro Fachgruppe (n Ä). Sortiert nach der absoluten Abrechnungshäufigkeit der GOP 01648. APK = Arzt-Patienten-Kontakt.

Fachgruppe	Gesamtanzahl Ärztinnen/Ärzte	Abrechnungshäufigkeiten (AH) und Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte (n Ä)					
		GOP 01431 (Zusatzpauschale – ohne APK)		GOP 01647 (Zusatzpauschale – mit APK)		GOP 01648 (Erstbefüllung)	
		AH	n Ä	AH	n Ä	AH	n Ä
Hausärztinnen/-ärzte	63.549	8.483	107	18.935	194	23.502	839
Gynäkologie	13.530	2.881	48	7.924	47	4.049	69
Neurologie/Nervenheilk.	5.330	418	13	3.424	16	3.526	28
Innere Medizin	14.420	3.547	57	10.925	20	3.083	52
Urologie	3.963	24	8	5.332	14	3.076	18
Orthopädie	9.190	1.122	15	15.080	19	2.872	37
Dermatologie	4.334	361	14	217	9	2.519	23
Kinder-/Jugendmedizin	9.133	3.131	28	3.081	10	1.418	34
Psychiatrie	3.647	26	≤5	2.572	7	740	≤5
Chirurgie	7.965	44	7	13.222	6	573	13
Psychotherapie	37.442	≤5	≤5	83	≤5	501	14
HNO und Phoniatrie	4.861	13	9	1.153	9	433	17
Augenheilkunde	7.014	860	16	4.586	≤5	23	8
Anästhesiologie	4.165	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
Sonstige	23.516	≤5	≤5	3.336	≤5	≤5	≤5
Radiologie/Nuklear- med./Strahlentherapie	7.025	0	0	22	16	≤5	≤5
Psychosomatische Medizin	2.235	0	0	0	0	≤5	≤5
Physikalische/Rehab. Med.	640	12	≤5	578	≤5	0	0
Humangenetik	353	≤5	≤5	0	0	0	0
Labor	1.633	0	0	≤5	≤5	0	0

An dieser Stelle folgen die wichtigsten Erkenntnisse betreffend der Erstbefüllung einer ePA (GOP 01648) und dem Zuschlag GOP 01647 (Tabelle 31):

- Die Fachgruppe der Hausärztinnen/-ärzte befüllte – gegenüber dem Jahr 2022 mit ca. 14.000 Erstbefüllungen – im Jahr 2023 deutlich mehr ePA (n = 23.502) erstmalig und steigerte ihren Anteil an allen im Jahr 2023 erstmals befüllten ePA auf 51 % (Jahr 2022: 39 %). Die folgenden Fachgruppen Gynäkologie (n = 4.049, ~9 %; Jahr 2022: 3.797; ~10,5 %) und Neurologie und Nervenheilkunde (n = 3.526; ~8 %; Jahr 2022: 6.824, ~19 %) verloren hingegen hinsichtlich ihrer Anteile an der Gesamtabrechnungshäufigkeit der Erstbefüllung.
- Eine Zahl von 839 Hausärztinnen/-ärzten von insgesamt 63.549 Hausärztinnen/Hausärzten befüllten im Jahr 2023 eine ePA erstmals. Dies entsprach einem Anteil von 1,3 % innerhalb der Fachgruppe. Gegenüber dem Jahr 2022 mit einem Anteil von 0,6 % kam es hier zu einer deutlichen Steigerung. Insgesamt befüllte aber ein nur sehr geringer Anteil an Ärztinnen/Ärzten einer Fachgruppe eine ePA erstmals – so z. B. in der Fachgruppe Gynäkologie mit 69 Ärztinnen/Ärzte (Anteil ~0,5 %) und Neurologie/Nervenheilkunde mit 28 Ärztinnen/Ärzte (Anteil ~0,4 %). Diese Anteile zeigten sich faktisch unverändert gegenüber dem Jahr 2022.
- Die ePA-Zusatzpauschale mit Arzt-Patienten-Kontakt (GOP 01647) wurde weiterhin mit ca. 19.000 Abrechnungen am häufigsten von den Hausärztinnen/-ärzten (Jahr 2022, n = 30.107) abgerechnet. Der Anteil an den ca. 90.500 insgesamt abgerechneten GOP 01647 betrug hier 21 % (Jahr 2022: ca. 29 %). Die Fachgruppe der Orthopädie (n = 15.080, ~17 %; Jahr 2022: ~19 %) und die Fachgruppe der Chirurgie (n = 13.222, 15 %; Jahr 2022 ca. 10 %) folgten mit einigem Abstand.
- Auch bei der Abrechnung der Zusatzpauschale mit Arzt-Patienten-Kontakt (GOP 01647) fiel bei allen Fachgruppen der sehr geringe Anteil von insgesamt abrechnenden Ärztinnen/Ärzten auf. So rechneten 194 Hausärztinnen/-ärzte entsprechend ca. 0,3 % aller Ärztinnen/Ärzte der Fachgruppe, 19 Orthopädinnen/Orthopäden (~0,2 %) und 6 Chirurgen/Chirurgen (~0,1 %) im Jahr 2023 die GOP 01647 ab.

Zusammenfassend erfolgte sowohl die Erstbefüllung (GOP 01648) als auch die Anpassung der ePA (GOP 01647) im Jahr 2023 noch auf einem sehr niedrigen Niveau, insbesondere hinsichtlich der teilnehmenden Ärztinnen/Ärzte. Wesentliche Änderungen sind hier erst mit der Einführung der ePA als Opt-out-Leistung zu erwarten.

Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Einrichtungsformen

Die Daten der Abrechnungshäufigkeit von Leistungen zur ePA bezüglich der Einrichtungsform sind in Abbildung 34 und Tabelle 79 im Anhang ersichtlich.

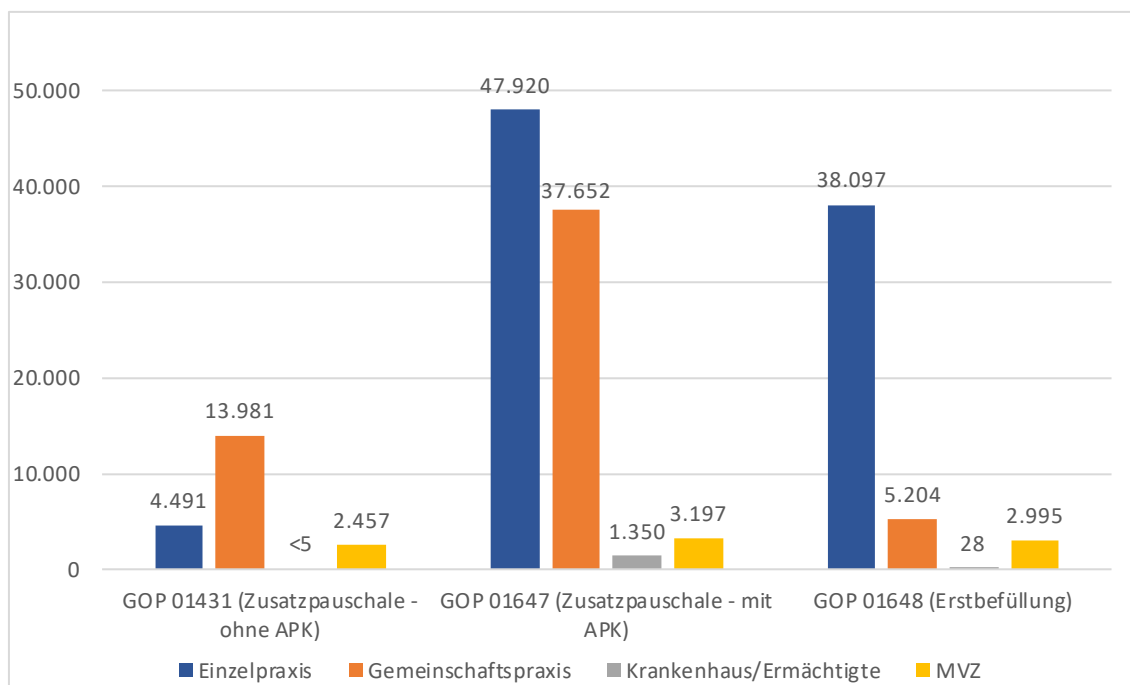


Abbildung 34 Abrechnungshäufigkeit der Leistungen zur ePA nach Einrichtungsformen im Jahr 2023.
APK = Arzt-Patienten-Kontakt.

Die Erstbefüllung von ePA erfolgten im Jahr 2023 überwiegend durch Einzelpraxen (n=38.079), womit Einzelpraxen im Jahr 2023 einen Anteil von ca. 82 % aller ePA erstmals befüllten (Jahr 2022: 71 %). Dabei waren durchschnittlich 54 ePA-Erstbefüllungen pro Praxis zu verzeichnen (s. a. Tabelle 79). Im Jahr 2022 verteilten sich ca. 26.000 ePA-Erstbefüllungen noch auf deutlich weniger Praxen bei einer deutlich höheren durchschnittlichen ePA-Erstbefüllung pro Praxis von 70. Damit wurde die ePA von einer zunehmenden Anzahl von Praxen erstmalig befüllt.

Gemeinschaftspraxen befüllten ca. 5.200 ePA im Jahr 2023 erstmalig (GOP 01648) und damit weniger als im Jahr 2022 (7.622 ePA). Allerdings verteilen sich diese Abrechnungen bei einer durchschnittlichen Abrechnungsanzahl pro Gemeinschaftspraxis von 17 ebenfalls auf eine deutlich höhere Anzahl an Gemeinschaftspraxen als im Jahr 2022 (43).

Bei den Aktualisierungen der ePA (Zusatzpauschale mit Arzt-Patienten-Kontakt, GOP 01647) wurden im Jahr 2023 von Einzelpraxen mit ca. 48.000 annähernd gleich viele Abrechnungen durchgeführt wie im Jahr 2022 (47.143). Die Abrechnungshäufigkeit bei den Gemeinschaftspraxen sank hingegen von ca. 47.000 Abrechnungen (Jahr 2022) auf ca. 38.000 Abrechnungen im Jahr 2023.

Krankenhausärztinnen und -ärzte leisteten auch 2023 im vertragsärztlichen Bereich keinen nennenswerten Beitrag für die Pflege oder insbesondere die Erstbefüllung der ePA, wobei zu beachten ist, dass nur ermächtigte Ärztinnen/Ärzte oder Psychotherapeutinnen/-therapeuten im Krankenhaus die entsprechenden ePA-Leistungen berechnen dürfen.

Der Zuwachs der Abrechnungshäufigkeit der Zusatzpauschale – ohne Arzt-Patienten-Kontakt (GOP 01431) im Jahr 2023 (siehe Kapitel 7.3 des Berichts) scheint fast ausschließlich auf die vermehrte Abrechnung von Gemeinschaftspraxen zurückzugehen. Die Abrechnungen stiegen hier

von ca. 2.800 im Jahr 2022 auf ca. 14.000 Abrechnungen im Jahr 2023 an, während die Abrechnungen bei Einzelpraxen nur leicht auf ca. 4.500 Abrechnungen (Jahr 2022: 4.289) stiegen oder bei MVZ sogar von ca. 3.000 (Jahr 2022) auf ca. 2.500 Abrechnungen im Jahr 2023 abfielen.

7.5 Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten mit Inanspruchnahme der ePA

Die Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten mit Inanspruchnahme einer Erstbefüllung einer ePA (GOP 01648) und der Zusatzpauschale mit Arzt-Patienten-Kontakt (GOP 01647) zeigen Abbildung 35 und Abbildung 36.

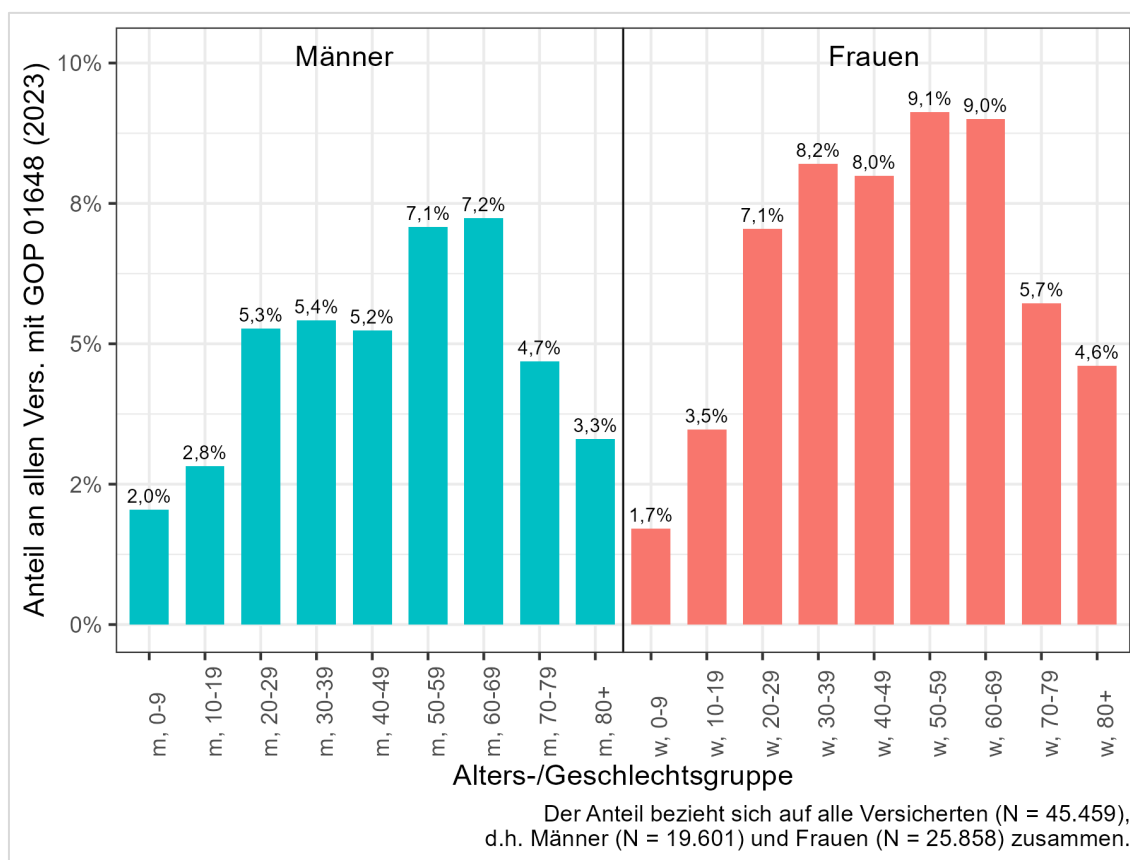


Abbildung 35 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten, bei denen eine Erstbefüllung einer ePA (GOP 01648) im Jahr 2023 abgerechnet wurde; m = männlich, w = weiblich.

Der Anteil der weiblichen Versicherten an den ca. 45.500 Versicherten mit Erstbefüllung einer ePA war mit ca. 57 % größer als der Anteil der männlichen Versicherten. Dieser Umstand trifft faktisch auf alle Altersklassen über 10 Jahren zu. Allerdings entschlossen sich mit einem Anteil von 43 % mehr männliche Versicherte für die Erstbefüllung einer ePA als im Jahr 2022 (38 %).

Ein ähnliches Bild der Geschlechterverteilung ergibt sich bei Betrachtung der Zusatzpauschale nach der GOP 01647. Allerdings liegt hier der prozentuale Anteil an Abrechnungen für männliche Versicherte insgesamt gegenüber dem Jahr 2022 unverändert bei 39 % (Abbildung 36):

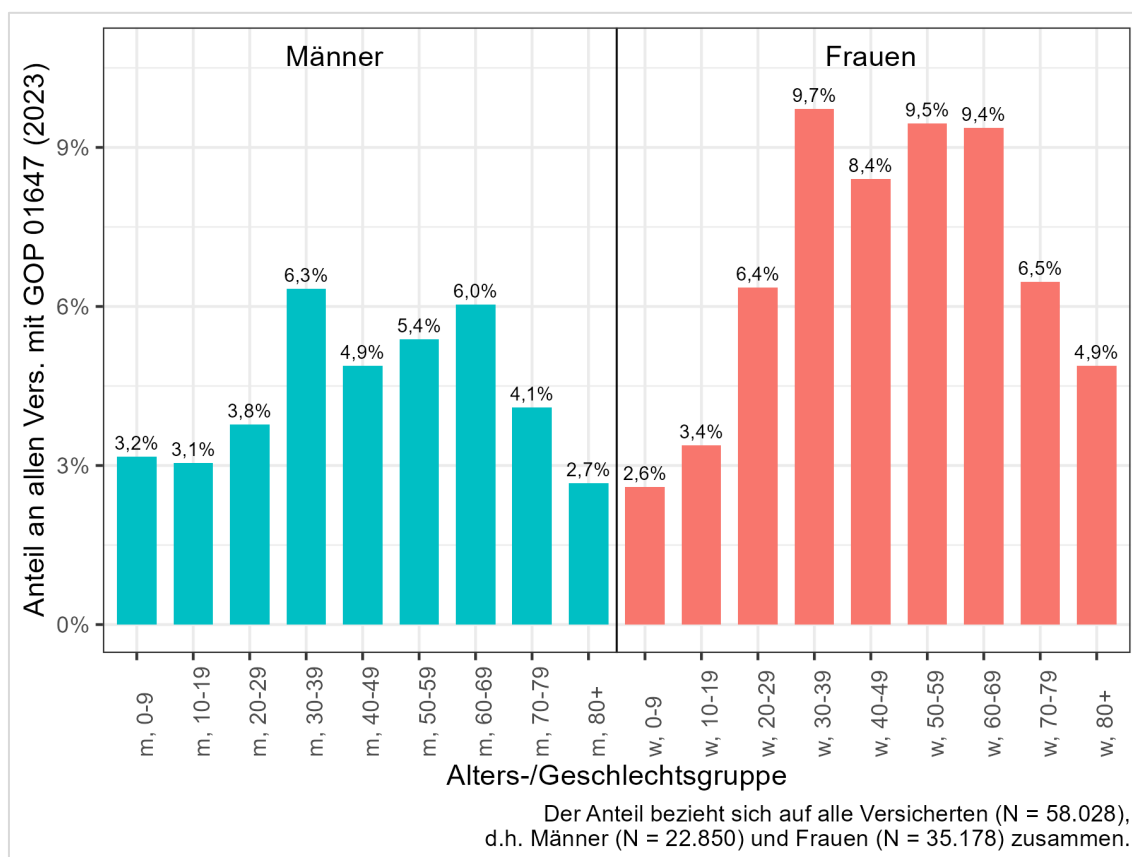


Abbildung 36 Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten, bei denen eine Zusatzpauschale für die ePA (GOP 01647) im Jahr 2023 abgerechnet wurde.

8 Elektronische Arztbriefe

8.1 Allgemeine Erläuterungen

Begrifflichkeiten

Ärztinnen, Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten können schon länger Informationen und Befunde zu ihren Patientinnen und Patienten schriftlich austauschen, indem sie elektronische Arztbriefe (eArztbriefe) direkt aus dem Praxisverwaltungssystem (PVS) heraus versenden und empfangen. Mit einem neuen Vergütungsmodell, das teilweise in der TI-Finanzierungsvereinbarung (Anlage 32 zum BMV-Ä)⁴⁵ und teilweise über den Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 481. Sitzung⁴⁶ umgesetzt wurde, wurde die elektronische Kommunikation gefördert.

Nach einer Übergangsphase, in welcher der alternative Übergangsdienst KV-Connect genutzt werden konnte, werden die Kosten für den Versand von eArztbriefen seit 1. April 2021 nur erstattet, wenn der Versand über den gesicherten E-Mail-Fachdienst Kommunikation im Medizinwesen (KIM) erfolgt, der als Modul in das Praxisverwaltungssystem der Arztpraxen eingebettet werden kann. Der KIM-Dienst stellt technisch eine Anwendung der Telematikinfrastruktur der gematik dar und ist von verschiedenen Anbietern verfügbar. Ärztinnen, Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten benötigen für den Versand einen elektronischen Heilberufsausweis (eHBA), um damit ihre persönliche qualifizierte elektronische Signatur (QES) für die elektronische Unterzeichnung der Dokumente erstellen zu können.

Im Umgang stellt sich der KIM-Dienst wie ein E-Maildienst dar, der ausgehende Nachrichten verschlüsselt und erst nach dem Empfang wieder entschlüsselt. Üblicherweise werden medizinische Dokumente, wie eArztbriefe oder Laborbefunde, an die Nachrichten angehängt.

Rechtlicher Hintergrund

Die Verpflichtung, den KIM-Dienst für die Übermittlung elektronischer Kommunikation wie eArztbriefe zu verwenden, wurde durch das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG)⁴⁷ zum 19. Dezember 2019 eingeführt. Zur Umsetzung der Details sind die genauen Anforderungen zur Übermittlung von eArztbriefen in der Richtlinie „Elektronischer Brief“⁴⁸ der Kassenärztlichen Bundesvereinigung festgelegt. Nach einer Übergangsphase von sechs Monaten wurde die Nutzung eines KIM-Dienstes für eArztbriefe zum 1. April 2021 für Vertragsarztpraxen verpflichtend.

⁴⁵ Siehe [Vereinbarung](#) zur Finanzierung und Erstattung der bei den Vertragsärzten entstehenden Kosten im Rahmen der Einführung und des Betriebes der Telematikinfrastruktur (BMV-Ä Anlage 32) vom 14. Dezember 2017 in der Fassung vom 26. August 2022 – Kassenärztliche Bundesvereinigung (kbv.de).

⁴⁶ Siehe [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 481. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

⁴⁷ Siehe Digitale-Versorgung-Gesetz ([DVG](#)) vom 11.12.2019 – Bundesgesetzblatt I S. 2652 (bgbl.de)

⁴⁸ Siehe [Richtlinie](#) über die Übermittlung elektronischer Briefe in der vertragsärztlichen Versorgung (Richtlinie elektronischer Brief) – Kassenärztliche Bundesvereinigung (kbv.de).

Den Anschluss an die Telematikinfrastruktur sowie die Einrichtung und den Betrieb des Übertragungsdienstes KIM erhalten Arztpraxen pauschal erstattet, wie bereits im Vorbericht 2020 ausführlich dargestellt. Dies war bis zum 30. Juni 2023 in der Anlage 8 der TI-Finanzierungsvereinbarung (Anlage 32 zum BMV-Ä) definiert. Seitdem gilt die Festlegung der TI-Pauschale durch das BMG.

Mit dem DigiG wurde in § 295 Abs. 1c SGB V festgelegt, dass alle vertragsärztlich abrechnenden Ärztinnen/Ärzte und Einrichtungen ab dem 30. Juni 2024 in der Lage sein müssen, eArztbriefe über einen KIM-Dienst zu empfangen. Außerdem wurde durch dieses Gesetz in § 87 Abs. 2o SGB V festgelegt, dass elektronische Arztbriefe im Zusammenhang mit telemedizinischen Leistungen Berücksichtigung finden sollen. Deshalb wurde in der Vereinbarung über die Anforderungen für die Sicherung der Versorgungsqualität von telemedizinischen Leistungen geregelt, dass Ärztinnen und Ärzte eArztbriefe in der Regel auch bei telemedizinischen Leistungen in die ePA ihrer Patientinnen und Patienten übertragen müssen.⁴⁹

8.2 Regelungen und Vergütung im EBM bzw. der TI-Finanzierungsvereinbarung

Seit dem 1. Juli 2020 sind folgende Gebührenordnungsposition und Pseudo-Gebührenordnungspositionen für den Versand bzw. Empfang von eArztbriefen berechnungsfähig (Tabelle 32):

Tabelle 32 Gebührenordnungsposition 01660 und Pseudo-Gebührenordnungspositionen 86900 und 86901 für Versand und Empfang von eArztbriefen.

(Pseudo-)GOP	Bezeichnung	Punkte	€ (2023)
01660	Zuschlag zur Versandpauschale zur Förderung elektronischer Briefe befristet bis 30.06.2023	1	0,11
86900	In TI-Finanzierungsvereinbarung geregelt: Pauschale für den Versand eines eArztbriefes		0,28
86901	Pauschale für den Empfang eines eArztbriefes		0,27

Die Vergütung der beiden Pauschalen für den Versand und Empfang von eArztbriefen (Pseudo-GOP 86900 und 86901) war bis zum 30. Juni 2023 in der TI-Finanzierungsvereinbarung geregelt und mit einem gemeinsamen Höchstwert versehen. Auch nach der Festlegung der TI-Finanzierungsvereinbarung als Rechtsverordnung durch das Bundesministerium für Gesundheit zum 1. Juli 2023 gelten die Übermittlungspauschalen und der gemeinsame Höchstwert fort. Mit Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 481. Sitzung (Teil A) wurde zur Förderung der eArztbriefe der Zuschlag zur Versandpauschale (GOP 01660) befristet in den EBM

⁴⁹ [Vereinbarung](#) über die Anforderungen für die Sicherung der Versorgungsqualität von telemedizinischen Leistungen (BMV-Ä Anlage 31c) vom 1. März 2025 – Kassenärztliche Bundesvereinigung (kbv.de).

aufgenommen. Die Vergütung erfolgte gemäß Teil B des Beschlusses bis zur Streichung der GOP 01660 am 30. Juni 2023 außerhalb der MGV.

Parallel zur Förderung des eArztbriefes durch die Einführung der befristeten GOP 01660 wurde die Vergütung für nichtdigitale Kommunikation abgesenkt. Zunächst wurden die Kostenpauschalen für Postsendungen und Faxe mit dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 481. Sitzung (Teil C) zum 1. Juli 2020 reduziert, wie bereits in den Vorberichten 2020 und 2022 ausgeführt. So war die Kostenpauschale 40110 für Postsendungen unabhängig von Umfang und Gewicht mit 81 Cent bewertet. Seitdem wurde die Bewertung zum 1. Januar 2022 mit den steigenden Portopreisen angepasst auf 86 Cent. Die Kostenpauschale 40111 für Faxe war zunächst mit 10 Cent und seit dem 1. Juli 2021 mit 5 Cent bewertet.

Außerdem wurde durch den Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 513. Sitzung⁵⁰ die Abrechnung der Kostenpauschalen für nicht-digitale Kommunikation ab dem 1. Oktober 2021 auf einen fachgruppenspezifischen Höchstwert begrenzt. Zum 1. Oktober 2022 und zum 1. Oktober 2023 wurden die Höchstwerte jeweils abgesenkt. Hierdurch wurde der Forderung des Gesetzgebers Rechnung getragen, die Übermittlung von eArztbriefen stärker zu fördern.

8.3 Leistungsentwicklung

Abrechnungshäufigkeit

Für das Berichtsjahr 2023 lagen 7,6 Mio. Abrechnungen der Versandpauschale für eArztbriefe (Pseudo-GOP 86900) vor, eine Steigerung um 182 % im Vergleich zum Vorjahr (2022: 2,7 Mio. Abrechnungen) (siehe auch Anhang, Tabelle 82). Der Zuschlag zu der Versandpauschale (GOP 01660) hatte rund 3,9 Mio. Abrechnungen im Jahr 2023. Dies war ein Anstieg um 64 % im Vergleich zu 2,3 Mio. Abrechnungen im Jahr 2022, obwohl diese Leistung nur in den ersten beiden Quartalen des Jahres 2023 berechnungsfähig war. Die Abrechnungshäufigkeit der Empfangspauschale für eArztbriefe (Pseudo-GOP 86901) lag bei rund 4,8 Mio. Abrechnungen im Jahr 2023. Dies bedeutete eine Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr durch eine Steigerung um 249 % gegenüber rund 1,4 Mio. Abrechnungen im Jahr 2022.

Abbildung 37 zeigt, wie sich die Abrechnungszahlen für die verschiedenen Leistungen zum eArztbrief in den einzelnen Quartalen entwickelt haben (siehe auch Anhang, Tabelle 80).

⁵⁰ Siehe [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 513. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

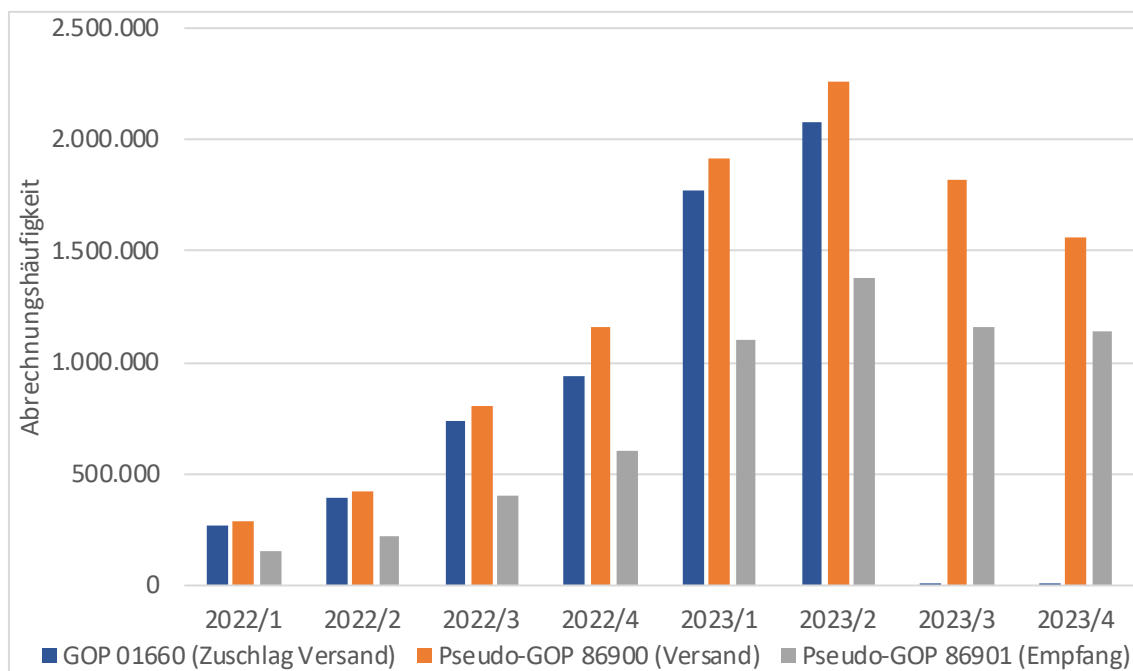


Abbildung 37 Abrechnungshäufigkeit der (Pseudo-)Gebührenordnungspositionen für Versand und Empfang von eArztbriefen. Der Zuschlag zur Versandpauschale (GOP 01660) war nur bis zum Ende des 2. Quartals 2023 berechnungsfähig.

Abbildung 37 zeigt, dass große Unterschiede bei der Abrechnungshäufigkeit für die Versendung von eArztbriefen und für deren Empfang im Jahr 2023 wie auch im Jahr 2022 bestanden (siehe auch Anhang, Tabelle 80). Die Pauschale für den Versand eines eArztbriefes (Pseudo-GOP 86900) wurde deutlich häufiger abgerechnet als die Pauschale für den Empfang (Pseudo-GOP 86901): Im 1. Quartal 2023 zeigte sich eine Differenz von rund 810.000 Abrechnungen bei rund 1,9 Mio. Abrechnungen der Pseudo-GOP 86900 und rund 1,1 Mio. Abrechnungen der Pseudo-GOP 86901. Diese Differenz nahm bis zum 4. Quartal 2023 ab bis zu einer Differenz von rund 280.000 Abrechnungen bei rund 1,1 Mio. Abrechnungen der Pseudo-GOP 86900 und rund 850.000 Abrechnungen der Pseudo-GOP 86901.

Die Abnahme der Abrechnungshäufigkeit der Versand- und der Empfangspauschale (Pseudo-GOP 86900 und 86901) in der zweiten Jahreshälfte 2023 lässt sich damit erklären, dass die Berechnungsfähigkeit der Pseudo-GOP 86900 und 86901 zunächst geklärt werden musste.

Leistungsbedarf

In Tabelle 33 ist jeweils der Leistungsbedarf für die Leistungen zu Versand und Empfang von eArztbriefen nach den Quartalen und Jahressummen für die Jahre 2022 und 2023 dargestellt:

*Tabelle 33 Leistungsbedarf für eArztbriefe in den Jahren 2022 und 2023. * Da der Förder-Zuschlag für eArztbriefe (GOP 01660) ab dem 1. Juli 2023 nicht mehr berechnungsfähig war, ist bei den Summen aus dem 3. und 4. Quartal 2023 von nachträglichen Abrechnungen auszugehen.*

Leistung	Leistungsbedarf 2022 in €					Leistungsbedarf 2023 in €				
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	Gesamt	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4	Gesamt
GOP 01660 (Zuschlag)	30.021	43.643	81.559	104.471	259.693	197.465	232.539	42*	4*	430.049
Pseudo-GOP 86900 (Versand)	36.775	50.209	86.022	112.211	285.217	161.541	189.492	81.750	78.539	511.322
Pseudo-GOP 86901 (Empfang)	24.079	42.475	85.858	132.737	285.149	233.893	296.597	126.326	139.481	796.298

Wie Tabelle 33 zeigt, belief sich der Leistungsbedarf für die Versandpauschale (Pseudo-GOP 86900) und die Empfangspauschale (Pseudo-GOP 86901) im Jahr 2023 in Summe auf rund 510.000 € bzw. rund 800.000 € (siehe auch Anhang, Tabelle 81 und Tabelle 82). Für den Zuschlag zur Versandpauschale (GOP 01660) belief sich der Leistungsbedarf im Jahr 2023 auf insgesamt rund 430.000 €.

8.4 Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit sowie nach Einrichtungsformen

Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit

Aufgeschlüsselt nach KV-Bezirken stellt Abbildung 38 die regionale Abrechnungshäufigkeit im Jahr 2023 für die Versandpauschale und die Empfangspauschale für eArztbriefe dar. Hierbei ist zu beachten, dass die Abrechnungen jeweils pro 100.000 Versicherte angegeben sind, um trotz der Größenunterschiede zwischen den KV-Bezirken eine Vergleichbarkeit zu erlangen.

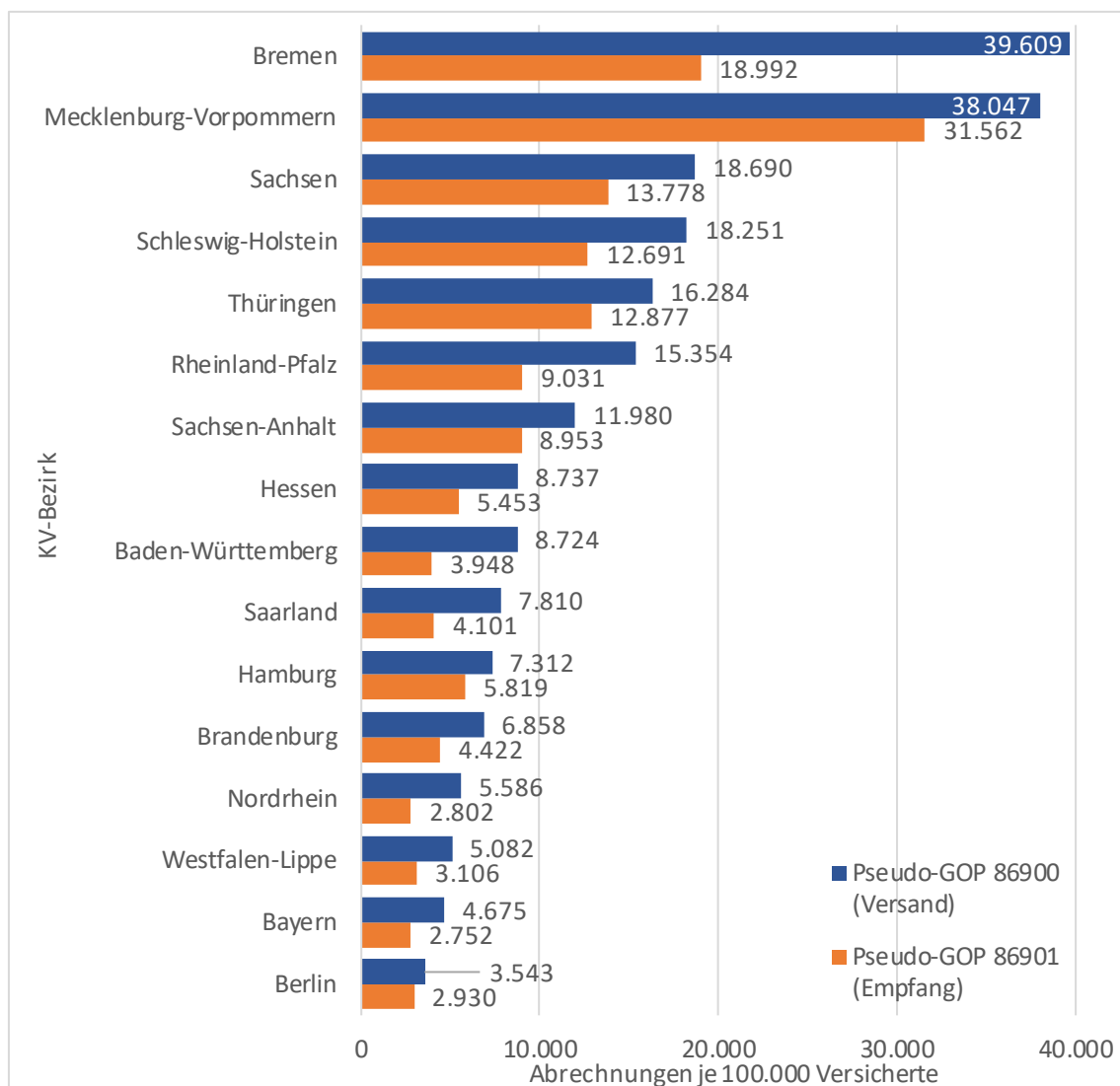


Abbildung 38 Regionale Abrechnungshäufigkeit der Versandpauschale (Pseudo-GOP 86900) und der Empfangspauschale (Pseudo-GOP 86901) für eArztbriefe nach KV-Bezirken im Jahr 2023. Dargestellt ist die normierte Abrechnungshäufigkeit je 100.000 Versicherte. Sortiert nach der Abrechnungshäufigkeit der Pseudo-GOP 86900.

Wie Abbildung 38 zu entnehmen ist, wurde die Versandpauschale (Pseudo-GOP 86900) im Jahr 2023 in fünf KV-Bezirken (Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen, Bremen, Schleswig-Holstein) relativ zu ihrer Größe besonders häufig abgerechnet. In allen KV-Bezirken wird die Empfangspauschale (Pseudo-GOP 86901) seltener abgerechnet als die Versandpauschale (Pseudo-GOP 86900). Dies spiegelt sich auch in der bundesweiten Abrechnungshäufigkeit wider (siehe Abbildung 37). Die absolute Abrechnungshäufigkeit für die beiden Leistungen sowie für den Zuschlag zur Versandpauschale (GOP 01660) je KV-Bezirk ist im Anhang aufgeführt (siehe Tabelle 83).

Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Einrichtungsformen

Einzelpraxen rechneten im Jahr 2023 rund 3,3 Mio., Gemeinschaftspraxen etwa 3,4 Mio. und MVZ rund 800.000 Versandpauschalen für eArztbriefe (Pseudo-GOP 86900) ab. Die Empfangspauschale für eArztbriefe (Pseudo-GOP 86901) rechneten Einzelpraxen insgesamt rund 2,7 Mio.-mal ab, Gemeinschaftspraxen rund 1,9 Mio.-mal und MVZ rund 250.000-mal.

Die vorliegenden Abrechnungshäufigkeiten sind bemerkenswert, da Einzelpraxen deutlich weiter verbreitet sind als Gemeinschaftspraxen. Letztere hatten aber im Jahr 2023 ebenfalls hohe Abrechnungszahlen der Versand- und Empfangspauschale (Pseudo-GOP 86900 bzw. 86901). Deshalb wurden zusätzlich die durchschnittlichen Abrechnungszahlen derjenigen Einrichtungen analysiert, die im Jahr 2023 mindestens eine Leistung nach Pseudo-GOP 86900 bzw. 86901 abgerechnet haben (Abbildung 39).

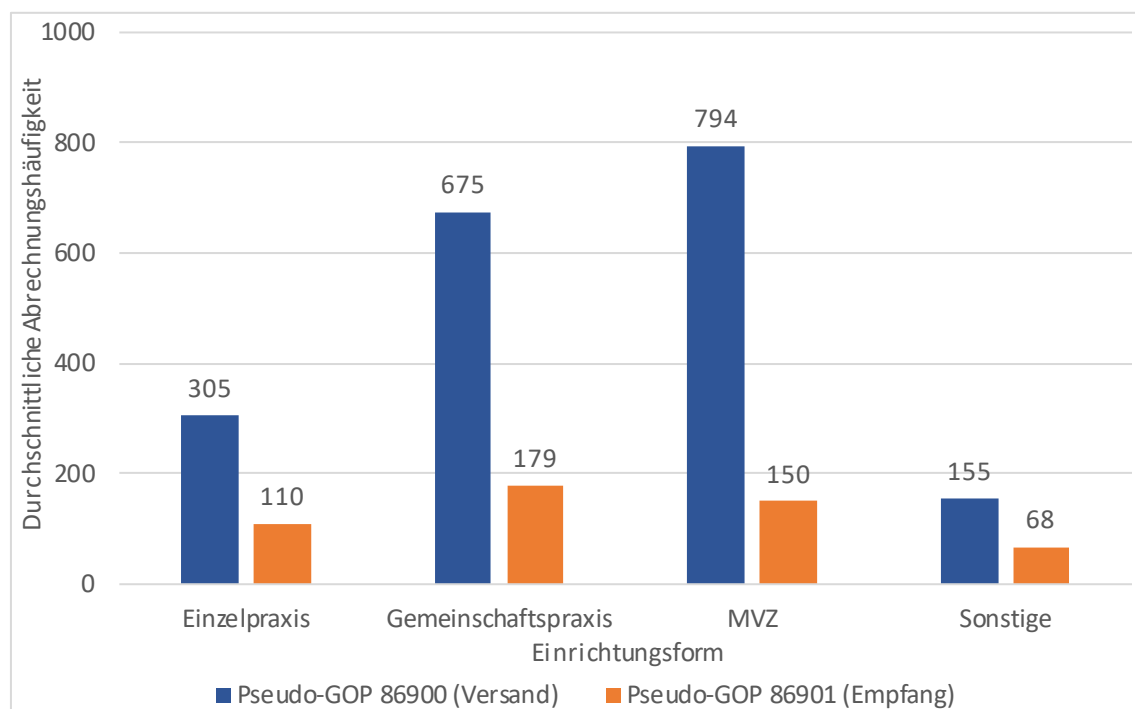


Abbildung 39 Durchschnittliche Abrechnungen je abrechnende Einrichtung der Leistungen zu eArztbriefen im Jahr 2023, dargestellt nach Einrichtungsformen.

MVZ und Gemeinschaftspraxen rechneten im Jahr 2023 durchschnittlich am meisten Pauschalen für den Versand von eArztbriefen ab: Für sie lagen mit rund 790 bzw. rund 680 Abrechnungen der Versandpauschale für eArztbriefe (Pseudo-GOP 86900) mehr als doppelt so viele Abrechnungen vor wie für Einzelpraxen mit rund 300 Abrechnungen je Praxis (siehe Abbildung 39). Weniger ausgeprägt waren die Unterschiede der durchschnittlichen Abrechnungszahlen für die Empfangspauschale (Pseudo-GOP 86901), die von Gemeinschaftspraxen im Schnitt rund 180-mal, von MVZ 150-mal und von Einzelpraxen 110-mal abgerechnet wurden.

Die Abrechnungshäufigkeit der Förderpauschale für eArztbriefe (GOP 01660) nach Einrichtungsformen ist im Anhang zu finden (Tabelle 84).

8.5 Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Fachgruppen und Anteil abrechnender Ärztinnen und Ärzte in den Fachgruppen

Bei der fachgruppenspezifischen Betrachtung der Leistungsentwicklung der Versandpauschale (Pseudo-GOP 86900) und der Empfangspauschale (Pseudo-GOP 86901) zu eArztbriefen im Jahr 2023 fällt auf, dass einige Fachgruppen die Versandpauschale, andere Fachgruppen die Empfangspauschale in größerem Maße abrechneten. Dies ist in Abbildung 40 zu sehen:

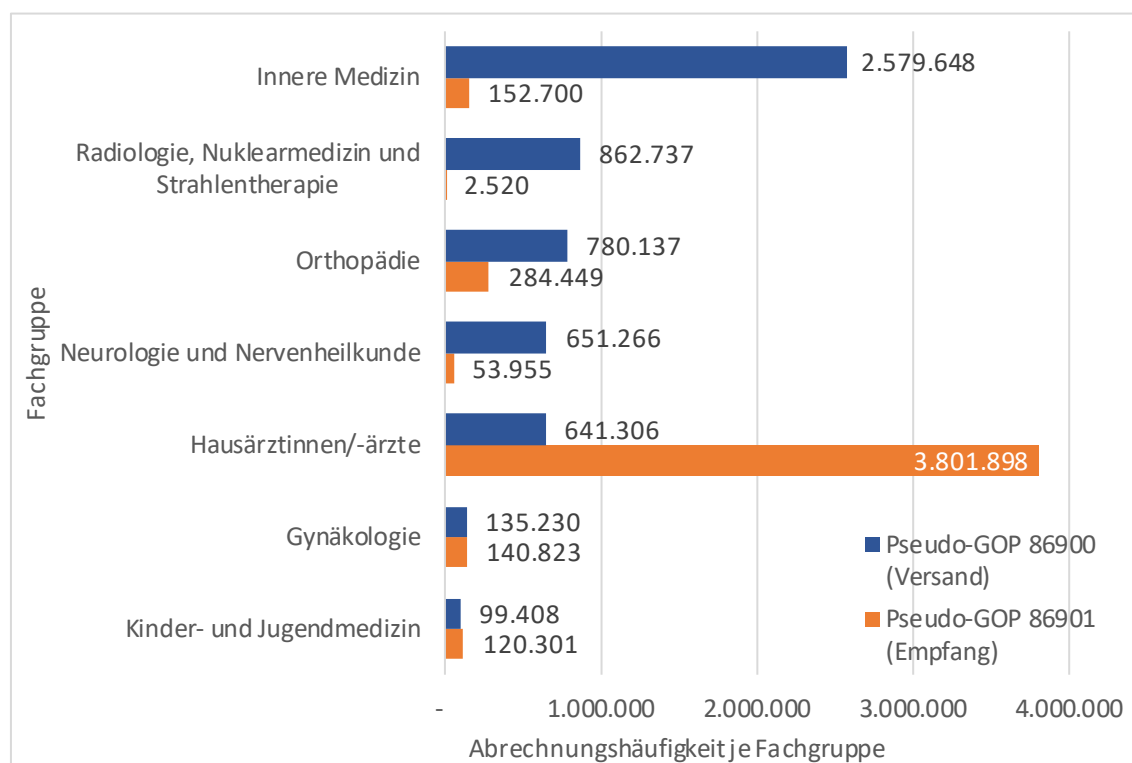


Abbildung 40 Abrechnungshäufigkeit der Versandpauschale (Pseudo-GOP 86900) und der Empfangspauschale (Pseudo-GOP 86901) für eArztbriefe im Jahr 2023 je Fachgruppe mit besonders großer Abrechnungshäufigkeit. Sortiert nach Abrechnungen der Pseudo-GOP 86900.

Der Großteil der Fachgruppen hat im Jahr 2023 die Versandpauschale für eArztbriefe (Pseudo-GOP 86900) häufiger abgerechnet als die Empfangspauschale (Pseudo-GOP 86901). Darunter haben Fachärztinnen und -ärzte der Inneren Medizin die Versandpauschale für eArztbriefe (Pseudo-GOP 86900) mit rund 2,6 Mio. Abrechnungen am häufigsten abgerechnet (Abbildung 40). Die einzigen Fachgruppen, welche die Empfangspauschale häufiger als die Versandpauschale abrechneten, waren die Hausärztinnen und -ärzte, die Gynäkologie und die Kinder- und Jugendmedizin. Für die Hausärztinnen und -ärzte lag mit rund 3,8 Mio. Abrechnungen der Empfangspauschale (Pseudo-GOP 86901) auch die größte Abrechnungshäufigkeit für die Pseudo-GOP 86901 vor. Die detaillierten Werte für alle Fachgruppen sind im Anhang in zu finden (Tabelle 85).

Bei den Auswertungen zur Abrechnungshäufigkeit der Leistungen zu eArztbriefen nach Fachgruppen ist zu beachten, dass die Fachgruppe der Inneren Medizin mit 14.400 Ärztinnen und Ärzten sowie die der Hausärztinnen und -ärzte mit rund 63.500 Ärztinnen und Ärzten besonders große Fachgruppen sind. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass die Abrechnungshäufigkeit bei diesen Fachgruppen höher lag als bei den anderen Fachgruppen. Abbildung 41 zeigt, in welchen Fachgruppen im Jahr 2023 die Versandpauschale (GOP 86900) oder die Empfangspauschale (GOP 86901) für eArztbriefe von einem besonders großen Anteil abgerechnet wurde.

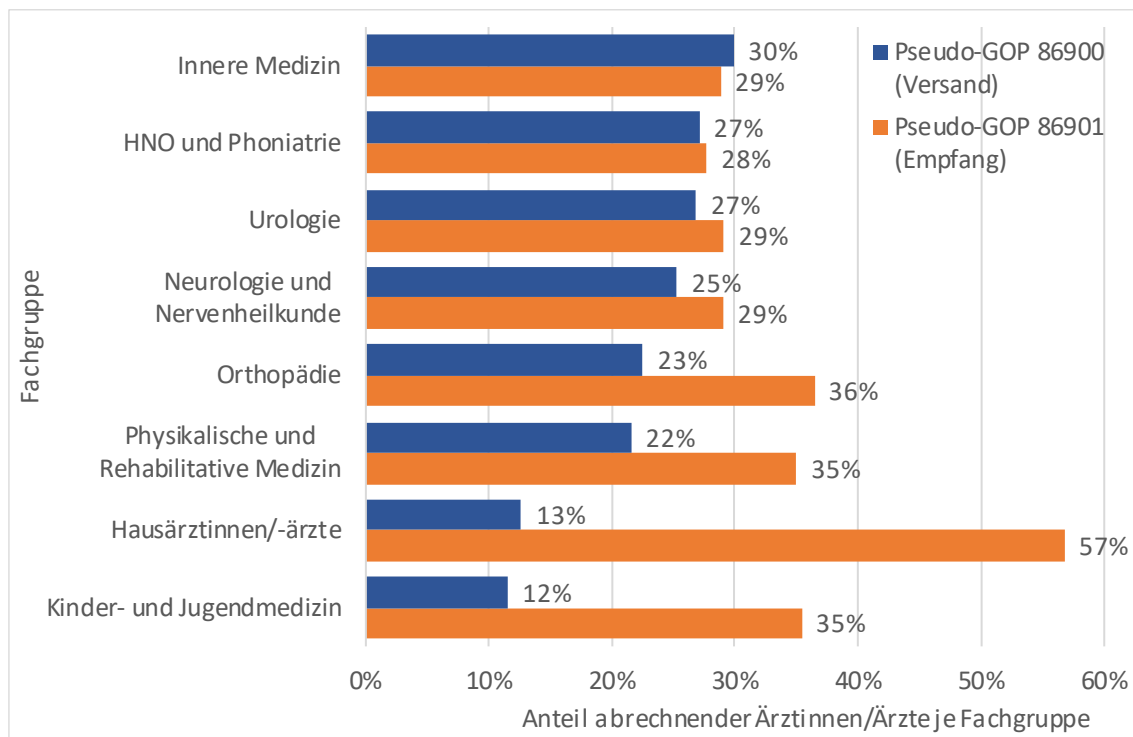


Abbildung 41 Anteil der Ärztinnen/Ärzte in den Fachgruppen, die die Versandpauschale (Pseudo-GOP 86900) und die Empfangspauschale (Pseudo-GOP 86901) für eArztbriefe im Jahr 2023 abgerechnet hat. Dargestellt sind jeweils die Fachgruppen mit dem größten Anteil. Sortiert nach Anteil der Ärztinnen/Ärzte, die die Versandpauschale abgerechnet hat.

In Abbildung 41 fällt auf, dass bei den Fachgruppen, in denen der Anteil der Ärztinnen und Ärzte, die mindestens eine Versandpauschale für eArztbriefe (Pseudo-GOP 86900) im Jahr 2023 abgerechnet haben, besonders groß ist, auch ein ähnlich großer Anteil mindestens eine Empfangspauschale (Pseudo-GOP 86901) abgerechnet hat. Dies zeigt sich für die Fachgruppen Innere Medizin, HNO und Phoniatrie, Urologie sowie Neurologie und Nervenheilkunde. Demgegenüber haben in den Fachgruppen Orthopädie, Physikalische und Rehabilitative Medizin, Hausärztinnen/-ärzte und Kinder- und Jugendmedizin im Verhältnis deutlich mehr Ärztinnen und Ärzte Empfangspauschalen (Pseudo-GOP 86901) als Versandpauschalen (Pseudo-GOP 86900) abgerechnet. Die Anteile für alle Fachgruppen sind im Anhang in Tabelle 85 aufgeführt.

9 Anwendungen auf der elektronischen Gesundheitskarte

9.1 Allgemeine Erläuterungen

Begrifflichkeiten

Zu den ersten medizinischen Anwendungen in der Telematikinfrastruktur gehören der elektronische Medikationsplan (eMP) und das Notfalldatenmanagement (NFDm). Der Notfalldatensatz enthält auch den Datensatz Persönliche Erklärungen (DPE), in dem der Hinweis auf das Vorhandensein eines Organspendeausweises, einer Patientenverfügung oder einer Vorsorgevollmacht gespeichert werden kann.

Der elektronische Medikationsplan ist die digitale Umsetzung des bereits im Oktober 2016 eingeführten bundeseinheitlichen Medikationsplans (BMP). Den elektronischen Medikationsplan müssen Haus- und Fachärztinnen/-ärzte für anspruchsberechtigte Versicherte erstellen und aktualisieren (sofern von den anspruchsberechtigten Versicherten gewünscht). Technisch gesehen legt die Ärztin/der Arzt einen elektronischen Medikationsplan für die Versicherte/den Versicherten an und erzeugt auf Basis der eingetragenen Daten einen BMP zum Ausdrucken und Aushändigen an die Versicherte/den Versicherten.

Wegen des Fehlens der technischen Voraussetzungen konnten die Gebührenordnungspositionen des Notfalldatenmanagements bis Juli 2020 noch nicht abgerechnet werden und auch der elektronische Medikationsplan noch keine Anwendung finden. Ein technischer Engpass war vor allem durch zu dieser Zeit noch nicht in ausreichendem Umfang vorhandene E-Health-Konnektoren und ihre mangelnde Integration in die Praxisverwaltungssysteme entstanden.

Rechtlicher Hintergrund

Mit dem PDSG wurde in § 87 Abs. 2a SGB V eine zeitlich befristete Förderung für die Erstellung des Notfalldatensatzes festgeschrieben.

Im DVPMG war vorgesehen, den Notfalldatensatz und den DPE in die Patientenkurzakte zu überführen. Damit sollten diese Daten nur noch online abrufbar sein. Eine weitere Pflege dieser Daten auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) des Versicherten war nicht mehr vorgesehen. Mit dem DigiG wurde die Ausrichtung der Patientenkurzakte geändert. In § 334 Abs. 2 Satz 3 SGB V i. V. m. § 355 Abs. 4 SGB V ist vorgesehen, dass die Patientenkurzakte als Teil der ePA den Notfalldatensatz sowie weitere Daten enthalten soll, die geeignet sind, eine Übersicht aller relevanten Daten des Versicherten zu geben. Näheres soll in einer Rechtsverordnung festgelegt werden. Zusätzlich soll der Notfalldatensatz weiterhin als Offline-Anwendung auf der eGK erhalten bleiben (vgl. § 291 Abs. 2 Nr. 3 SGB V).

Details zum bundeseinheitlichen Medikationsplan sind seit 2016 in § 31a SGB V geregelt. Durch das DVPMG ist dort seit Juni 2021 auch das Anrecht für Versicherte auf Erstellung und Aktualisierung eines elektronischen Medikationsplans verankert.

Das DigiG sieht in § 342 Absatz 2a Satz 1 Punkt 1 SGB V vor, dass die ePA ab 15. Januar 2025 zur digitalen Unterstützung des Medikationsprozesses über eine elektronische Medikationsliste

Verordnungs- und Dispensierdaten sowie Daten von freiverkäuflichen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln beinhalten können muss. Diese Medikationsliste ist der erste Schritt auf dem Weg zum digital gestützten Medikationsprozess in der ePA, der den elektronischen Medikationsplan auf der eGK ablösen soll.

9.2 Notfalldatenmanagement

9.2.1 Regelungen und Vergütung im EBM

Durch den Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 53. Sitzung⁵¹ mit Wirkung zum 1. Januar 2018 wurden drei Gebührenordnungspositionen für Leistungen im Zusammenhang mit dem Notfalldatensatz in den EBM aufgenommen. Mit dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 524. Sitzung⁵² wurde gemäß dem Auftrag aus dem PDSG zeitlich befristet vom 20. Oktober 2020 bis 19. Oktober 2021 die Bewertung des Zuschlags für die Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) von 80 Punkten auf 160 Punkte verdoppelt. Danach betrug die Bewertung wieder 80 Punkte (Tabelle 34):

Tabelle 34 Gebührenordnungspositionen für das Management von Notfalldatensätzen; KV = Kassenärztliche Vereinigung.

GOP	Bezeichnung	Punkte	€ (2023)
01640	Zuschlag für die Anlage eines Notfalldatensatzes Einmal im KHF	80	9,19
01641	Zuschlag Notfalldatensatz, insbesondere für die Überprüfung auf dessen Notwendigkeit und dessen Aktualisierung Zuschlag zu allen Versicherten-, Grund-/Konsiliarpauschalen bei persönlichem Arzt-Patienten-Kontakt; wird von KV automatisch einmal im BHF hinzugefügt	4	0,46
01642	Löschen eines Notfalldatensatzes Einmal im BHF	1	0,11

Eine Berechnung der Gebührenordnungspositionen für den Notfalldatensatz ist nur möglich, wenn die Vertragsarztpraxis an die Telematikinfrastruktur angeschlossen ist und nach Kenntnis der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung die technischen Voraussetzungen zur Nutzung des Notfalldatenmanagements (§ 334 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 SGB V i. V. m. Anlage 4a zum BMV-Ä) in der Arztpraxis vorliegen. Ein Notfalldatensatz kann nur für Patientinnen und Patienten angelegt werden, die Vorerkrankungen oder Allergien haben, von denen Ärztinnen, Ärzte und medizinisches Personal in einem Notfall wissen sollten.⁵³ Ein besonderes Einsatzgebiet für den

⁵¹ Siehe [Beschluss](#) des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 53. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

⁵² Siehe [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 524. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

⁵³ Siehe Anhang 2 der [Vereinbarung](#) zum Inhalt und zur Anwendung der elektronischen Gesundheitskarte (BMV-Ä Anlage 4a) – Kassenärztliche Bundesvereinigung (kbv.de).

Notfalldatensatz ist die Schwangerschaft, für die der Notfalldatensatz zunächst für den begrenzten Zeitraum der Schwangerschaft angelegt und danach auf Wunsch der Versicherten ggf. gelöscht wird.

Mit den Beschlüssen aus der 603. und 664. Sitzung des BA, welche die Finanzierungsregelung außerhalb der MGV zusammentragen, wurde die Finanzierung des Notfalldatenmanagements für das Jahr 2023 bzw. 2024 weiterhin über eine extrabudgetäre Vergütung gewährleistet. Diese Beschlüsse, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind bzw. gefasst wurden, stellt Tabelle 35 zusammengefasst dar.

Tabelle 35 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zum Notfalldatenmanagement, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden. MGV= morbiditätsbedingte Gesamtvergütung.

Kategorie	Beschluss	Inkrafttreten	Inhalt/GOP	Laufzeit/Befristung
Finanzierung	603. BA	01.01.2023	Vergütung GOP 01640 bis 01642 außerhalb der MGV	31.12.2023
Finanzierung	664. BA	01.01.2024	Vergütung GOP 01640 bis 01642 außerhalb der MGV	31.12.2024

9.2.2 Leistungsentwicklung

Zu den Leistungen für den Notfalldatensatz zählen die Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640), die Prüfung der Notwendigkeit bzw. Aktualisierung eines Notfalldatensatzes (GOP 01641) sowie die Löschung eines Notfalldatensatzes (GOP 01642). Im Folgenden werden für diese Leistungen jeweils die Abrechnungshäufigkeit und der Leistungsbedarf dargestellt.

Abrechnungshäufigkeit der Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640)

Die Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) wurde im Jahr 2023 insgesamt rund 572.200-mal abgerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr entsprach dies einem Anstieg um 77 % (2022: rund 324.000 Abrechnungen). Die Entwicklung der vorigen Jahre zeigt Abbildung 42 (siehe auch Anhang, Tabelle 88).

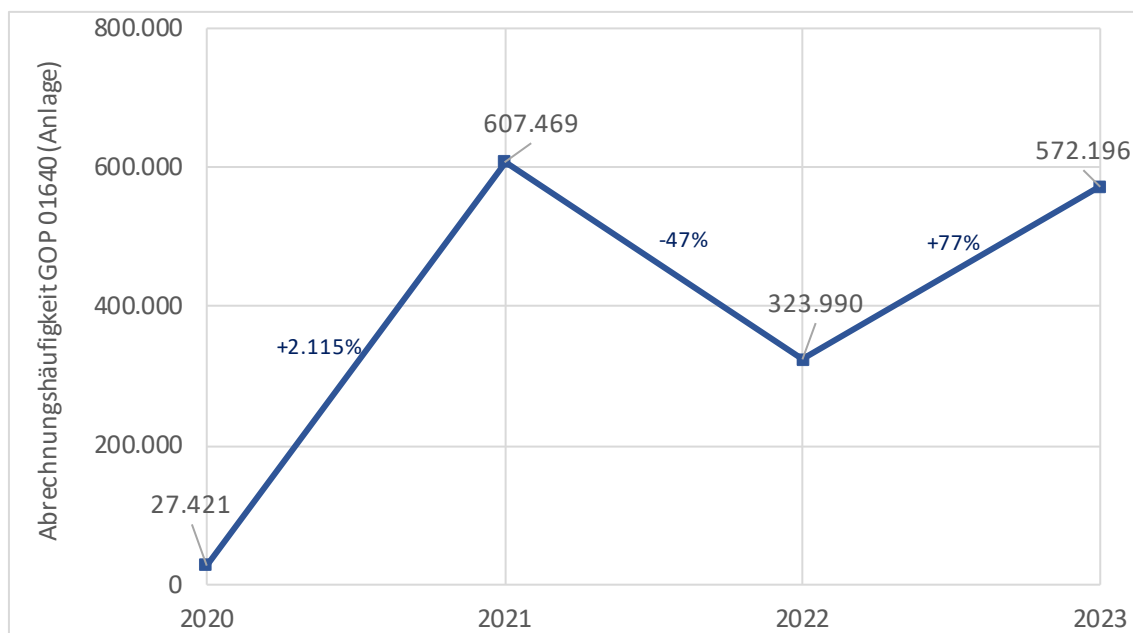


Abbildung 42 Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit der Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) in den Jahren 2020 bis 2023.

Mit der Verbreitung der notwendigen Technologien für die Bearbeitung von NFD in den Arztpraxen stieg die Abrechnungshäufigkeit der Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) vom Jahr 2020 zum Jahr 2021 stark an – mehr als eine Verzwanzigfachung auf rund 607.000 Abrechnungen. Im Jahr 2021 ging sie bis zum Jahr 2022 um rund die Hälfte auf rund 324.000 Abrechnungen zurück, stieg im Jahr 2023 aber erneut um 77 % auf rund 572.000 Abrechnungen.

Abbildung 43 zeigt die Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit des Zuschlags für die Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) zwischen dem 1. Quartal 2022 und dem 4. Quartal 2023.

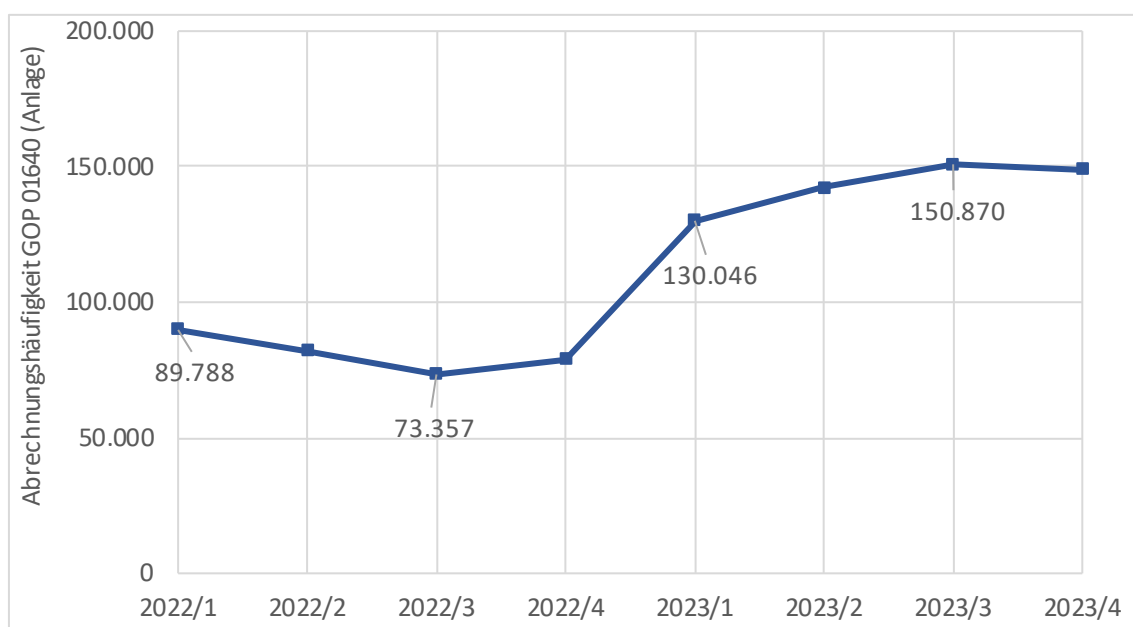


Abbildung 43 Abrechnungshäufigkeit der Gebührenordnungsposition für die Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) in den Jahren 2022 und 2023.

Die Abrechnungshäufigkeit der Anlage eines NFD (GOP 01640) stieg im Jahr 2023 bis auf einen Höchststand von rund 150.900 Abrechnungen im 3. Quartal an, nach einem Rückgang im Jahr 2022 auf bis zu rund 73.400 Abrechnungen im 3. Quartal (Abbildung 43; siehe auch Anhang, Tabelle 86). Der Anstieg der Leistung könnte insbesondere durch eine anzunehmende Zunahme der technischen Voraussetzungen in den Praxen zu erklären sein.

Leistungsbedarf der Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640)

Der Abrechnungshäufigkeit folgend stieg der Leistungsbedarf der Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) von rund 2,9 Mio. € im Jahr 2022 um rund 80 % auf 5,3 Mio. € im Jahr 2023 (siehe Tabelle 36 und Anhang, Tabelle 88). Im 4. Quartal 2023 verdoppelte sich der Leistungsbedarf nahezu auf rund 1,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahresquartal (4. Quartal 2022: 710.402 €; siehe auch Anhang, Tabelle 87).

Tabelle 36 Leistungsbedarf zum Notfalldatenmanagement (GOP 01640 bis 01642) im Jahr 2023.

Leistung	Leistungsbedarf 2023 in €				
	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4	Gesamt
GOP 01640 (Anlage)	1.194.905	1.307.362	1.386.349	1.369.223	5.257.838
GOP 01641 (Zuschlag NFD)	39.095.323	38.941.598	44.969.867	45.173.046	168.179.833
GOP 01642 (Löschung)	25	29	29	98	181

Abrechnungshäufigkeit des Zuschlags Notfalldatensatz (GOP 01641)

Der Zuschlag Notfalldatensatz (GOP 01641) wird pro Behandlungsfall automatisch von der zuständigen KV zugesetzt, sobald am Arbeitsplatz einer Ärztin oder eines Arztes ein Anschluss an die TI und zusätzliche technische Voraussetzungen gegeben sind. Deshalb lässt sich an der Zunahme der Abrechnungshäufigkeit ablesen, wie sich die Anschlüsse an die Telematik-Infrastruktur und die weiteren Voraussetzungen über die Jahre verbreitet haben. Die Verbreitung der Technologien in einzelnen Fachgruppen wird unter 9.2.3 dargestellt.

Die Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit der GOP 01641 in den Jahren 2020 bis 2023 ist in Abbildung 44 dargestellt.

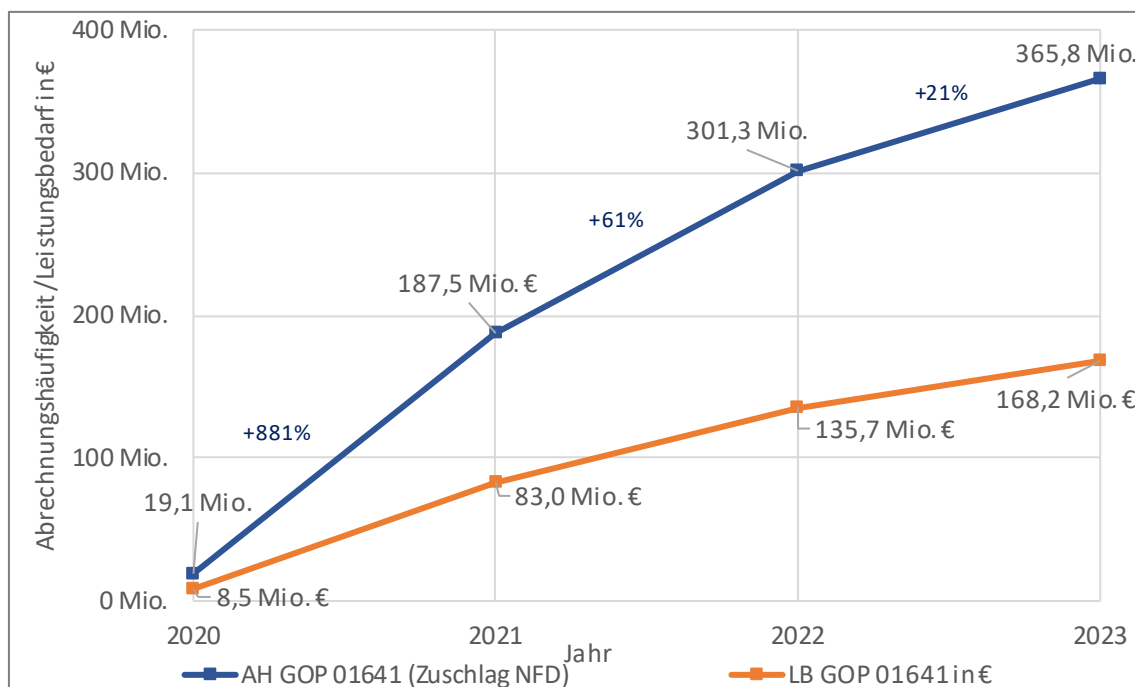


Abbildung 44 Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit und des Leistungsbedarfes des Zuschlags für die Überprüfung und Aktualisierung des Notfalldatensatzes (GOP 01641) in den Jahren 2020 bis 2023. Die Entwicklungen in den Jahren 2018 und 2019 sind nicht dargestellt.

Seitdem sich die technologischen Voraussetzungen im Jahr 2020 zu verbreiten begannen, ist die Abrechnungshäufigkeit des Zuschlags Notfalldatensatz (GOP 01641) in jedem Jahr stark gestiegen (Abbildung 44). Im Jahr 2021 verzehnfachte sie sich fast im Vergleich zum Vorjahr (+ 881 %) mit rund 187,5 Mio. Abrechnungen; im Jahr 2022 betrug sie mit rund 301,3 Mio. Abrechnungen 61 % mehr als im Jahr 2021 und im Jahr 2023 mit rund 365,8 Mio. Abrechnungen 21 % mehr als im Jahr 2022.

Der Zuschlag Notfalldatensatz wird unabhängig vom tatsächlichen Vorhandensein eines Notfalldatensatzes bei einer/einem Versicherten abgerechnet, wenn die Praxis über die technischen Voraussetzungen zur Verarbeitung eines Notfalldatensatzes verfügt.

Im Vergleich mit der Abrechnungshäufigkeit der GOP 01640 (Anlage eines Notfalldatensatzes) sowie der GOP 01642 (Löschung eines Notfalldatensatzes) fällt auf, dass diese beiden Leistungen mit rund 572.000 bzw. 1.600 Abrechnungen im Jahr 2023 sehr viel niedrigere Zahlen zeigten als der Zuschlag Notfalldatensatz (GOP 01641) mit 365,8 Mio. Abrechnungen (siehe Abbildung 42, Abbildung 44 und Anhang, Tabelle 88). Daraus folgt, dass im Verhältnis in einem sehr kleinen Teil der Behandlungsfälle ein Notfalldatensatz von einer Ärztin oder einem Arzt aktiv angelegt oder gelöscht wurde, für den ein Zuschlag Notfalldatensatz (GOP 01641) anfiel.

Die Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit des Zuschlags für die Überprüfung und Aktualisierung des Notfalldatensatzes (GOP 01641) in den Quartalen der Jahre 2022 und 2023 ist in Abbildung 45 nachzuvollziehen.

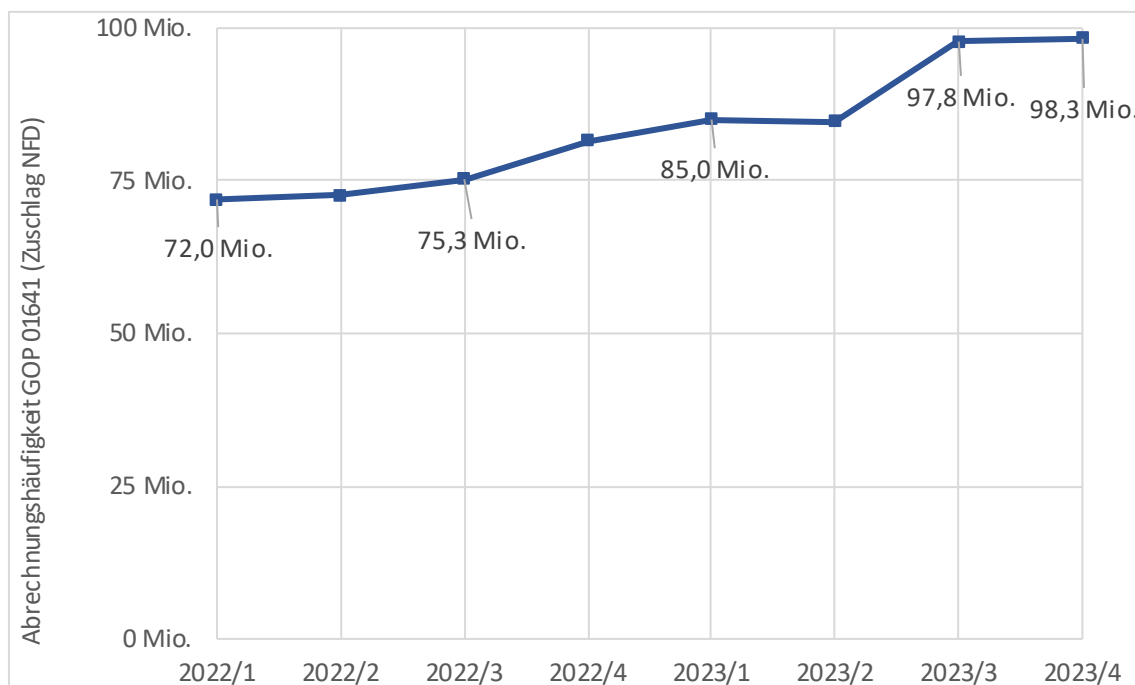


Abbildung 45 Abrechnungshäufigkeit für den Zuschlag Überprüfung und Aktualisierung des Notfalldatensatzes (GOP 01641) in den Jahren 2022 und 2023.

Im 3. Quartal 2023 stieg die Abrechnungshäufigkeit besonders stark an: um rund 30 % von rund 75,3 Mio. Abrechnungen im 3. Quartal 2022 auf 97,8 Mio. (siehe auch Anhang, Tabelle 86). Daran lässt sich ablesen, wie sich die Technologien für das Notfalldatenmanagement in den Einrichtungen der vertragsärztlichen Versorgung in diesem Zeitraum verbreitet haben.

Leistungsbedarf des Zuschlags Notfalldatensatz (GOP 01641)

Auch der Leistungsbedarf der GOP 01641 im Jahr 2023 spiegelt die dynamische Entwicklung wider; er stieg von rund 135,7 Mio. € im Jahr 2022 um rund ein Viertel auf 168,2 Mio. € im Jahr 2023 (siehe Abbildung 44 sowie Anhang, Tabelle 88). Die größte Steigerung ergab sich im 3. Quartal 2023 (siehe Tabelle 36 sowie Anhang, Tabelle 87).

Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf der Löschung eines Notfalldatensatzes (GOP 01642)

Die Gebührenordnungsposition für die Löschung eines Notfalldatensatzes (GOP 01642) wurde im Jahr 2023 rund 1.600-mal abgerechnet. Abbildung 46 zeigt die Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit quartalsweise in den Jahren 2022 und 2023:

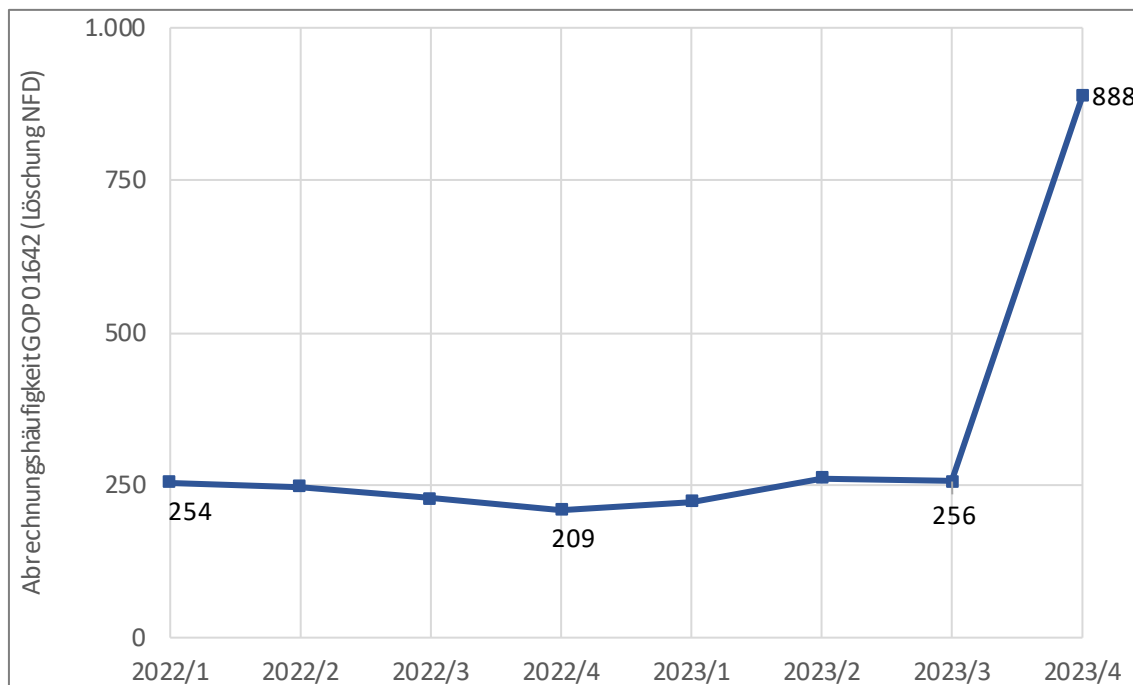


Abbildung 46 Abrechnungshäufigkeit der Gebührenordnungsposition für die Löschung des Notfalldatensatzes (GOP 01642) in den Jahren 2022 und 2023.

Die Streichung eines Notfalldatensatzes (GOP 01642) wurde in den Jahren 2022 und 2023 bis zum 3. Quartal 2023 auf niedrigem, konstantem Niveau abgerechnet, aber im 4. Quartal 2023 stieg die Abrechnungshäufigkeit mit rund 900 Abrechnungen auf mehr als das Vierfache des Vorjahresquartals an (4. Quartal 2022: n = 209).

Über das gesamte Jahr 2023 entstand durch Abrechnungen der GOP 01642 ein Leistungsbedarf von rund 180 € (siehe Tabelle 36).

Alle Abrechnungszahlen und der Leistungsbedarf finden sich im Anhang (Tabelle 86, Tabelle 87 und Tabelle 88).

9.2.3 Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit sowie nach Fachgruppen und Einrichtungsformen

Die Leistungen des Notfalldatenmanagements zeigten im Jahr 2023 große Unterschiede in den Abrechnungshäufigkeiten (siehe Kapitel 9.2.2 des Berichts). Da diese Leistungen auch in ihrer Art sehr unterschiedlich konzipiert sind – als aktive Bearbeitung eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) und als automatisch von der KV zugesetzter Zuschlag (GOP 01641) – werden im Folgenden verschiedene Kennzahlen für die Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) und den Zuschlag Notfalldatensatz (GOP 01641) untersucht. Zur Löschung eines Notfalldatensatzes (GOP 01642) enthält der vorliegende Bericht wegen der geringen Verbreitung dieser Leistung keine weiteren Analysen.

Regionale Abrechnungshäufigkeit (GOP 01640)

In Abbildung 47 ist zu sehen, wie häufig die Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) im Jahr 2023 in verschiedenen KV-Bezirken abgerechnet wurde. Die Abrechnungshäufigkeit ist jeweils pro 100.000 Versicherte angegeben, um die KV-Bezirke trotz ihrer unterschiedlichen Größe vergleichen zu können.

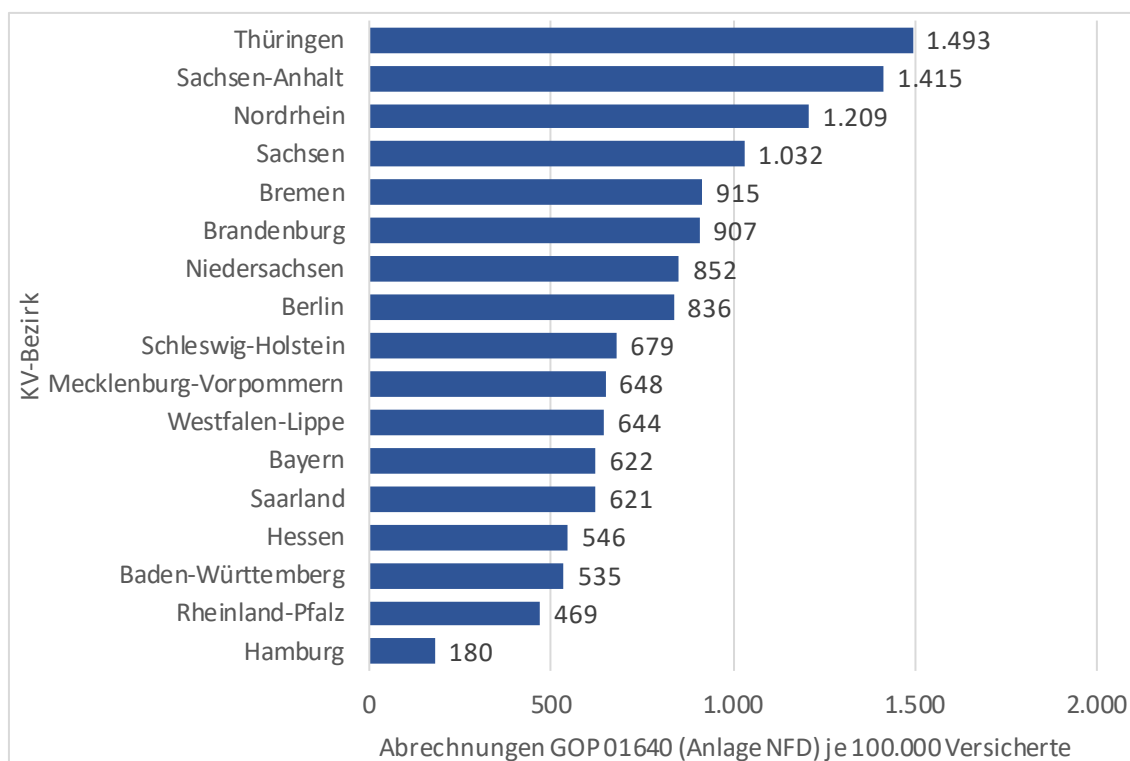


Abbildung 47 Regionale Abrechnungshäufigkeit für den Zuschlag für die Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) nach KV-Bezirken im Jahr 2023. Dargestellt ist die normierte Abrechnungshäufigkeit je 100.000 Versicherte.

Die Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) wurde im Jahr 2023 besonders häufig in den KV-Bezirken Thüringen mit 1.500 Abrechnungen, Sachsen-Anhalt mit 1.400 Abrechnungen, in Nordrhein mit 1.200 Abrechnungen sowie Sachsen mit 1.000 Abrechnungen je 100.000 Versicherte abgerechnet. Insgesamt wurde die GOP 01640 mit rund 103.000 Abrechnungen im Jahr 2023 am häufigsten im KV-Bezirk Nordrhein abgerechnet. Die gesamte und die relative Abrechnungshäufigkeit für alle KV-Bezirke sind im Anhang dargestellt (Tabelle 89).

Abrechnungshäufigkeit nach Fachgruppen: Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640)

Besonders interessant ist, die Abrechnungshäufigkeit der verschiedenen Leistungen zum Notfalldatenmanagement aufgeschlüsselt nach Fachgruppen zu betrachten. Die fünf Fachgruppen, die im Jahr 2023 am häufigsten die Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) abgerechnet haben, zeigt Abbildung 48.

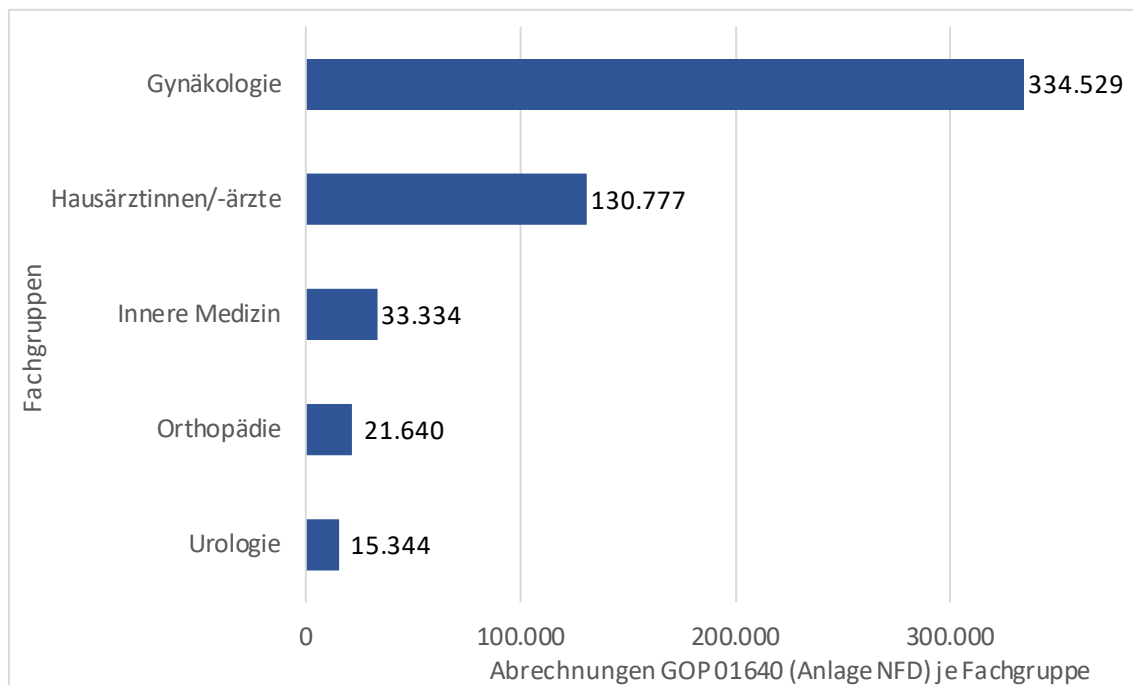


Abbildung 48 Die fünf Fachgruppen mit der größten Abrechnungshäufigkeit für den Zuschlag für die Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640).

Abbildung 48 ist zu entnehmen, dass die Gynäkologie mit rund 335.000 Abrechnungen diejenige Fachgruppe ist, welche am häufigsten die Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) abgerechnet hat, gefolgt von der Gruppe der Hausärztinnen und Hausärzte mit rund 131.000 Abrechnungen. Da die Gruppe der Hausärztinnen und -ärzte rund fünfmal so groß ist wie die Fachgruppe Gynäkologie (63.549 bzw. 13.530 Ärztinnen und Ärzte), hat die Fachgruppe Gynäkologie die GOP 01640 überproportional häufig abgerechnet. Ein häufiger Grund für die gynäkologisch angezeigte Anlage eines Notfalldatensatzes ist eine Schwangerschaft. Die Anlage eines Notfalldatensatzes für Schwangere kann deshalb als mögliche Erklärung für die besonders häufige Abrechnung der GOP 01640 gelten.⁵⁴ Zu den Daten aller Fachgruppen siehe Anhang, Tabelle 90.

Abrechnungshäufigkeit nach Fachgruppen: Zuschlag Notfalldatensatz (GOP 01641)

Die Überprüfung der Notwendigkeit und die Aktualisierung eines Notfalldatensatzes (GOP 01641) wird pro Behandlungsfall automatisch von der zuständigen KV zugesetzt, sobald am Arbeitsplatz einer Ärztin oder eines Arztes ein Anschluss an die TI und zusätzliche technische Voraussetzungen gegeben sind. Deshalb lässt sich am Prozentsatz der Ärztinnen und Ärzte, für die mindestens eine GOP 01641 im Jahr 2023 abgerechnet wurde, für die meisten Fachgruppen

⁵⁴ Die Fachgruppe Gynäkologie hat auch die Löschung eines Notfalldatensatzes (GOP 01642) mit 1.498 Abrechnungen (von 1.628 Abrechnungen insgesamt) im Jahr 2023 mit Abstand am häufigsten abgerechnet. Auch hierfür dürften Schwangerschaften ein Faktor sein, da der Grund für einen Notfalldatensatz mit Ende der Schwangerschaft wegfallen kann und die Patientinnen evtl. die Löschung des Notfalldatensatzes wünschen. Siehe Anhang, Tabelle 90.

ablesen, ob die technischen Voraussetzungen besonders weit oder ggf. besonders wenig verbreitet waren.

Abbildung 49 zeigt diejenigen Fachgruppen, bei denen der Anteil der abrechnenden Ärztinnen und Ärzte für die GOP 01641 im Jahr 2023 bei über 85 % lag. Für alle anderen Fachgruppen mit regulärem Patientenkontakt lag der Anteil abrechnender Ärztinnen und Ärzte zwischen 66 % (Fachgruppe Psychotherapie) und 85 % (Fachgruppen Neurologie und Nervenheilkunde und Orthopädie).⁵⁵

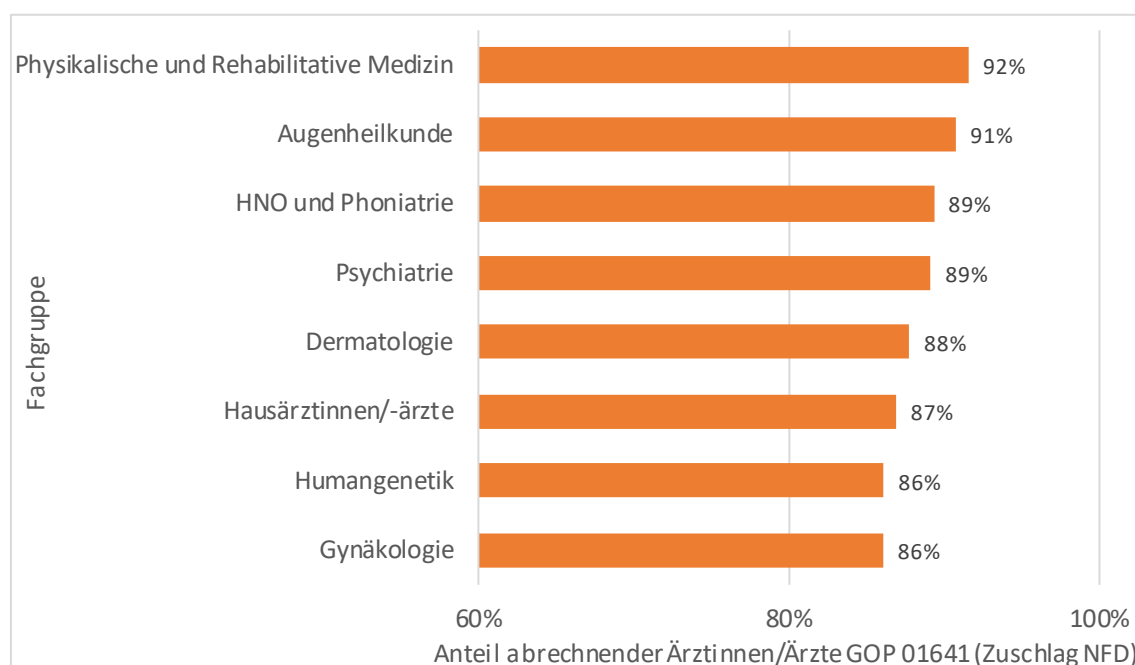


Abbildung 49 Fachgruppen mit dem größten Anteil Ärztinnen/Ärzte, für die im Jahr 2023 GOP 01641 abgerechnet wurde. Für die Gesamtzahlen der abrechnenden Ärztinnen/Ärzte siehe Anhang, Tabelle 90.

Wie in Abbildung 49 ersichtlich, wurde der Zuschlag Notfalldatensatz (GOP 01641) für mehr als 90 % der Ärztinnen und Ärzte in den Fachgruppen Physikalische und Rehabilitative Medizin und Augenheilkunde im Jahr 2023 abgerechnet. Bei insgesamt zehn Fachgruppen wurde für rund 90 % der Ärztinnen und Ärzte mindestens eine GOP 01641 abgerechnet, bei sieben Fachgruppen für rund 80 % und bei den restlichen vier Fachgruppen rund 70 % oder weniger (siehe Anhang, Tabelle 90).

Abrechnungshäufigkeit nach Einrichtungsformen: Anlage NFD (GOP 01640) und Zuschlag NFD (GOP 01641)

Um zu verstehen, in welchen Einrichtungsformen Notfalldatensätze angelegt, überprüft und aktualisiert werden, wird die Abrechnungshäufigkeit des Zuschlags für die Anlage eines

⁵⁵ Für die Fachgruppen ohne regulären Patientenkontakt, Pathologie und Labor, lag der Anteil der Ärztinnen und Ärzte, die GOP 01641 abgerechnet haben, bei 4 % bzw. 20 % (Siehe Anhang, Tabelle 90).

Notfalldatensatzes (GOP 01640) sowie des Zuschlags Notfalldatensatz (GOP 01641) untersucht. Dabei werden die durchschnittlichen Abrechnungen je abrechnende Einrichtung miteinander verglichen, um der unterschiedlich häufigen Verbreitung der Einrichtungsformen Rechnung zu tragen. Die Entwicklung der durchschnittlichen Abrechnungshäufigkeit für beide Leistungen ist in Abbildung 50 dargestellt.

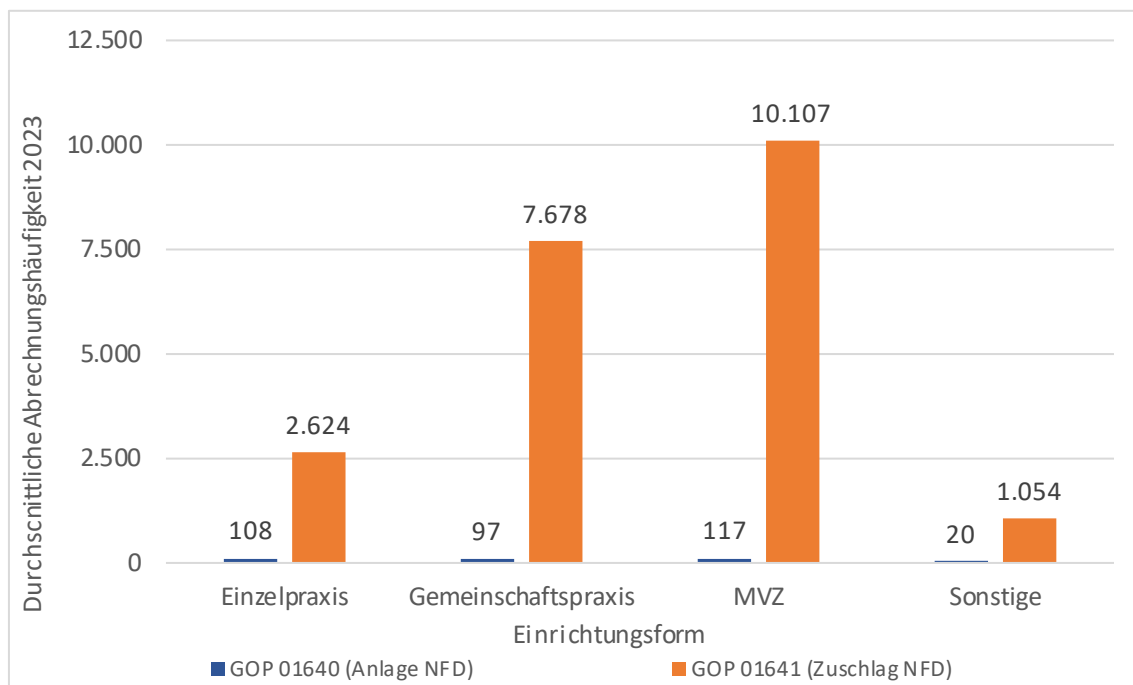


Abbildung 50 Durchschnittliche Abrechnungen des Zuschlags für die Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) und des Zuschlags Notfalldatensatz (GOP 01641) je abrechnende Einrichtung im Jahr 2023, dargestellt nach Einrichtungstypen.

Im Vergleich der beiden Leistungen in den verschiedenen Einrichtungstypen fällt auf, dass die Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) mit ähnlicher Häufigkeit in Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen und MVZ abgerechnet wurde (Abbildung 50, siehe auch Anhang, Tabelle 91). Am häufigsten rechneten im Durchschnitt MVZ (rund 120 Abrechnungen) die GOP 01640 im Jahr 2023 ab, gefolgt von Einzelpraxen (rund 110 Abrechnungen) und an dritter Stelle Gemeinschaftspraxen (rund 100 Abrechnungen).

Anders zeigt sich das Verhältnis der Abrechnungshäufigkeit des Zuschlags Notfalldatensatz (GOP 01641) unter den Einrichtungstypen. Diese Leistung wurde für Einzelpraxen am seltensten abgerechnet (rund 2.600 Abrechnungen), fast dreimal häufiger für Gemeinschaftspraxen (rund 7.700 Abrechnungen) und rund viermal häufiger für MVZ (rund 10.100 Abrechnungen). Dies dürfte in der unterschiedlich großen Anzahl der behandelten Versicherten bzw. der abgerechneten Grund-, Versicherten- und Konsiliarpauschalen je Einrichtung begründet liegen, denen der Zuschlag Notfalldatensatz automatisch zugesetzt wurde.

9.2.4 Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten mit der Anlage eines Notfalldatensatzes

Im Jahr 2023 wurde für rund 558.000 Versicherten ein Notfalldatensatz angelegt und der Zuschlag für die Anlage (GOP 01640) abgerechnet. Abbildung 51 zeigt das Alter und Geschlecht der Versicherten, bei denen diese Leistung abgerechnet wurde.

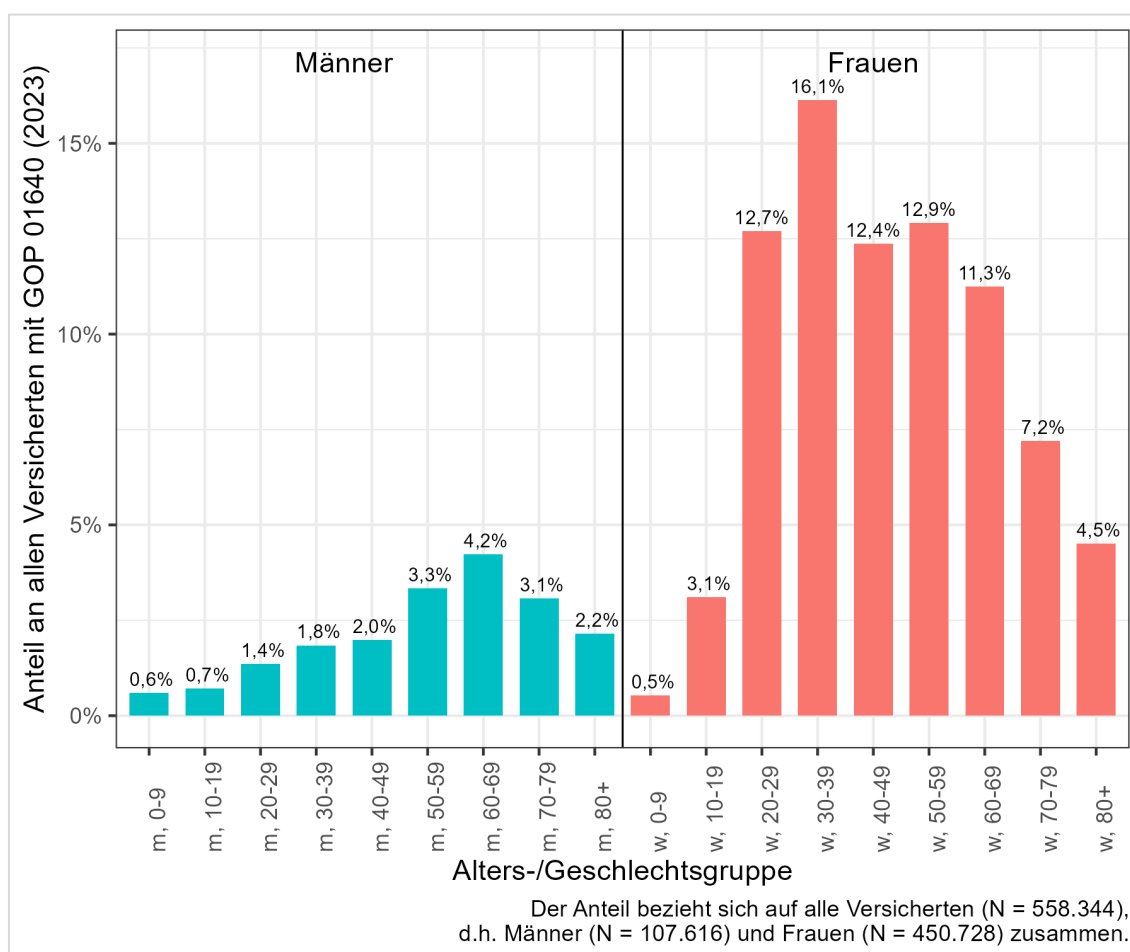


Abbildung 51 Anteil der verschiedenen Altersgruppen und Geschlechter derjenigen Versicherten, für die im Jahr 2023 ein Notfalldatensatz angelegt wurde (GOP 01640); m = männlich, w = weiblich.

Insgesamt wurde wesentlich häufiger für Frauen als für Männer ein Notfalldatensatz angelegt und GOP 01640 abgerechnet. Rund 81 % der Versicherten, für welche die Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) abgerechnet wurde, waren weiblich (450.728 Frauen von 558.344 Versicherten insgesamt).

Die Anlage eines Notfalldatensatzes (GOP 01640) wurde am häufigsten für Frauen zwischen 30 und 39 Jahren abgerechnet (16 % der Versicherten), gefolgt von Frauen zwischen 20 und 29 Jahren sowie zwischen 50 und 59 Jahren (jeweils 13 %), wie in Abbildung 51 zu sehen ist. Ein möglicher Grund für die häufige Abrechnung der GOP 01640 bei jüngeren Frauen kann darin liegen, dass eine Schwangerschaft einen medizinischen Anlass für die Anlage eines Notfalldatensatzes darstellt.

9.3 Elektronischer Medikationsplan

9.3.1 Regelungen und Vergütung im EBM

Der Bewertungsausschuss hat im Jahr 2016 in seiner 383. Sitzung die Vergütung für die Erstellung und Aktualisierung eines Medikationsplans beschlossen. Ärztinnen und Ärzte erhalten die Vergütung für den Medikationsplan pauschal als Einzelleistung über die GOP 01630 (Tabelle 33) und über Zuschläge. Hausärztinnen/-ärzte sowie Kinder- und Jugendmedizinerinnen/-mediziner erhalten die Einzelleistungsvergütung (GOP 01630) bei Versicherten, bei denen sie nicht die Chronikerpauschale abrechnen. Fachärztinnen/-ärzte erhalten die Einzelleistungsvergütung (GOP 01630) für Versicherte, bei denen sie die fachgruppenspezifische Zusatzpauschale Onkologie, die GOP 30700 (Schmerztherapie) bzw. die fachgruppenspezifische Zusatzpauschale für die Behandlung eines Transplantatträgers bzw. einer Transplantatträgerin abrechnen.

Im Jahr 2019 hat der Bewertungsausschuss in seiner 430. Sitzung in Beschlussteil G⁵⁶ mit Wirkung zum 1. Januar 2019 die Übertragung des elektronischen Medikationsplans auf die eGK des Versicherten als fakultativen Leistungsinhalt der GOP 01630 aufgenommen. Zusätzlich wurden die Übertragung des elektronischen Medikationsplans auf die eGK der Versicherten in den Anhang 1 des EBM aufgenommen, um zu konkretisieren, dass dies ein Leistungsbestandteil der Versicherten- und Grundpauschalen sowie von sonstigen Gebührenordnungspositionen ist. Diese Ergänzung wurde durch die Einführung der technischen Voraussetzung zur Nutzung der Fachanwendung elektronischer Medikationsplan in der TI begründet.

Tabelle 37 Zuschlag für die Erstellung eines Medikationsplans (Die Übertragung eines elektronischen Medikationsplans auf die eGK ist fakultativ).

GOP	Bezeichnung	Punkte	€ (2023)
01630	Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 03000, 04000, 07345, 08345, 09345, 10345, 13435, 13437, 13439, 13561, 13601, 13675, 13677, 15345, 26315 und 30700 für die Erstellung eines Medikationsplans gemäß § 29a Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä)	39	4,39

Mit den Beschlüssen aus den Sitzungen des 603. und 664. BA, welche die Finanzierungsregelung außerhalb der MGV zusammentragen, wurde die Finanzierung der GOP 01630 für das Jahr 2023 bzw. 2024 weiterhin über eine extrabudgetäre Vergütung gewährleistet. Diese neuen Beschlüsse des Jahres 2023 zum elektronischen Medikationsplan sind als Übersicht in Tabelle 38 zusammengestellt.

⁵⁶ Siehe [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 430. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

Tabelle 38 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zum Medikationsplan, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden. MGV = morbiditätsbedingte Gesamtvergütung.

Kategorie	Beschluss	Inkrafttreten	Inhalt/ GOP	Laufzeit/Befristung
Finanzierung	603. BA	01.01.2023	Vergütung GOP 01630 außerhalb der MGV	31.12.2023
Finanzierung	664. BA	01.01.2024	Vergütung GOP 01630 außerhalb der MGV	31.12.2024

9.3.2 Leistungsentwicklung

Die Leistungsentwicklung für die Erstellung eines elektronischen Medikationsplans lässt sich an dieser Stelle nicht darstellen, da diese für den größten Teil der Anspruchsberechtigten Bestandteil sowohl der Versicherten- und Grundpauschalen als auch der Behandlungspauschalen für geriatrische und chronisch kranke Versicherte ist.

Zudem ist die Erstellung eines elektronischen Medikationsplans über die GOP 01630 lediglich ein fakultativer Leistungsinhalt neben dem obligaten Leistungsinhalt der Erstellung eines gedruckten Medikationsplans. Es liegen dem Bewertungsausschuss keine gesonderten Daten über die Erstellung eines elektronischen Medikationsplans vor. Beide Leistungen lassen sich deshalb nicht voneinander trennen.

10 Digitale Gesundheitsanwendungen

10.1 Allgemeine Erläuterungen

Begrifflichkeiten

Als Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) werden Medizinprodukte mit niedriger Risikoklasse (Klasse I oder IIa) bezeichnet, deren Hauptfunktion wesentlich auf digitalen Technologien beruht. DiGA können von den Krankenkassen erstattet werden. Sie sind dazu bestimmt, die Erkennung, Überwachung und Behandlung von Krankheiten oder Kompensierung von Behinderungen zu unterstützen. Die Einsatzgebiete und gesundheitsbezogenen Ziele von DiGA sind beispielsweise die Bereitstellung von elektronischen Gesundheitsinformationen, die Bereitstellung von elektronischen Tagebüchern zur Dokumentation und die Unterstützung durch Diagnostik- und Therapie-Software oder interaktive Online-Therapieprogramme.

Durch das DigiG, das im März 2024 in Kraft getreten ist, können zukünftig auch Medizinprodukte mit höherer Risikoklasse (Klasse IIb) als dauerhafte DiGA zugelassen werden.

Rechtlicher Hintergrund

Mit dem DVG vom 19. Dezember 2019 wurde im § 33a Abs. 1 SGB V erstmals für alle gesetzlich Krankenversicherten ein Anspruch auf die Versorgung mit DiGA geschaffen.

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) wurde dabei durch den § 139e Abs. 9 SGB V ermächtigt, eine Rechtsverordnung für das Verfahren und die Anforderungen zur Prüfung der Erstattungsfähigkeit von DiGA in der gesetzlichen Krankenversicherung zu erlassen (Digitale-Gesundheitsanwendungen-Verordnung – DiGAV). Mit dem Gesetz wurde das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) beauftragt, ein Verzeichnis für die erstattungsfähigen digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA-Verzeichnis) zu führen (darin dauerhaft aufgenommene DiGA siehe Tabelle 39).

Sofern mit der Nutzung einer DiGA ärztliche Leistungen verbunden sind, sind diese der Ärztin oder dem Arzt zu vergüten. Das BfArM legt fest, ob und gegebenenfalls welche ärztlichen Leistungen betroffen sind. Bei der Festlegung der entsprechenden Vergütung dieser ärztlichen Leistungen ist zu unterscheiden, ob die DiGA dauerhaft oder vorläufig zur Erprobung in das DiGA-Verzeichnis aufgenommen wurde. Für ärztliche Leistungen zu dauerhaft aufgenommenen DiGA ist gemäß § 87 Abs. 5c SGB V der EBM anzupassen. Die Vergütung der ärztlichen Leistungen im Zusammenhang mit vorläufig aufgenommenen DiGA haben die Partner des BMV-Ä ebenfalls gemäß § 87 Abs. 5c SGB V vereinbart und in der DiGA-Vereinbarung (Anlage 34 zum BMV-Ä) geregelt.⁵⁷

⁵⁷ Siehe [Vereinbarung](#) über ärztliche Leistungen und deren Vergütung im Zusammenhang mit vorläufig zur Erprobung in das Verzeichnis nach § 139e Absatz 1 SGB V aufgenommenen digitalen Gesundheitsanwendungen gemäß § 87 Absatz 5c Satz 2 SGB V in der vertragsärztlichen Versorgung vom 01.08.2021 in der Fassung vom 15. November 2024 – Kassenärztliche Bundesvereinigung (kbv.de).

Tabelle 39 Auflistung der dauerhaften DiGA (n=29) (Stand Ende 2023). *DiGA, zu denen für das Jahr 2023 vertragsärztliche Aufgaben durch das BfArM festgelegt wurden.

Name DiGA	Kurzbeschreibung	seit Quartal
velibra	bei generalisierter Angststörung, einer Panikstörung oder einer sozialen Angststörung	2020/4
somnio*	bei Ein- und Durchschlafstörungen	2020/4
elevida	bei Multipler Sklerose, wenn zusätzlich eine Fatigue vorliegt	2020/4
deprexis	bei Depression und depressiven Verstimmungen	2021/1
vorvida	bei schädlichem Alkoholkonsum oder Alkoholabhängigkeit	2021/2
HelloBetter Stress und Burnout	bei Stressbeanspruchung durch Schwierigkeiten bei der Lebens- und Arbeitsbewältigung	2021/4
HelloBetter Diabetes und Depression	zur Reduktion der depressiven Symptomschwere bei Personen mit Diabetes Mellitus	2021/4
Kalmeda*	bei chronischer Tinnitusbelastung	2021/4
HelloBetter Vaginismus Plus	zur Verbesserung der vaginalen Penetrationsfähigkeit beim Geschlechtsverkehr	2022/1
Vivira*	bei nicht-spezifischen Kreuzschmerzen oder Arthrose der Wirbelsäule	2022/1
HelloBetter Panik	zur Behandlung und Reduktion der Symptomschwere einer Panikstörung und Agoraphobie mit Panikstörung	2022/2
Selfapys Online-Kurs bei Depression	bei Depression	2022/2
zanadio*	für Personen mit Adipositas	2022/3
Selfapys Online-Kurs bei Generalisierter Angststörung	bei Generalisierter Angststörung	2022/4
Invirto*	Expositionstherapie bei Agoraphobie, Panikstörung oder sozialer Phobie	2022/4
Kaia Rückenschmerzen	multimodale Therapie für erwachsene Patientinnen und Patienten mit nicht-spezifischen Rückenschmerzen	2023/1
Kranus Edera	Behandlung von Erektionsstörungen und ihren Ursachen	2023/1
Mindable Panik & Agoraphobie	Schwerpunkt auf der Gewöhnung an Körpersymptome, sowie in-vivo Konfrontation	2023/2
Oviva Direkt für Adipositas*	multimodale Adipositas therapie	2023/2
Nichtraucher Helden-App	Überwachung, Behandlung und Linderung einer diagnostizierten Tabakabhängigkeit	2023/2
HelloBetter Chronische Schmerzen	psychologisches Online-Programm zur anhaltenden Reduktion der Beeinträchtigung durch chronische Schmerzen	2023/3
Selfapys Online-Kurs bei Binge-Eating-Störung	Methoden und Techniken basierend auf der kognitiven Verhaltenstherapie sowie Dokumentation der Übungen bei Binge-Eating-Störung	2023/3
Mawendo*	Trainingsprogramm bei Erkrankungen der Kniescheibe (Patella), das auf das Krankheitsbild, die Übungen und die Trainingsphasen individualisiert wird	2023/3
Selfapys Onlinekurs bei Bulimia Nervosa	Methoden und Techniken basierend auf der kognitiven Verhaltenstherapie sowie Dokumentation der Übungen bei Bulimia Nervosa	2023/3
companion patella*	für Patientinnen und Patienten mit Vorderem Knieschmerz im Alter von 14- 65 Jahren	2023/4
Novego: Depressionen bewältigen	Online-Unterstützungsprogramm zur Überbrückung von Wartezeiten, begleitend zu einer Therapie oder als Anschlussangebot zur Stabilisierung	2023/4

Name DiGA	Kurzbeschreibung	seit Quartal
PINK! Coach	zur Stärkung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und der Gesundheitskompetenz sowie einer Linderung der psychischen, psychosomatischen und somatischen Folgen einer Brustkrebserkrankung	2023/4
Cara Care für Reizdarm	zur Symptomreduktion funktioneller gastrointestinaler Beschwerden	2023/4
edupression.com	webbasiertes Therapieprogramm bei Depressionen durch Psychoedukation inkl. eines Stimmungsdiagramms	2023/4

In § 134 Abs. 1 SGB V ist geregelt, dass der Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit den Herstellern digitaler Gesundheitsanwendungen mit Wirkung für alle Krankenkassen Vergütungsbeträge für DiGA vereinbart.

Der Rechtsanspruch auf die Versorgung mittels einer DiGA für gesetzlich Versicherte ist im § 33a Abs. 1 SGB V geregelt. Mögliche ärztliche Leistungen, die im Zusammenhang mit einer dauerhaft in das DiGA-Verzeichnis aufgenommenen DiGA stehen, werden vom Bewertungsausschuss gemäß § 87 Abs. 5c Satz 1 SGB V innerhalb von drei Monaten nach der dauerhaften Aufnahme in den EBM aufgenommen – sofern die Leistungen dort noch nicht berücksichtigt sind.

Für 22 der 29 DiGA, die bis Ende des Jahres 2023 dauerhaft aufgenommen wurden – alle DiGA außer somnio, Vivira, Kalmeda, zanadio, Invirto, Mawendo und companion patella – hat das BfArM keine erforderlichen ärztlichen Leistungen bestimmt, sodass keine Beschlüsse zur Anpassung des EBM getroffen wurden. Für die dauerhafte DiGA Kalmeda hat das BfArM erforderliche ärztliche Leistungen bestimmt. Der Bewertungsausschuss hat nach fachlicher Prüfung festgestellt, dass es sich dabei um Leistungen handelt, die bereits Bestandteil des EBM sind und daher ebenfalls keinen Beschluss zur Anpassung des EBM getroffen. Im Jahr 2024 hat das BfArM seine Entscheidung zu den ärztlichen Leistungen revidiert und sieht nun keine ärztlichen Leistungen mehr im Zusammenhang mit der DiGA Kalmeda.

10.2 Regelungen und Vergütung im EBM

Für die Einführungszeit von DiGA als neue Versorgungsform beschloss der Erweiterte Bewertungsausschuss (EBA) in seiner 70. Sitzung (Teil A)⁵⁸ eine gesonderte und befristete Vergütung mit der GOP 01470 (Erstverordnung einer DiGA). Die GOP 01470 galt für dauerhaft aufgenommene DiGA vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2022 und für vorläufig aufgenommene DiGA vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2022.

Ab 1. Januar 2023 wurde die Erstverordnung einer DiGA dann – wie in Teil C des Beschlusses geregelt – Bestandteil der Versicherten- und Grundpauschalen.

Mit dem Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschuss (EBA) in seiner 70. Sitzung (Teil B) wurde bereits erstmalig eine DiGA-spezifische Leistung in den EBM aufgenommen (GOP 01471).

⁵⁸ Siehe [Beschluss](#) des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 70. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

Die GOP 01471 vergütet die im Zusammenhang mit der DiGA somnio notwendigen ärztlichen Leistungen zur Verlaufskontrolle und Auswertung.

Im weiteren Verlauf wurden weitere Leistungen bei nachfolgenden DiGA implementiert. Zum 1. Juli 2022 wurde die Verlaufskontrolle und Auswertung zur DiGA Vivira mit der GOP 01472 berechnungsfähig⁵⁹. Im Verlauf des Jahres 2023 wurden die Leistungen zu den DiGA zanadio (GOP 01473 zum 1. Januar 2023)⁶⁰, Invirto (GOP 01474 zum 1. April 2023),⁶¹ Oviva direkt für Adipositas und Mawendo (GOP 01475 bzw. 01476 zum 1. Oktober 2023)⁶² in den EBM aufgenommen.

Einen Überblick über die bis Ende des Jahres 2023 im Zusammenhang mit einer DiGA berechnungsfähigen Gebührenordnungspositionen liefert Tabelle 40:

Tabelle 40 Gebührenordnungspositionen für die Verlaufskontrolle und Auswertung der DiGA somnio, Vivira, zanadio, Invirto, Oviva Direkt für Adipositas und für die Auswahl und/oder Individualisierung von Inhalten der DiGA Mawendo.

GOP	Bezeichnung	Punkte	€ (2023)
01471	Zusatzpauschale für die Verlaufskontrolle und die Auswertung der DiGA somnio Einmal im BHF berechnungsfähig, auch im Rahmen einer Videosprechstunde. Die Durchführung per Video muss durch Angabe einer Zusatzkennzeichnung dokumentiert werden.	64	7,35
01472	Zusatzpauschale für die Verlaufskontrolle und die Auswertung der DiGA Vivira Einmal im BHF, aber höchstens zweimal im KHF berechnungsfähig.	64	7,35
01473	Zusatzpauschale für die Verlaufskontrolle und die Auswertung der DiGA zanadio Einmal im BHF, aber höchstens zweimal im KHF berechnungsfähig. Nicht neben GOP01475 berechnungsfähig.	64	7,35
01474	Zusatzpauschale für die Verlaufskontrolle und die Auswertung der DiGA Invirto	64	7,35
01475	Zusatzpauschale für die Verlaufskontrolle und die Auswertung der DiGA Oviva Direkt für Adipositas Einmal im KHF und nicht neben GOP01473 berechnungsfähig.	64	7,35
01476	Zusatzpauschale für die Auswahl und/oder Individualisierung von Inhalten der DiGA Mawendo	64	7,35

Außerdem wurde im Jahr 2023 die Berechnungsfähigkeit mehrerer DiGA-Leistungen ausgeweitet:

- Die Verlaufskontrolle und Auswertung der DiGA Vivira (GOP 01472) wurde zum 1. Januar 2023 auch für die Fachgruppe Physikalische und Rehabilitative Medizin

⁵⁹ Siehe [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 595. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

⁶⁰ Siehe [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 618. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

⁶¹ Siehe [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 641. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

⁶² Siehe [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 677. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

berechnungsfähig (Beschluss des BA in seiner 618. Sitzung (Teil B)). Diese Gruppe kommt zu der bereits berechnungsberechtigten Gruppe der Hausärzte und -ärztinnen, der Fachgruppen Chirurgie und Orthopädie sowie Internisten und Internistinnen ohne Schwerpunkt hinzu.

- Die Verlaufskontrolle und Auswertung der DiGA zanadio (GOP 01473) wurde zum 1. Juli 2023 auch bei männlichen Versicherten berechnungsfähig (Beschluss des BA in seiner 655. Sitzung).⁶³ Auch für den Schwerpunkt Angiologie in der Fachgruppe Innere Medizin wurde diese Leistung mit diesem Beschluss berechnungsfähig. Diese Gruppe kommt zu der bereits berechnungsberechtigten Gruppe der Hausärzte und -ärztinnen und der Schwerpunkte Endokrinologie, Gastroenterologie und Kardiologie in der Fachgruppe Innere Medizin.
- Zwei Leistungen wurden für die Verlaufskontrolle und Auswertung der DiGA somnio und Vivira (GOP 30780 bzw. 30781) in der Schmerztherapie ab 1. Januar 2024 berechnungsfähig (Beschluss des BA in seiner 691. Sitzung).⁶⁴

Eine Übersicht der neuen Beschlüsse des Jahres 2023 zu DiGA enthält Tabelle 41:

Tabelle 41 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zu DiGA, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden. MGv = morbiditätsbedingte Gesamtvergütung.

Kategorie	Beschluss	Inkrafttreten	Inhalt/GOP	Laufzeit/Befristung
Finanzierung	603. BA	01.01.2023	Vergütung der Leistungen zu DiGA außerhalb der MGv	31.12.2023
Neue Leistung/ Finanzierung	618. BA	01.01.2023	Aufnahme und Vergütung der GOP 01473 außerhalb der MGv	Nein
Änderung	618. BA	01.01.2023	Erweiterung der Berechnungsfähigkeit GOP 01472	Nein
Neue Leistung/ Finanzierung	641. BA	01.04.2023	Aufnahme und Vergütung der GOP 01474 außerhalb der MGv	Nein
Änderung	655. BA	01.07.2023	Erweiterung der Berechnungsfähigkeit GOP 01471 und 01473	Nein
Finanzierung	664. BA	01.01.2024	Vergütung der Leistungen zu DiGA außerhalb der MGv	31.12.2024
Neue Leistungen/ Finanzierung	677. BA	01.10.2023	Aufnahme und Vergütung der GOP 01475 und 01476 außerhalb der MGv	Nein
Neue Leistungen/ Finanzierung	691. BA	01.01.2024	Aufnahme und Vergütung der GOP 30780 und 30781 außerhalb der MGv	Nein
Neue Leistung/ Finanzierung	703. BA	01.01.2024	Aufnahme und Vergütung der GOP 01477 außerhalb der MGv	Nein

⁶³ Siehe [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 655. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

⁶⁴ Siehe [Beschluss](#) des Bewertungsausschusses in seiner 691. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

10.3 Leistungsentwicklung

Ende des Jahres 2023 waren insgesamt 52 DiGA im DiGA-Verzeichnis gelistet, davon waren 29 DiGA dauerhaft in das Verzeichnis aufgenommen worden, wie Tabelle 39 zeigt. Zu sechs DiGA waren ärztliche Leistungen mit je einer Gebührenordnungsposition im EBM abgebildet (GOP 01471 bis 01476). Im Folgenden werden die Abrechnungshäufigkeit und der Leistungsbedarf dieser Leistungen im Berichtszeitraum dargestellt.

Abrechnungshäufigkeit

Im Jahr 2023 wurden insgesamt rund 29.000 ärztliche Leistungen zu DiGA (GOP 01471 bis 01476) abgerechnet (siehe Anhang, Tabelle 94). Zu beachten ist, dass die Abrechnungshäufigkeit der Leistungen zu den einzelnen DiGA nicht gleichzusetzen ist damit, wie häufig die DiGA bei Versicherten eingesetzt wird. Die Leistungen zu DiGA (GOP 01471 bis 01476) haben unterschiedliche Bestimmungen für ihre Abrechnung; beispielsweise können die GOP 01472 und 01473 zweimal im Krankheitsfall berechnet werden.

Die Zusatzpauschale für die Verlaufskontrolle und die Auswertung der DiGA somnio (GOP 01471) wurde im Jahr 2023 insgesamt rund 5.400-mal abgerechnet; die Abrechnungszahl stieg um 61 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Leistung zur DiGA Vivira (GOP 01472) wurde im Berichtsjahr rund 18.300-mal abgerechnet. Die Leistung zur DiGA zanadio (GOP 01473) war im Jahr 2023 berechnungsfähig und wurde rund 4.200-mal abgerechnet (alle Zahlen siehe Anhang, Tabelle 94). Die Leistungen zu den DiGA Invirto, Oviva direkt für Adipositas und Mawendo waren nicht für das gesamte Jahr 2023 berechnungsfähig.

Der Verlauf der Abrechnungshäufigkeit der ärztlichen DiGA-Leistungen in den Jahren 2022 und 2023 ist in Abbildung 52 zu sehen.

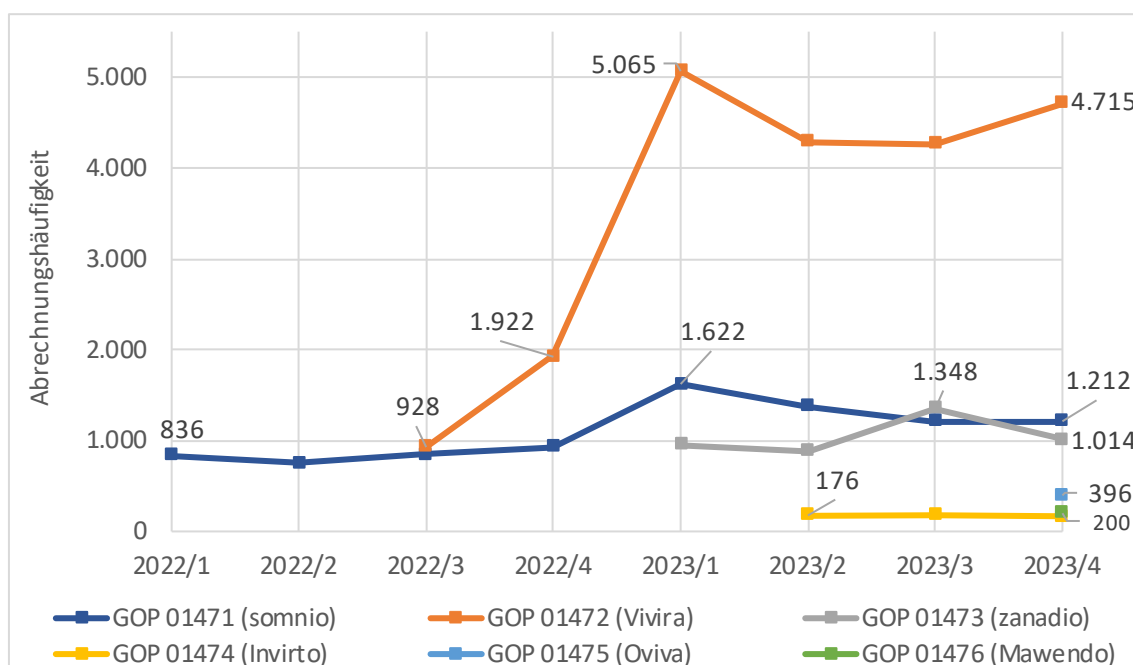


Abbildung 52 Abrechnungshäufigkeit der ärztlichen Leistungen zu den DiGA somnio, Vivira, zanadio, Invirto, Oviva direkt für Adipositas und Mawendo (GOP 01471 bis 01476) in den Jahren 2022 und 2023.

Die Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit für die ärztlichen Leistungen zu einer DiGA unterschied sich stark zwischen den jeweiligen DiGA. Während sich die Abrechnungen der GOP 01472 zur Rückenschmerz-DiGA Vivira zum 1. Quartal 2023 von rund 1.900 auf rund 5.100 Abrechnungen mehr als verdoppelten, stagnierten die Zahlen der GOP 01474 zur Psychotherapie-DiGA Invirto seit ihrer Einführung im 2. Quartal 2023 bei unter 200 Abrechnungen pro Quartal (Abbildung 52). Die Abrechnungshäufigkeit für alle Quartale ist im Anhang zu finden (Tabelle 92).

Leistungsbedarf

Für die im EBM abgebildeten ärztlichen Leistungen zu DiGA ergab sich im Jahr 2023 ein Leistungsbedarf von rund 213.000 €. Diese Summe war annähernd fünfmal größer als der gesamte Leistungsbedarf für die DiGA im Jahr 2022 von rund 45.000 € (Tabelle 42). Dies erklärt sich vor allem durch den Anstieg der Abrechnungshäufigkeit der ärztlichen Leistungen zu der DiGA Vivira (GOP 01472), aber auch dadurch, dass vier neue Leistungen zu DiGA (GOP 01473 bis 01476) im Jahr 2023 berechnungsfähig wurden.

Mehr als die Hälfte des gesamten Leistungsbedarfes im Jahr 2023 machte der Leistungsbedarf für die Verlaufskontrolle und Auswertung zur DiGA Vivira (GOP 01472) von rund 135.000 € aus. (siehe auch Anhang, Tabelle 93).

*Tabelle 42 Leistungsbedarf in € der ärztlichen Leistungen zu DiGA in den Jahren 2022 und 2023. * Bei GOP 01472 gehen im Jahr 2022 und bei GOP 01474 bis 01476 gehen im Jahr 2023 jeweils nicht alle Quartale in die Jahressumme ein, da die Leistungen zum 3., 2. bzw. 4. Quartal des jeweiligen Jahres eingeführt wurden.*

Leistung	Leistungsbedarf 2022 in €					Leistungsbedarf 2023 in €				
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	Gesamt*	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4	Gesamt*
GOP 01471	6.026	5.420	6.064	6.613	24.123	11.800	10.022	8.845	8.845	39.512
GOP 01472	.	.	6.692	13.859	20.550	37.238	31.538	31.348	34.665	134.789
GOP 01473	.	.	.	.	.	6.990	6.469	9.907	7.455	30.822
GOP 01474	.	.	.	.	.	.	1.294	1.308	1.228	3.830
GOP 01475	.	.	.	.	.	.	.	.	2.911	2.911
GOP 01476	.	.	.	.	.	.	.	.	1.470	1.470
Gesamt	6.026	5.420	12.755	20.472	44.673	56.029	49.323	51.409	56.574	213.334

10.4 Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit sowie nach Fachgruppen und Einrichtungenformen

Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit

An der Abrechnungshäufigkeit aller ärztlichen Leistungen zu DiGA in den einzelnen KV-Bezirken lässt sich die regionale Verteilung der Abrechnungen dieser Leistungen ablesen. Die Abrechnungszahlen in Abbildung 53 sind dabei je 100.000 Versicherte angegeben, um die unterschiedlich großen KV-Bezirke miteinander vergleichen zu können.

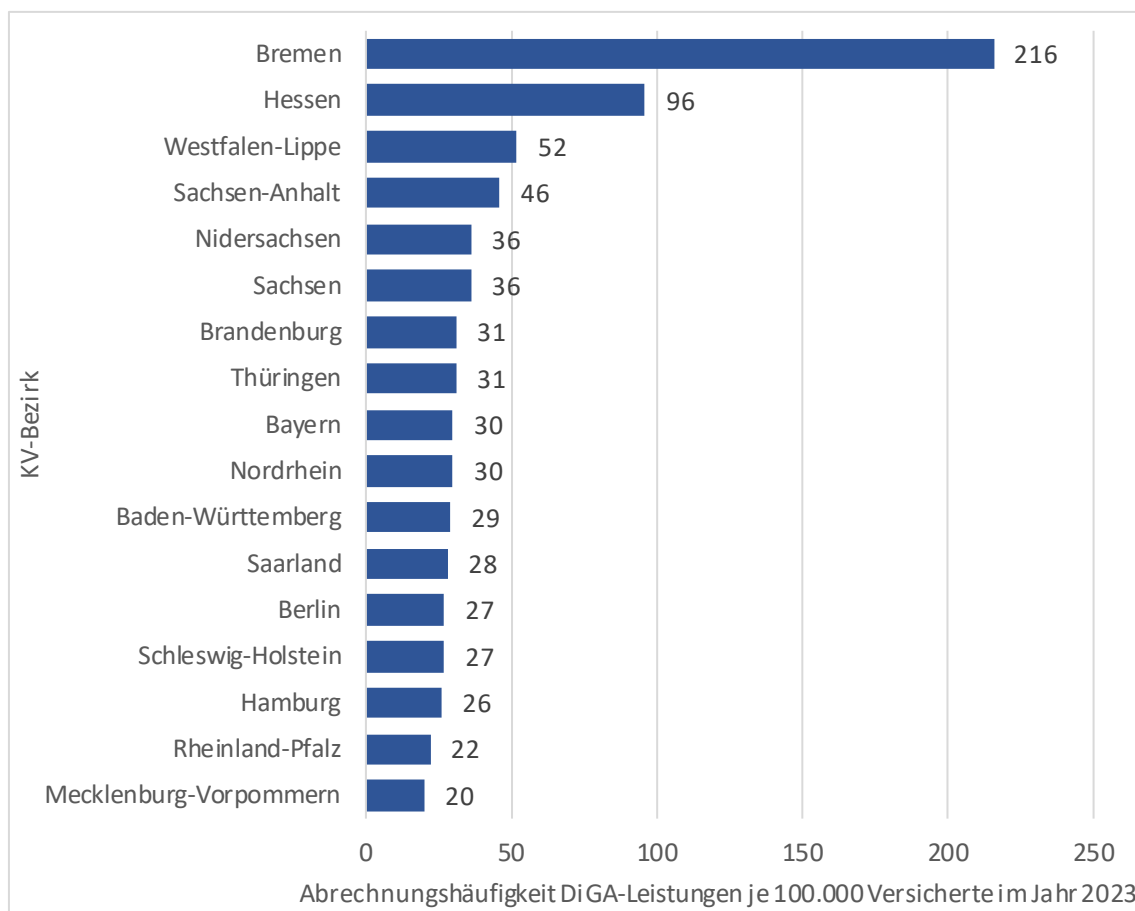


Abbildung 53 Regionale Abrechnungshäufigkeit von ärztlichen Leistungen zu DiGA (GOP 01471 bis 01476) nach KV-Bezirken im Jahr 2023. Dargestellt ist die normierte Abrechnungshäufigkeit je 100.000 Versicherte.

Abbildung 53 zeigt, dass im Jahr 2023 Ärztinnen und Ärzte in den KV-Bezirken Bremen, Hessen, Westfalen-Lippe und Sachsen-Anhalt relativ gesehen am häufigsten ärztliche Leistungen zu DiGA abgerechnet haben. Neben diesen vier Bezirken mit größerer Verbreitung lag die Verbreitung in etwa der Hälfte der KV-Bezirke nah beieinander: die Abrechnungszahlen betrugen dort rund 30 Leistungen nach den GOP 01471 bis 01476 je 100.000 Versicherte. Auch in den KV-Bezirken mit den wenigsten Abrechnungen weicht die Abrechnungshäufigkeit nicht stark von dieser durchschnittlichen Abrechnungshäufigkeit ab (Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern mit rund 20 Abrechnungen je 100.000 Versicherte). Die gesamte Abrechnungshäufigkeit dieser Leistungen in den verschiedenen KV-Bezirken ist im Anhang dargestellt (Tabelle 95).

Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Fachgruppen

Um zu untersuchen, welche Fachgruppen ärztliche Leistungen zu einer DiGA (GOP 01471 bis 01476) im Jahr 2023 besonders häufig abgerechnet haben, sind in Abbildung 54 die Fachgruppen mit mehr als 1.000 Abrechnungen dargestellt.

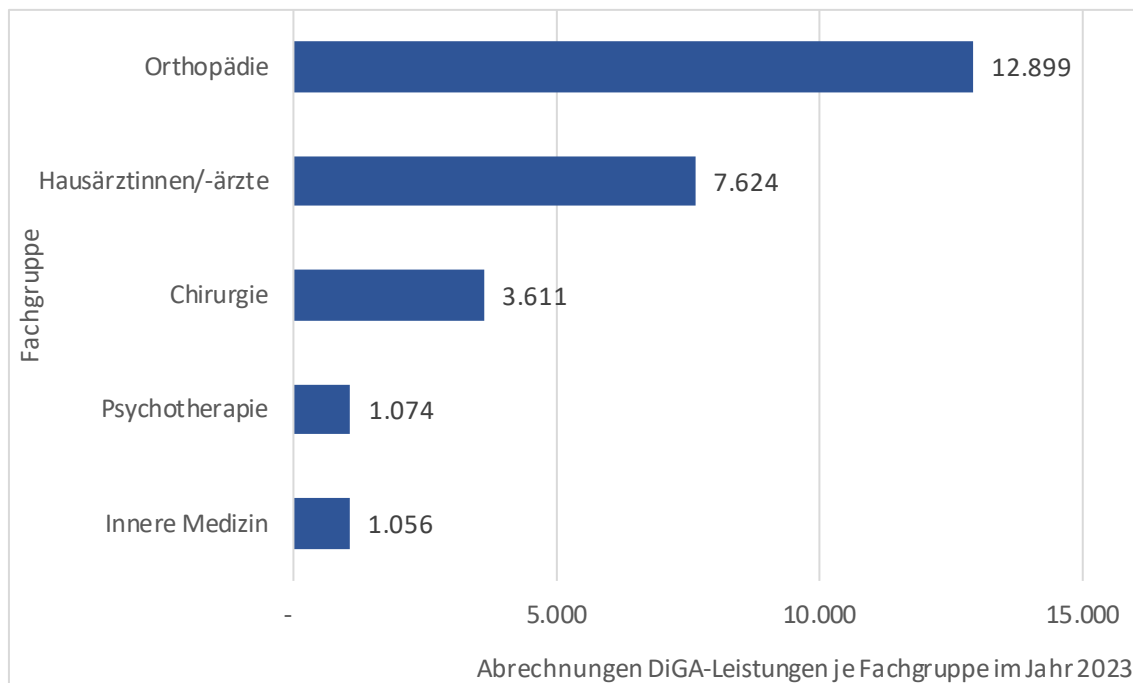


Abbildung 54 Abrechnungshäufigkeit der ärztlichen Leistungen zu DiGA im Jahr 2023 nach Fachgruppen. Dargestellt sind die Fachgruppen mit mehr als 1.000 Abrechnungen.

Die ärztlichen Leistungen zu DiGA waren in der Fachgruppe Orthopädie mit rund 12.900 Abrechnungen im Jahr 2023 am häufigsten, gefolgt von den Hausärztinnen und -ärzten mit rund 7.600 Abrechnungen. Dabei ist zu beachten, dass die Fachgruppe der Hausärzte und -ärztinnen rund siebenmal so groß ist wie die Fachgruppe Orthopädie.

Die im Verhältnis hohe Abrechnungshäufigkeit in der Orthopädie kann als Hinweis darauf gelten, dass relativ häufig DiGA mit orthopädischer Indikation verordnet wurden. So waren im 4. Quartal 2023 die GOP 01472 (Leistungen zu Vivira) und GOP 01476 (Leistungen zu Mawendo) berechnungsfähig, zwei DiGA für die Behandlung von Rücken- oder Gelenkbeschwerden. Der Großteil der Abrechnungen entfiel dabei auf die GOP 01472 ($n = 12.722$, siehe Anhang, Tabelle 96).

Hausärztinnen und Hausärzte rechneten besonders häufig Leistungen zu DiGA zur Behandlung von Adipositas (GOP 01473 zur DiGA zanadio: $n = 3.779$; GOP 01475 zur DiGA Oviva direkt: $n = 392$), Schlafstörungen (GOP 01471 zur DiGA somnio: $n = 2.104$) sowie Rückenschmerzen (GOP 01472 zur DiGA Vivira: $n = 1.318$) ab (siehe Anhang, Tabelle 96).

Am dritthäufigsten hat im Jahr 2023 die Fachgruppe Chirurgie ärztliche DiGA-Leistungen abgerechnet (rund 3.600 Abrechnungen). Für diese Fachgruppe sind (wie für die Orthopädie) die Verlaufskontrolle und Auswertung der DiGA Vivira (GOP 01472) und die Auswahl und/oder Individualisierung von Inhalten der DiGA Mawendo (GOP 01476) berechnungsfähig. Auch hier entfiel der Großteil der Abrechnungen auf die GOP 01472 ($n = 3.312$, siehe Anhang, Tabelle 96). Außerdem rechnete diese Fachgruppe die Verlaufskontrolle und Auswertung der DiGA somnio (GOP 01471) rund 300-mal ab.

Auch die Abrechnungen durch Vertreter der Fachgruppen Psychotherapie und Psychiatrie (rund 1.000 bzw. 700 Abrechnungen, siehe Anhang, Tabelle 96) geht vor allem auf die

Berechnungsfähigkeit zweier spezifischer DiGA für psychische Erkrankungen zurück: Die Verlaufskontrolle und Auswertung der DiGA somnio (GOP 01471) und der DiGA Invirto (GOP 01474). Die Fachgruppe Psychotherapie berechnete die GOP 01471 rund 600-mal und die GOP 01474 rund 500-mal; die Fachgruppe Psychiatrie berechnete die GOP 01471 rund 700-mal (siehe Anhang, Tabelle 96).

Eine Übersicht der Abrechnungshäufigkeit und der Anzahl der abrechnenden Ärztinnen und Ärzte für alle Fachgruppen ist im Anhang zu finden (Tabelle 96).

Die Abrechnungshäufigkeit für alle Fachgruppen sowie die zugehörigen Arztzahlen finden sich im Anhang (Tabelle 96).

Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Einrichtungsformen

Abbildung 55 zeigt, wie häufig ärztliche Leistungen zu einer DiGA (GOP 01471 bis 01476) in den verschiedenen Einrichtungsformen im Jahr 2023 abgerechnet wurde.

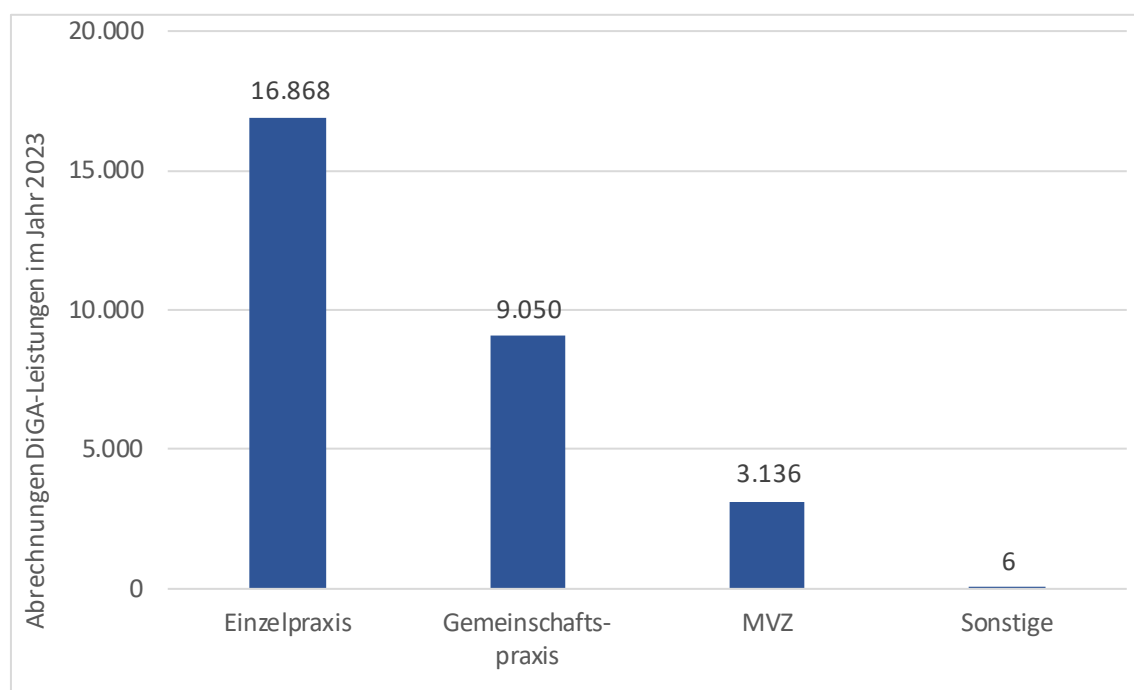


Abbildung 55 Abrechnungen von Leistungen zu DiGA (GOP 01471 bis 01476) im Jahr 2023 nach Einrichtungsformen.

Am häufigsten haben Einzelpraxen mit rund 16.900 Abrechnungen Leistungen zu DiGA (GOP 01471 bis 01476) abgerechnet. Diese Praxen sind bundesweit auch am häufigsten vertreten. Gemeinschaftspraxen rechneten rund 9.000 DiGA-Leistungen ab, MVZ rund 3.000.

Im Verhältnis haben MVZ durchschnittlich 10-mal im Jahr 2023 – und damit am häufigsten – eine ärztliche Leistung zu einer DiGA (GOP 01471 bis 01476) abgerechnet, während Einzel- und

Gemeinschaftspraxen diese Leistungen im Durchschnitt 7-mal abgerechnet haben. Alle Daten zu DiGA-Leistungen nach Einrichtungsformen finden sich auch im Anhang (Tabelle 97).

10.5 Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten DiGA-Leistungen

Im Jahr 2023 wurde bei rund 25.700 Versicherten mindestens eine Leistung zu einer DiGA (GOP 01471 bis 01476) abgerechnet. Abbildung 56 zeigt die Verteilung der Alters- und Geschlechtsgruppen der Versicherten, bei denen diese Leistungen abgerechnet wurden.

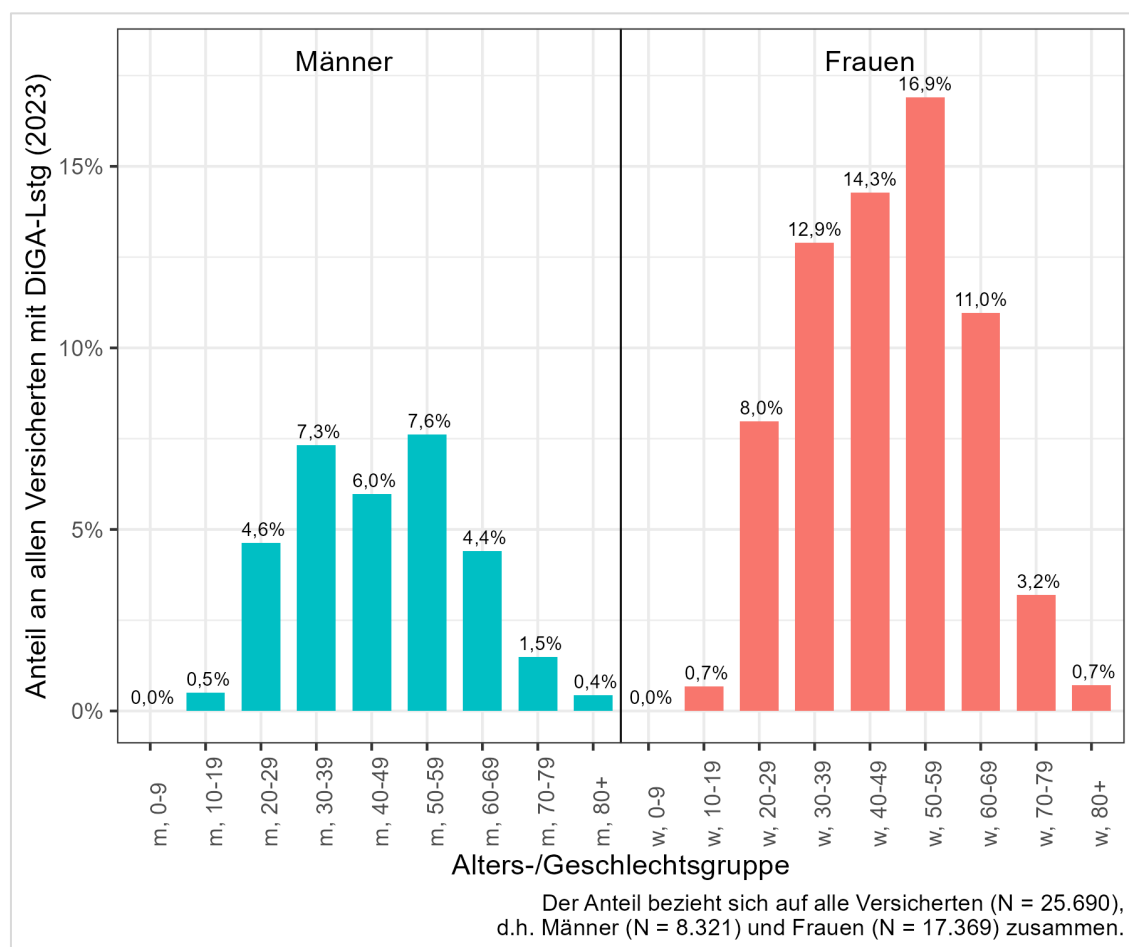


Abbildung 56 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten, bei denen im Jahr 2023 eine DiGA-Leistung (GOP 01471 bis 01476) abgerechnet wurde; m = männlich, w = weiblich.

Insgesamt wurden wesentlich häufiger ärztliche DiGA-Leistungen bei Frauen als bei Männern abgerechnet. Rund 68 % der Versicherten, bei denen ärztliche DiGA-Leistungen abgerechnet wurden, waren weiblich (17.369 Frauen von 25.690 Versicherten insgesamt). Ärztliche Leistungen zu DiGA (GOP 01471 bis 01476) wurden im Jahr 2023 am häufigsten bei Frauen zwischen 50 und 59 Jahren abgerechnet (17 %), gefolgt von Frauen zwischen 40 und 49 Jahren sowie Frauen zwischen 30 und 39 Jahren (14 % bzw. 13 %), wie in Abbildung 56 zu sehen ist.

Teil B Bericht des ergänzten Bewertungsausschusses

11 Einleitung

Der ergänzte Bewertungsausschuss legt dem Bundesministerium für Gesundheit im Berichtsteil B den vierten Bericht zu sektorenübergreifenden telemedizinischen Leistungen vor. Der Bericht befasst sich mit den Neuerungen des Jahres 2023 durch Beschlussfassungen zwischen dem GKV-Spitzenverband, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Dieser Teil berichtet von den bestehenden telemedizinischen Leistungen Telekonsilien, den Regelungen der telemedizinischen Versorgung in Zweitmeinungsverfahren sowie in der Ambulanten Spezialfachärztlichen Versorgung (ASV). Im Laufe des Vorberichtsjahres 2022 sind außerdem telemedizinische Leistungen im organisierten Not(-fall)dienst sowie in der Koordinierten und Strukturierten Versorgung insbesondere schwer psychisch kranker Versicherte (KSVPsych) in den EBM eingeführt worden. Zu den telemedizinischen Leistungen im organisierten Not(-fall)dienst geht nun erstmalig ein gesamtes Abrechnungsjahr in den Bericht ein.

11.1 Inhaltliche Umsetzung des Berichts im Rahmen der Anpassungen des § 87 SGB V durch das Digital-Gesetz (DigiG)

Die in der Einleitung zu Teil A dargelegten Erläuterungen gelten auch für Teil B dieses Berichts (siehe Kapitel 1.1 des Berichts).

11.2 Datengrundlage

Die in der Einleitung zu Teil A dargelegten Erläuterungen gelten auch für Teil B dieses Berichts (siehe Kapitel 1.2 des Berichts).

12 Sektorenübergreifende Telekonsilien

12.1 Allgemeine Erläuterungen

Begrifflichkeiten

Telekonsilien, oder auch telemedizinische Konsilien, können zwischen Fachärztinnen und Fachärzten und psychologischen, nicht-ärztlichen Psychotherapeutinnen und -therapeuten gleicher oder verschiedener Disziplinen genutzt werden, um sich auf elektronischem Weg über eine patientenbezogene medizinische Fragestellung auszutauschen und somit schnellstmöglich Diagnosen sowie Behandlungsstrategien aufstellen zu können. Das Telekonsilium bietet dabei beispielsweise die Möglichkeit, anderen Behandelnden medizinische Befunde mit einer hohen Datensicherheit zur Verfügung zu stellen und diese fachlich zu erörtern. Telekonsilien gestatten eine zeitgleiche oder zeitversetzte Kommunikation zwischen einer einholenden Ärztin oder Arzt, Psychotherapeutin oder Psychotherapeuten, Zahnärztin oder Zahnarzt und einer Konsiliarärztin, -arzt, -psychotherapeutin oder -psychotherapeuten, -zahnärztin oder -zahnarzt, dabei können diese ambulant oder stationär tätig sein (sektorenübergreifend).

Rechtlicher Hintergrund

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der GKV-Spitzenverband haben gemäß § 87 Abs. 2a SGB V im ergänzten Bewertungsausschuss nach § 87 Abs. 5a SGB V vereinbart, dass Konsilien als telemedizinische Leistung in der vertragsärztlichen und in der sektorenübergreifenden Versorgung über den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) abgerechnet werden können. Grundlage ist das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG).

Für Telekonsilien müssen sichere elektronische Informations- und Kommunikationstechnologien genutzt werden. Grundlage hierfür bildet die Vereinbarung gemäß § 367 Abs. 1 SGB V über technische Verfahren zu telemedizinischen Konsilien (Telekonsilien-Vereinbarung),⁶⁵ die zwischen Deutscher Krankenhausgesellschaft, GKV-Spitzenverband, Kassenärztlicher Bundesvereinigung und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung mit Wirkung zum 1. April 2020 getroffen wurde.

12.2 Regelungen und Vergütung im EBM

Mit dem Beschluss des ergänzten Bewertungsausschusses in seiner 60. Sitzung⁶⁶ wurde die Abrechnung von Telekonsilien mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 ermöglicht. Folgende Gebührenordnungspositionen wurden in den Abschnitt 1.6 (Schriftliche Mitteilungen, Gutachten, Telekonsilien) des EBM aufgenommen (Tabelle 43):

⁶⁵ Siehe [Vereinbarung](#) über technische Verfahren zu telemedizinischen Konsilien (Telekonsilien-Vereinbarung) – Kassenärztliche Bundesvereinigung (kbv.de).

⁶⁶ Siehe [Beschluss](#) des ergänzten Bewertungsausschusses in seiner 60. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

Tabelle 43 Gebührenordnungspositionen für die Einholung und Durchführung von Telekonsilien.

GOP	Bezeichnung	Punkte	€ (2023)
01670	Zuschlag Einholung eines Telekonsiliums zweimal im Behandlungsfall	110	12,64
01671	Telekonsiliarische Beurteilung einmal im Arztgruppenfall (min. 10 Minuten Dauer)	128	14,71
01672	Zuschlag zur GOP 01671 für die Fortsetzung der Beurteilung dreimal im Arztgruppenfall (je weitere vollendete 5 Minuten)	65	7,47

Mit der Einführung der Leistungen wurde auch geregelt, dass eine telekonsiliarische Abstimmung im Rahmen eines Videokonsiliums erfolgen kann. Im Zuge dessen wurde die GOP 01450 (Zuschlag Videosprechstunde) für die Abrechnung durch die initiiierende Ärztin oder den initiiierenden Arzt, die initiiierende Psychotherapeutin oder den initiiierenden Psychotherapeuten angepasst (siehe Kapitel 2 des Berichts).

Tabelle 44 zeigt die Beschlüsse für das oder aus dem Jahr 2023, welche für Telekonsilien eine Vergütung außerhalb der MGV empfehlen.

Tabelle 44 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zu Telekonsilien, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden. MGV = morbiditätsbedingte Gesamtvergütung.

Kategorie	Beschluss	Inkrafttreten	Inhalt/GOP	Laufzeit/Befristung
Finanzierung	603. BA	01.01.2023	Vergütung GOP 01670 bis 01672 außerhalb der MGV	31.12.2023
Finanzierung	664. BA	01.01.2024	Vergütung GOP 01670 bis 01672 außerhalb der MGV	31.12.2024

12.3 Leistungsentwicklung

Abrechnungshäufigkeit

Insgesamt wurde die GOP 01670 (Einholung eines Telekonsiliums) im Jahr 2023 rund 48.400-mal abgerechnet. Dies ist ein Anstieg von 36 % für das Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr (siehe Anhang, Tabelle 100). Zu beachten ist, dass diese Leistung ausschließlich im vertragsärztlichen Bereich durchgeführt werden kann.

Die Gesamtzahlen der Abrechnungshäufigkeit zwischen GOP 01670 und GOP 01671 zeigen große Unterschiede. Die Leistung nach der GOP 01671 (telekonsiliarische Beurteilung) wurde im Jahr 2023 insgesamt rund 18.900-mal abgerechnet. Dies sind knapp 40 % der Abrechnungen der GOP 01670. Die Abrechnungshäufigkeit der GOP 01671 stieg im Jahr 2023 um rund 43 % im Vergleich zum Jahr 2022 (siehe Anhang, Tabelle 100).

Die GOP 01672 (Zuschlag zur GOP 01671 für die Fortsetzung der telekonsiliarischen Beurteilung) wurde im Jahr 2023 rund 3.300-mal abgerechnet. Im Jahr 2022 wurde die GOP 01672 rund 2.500-mal abgerechnet, dies entspricht einem Anstieg von 31 % (alle Zahlen siehe Anhang, Tabelle 100).

In Abbildung 57 ist die Entwicklung der Abrechnungshäufigkeiten der GOP 01670 (Einholung eines Telekonsiliums), GOP 01671 (Telekonsiliarische Beurteilung) und GOP 01672 (Zuschlag zu GOP 01671) dargestellt.

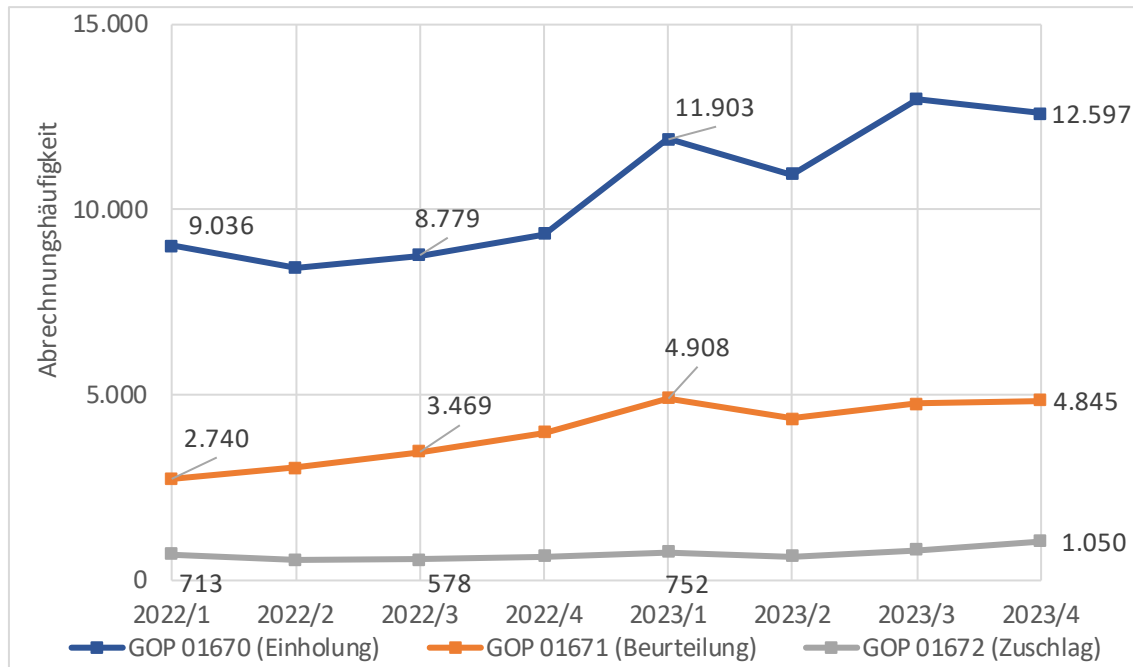


Abbildung 57 Abrechnungshäufigkeit der Einholung eines Telekonsiliums (GOP 01670), Telekonsiliarischen Beurteilung (GOP 01671) und des Zuschlags für zeitaufwändige Telekonsilien (GOP 01672) pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.

Im Jahr 2023 stieg die Anzahl der Abrechnungen bis auf rund 12.600 Abrechnungen im 4. Quartal an; dies war ein Zuwachs von rund 35 % im Vergleich zum Vorjahresquartal (Entwicklung siehe Anhang, Tabelle 98).

Leistungsbedarf

Der Leistungsbedarf im Jahr 2023 betrug für die GOP 01670 bis GOP 01672 insgesamt rund 914.600 € (Tabelle 45, siehe auch Anhang, Tabelle 99). Der größte Anteil (67 %), wie auch in den Abrechnungshäufigkeiten erkennbar, kommt durch die Einholung eines Telekonsiliums (GOP 01670) zustande.

Tabelle 45 Leistungsbedarf in € der Leistungen zu Telekonsilien in den Jahren 2022 und 2023.

Leistung	Leistungsbedarf 2022 in €					Leistungsbedarf 2023 in €				
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	Gesamt	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4	Gesamt
GOP 01670 (Einholung)	112.001	104.553	108.815	115.924	441.293	150.483	138.409	164.161	159.258	612.311
GOP 01671 (Beurteilung)	39.517	43.987	49.997	57.384	190.886	72.205	64.375	70.072	71.278	277.930
GOP 01672 (Zuschlag)	5.222	4.058	4.233	4.709	18.222	5.618	4.782	6.082	7.845	24.327
Gesamt	156.740	152.597	163.045	178.017	650.400	228.305	207.566	240.316	238.381	914.568

12.4 Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit sowie nach Fachgruppen und Einrichtungen

Um darzustellen, wie sich die Abrechnungen von Telekonsilien regional in Deutschland verteilen, wurden die Abrechnungshäufigkeit der Einholung eines Telekonsiliums (GOP 01670) und der telekonsiliarischen Beurteilung (GOP 01671) in den einzelnen KV-Bezirken ausgewertet. Abbildung 58 zeigt jeweils die Abrechnungshäufigkeit im Jahr 2023 pro 100.000 Versicherte, die in einem KV-Bezirk leben, um die Zahlen aus den unterschiedlich großen KV-Bezirken vergleichen zu können.

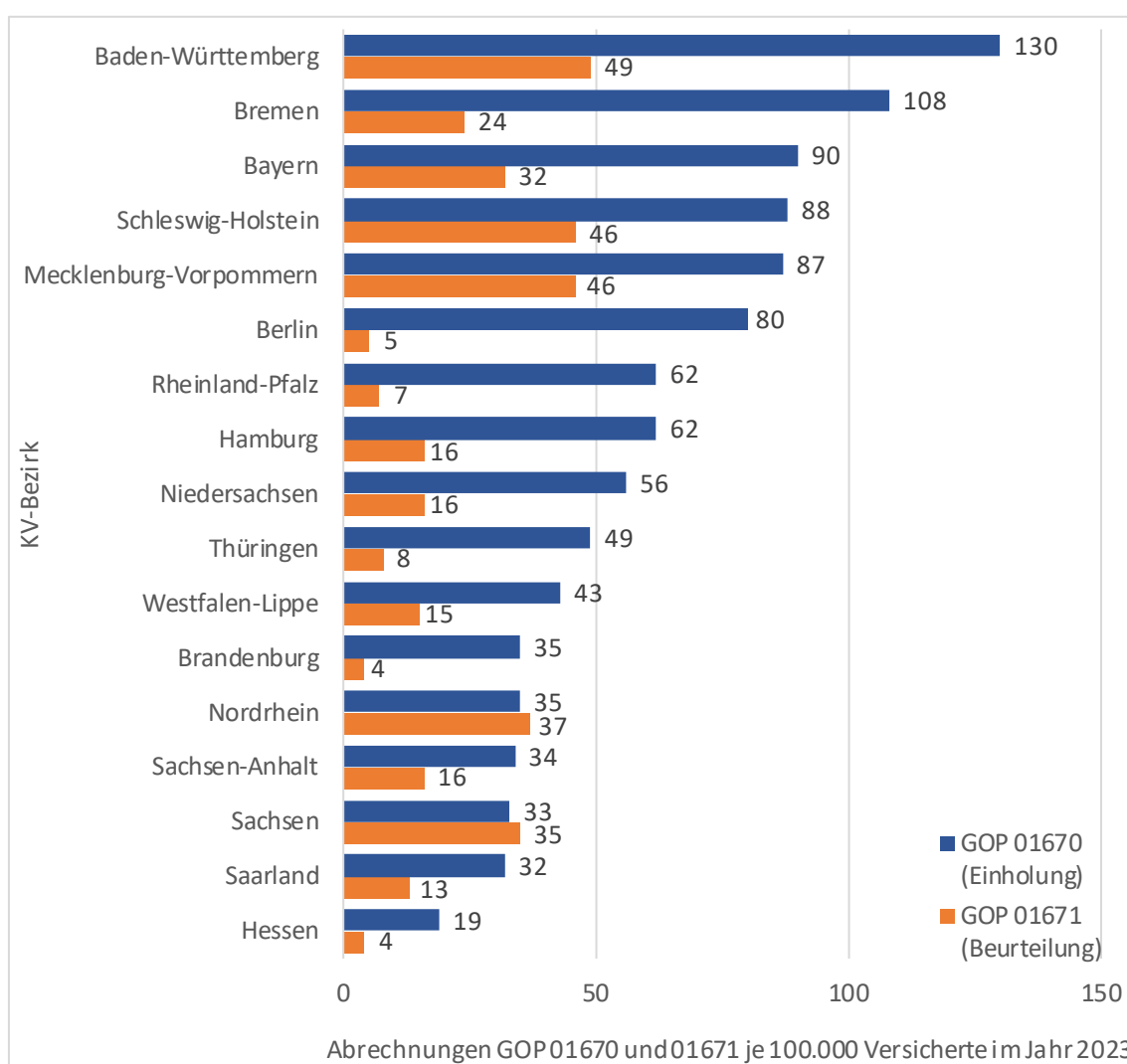


Abbildung 58 Regionale Abrechnungshäufigkeit der Einholung eines Telekonsiliums (GOP 01670) sowie der telekonsiliarischen Beurteilung (GOP 01671) nach KV-Bezirken im Jahr 2023. Dargestellt ist die normierte Abrechnungshäufigkeit je 100.000 Versicherte.

Die Abrechnungshäufigkeit der GOP 01670 ist in Deutschland regional uneinheitlich verteilt, wie in Abbildung 58 zu sehen ist. Am häufigsten wurde die GOP 01670 im Jahr 2023 in Baden-Württemberg abgerechnet (130 Abrechnungen je 100.000 Versicherte); danach folgen Bremen (108 Abrechnungen) und Bayern (90 Abrechnungen).

Die Abrechnungshäufigkeit der GOP 01671 verteilt sich bundesweit ähnlich uneinheitlich wie die der GOP 01670, wie Abbildung 58 zeigt. Auch die GOP 01671 wurde im Jahr 2023 am häufigsten in Baden-Württemberg abgerechnet (49 Abrechnungen je 100.000 Versicherte). Die zweithöchste Abrechnungshäufigkeit der GOP 01671 im Jahr 2023 hatten Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein (je 46 Abrechnungen je 100.000 Versicherte).

Die regionale Abrechnungshäufigkeit zu allen Leistungen zu Telekonsilien (GOP 01670 bis 01672) insgesamt findet sich im Anhang (Tabelle 101) in absoluten Zahlen und je 100.000 Einwohner.

Leistungsentwicklung nach Fachgruppen

In Abbildung 59 sind die Fachgruppen abgebildet, die im Jahr 2023 am häufigsten eine Einholung eines Telekonsiliums (GOP 01670) abgerechnet haben.

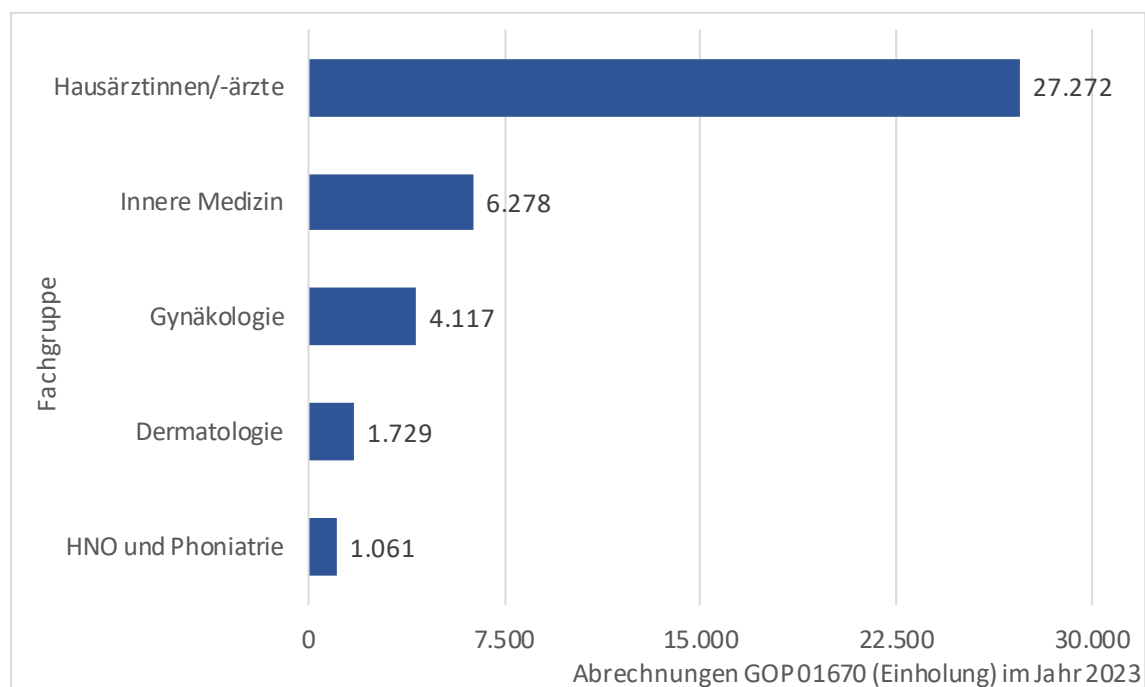


Abbildung 59 Abrechnungshäufigkeit der Einholung eines Telekonsiliums (GOP 01670) in den Fachgruppen. Dargestellt sind die fünf Fachgruppen mit den meisten Abrechnungen im Jahr 2023.

Hausärztinnen und Hausärzte rechneten im Jahr 2023 rund 27.300-mal die GOP 01670 ab, gefolgt von den Fachgruppen Gynäkologie und Innere Medizin mit rund 6.300 bzw. 4.100 Abrechnungen (Abbildung 59). Dabei ist zu beachten, dass die Fachgruppe der Hausärztinnen und Hausärzte – gegenüber den anderen Fachgruppen – bundesweit die meisten Ärztinnen und Ärzte umfasst. Deshalb wird im Folgenden zusätzlich die Abrechnungshäufigkeit je abrechnende Ärztin oder abrechnender Arzt in den Fachgruppen untersucht. Dabei ändern sich die Fachgruppen, welche die Einholung eines Telekonsiliums (GOP 01670) im Jahr 2023 besonders häufig abgerechnet haben, wie Abbildung 60 verdeutlicht.

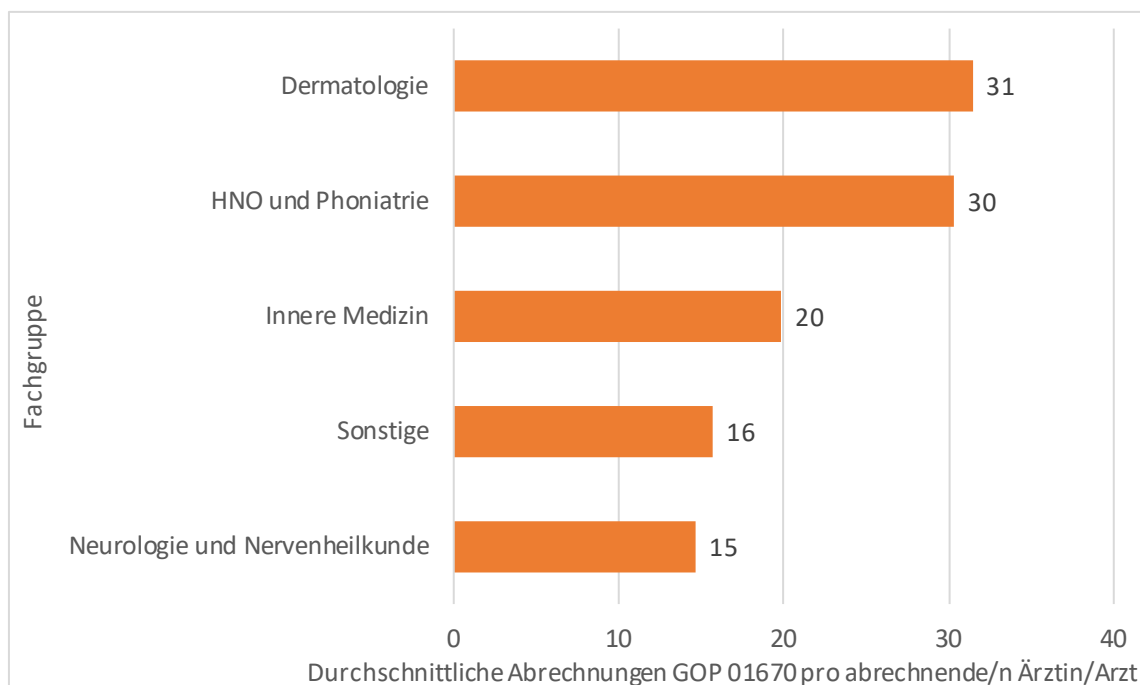


Abbildung 60 Durchschnittliche Abrechnungshäufigkeit pro abrechnende/n Ärztin/Arzt für die Einholung eines Telekonsiliums (GOP 01670) der Fachgruppen aus Abbildung 59.

Über alle Fachgruppen hinweg gab es im Jahr 2023 durchschnittlich 13 Abrechnungen der GOP 01670 pro abrechnende Ärztin oder abrechnender Arzt. Die fünf Fachgruppen in Abbildung 60 hatten im Jahr 2023 eine besonders große Abrechnungshäufigkeit der GOP 01670 pro abrechnender Arzt oder abrechnende Ärztin: In der Fachgruppe Dermatologie rechneten die Ärztinnen und Ärzte jeweils im Durchschnitt mit rund 31 Abrechnungen pro Kopf die meisten Einholungen eines Telekonsiliums ab (Abbildung 60); insgesamt hatte diese Gruppe die viertgrößte Abrechnungshäufigkeit im Jahr 2023 (Abbildung 59). An zweiter Stelle steht in diesem Vergleich die Fachgruppe HNO und Phoniatrie mit rund 30 Abrechnungen der GOP 01670 pro Ärztin/Arzt; insgesamt hatte diese Fachgruppe die fünftgrößte Abrechnungshäufigkeit. In der Fachgruppe der Inneren Medizin wurde die GOP 01670 mit rund 20 Abrechnungen je Ärztin/Arzt im Jahr deutlich seltener abgerechnet, obgleich diese Fachgruppe die zweitgrößte Abrechnungshäufigkeit insgesamt im Jahr 2023 aufwies.

Für telekonsiliarische Beurteilungen (GOP 01671) ergibt sich eine andere Verteilung in den Fachgruppen. Insgesamt rechnete die Fachgruppe der Inneren Medizin im Jahr 2023 mit rund 6.600 Abrechnungen die GOP 01671 am häufigsten ab, gefolgt von der Fachgruppe der Hausärztinnen und Hausärzte mit rund 4.200 Abrechnungen und der Neurologie und Nervenheilkunde mit rund 1.700 Abrechnungen. Die Abrechnungszahlen und die Anzahl der Ärztinnen/Ärzte, die 2023 mindestens ein Telekonsilium abgerechnet haben, ist für alle Fachgruppen dem Anhang zu entnehmen (Tabelle 102).

Für die GOP 01671 ist die durchschnittliche Abrechnungshäufigkeit pro abrechnende/n Ärztin/Arzt im Jahr 2023 in Abbildung 61 zu sehen.

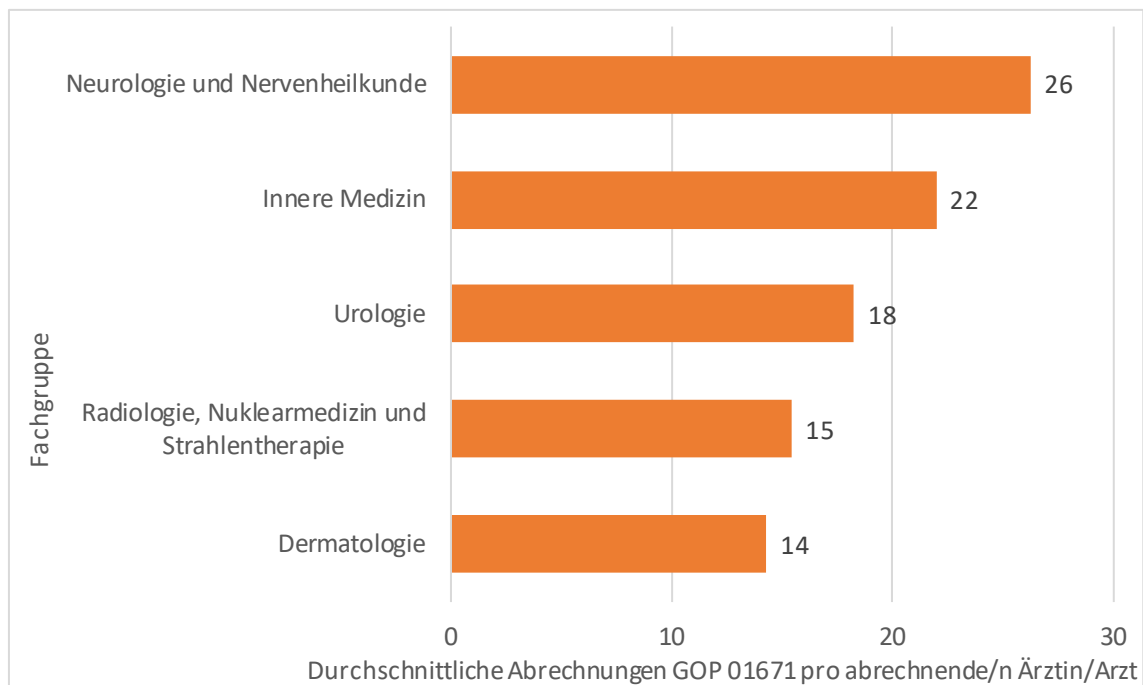


Abbildung 61 Durchschnittliche Abrechnungshäufigkeit der telekonsiliarischen Beurteilung (GOP 01671) pro abrechnende/n Ärztin/Arzt in den Fachgruppen. Dargestellt sind die fünf Fachgruppen mit mehr als 10 abrechnenden Ärzten/Ärztinnen mit dem höchsten Anteil im Jahr 2023.

Die fünf Fachgruppen, die im Jahr 2023 durchschnittlich am häufigsten eine telekonsiliarische Beurteilung (GOP 01671) pro abrechnende Ärztin oder abrechnender Arzt durchführten, sind in Abbildung 61 aufgeführt. Alle fünf Fachgruppen waren der fachärztlichen Versorgung zuzuordnen.⁶⁷ Ärztinnen und Ärzte in der Fachgruppe Neurologie und Nervenheilkunde rechneten im Durchschnitt 26 telekonsiliarische Beurteilungen ab; gefolgt von der Fachgruppe der Inneren Medizin mit 22 Abrechnungen der GOP 01671 pro abrechnende Ärztin oder Arzt. In der Fachgruppe der Urologie lagen pro Ärztin/Arzt im Jahr 2023 durchschnittlich 18 Abrechnungen vor. Hausärztinnen und Hausärzte rechneten im Vergleich dazu im Durchschnitt 6-mal eine telekonsiliarische Beurteilung (GOP 01671) ab. Zu beachten ist hier, dass die Gruppe der abrechnenden Ärztinnen und Ärzte aus Augenheilkunde und Pathologie aus der Auswertung ausgeschlossen wurden, da sie mit 9 bzw. 6 abrechnenden Personen sehr klein ist (siehe Anhang, Tabelle 102).

Leistungsentwicklung nach Einrichtungsformen

Da es sich bei Telekonsilien um grundlegend sektorenübergreifende Leistungen handelt, ist bei der Betrachtung der Leistungen zu Telekonsilien auch die Abrechnungshäufigkeit in Krankenhäusern einzubeziehen. Dabei ist zu beachten, dass in der vorliegenden Datengrundlage die Abrechnungsdaten aus dem vertragsärztlichen Bereich vorliegen und Abrechnungsinformationen aus dem Krankenhausbereich in den vorliegenden Daten unvollständig abgebildet sind (siehe Fußnote 4, S. 22).

⁶⁷ Hausärztliche Internisten sind für die Auswertungen in diesem Bericht grundsätzlich der Fachgruppe Hausärztinnen/Hausärzte zugeordnet.

Insgesamt rechneten Gemeinschaftspraxen und Einzelpraxen im Jahr 2023 jeweils rund 21.000-mal eine Einholung eines Telekonsiliums (GOP 01670) ab, gefolgt von MVZ mit rund 6.000 Abrechnungen (siehe Anhang, Tabelle 103).

Die Abrechnungshäufigkeit der telekonsiliarischen Beurteilung (GOP 01671) lag im Jahr 2023 für Einzelpraxen bei rund 9.000 Abrechnungen, für Gemeinschaftspraxen bei rund 7.000 Abrechnungen und für MVZ bei etwa 2.000 Abrechnungen.

Die Abrechnungshäufigkeit für den Zuschlag für zeitintensivere Telekonsilien (GOP 01672) lag generell deutlich niedriger als diejenige für telekonsiliarische Beurteilungen (GOP 01671); so lag sie für Einzelpraxen im Jahr 2023 bei rund 2.000 Abrechnungen und für Gemeinschaftspraxen bei unter 1.000 Abrechnungen.

Auf Krankenhäuser entfielen insgesamt im Jahr 2023 eine geringe Anzahl Abrechnungen auf die drei Abrechnungsziffern Einholung eines Telekonsiliums (GOP 01670), telekonsiliarische Beurteilung (GOP 01671), sowie Zuschlag für zeitintensivere Telekonsilien (GOP 01672) (siehe Anhang, Tabelle 103).

Diese Zahlen besitzen zudem nur eine begrenzte Aussagekraft, da die verschiedenen Einrichtungenformen in der deutschen Versorgungslandschaft unterschiedlich weit verbreitet sind. Die Abrechnungshäufigkeit für die einzelnen Einrichtungenformen wurde deshalb in Abbildung 62 jeweils auf die durchschnittlichen Abrechnungen je telekonsiliarisch abrechnende Einrichtung umgerechnet.

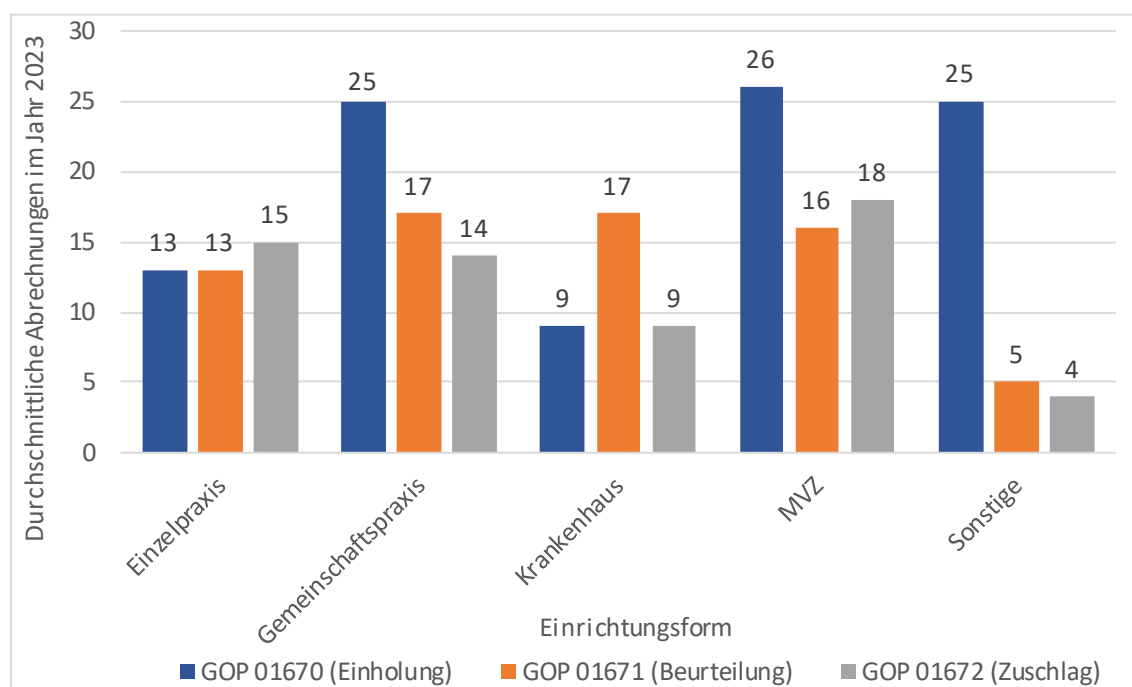


Abbildung 62 Durchschnittliche Abrechnungen der Leistungen zu Telekonsilien je abrechnende Einrichtung im Jahr 2023, dargestellt nach Einrichtungenformen. In den Abrechnungen von Krankenhäusern sind die Abrechnungen aus Ermächtigten Praxen enthalten.

Wie in Abbildung 62 zu sehen ist, zeigten die unterschiedlichen Einrichtungsformen im Jahr 2023 verschiedene Muster bei der Einholung von Telekonsilien (GOP 01670) und telekonsiliarischen Beurteilungen (GOP 01671). Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen und MVZ rechneten im Vergleich zu Krankenhäusern deutlich häufiger eine GOP 01670 als eine GOP 01671 je abrechnende Einrichtung ab. So berechneten Einzelpraxen im Schnitt 13-mal, Gemeinschaftspraxen 25-mal und MVZ 26-mal eine GOP 01670 im Jahr 2023. Eine Leistung nach GOP 01671 rechneten Einzelpraxen durchschnittlich 13-mal, MVZ 16-mal, Gemeinschaftspraxen und Krankenhäuser je 17-mal in diesem Zeitraum ab. Nur durch Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Krankenhausärztinnen/-ärzte nach § 116 SGB V sowie Ermächtigungsambulanzen nach § 116a SGB V können ein Telekonsilium im Krankenhaus einholen. Dies erklärt auch, dass Krankenhäuser als institutionelle Leistungserbringer diese Ziffer nicht abrechnen und durch telekonsiliarische Beurteilungen (GOP 01671) an der Versorgung teilnahmen (siehe Anhang, Tabelle 103).

Die durchschnittliche Abrechnungshäufigkeit des Zuschlags für zeitintensive Telekonsilien (GOP 01672) wurde je abrechnende Einrichtung im Jahr 2023 am häufigsten in MVZ abgerechnet (18 Abrechnungen); in Einzel- und Gemeinschaftspraxen war die Abrechnungshäufigkeit mit 15 und 14 Abrechnungen je Praxis annähernd gleich verteilt. Zu bedenken bleibt, dass die Abrechnungshäufigkeit der GOP 01672 im Jahr 2023 in allen Einrichtungsformen insgesamt recht niedrig blieb (siehe Anhang, Tabelle 103).

12.5 Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten mit Leistungen zu Telekonsilien

Im Jahr 2023 wurde für rund 39.400 Versicherte ein Telekonsilium eingeholt und dafür der Zuschlag für die Einholung (GOP 01670) abgerechnet. Abbildung 63 zeigt die prozentualen Anteile der Versicherten in Bezug auf ihr Alter und Geschlecht, für welche im Jahr 2023 mindestens eine GOP 01670 abgerechnet wurde.

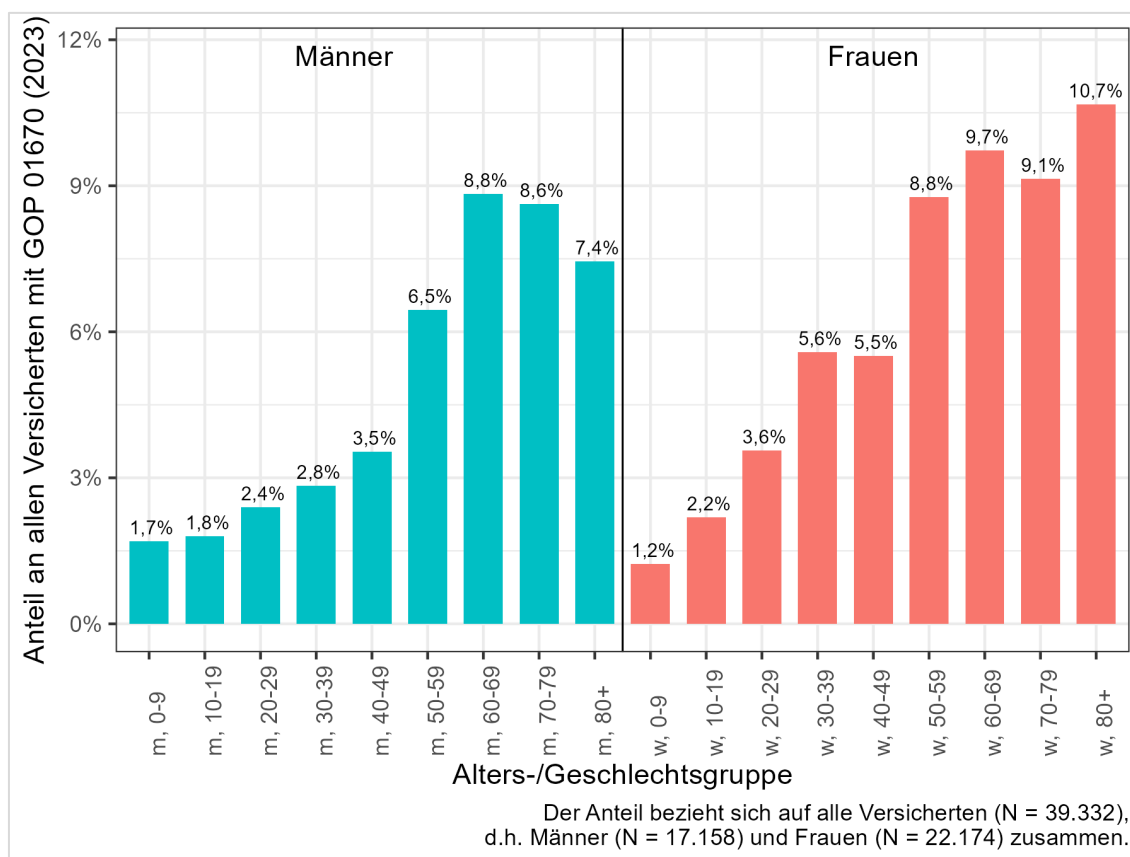


Abbildung 63 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten, bei denen eine Einholung eines Telekonsiliums (GOP 01670) im Jahr 2023 abgerechnet wurde; m = männlich, w = weiblich.

Die Einholung eines Telekonsiliums wurde im Jahr 2023 am häufigsten für Frauen abgerechnet, die 80 Jahre alt und älter waren (rund 11 % der Abrechnungen), gefolgt von Frauen zwischen 60 und 69 Jahren (rund 10 %), wie in Abbildung 63 zu sehen ist. Insgesamt wurde häufiger für ältere Versicherte im Jahr 2023 ein Telekonsilium eingeholt und abgerechnet. Bei rund 54 % der abgerechneten Einholungen eines Telekonsiliums waren die Versicherten 60 Jahre alt oder älter. Dies deutet darauf hin, dass in dieser Altersgruppe häufiger komplexe Erkrankungen auftreten, für die behandelnde Ärztinnen und Ärzte über ein Telekonsilium Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen ersuchen.

Eine ähnliche Verteilung der Anteile unter den Versicherten in Bezug auf ihr Alter und Geschlecht ergibt sich für telekonsiliarische Beurteilungen (GOP 01671) im Jahr 2023, wie Abbildung 64 verdeutlicht.

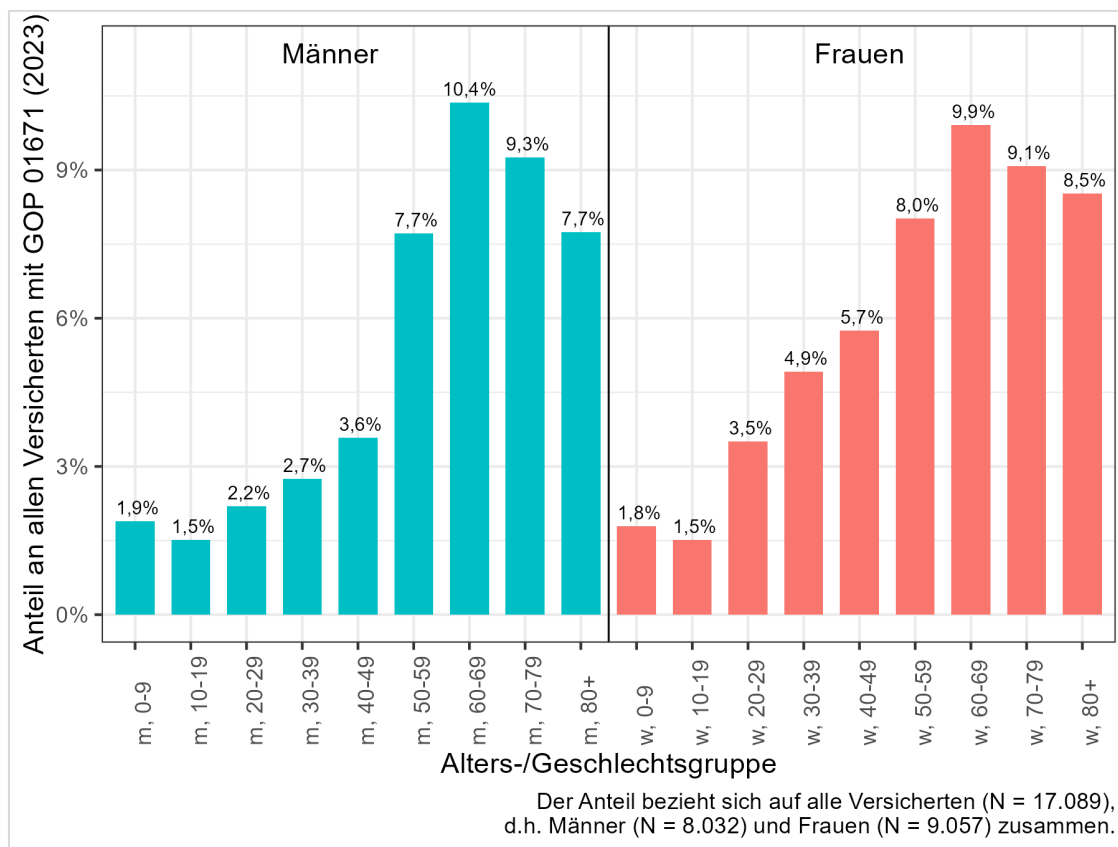


Abbildung 64 Alters- und Geschlechtsverteilung der Versicherten, bei denen eine telekonsiliarische Beurteilung (GOP 01671) im Jahr 2023 abgerechnet wurde; m = männlich, w = weiblich.

Eine telekonsiliarische Beurteilung (GOP 01671) wurde im Jahr 2023 am häufigsten für männliche Versicherte zwischen 60 und 69 Jahren abgerechnet und für weibliche Versicherte in diesem Alter (je rund 10 %, Abbildung 64). Auch telekonsiliarische Beurteilungen (GOP 01671) wurden häufiger für ältere Versicherte abgerechnet: Der Anteil von Versicherten in einem Alter von 60 Jahren und älter lag bei rund 55 %. Damit war der Anteil für diese Altersgruppe aus allen Versicherten, für die eine GOP 01671 abgerechnet wurde, ähnlich hoch wie der Anteil für diese Altersgruppe, für die eine GOP 01670 abgerechnet wurde (GOP 01670: 54 %). Zwischen den Geschlechtern ergibt sich für Abrechnungen der GOP 01670 und Abrechnungen der GOP 01671 jeweils eine leichte Verschiebung, wobei bei beiden Leistungen mehr als die Hälfte bei Frauen abgerechnet wurden (GOP 01670: 44 % Männer, 56 % Frauen; GOP 01671: 47 % Männer, 53 % Frauen).

Daraus ergibt sich, dass die Altersverteilung für die Abrechnungen der telekonsiliarischen Beurteilung (GOP 01671) und der Einholung von Telekonsilien (GOP 01670) unauffällig war. Das bedeutet, dass insgesamt für keine der groben Altersgruppen (im Alter unter 60 Jahre bzw. über 60 Jahre) in einem deutlichen Ausmaß mehr telekonsiliarische Beurteilungen (GOP 01671) abgerechnet wurden als Einholungen eines Telekonsiliums (GOP 01670). Für die Verteilung zwischen den Geschlechtern gibt es eine leichte Verschiebung zugunsten der Männer, für die ein kleinerer Anteil Telekonsilien eingeholt wurde (44 % der Abrechnungen der GOP 01670), aber ein größerer Anteil Beurteilungen abgerechnet wurde (47 % der Abrechnungen der GOP 01671) als für Frauen (56 % vs. 53 %).

13 Telemedizinische Leistungen im Rahmen der Ambulanten Spezialfachärztlichen Versorgung (ASV)

13.1 Allgemeine Erläuterungen

Begrifflichkeiten

Bei der Ambulanten Spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) handelt es sich um eine hochspezialisierte, interdisziplinär abgestimmte Versorgung von Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen, seltenen Erkrankungen und Erkrankungszuständen mit entsprechend geringen Fallzahlen sowie hochspezialisierten Leistungen. Niedergelassene Ärztinnen/Ärzte und Krankenhausärztinnen/-ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen sowie psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten arbeiten als Team zusammen, um eine optimale Versorgung von schwerkranken Menschen zu ermöglichen.

Rechtlicher Hintergrund

Die nähere Ausgestaltung der ASV regelt der G-BA nach § 116b Abs. 4 SGB V in seiner „Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV-Richtlinie)“, die am 20. Juli 2013 in Kraft getreten ist. Darin sind unter anderem Festlegungen zu den berechtigten Ärztinnen und Ärzten („ASV-Berechtigte“), personelle sowie sachliche und organisatorische Anforderungen sowie Vorgaben zur Qualitätssicherung aufgeführt. Die genauen Details zu den einzelnen Erkrankungen und hochspezialisierten Leistungen legt der G-BA in den Anlagen zur ASV-Richtlinie fest. Ende des 4. Quartals 2023 lagen für 21 Indikationen spezifische Vorgaben zur Behandlung im Rahmen der ASV vor.⁶⁸

13.2 Regelungen und Vergütung im EBM

Im Jahr 2023 wurden durch Beschlüsse des ergänzten Bewertungsausschusses zwei neue Leistungen spezifisch für die ASV in Kapitel 50 des EBM aufgenommen, die auch per Video durchgeführt werden können. Mit dem Beschluss des ergänzten Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 7. Sitzung⁶⁹ wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2023 eine Leistung für ein problemorientiertes ärztliches Gespräch aufgrund einer Mukoviszidose-Erkrankung (GOP 50700) aufgenommen, welches auch als Videosprechstunde durchgeführt werden kann. Die GOP 50700 trat neben die sieben bestehenden Leistungen in der ASV, die auch als Videosprechstunde, Videofallkonferenz bzw. elektronische Version möglich sind (Tabelle 46, siehe auch Vorbericht 2024). Zusätzlich zu diesen ASV-spezifischen Leistungen können zahlreiche telemedizinische Leistungen aus anderen Kapiteln des EBM in der ASV abgerechnet werden. Eine Liste aller im Rahmen der

⁶⁸ Siehe [Richtlinie](#) ambulante spezialfachärztliche Versorgung § 116b SGB V – Gemeinsamer Bundesausschuss (g-ba.de).

⁶⁹ Siehe [Beschluss](#) des ergänzten Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 7. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

ASV berechnungsfähigen Leistungen stellt die Geschäftsführung des ergänzten Bewertungsausschusses regelmäßig in maschinenlesbaren Tabellen zur Verfügung.⁷⁰

Tabelle 46 Leistungen in der ASV aus Kapitel 50 EBM, die auch als Videosprechstunde/-fallkonferenz bzw. elektronische Version berechnungsfähig sind.

GOP	Bezeichnung	Punkte	€ (2023)
50510	Grundpauschale für Versicherte bis zum vollendeten 5. Lebensjahr einmal im BHF berechnungsfähig als persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt oder im Rahmen einer Videosprechstunde	256	29,42
50511	Grundpauschale für Versicherte ab Beginn des 6. bis zum vollendeten 59. Lebensjahr einmal im BHF berechnungsfähig als persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt oder im Rahmen einer Videosprechstunde	314	36,08
50512	Grundpauschale für Versicherte ab Beginn des 60. Lebensjahres einmal im Behandlungsfall berechnungsfähig als persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt oder im Rahmen einer Videosprechstunde	330	37,92
50600	Vorstellung einer/eines Versicherten in einer interdisziplinären CED-Fallkonferenz durch ein Mitglied des Kernteams einmal im Kalendervierteljahr berechnungsfähig als persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt oder im Rahmen einer Videosprechstunde	201	23,10
50700	Problemorientiertes ärztliches Gespräch aufgrund einer Mukoviszidose-Erkrankung je vollendete 10 Minuten, höchstens viermal im Kalendervierteljahr berechnungsfähig als persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt oder im Rahmen einer Videosprechstunde	128	14,71
51020	Erstellen eines Medikationsplans gemäß § 5 Abs. 3 ASV-RL Fakultativer Leistungsinhalt: Übertragung des elektronischen Medikationsplans auf die elektronische Gesundheitskarte (eGK) der Versicherten, einmal in vier Kalendervierteljahren	39	4,48
51030	Psychotherapeutisches Gespräch als Einzelbehandlung Dauer mindestens 10 Minuten	154	17,70
51041	Vorstellung einer/eines Versicherten in einer interdisziplinären Tumorkonferenz durch ein Mitglied des Kernteams gemäß den Anlagen der ASV-Richtlinie des G-BA; einmal im BHF und auch im Rahmen einer Videofallkonferenz berechnungsfähig	201	23,10

Werden die Gespräche für die Grundpauschalen für die Versorgung von Versicherten mit Hämophilie (GOP 50510 bis 50512) sowie psychotherapeutische Gespräche als Einzelbehandlung im Rahmen der ASV (GOP 51030) als Videosprechstunden durchgeführt, so ist der Technikzuschlag Videosprechstunde (GOP 01450) berechnungsfähig (siehe Kapitel 2 des Berichts). Die Vorstellung einer oder eines Versicherten in einer interdisziplinären Tumorkonferenz (GOP 51041) ist dagegen nicht in Kombination mit der GOP 01450 berechnungsfähig.

⁷⁰ Siehe [Abrechnungsfähige Leistungen](#) in der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

Folgende Beschlüsse zu telemedizinischen Leistungen in der ASV wurden im Jahr 2023 getroffen (Tabelle 47):

Tabelle 47 Beschlüsse des ergänzten Bewertungsausschusses (ergBA) und des ergänzten Erweiterten Bewertungsausschusses (ergEBA) zu telemedizinischen Leistungen in der ASV, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden.

Kategorie	Beschluss	Inkrafttreten	Inhalt/GOP	Laufzeit/Befristung
Neue Leistung	7. ergEBA	01.01.2023	Aufnahme GOP 50700	Nein
Streichung einer Leistung	94. ergBA	03.05.2023	Streichung Zusatzpauschale Erstverordnung DiGA (GOP 01471)	Nein

13.3 Leistungsentwicklung telemedizinischer Leistungen in der ASV

Aussagen zur Leistungsentwicklung der Videosprechstunden in der ASV sind nicht möglich, da Abrechnungsdaten der ASV nicht in der vorliegenden Datengrundlage enthalten sind.

14 Telemedizinische Durchführung von Zweitmeinungsverfahren

14.1 Allgemeine Erläuterungen

Begrifflichkeiten

Versicherte haben einen Rechtsanspruch darauf, sich vor bestimmten planbaren Operationen (Eingriffen) eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Die Ärztin oder der Arzt, die/der die Indikation für den planbaren Eingriff stellt, ist dazu verpflichtet, Versicherte über dieses Recht aufzuklären. Diese Aufklärung muss mündlich und verständlich, in der Regel mindestens zehn Tage vor dem geplanten Eingriff erfolgen.

Eine Zweitmeinung soll als unabhängige, neutrale ärztliche Meinung abgegeben werden. Die Zweitmeinenden sollen die Versicherten über mögliche Therapie- oder Handlungsalternativen informieren und beraten oder auch die Indikation zum geplanten Eingriff bestätigen, damit Versicherte eine Entscheidung treffen können. Für die Abgabe einer Zweitmeinung sind vorliegende ärztliche Befunde – beispielsweise die von der indikationsstellenden Ärztin oder dem Arzt direkt zur Verfügung gestellten – durchzusehen und ein Anamnesegespräch zu führen.

Reichen die Vorbefunde nicht aus, können Zweitmeinende gegebenenfalls weitere Unterlagen bei der indikationsstellenden Ärztin oder dem Arzt anfordern oder ergänzende Untersuchungen durchführen. Ergänzende Untersuchungen müssen medizinisch begründet sein und bei der Abrechnung entsprechend gekennzeichnet werden. Das Ergebnis der Zweitmeinung wird der oder dem Versicherten mündlich mitgeteilt; dies ist auch im Rahmen einer Videosprechstunde möglich. Falls die oder der Versicherte es möchte, erhält sie oder er einen zusammenfassenden schriftlichen Bericht. Die indikationsstellende Ärztin oder der Arzt erhält einen schriftlichen Konsiliarbericht, der elektronisch übermittelt wird.

Rechtlicher Hintergrund

Die gesetzliche Grundlage bildet § 27b SGB V, der mit dem Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz) 2015 in das SGB V aufgenommen wurde.

Der G-BA legt in einer Richtlinie⁷¹ die entsprechenden Indikationen für planbare Eingriffe fest, für die sich die oder der Versicherte eine Zweitmeinung einholen kann. Die Liste der Indikationen wird fortlaufend aktualisiert. Die Richtlinie legt außerdem die allgemeinen und indikationsspezifischen Anforderungen an das Zweitmeinungsverfahren und die Anforderungen an die Durchführenden einer Zweitmeinung fest. Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 trat eine Richtlinienanpassung in Kraft, die im vorliegenden Bericht (Berichtsjahr 2023) berücksichtigt wird; weitere im Jahr 2023 beschlossene Richtlinienkonkretisierungen finden keine Berücksichtigung, da diese nicht im Jahr 2023 in Kraft getreten sind. Am Ende des 4. Quartals 2023 waren neun Indikationen für ein Zweitmeinungsverfahren vorgesehen (Tabelle 48):

⁷¹ Siehe [Richtlinie](https://www.g-ba.de/richtlinien/27b-sgb-v) zum Zweitmeinungsverfahren – Gemeinsamer Bundesausschuss (g-ba.de).

Tabelle 48 Eingriffe mit gesetzlich vorgesehenen Zweitmeinungsverfahren (Stand Dezember 2023).

Indikation	Inkrafttreten Richtlinie G-BA	Anpassung EBM in Quartal
Mandeloperationen (Tonsillektomie, Tonsillotomie)	08.12.2018	2019/1 (31. ergBA)
Gebärmutterentfernungen (Hysterektomien)	08.12.2018	2019/1 (31. ergBA)
Arthroskopische Eingriffe an der Schulter	20.02.2020	2020/2 (48. ergBA)
Implantationen von Knieendoprothesen	12.01.2021	keine
Amputationen beim Diabetischen Fußsyndrom	27.05.2021	2021/3 (70. ergBA)
Eingriffe an der Wirbelsäule	19.11.2021	2022/1 (78. ergBA)
Kathetergestützte elektrophysiologische Herzuntersuchungen und Ablationen am Herzen	31.05.2022	2022/3 (81. ergBA)
Planbares Einsetzen eines Herzschrittmachers oder Defibrillators	28.07.2022	keine
Cholezystektomie	01.01.2023	2023/1 (89. ergBA)

14.2 Regelungen und Vergütung im EBM

Mit dem Beschluss des ergänzten Bewertungsausschusses in seiner 31. Sitzung⁷² wurde die Abrechnung von Leistungen im Zusammenhang mit dem Zweitmeinungsverfahren im EBM mit Wirkung zum 1. Januar 2019 ermöglicht. Folgende Gebührenordnungsposition wurde in den Abschnitt 1.6 (Schriftliche Mitteilungen, Gutachten, Telekonsilien) des EBM aufgenommen (Tabelle 49):

Tabelle 49 Gebührenordnungsposition für die indikationsstellende Ärztin oder den Arzt zur Beratung über die Möglichkeit einer Zweitmeinung.

GOP	Bezeichnung	Punkte	€ (2023)
01645	Aufklärung und Beratung sowie Zusammenstellung der Patientenunterlagen zum Zweitmeinungsverfahren	75	8,62

Zudem wurden Festlegungen in den allgemeinen Bestimmungen des Abschnitts 4.3.9 des EBM (Ärztliche Zweitmeinung) getroffen:

- Zweitmeinende können die jeweilige arztgruppenspezifische Versicherten-, Grund- oder Konsiliarpauschale beim ersten persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt oder beim Arzt-Patienten-Kontakt im Rahmen einer Videosprechstunde berechnen.
- Erfolgt die ärztliche Zweitmeinung im Rahmen einer Videosprechstunde, sind zu den jeweiligen arztgruppenspezifischen Versicherten-, Grund- oder Konsiliarpauschalen die GOP 01444 und GOP 01450 berechnungsfähig (siehe Kapitel 2 des Berichts).
- Ärztinnen oder Ärzte, die eine Zweitmeinung abgeben möchten, brauchen eine Genehmigung der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung. Grundsätzlich können sowohl Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzte als auch Privatärztinnen und Privatärzte eine Genehmigung erhalten.

⁷² Siehe [Beschluss](#) des ergänzten Bewertungsausschusses in seiner 31. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

- Wenn die oder der Zweitmeinende weitere Untersuchungen für notwendig erachtet, muss dies medizinisch begründet werden.
- Bei geplanten Eingriffen an paarigen Organen oder Körperteilen sind Zweitmeinungsverfahren je Seite berechnungsfähig.

Die Möglichkeit zur Durchführung im Rahmen einer Videosprechstunde erfolgte durch den Beschluss des ergänzten Bewertungsausschusses in seiner 74. Sitzung⁷³ mit Wirkung zum 1. Juli 2021. Die Videosprechstunde muss gemäß Anlage 31b zum BMV-Ä erfolgen.

Weitere Leistungen, die im Rahmen einer Videosprechstunde durchgeführt werden, werden in Teil A des Berichts unter den Punkten Videosprechstunde und Videofallkonferenzen berichtet (siehe Kapitel 2 und 3 des Berichts).

Im Berichtsjahr 2023 wurden folgende Beschlüsse zu Zweitmeinungen gefasst oder traten in Kraft (Tabelle 50):

Tabelle 50 Beschlüsse des Bewertungsausschusses zur telemedizinischen Durchführung von Zweitmeinungen, die im Jahr 2023 in Kraft getreten sind oder getroffen wurden. MGV = morbiditätsbedingte Gesamtvergütung.

Kategorie	Beschluss	Inkrafttreten	Inhalt/GOP	Laufzeit/Befristung
Finanzierung	603. BA	01.01.2023	Vergütung Zweitmeinungen außerhalb der MGV	31.12.2023
Änderung	93. ergBA	01.07.2023	Klarstellung, dass Zweitmeinungen bei paarigen Organen je Seite berechnungsfähig sind	Nein
Finanzierung	664. BA	01.01.2024	Vergütung Zweitmeinungen außerhalb der MGV	31.12.2024

14.3 Leistungsentwicklung

Zweitmeinungen können per Video und persönlich durchgeführt werden. In den vorliegenden Abrechnungsdaten finden sich keine Abrechnungsinformationen für ausschließlich per Video durchgeführte Zweitmeinungen. Zweitmeinungen, die per Video und im persönlichen Gespräch durchgeführt wurden, können in den Daten nicht identifiziert werden, da diese nicht entsprechend gekennzeichnet sind.

⁷³ Siehe [Beschluss](#) des ergänzten Bewertungsausschusses in seiner 74. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

15 Versorgung im organisierten Not(-fall)dienst mit telemedizinischen Leistungen

15.1 Allgemeine Erläuterungen

Begrifflichkeiten

Im organisierten Not(-fall)dienst werden Versicherte außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten vertragsärztlicher Praxen behandelt, deren Erkrankungen akut und nicht lebensbedrohlich sind, sodass keine Benachrichtigung des Rettungsdienstes notwendig ist. Die Durchführung des organisierten Not(-fall)dienstes kann seit Juli 2022 auch im Rahmen einer Videosprechstunde erfolgen.

Rechtlicher Hintergrund

Die gesetzliche Grundlage für die telemedizinischen Leistungen im Rahmen des organisierten Not(-fall)dienstes bildet der § 87 Abs. 2a SGB V, der mit dem DVPMG angepasst wurde.

15.2 Regelungen und Vergütung im EBM

Mit dem Beschluss des ergänzten Bewertungsausschusses in seiner 80. Sitzung⁷⁴ mit Wirkung zum 1. Juli 2022 wurden bestehende Gebührenordnungspositionen des Abschnitts 1.2 EBM (Versorgung im Notfall und im organisierten ärztlichen Not(-fall)dienst) auch im Rahmen einer Videosprechstunde berechnungsfähig. Folgende Gebührenordnungspositionen können bei telemedizinischer Versorgung im organisierten Not(-fall)dienst berechnet werden (Tabelle 51):

Tabelle 51 Gebührenordnungspositionen für den organisierten Not(-fall)dienst, die als Videosprechstunde durchgeführt werden können.

GOP	Bezeichnung	Punkte	€ (2023)
01210	Notfallpauschale I (im organisierten Not(-fall)dienst zwischen 07:00 und 19:00 Uhr; außer samstags, sonntags, an gesetzlichen Feiertagen, am 24.12. und 31.12.) einmal im BHF berechnungsfähig	120	13,79 €
01212	Notfallpauschale II (im organisierten Not(-fall)dienst zwischen 19:00 und 07:00 Uhr; ganztägig samstags, sonntags, an gesetzlichen Feiertagen, am 24.12. und 31.12.) einmal im BHF berechnungsfähig	195	22,41 €

Bei einem ausschließlichen Arzt-Patienten-Kontakt per Video im Quartal im organisierten Not(-fall)dienst wird jeweils ein Abschlag von 10 % auf die Bewertung der GOP 01210 und der

⁷⁴ Siehe [Beschluss](#) des ergänzten Bewertungsausschusses in seiner 80. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

GOP 01212 vorgenommen. Die Bewertung entspricht dann 108 Punkten für die GOP 01210 und 176 Punkten für die GOP 01212.

Die im EBM geltenden Obergrenzen für den ausschließlichen Kontakt im Rahmen einer Videosprechstunde finden im organisierten Not(-fall)dienst keine Anwendung.

Ergänzend wurden folgende Regelungen getroffen:

- Die Technikzuschläge nach GOP 01450 und GOP 01444 sind auch im organisierten Not(-fall)dienst berechnungsfähig (siehe Kapitel 2 des Berichts).
- Erfolgt im Quartal per Videosprechstunde ein weiterer Arzt-Patienten-Kontakt im organisierten Not(-fall)dienst, ist der Technikzuschlag auch im Zusammenhang mit den sogenannten Notfallkonsultationspauschalen nach den GOP 01214, 01216 und 01218 berechnungsfähig.
- Die Schweregradzuschläge zu den Notfallpauschalen nach GOP 01223, 01224 bzw. GOP 01226 sind weiterhin nur im persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt berechnungsfähig.
- Zusätzlich müssen Videosprechstunden im organisierten Not(-fall)dienst durch eine bundeseinheitlich kodierte Zusatzkennzeichnung dokumentiert werden; die GOP 01210 bzw. GOP 01212 sind dann mit dem Suffix „V“ zu versehen.

15.3 Leistungsentwicklung

Abrechnungshäufigkeit

Die Abrechnung der Notfallpauschale I als Videoleistung (GOP 01210V) erfolgte im Jahr 2023 auf niedrigem Niveau (610 Abrechnungen). Die Notfallpauschale II wurde häufiger als Videosprechstunde (GOP 01212V) abgerechnet; insgesamt rund 3.200 Abrechnungen. Daraus lässt sich schließen, dass Notfallleistungen als Videosprechstunden insbesondere zwischen 19:00 Uhr und 7:00 Uhr des Folgestages, an Wochenenden sowie Feiertagen in Anspruch genommen wurden. Wie Abbildung 65 zeigt, wurden jeweils rund drei Viertel der Videokontakte im organisierten Not(-fall)dienst im 4. Quartal 2023 abgerechnet:

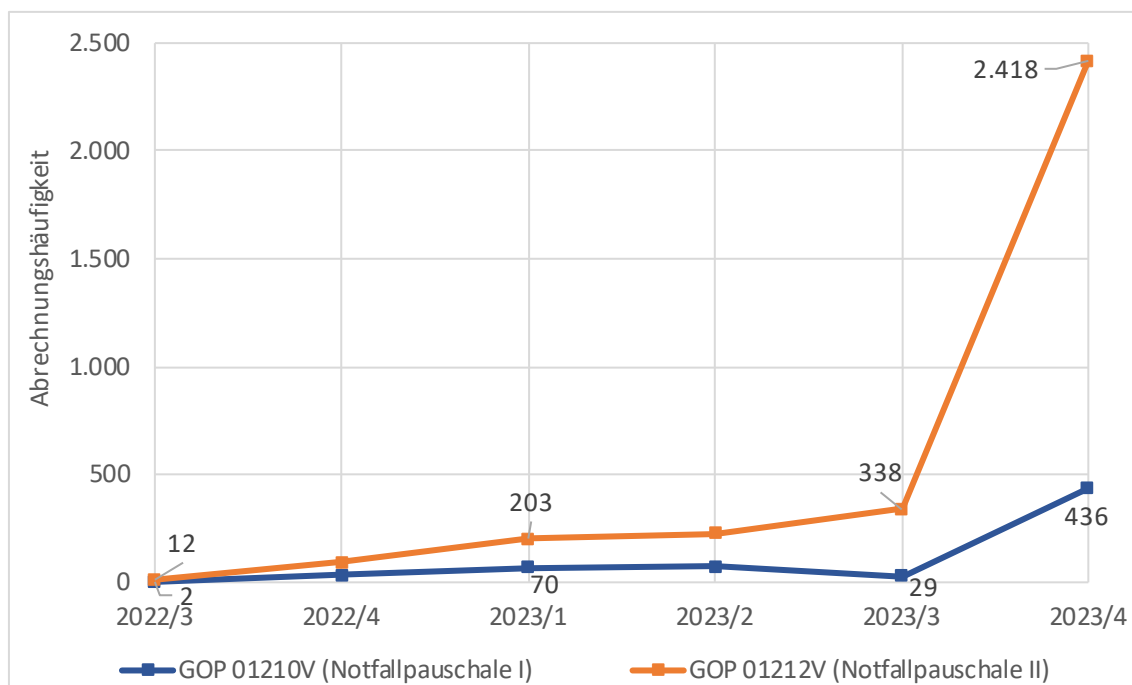


Abbildung 65 Abrechnungshäufigkeit der Notfallpauschale I und II als Videosprechstunde (GOP 01210V bzw. GOP 01212V) in den Jahren 2022 und 2023.

Es ist anzunehmen, dass die Zunahme der Leistungen im 4. Quartal 2023 insbesondere durch das saisonale Angebot von Videosprechstunden im organisierten Not(-fall)dienst zum Ende des Jahres in bestimmten KV-Bezirken angetrieben wurde. Weitere Auswertungen hierzu finden sich in Kapitel 15.4 des Berichts.

Die Leistungsentwicklung für die einzelnen Quartale ist auch im Anhang dargestellt (Tabelle 104).

Leistungsbedarf

Der Leistungsbedarf für die Notfallpauschale I per Video (GOP 01210V) belief sich im Jahr 2023 auf rund 7.600 €; für die Notfallpauschale II per Video belief er sich auf rund 64.300 € (siehe Anhang, Tabelle 106). Analog zur Abrechnungshäufigkeit fiel der Großteil des Leistungsbedarfs jeweils im 4. Quartal 2023 an (siehe Anhang, Tabelle 105).

15.4 Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit und nach Fachgruppen sowie Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten mit einer Notfallpauschale als Videoleistung

Regionale Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit

In Tabelle 107 (Anhang) ist ersichtlich, dass es im Jahr 2023 einige regionale Häufungen der Abrechnungshäufigkeit der Notfallpauschale II als Videosprechstunde (GOP 01212V) gegeben hat. So sind in Nordrhein-Westfalen mit den KV-Bezirken Nordrhein (998 Abrechnungen bzw.

durchschnittlich 12 Abrechnungen pro 100.000 Versicherte) und Westfalen-Lippe (475 Abrechnungen bzw. 6 Abrechnungen pro 100.000 Versicherte) und in Bayern (879 Abrechnungen bzw. 8 Abrechnungen pro 100.000 Versicherte) sowie Rheinland-Pfalz (358 Abrechnungen bzw. 10 Abrechnungen pro 100.000 Versicherte) insgesamt sowie im Verhältnis zur Versichertenzahl größere Abrechnungshäufigkeiten angefallen. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen dürfte diese Häufung zu einem großen Teil auf das Angebot von Videosprechstunden im organisierten Not(-fall)dienst für Kinder und Jugendliche im 4. Quartal 2023 zurückzuführen sein.⁷⁵

Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Fachgruppen und Einrichtungsformen

Tabelle 108 (im Anhang) zeigt, dass die Abrechnung der Notfallpauschalen I und II als Videoleistung (GOP 01210V bzw. 01212V) im Jahr 2023 insbesondere drei Fachgruppen betrifft – die Fachgruppen Hausärztinnen/Hausärzte, Kinder- und Jugendmedizin und Sonstige. Für die Notfallpauschale II (GOP 01212V) entfielen rund 800 Abrechnungen auf Hausärztinnen und -ärzte sowie 600 Abrechnungen auf die Kinder- und Jugendmedizin. Der Großteil der Abrechnungen (n = 1.763) entfiel auf die Fachgruppe Sonstige, die sich anhand der vorliegenden Daten nicht weiter auswerten lässt.

Der Großteil der Abrechnungen der GOP 01210V und GOP 01212V erfolgte im Jahr 2023 an sonstigen Leistungsorten (GOP 01210V: n = 229, GOP 01212V n = 1.730 siehe auch Anhang, Tabelle 109); es ist anzunehmen, dass es bei diesen Abrechnungen eine große Überlappung der Fachgruppe Sonstige und der Einrichtungsform Sonstige Leistungsorte gegeben hat.

Alters- und Geschlechtsverteilung von Versicherten mit einer Notfallpauschale als Videoleistung

In Abbildung 66 ist zu sehen, wie sich die Notfallpauschalen I und II als Videoleistungen (GOP 01210V bzw. 01212V) auf die verschiedenen Altersgruppen und Geschlechter verteilen.

⁷⁵ Laut Website der KV Nordrhein gab es für das Angebot von Videosprechstunden im Kindernotdienst eine [starke Inanspruchnahme über die Feiertage](https://www.kvno.de/aktuelles/2024/03/2024-03-01-starke-inanspruchnahme-ueber-die-feiertage) – KV Nordrhein (kvno.de). Hinweis: Das Angebot bestand im Jahr 2023 für beide KV-Bezirke des Landes und wurde zur Mitte des Jahres 2024 verstetigt.

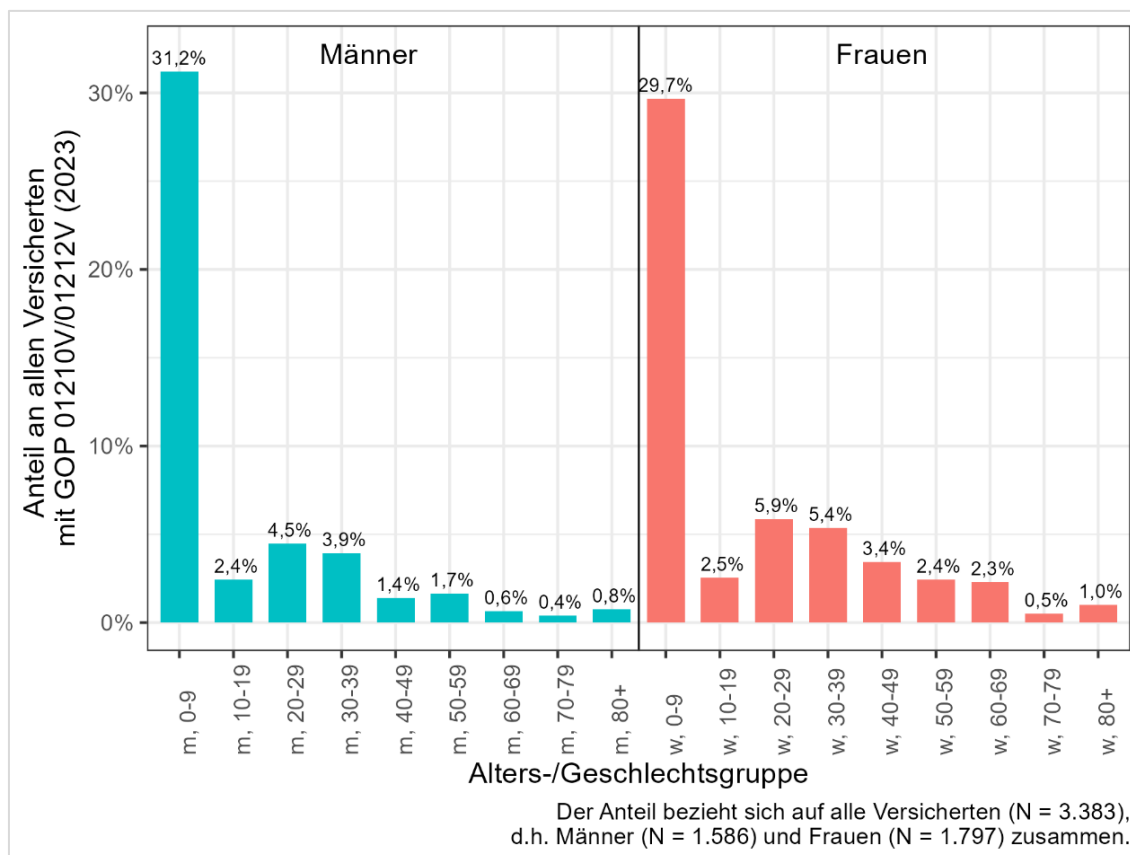


Abbildung 66 Alters- und Geschlechtsverteilung von männlichen und weiblichen Versicherten, für die im Jahr 2023 eine Notfallpauschale als Videoleistung (GOP 01210V bzw. 01212V) abgerechnet wurde; m = männlich, w = weiblich.

Auch diese Auswertung macht deutlich, dass der Großteil der Fälle, in denen eine Notfallpauschale als Videoleistung in Anspruch genommen wurde, in der pädiatrischen Versorgung lagen (Abbildung 66). So waren im Jahr 2023 über 60 % der Versicherten, für die eine GOP 01210V oder 01212V abgerechnet wurden, zwischen 0 und 9 Jahre alt und weitere 5 % im Alter zwischen 12 und 19 Jahren. Die Anteile der Geschlechter waren dabei annähernd gleich verteilt.

Die nächstgrößere Versichertengruppe, die eine Notfallpauschale als Videoleistung (GOP 01210V bzw. 01212V) im Jahr in Anspruch genommen haben, war die Gruppe der jungen Erwachsenen zwischen 20 und 39 Jahren mit insgesamt rund 20 %. Hierbei lagen die Anteile der Frauen mit rund 11 % leicht höher als die der Männer (8 %).

16 Telemedizinische Leistungen in der koordinierten und strukturierten Versorgung insbesondere schwer psychisch kranker Versicherter

16.1 Allgemeine Erläuterungen

Begrifflichkeiten

Um die Versorgung von schwer psychisch erkrankten Versicherten mit langfristigem Behandlungsbedarf zu optimieren, wurden zum 1. Oktober 2022 auf Grundlage der KSVPsych-Richtlinie des G-BA⁷⁶ neue Gebührenordnungspositionen in den EBM eingeführt.

Die KSVPsych-Richtlinie soll patientenindividuell notwendige Versorgungsangebote bündeln und deren Leistungen koordinieren. Ein wichtiges Element in der Umsetzung der Komplexbehandlung im Sinne der KSVPsych-Richtlinie ist der Zusammenschluss von insgesamt mindestens zehn Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen und Ärztinnen/Ärzten (z. B. aus den Bereichen Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatische Medizin) einer Region zu einem Netzwerk. In enger Zusammenarbeit mit Krankenhäusern und ergänzenden Gesundheitsberufen wie Ergotherapie, Sozialtherapie oder häuslicher psychiatrischer Krankenpflege soll der Netzwerk die Komplexbehandlung sicherstellen. Zentrale Ziele sind dabei die wohnortnahe Betreuung, schnelle Diagnostik und Therapie und eine bedarfsgerechte Behandlung. Auch die Koordination unterschiedlicher psychosozialer Hilfen, zum Beispiel beim Übergang von der Versorgung im Krankenhaus in die Praxis, ist ein Fokus der KSVPsych-Richtlinie.

Im Netzwerk sind die Versicherten jeweils stets einer Ärztin/einem Arzt oder Psychotherapeutin/Psychotherapeuten zugeordnet, die/der als Bezugsarzt/-ärztin bzw. Bezugstherapeut/-therapeutin auftritt. So soll dauerhaft dieselbe Person die Versicherten medizinisch bzw. psychotherapeutisch versorgen und begleiten. Mehrere Bezugsarztinnen/-ärzte/-psychotherapeutinnen/-therapeuten können gemeinsam einem Netzwerk angehören. Sie koordinieren die Versorgung in enger Abstimmung mit den anderen beteiligten Gesundheitsberufen. Eine Zuordnung erfolgt individuell in der Regel im Anschluss an die differenzialdiagnostische Abklärung.

Zusätzlich verfügt der Netzwerk über Fachkräfte, um bestimmte Koordinationsaufgaben zu übernehmen, zum Beispiel für die Versicherten Termine zu vereinbaren und sie bei Bedarf zu Hause aufzusuchen oder weitere Hilfen zu vermitteln. Alle Therapieschritte werden in einem zentralen Behandlungsplan festgelegt, laufend im Netzwerk abgestimmt und koordiniert. Deshalb gibt es regelmäßige Fallkonferenzen, die auch per Video oder telefonisch stattfinden können.

⁷⁶ Siehe [Richtlinie](#) über die berufsgruppenübergreifende, koordinierte und strukturierte Versorgung insbesondere für schwer psychisch kranke Versicherte mit komplexem psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlungsbedarf – Gemeinsamer Bundesausschuss (g-ba.de).

Rechtlicher Hintergrund

Die vom G-BA gemäß § 92 Abs. 6b SGB V beschlossene und im Dezember 2021 in Kraft getretene Richtlinie über die berufsgruppenübergreifende, koordinierte und strukturierte Versorgung insbesondere für schwer psychisch kranke Versicherte mit komplexem psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlungsbedarf (KSVPsych-RL) für erwachsene Versicherte regelt die Grundlagen der berufsgruppenübergreifenden, koordinierten und strukturierten Versorgung in den Netzverbänden.⁷⁷

Um einen Netzwerk zu gründen, müssen die zukünftigen Mitglieder eine Genehmigung bei der regional zuständigen KV beantragen. Untereinander schließen die Mitglieder außerdem einen Netzwerkvertrag sowie Kooperationsverträge mit mindestens einem Krankenhaus und weiteren Gesundheitsberufen ab, um die Grundlagen der Zusammenarbeit zu legen. Die KV prüft die Umsetzung der Richtlinie in allen Verträgen und erteilt im positiven Fall die Genehmigung.

16.2 Regelungen und Vergütung im EBM

Mit dem Beschluss des ergänzten Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 6. Sitzung⁷⁸ wurde ein neuer Abschnitt 37.5 zur Umsetzung der KSVPsych-Richtlinie zum 1. Oktober 2022 in den EBM aufgenommen. Fallbesprechungen innerhalb des Netzverbundes und mit seinen Kooperationspartnern (GOP 37550) sind in diesem Abschnitt als fakultativ telemedizinische Leistung umgesetzt (Tabelle 52).

Tabelle 52 Gebührenordnungsposition für die patientenorientierte Fallbesprechung gemäß KSVPsych-Richtlinie.

GOP	Bezeichnung	Punkte	€ (2023)
37550	Patientenorientierte KSVPsych-Fallbesprechung je vollendete 10 Minuten; bis zu viermal im BHF berechnungsfähig. Auch telefonisch oder per Video möglich.	128	14,71

Für KSVPsych-Fallbesprechungen, die per Video durchgeführt werden, gelten die Anforderungen gemäß Anlage 31b zum BMV-Ä.

Gemäß KSVPsych-Richtlinie können an einer Fallbesprechung (GOP 37550) auch nichtärztliche bzw. nichtpsychotherapeutische Kooperationspartnerinnen/-partner teilnehmen. Für diese Teilnehmenden ist die GOP 37551 als Zuschlag zur KSVPsych-Fallbesprechung berechnungsfähig. Diesen Zuschlag rechnet die Bezugsärztin/-psychotherapeutin oder der Bezugsarzt/-

⁷⁷ Der G-BA hat ergänzend eine KSVPsych-Richtlinie für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen beschlossen, die am 9. Juli 2024 in Kraft getreten ist. Siehe [Richtlinie](#) über die berufsgruppenübergreifende, koordinierte und strukturierte Versorgung insbesondere für schwer psychisch kranke Kinder und Jugendliche mit komplexem psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlungsbedarf (KJ-KSVPsych-RL) – Gemeinsamer Bundesausschuss (g-ba.de).

⁷⁸ Siehe [Beschluss](#) des ergänzten Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 6. Sitzung – Institut des Bewertungsausschusses (institut-ba.de).

psychotherapeut für die betreffenden nichtärztlichen bzw. nichtpsychotherapeutischen Teilnehmenden ab und leitet die Vergütung an diese weiter. Die GOP 37551 ist in gleicher Höhe bewertet wie die GOP 37550.

Ergänzend wurde folgende Regelung getroffen:

Der Technikzuschlag nach GOP 01450 ist bei Durchführung von KSVPsych-Fallbesprechungen (GOP 37550) als Videofallkonferenz berechnungsfähig (siehe Kapitel 2 des Berichts).

16.3 Leistungsentwicklung

Die Abrechnungsdaten zu der patientenorientierten KSVPsych-Fallbesprechung (GOP 37550) als Videofallkonferenz können nicht ausgewertet werden, da diese Abrechnungen in den Daten nicht entsprechend gekennzeichnet sind.

Anhang

Zu Kapitel 2: Videosprechstunde

Zu 2.4 Leistungsentwicklung Videosprechstunde, Authentifizierung und Fallkonferenz

Tabelle 53 Abrechnungshäufigkeit für die GOP 01442, 01444 und 01450 pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.

Leistung	Abrechnungshäufigkeit 2022				Abrechnungshäufigkeit 2023			
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
GOP 01442	3.310	2.499	2.380	2.138	2.008	2.038	2.117	2.597
GOP 01444	118.295	69.571	80.412	94.414	116.038	128.753	146.623	199.936
GOP 01450	1.054.725	532.214	513.314	580.905	577.905	474.368	472.443	674.740

Tabelle 54 Leistungsbedarf in € für die GOP 01442, 01444 und 01450 pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.

Leistung	Leistungsbedarf 2022				Leistungsbedarf 2023			
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
GOP 01442	32.099	24.207	23.060	20.716	19.782	20.140	20.922	25.668
GOP 01444	133.480	78.217	90.253	105.607	132.785	147.362	167.913	227.626
GOP 01450	2.792.999	1.837.756	1.702.716	1.822.416	1.859.115	1.540.407	1.471.614	1.858.494

Tabelle 55 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € pro Jahr für die GOP 01442, 01444 und 01450. In Klammern ist die Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit in % im Vergleich zum Vorjahr angegeben.

Jahr	Abrechnungshäufigkeit (Entwicklung in % zum Vorjahr)			Leistungsbedarf in €		
	GOP 01442	GOP 01444	GOP 01450	GOP 01442	GOP 01444	GOP 01450
2020	22.508	138.009	2.735.264	208.138	151.783	8.130.550
2021	13.803 (-39%)	265.562 (+92%)	3.526.110 (+29%)	132.126	295.028	9.856.628
2022	10.327 (-25%)	362.692 (+37%)	2.681.158 (-24%)	100.082	407.557	8.155.887
2023	8.760 (-15%)	591.350 (+63%)	2.199.456 (-18%)	86.511	675.686	6.729.630

Zu 2.5: Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Leistungsbereichen

Tabelle 56 Abrechnungshäufigkeit von Leistungen im Rahmen der Videosprechstunde; die ausgewerteten Grund-/Versicherten-/Konsiliar-Pauschalen beziehen sich auf Fälle, bei denen im Abrechnungsquartal ein ausschließlicher Video-Kontakt und kein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt stattfand. ¹ Diese Leistungen waren erst ab dem 4. Quartal 2021 berechnungsfähig. ² Diese Leistungen waren erst ab dem 3. Quartal 2022 berechnungsfähig. ³ Die GOP 08622 war seit dem 3. Quartal 2023 berechnungsfähig.

GOP	Leistung	2020	2021	2022	2023
01451	Anschubförderung Videosprechstunde	2.490.748	2.541.465	744	.
01444	Authentifizierung	138.009	265.562	362.692	591.350
01450	Zuschlag Videosprechstunde	2.735.264	3.526.110	2.681.158	2.199.456
03230	Gesprächsleistungen	117.931	123.404	191.516	179.837
04230	Gesprächsleistungen	16.564	19.020	13.240	11.431
04231	Gesprächsleistungen	1.322	1.890	708	882
04355	Gesprächsleistungen	2.574	3.088	1.925	2.119
04430	Gesprächsleistungen	1.681	1.770	1.637	1.865
14220	Gesprächsleistungen	90.997	107.110	76.779	43.840
14221	Gesprächsleistungen	.	.	43	18
14222	Gesprächsleistungen	38.015	38.093	25.276	16.282
16220	Gesprächsleistungen	11.001	10.084	11.298	11.336
21216	Gesprächsleistungen	5.104	3.251	1.850	1.233
21220	Gesprächsleistungen	63.410	65.567	49.569	42.808
21221	Gesprächsleistungen	.	≤5	7	41
22220	Gesprächsleistungen	35.145	47.730	34.602	23.636
22221	Gesprächsleistungen	15.998	27.224	18.946	13.579
22222	Gesprächsleistungen	.	.	69	32
23220	Gesprächsleistungen	530.832	791.518	570.728	403.371
30708	Gesprächsleistungen	11.140	14.461	12.170	11.551
35401	Einzeltherapien, Antrags-Psychotherapie	114.111	124.281	66.101	29.627
35402	Einzeltherapien, Antrags-Psychotherapie	106.072	122.448	68.069	35.680
35405	Einzeltherapien, Antrags-Psychotherapie	315.532	427.082	265.022	168.611
35411	Einzeltherapien, Antrags-Psychotherapie	10.006	9.484	4.315	1.868
35412	Einzeltherapien, Antrags-Psychotherapie	9.828	9.808	5.002	2.565
35415	Einzeltherapien, Antrags-Psychotherapie	250.574	312.279	184.422	109.686
35421	Einzeltherapien, Antrags-Psychotherapie	300.303	345.324	192.035	98.435
35422	Einzeltherapien, Antrags-Psychotherapie	250.876	317.941	183.926	108.389
35425	Einzeltherapien, Antrags-Psychotherapie	481.073	670.511	423.382	288.160
35431	Einzeltherapien, Antrags-Psychotherapie	96	598	411	273
35432	Einzeltherapien, Antrags-Psychotherapie	11	253	446	282
35435	Einzeltherapien, Antrags-Psychotherapie	.	35	150	210
35173	Gruppentherapien ¹	.	36	135	65
35174	Gruppentherapien ¹	.	21	91	106
35175	Gruppentherapien ¹	.	17	192	73
35176	Gruppentherapien ¹	.	12	92	104
35177	Gruppentherapien ¹	.	≤5	132	93
35178	Gruppentherapien ¹	.	.	19	89
35503	Gruppentherapien ¹	.	23	251	41
35504	Gruppentherapien ¹	.	10	166	41
35505	Gruppentherapien ¹	.	37	152	56
35506	Gruppentherapien ¹	.	9	68	40
35507	Gruppentherapien ¹	.	≤5	63	48
35508	Gruppentherapien ¹	.	.	20	40
35513	Gruppentherapien ¹	.	212	643	249
35514	Gruppentherapien ¹	.	133	617	200
35515	Gruppentherapien ¹	.	104	386	191
35516	Gruppentherapien ¹	.	25	311	136
35517	Gruppentherapien ¹	.	27	266	131
35518	Gruppentherapien ¹	.	13	71	87

Fortsetzung nächste Seite					
GOP	Leistung	2020	2021	2022	2023
35523	Gruppentherapien ¹	.	≤5	17	≤5
35524	Gruppentherapien ¹	.	11	22	≤5
35525	Gruppentherapien ¹	.	15	29	6
35526	Gruppentherapien ¹	.	10	13	9
35527	Gruppentherapien ¹	.	8	9	7
35528	Gruppentherapien ¹	.	9	10	≤5
35533	Gruppentherapien ¹	.	27	409	159
35534	Gruppentherapien ¹	.	66	429	105
35535	Gruppentherapien ¹	.	182	845	138
35536	Gruppentherapien ¹	.	151	763	248
35537	Gruppentherapien ¹	.	129	567	228
35538	Gruppentherapien ¹	.	74	251	154
35543	Gruppentherapien ¹	.	214	552	129
35544	Gruppentherapien ¹	.	158	589	208
35545	Gruppentherapien ¹	.	151	466	259
35546	Gruppentherapien ¹	.	24	275	262
35547	Gruppentherapien ¹	.	≤5	163	210
35548	Gruppentherapien ¹	.	≤5	183	134
35553	Gruppentherapien ¹	.	298	1.624	848
35554	Gruppentherapien ¹	.	236	990	411
35555	Gruppentherapien ¹	.	171	658	327
35556	Gruppentherapien ¹	.	51	355	280
35557	Gruppentherapien ¹	.	23	146	189
35558	Gruppentherapien ¹	.	7	109	177
30932	Nicht antragspfl. Psychotherapie	8.316	9.104	6.617	4.770
30933	Nicht antragspfl. Psychotherapie	.	<5	49	10
35110	Nicht antragspfl. Psychotherapie	26.968	30.186	27.362	29.606
35111	Nicht antragspfl. Psychotherapie	7.933	14.667	8.907	4.572
35112	Nicht antragspfl. Psychotherapie	45	315	296	318
35113	Nicht antragspfl. Psychotherapie	≤5	.	≤5	≤5
35141	Nicht antragspfl. Psychotherapie	18.830	29.516	16.920	8.703
35142	Nicht antragspfl. Psychotherapie	1.126	2.142	1.068	344
35152	Nicht antragspfl. Psychotherapie	.	23.350	93.905	53.287
35600	Nicht antragspfl. Psychotherapie	158.901	248.616	129.077	51.519
35601	Nicht antragspfl. Psychotherapie	17.079	18.941	13.508	6.053
01442	01442 - Videofallkonferenz	22.508	13.803	10.327	8.760
01952	Sonderregelungen Covid-19-Pandemie	476	694	216	.
14223	Sonderregelungen Covid-19-Pandemie	25.758	76.152	18.085	.
30931	Sonderregelungen Covid-19-Pandemie	323	348	104	.
35150	Sonderregelungen Covid-19-Pandemie	84.758	110.003	28.159	<5
35151	Sonderregelungen Covid-19-Pandemie	230.616	314.017	100.566	6
35163	Sonderregelungen Covid-19-Pandemie	.	14	68	.
35164	Sonderregelungen Covid-19-Pandemie	.	11	47	.
35165	Sonderregelungen Covid-19-Pandemie	.	21	43	.
35166	Sonderregelungen Covid-19-Pandemie	.	6	33	.
35167	Sonderregelungen Covid-19-Pandemie	.	≤5	8	.
35168	Sonderregelungen Covid-19-Pandemie	.	≤5	≤5	.
08619	Beratungen Kryokonservierung	.	.	≤5	.
08621	Beratungen Kryokonservierung	.	≤5	≤5	≤5
08622	Beratungen Kryokonservierung ³	.	.	.	.
08623	Beratungen Kryokonservierung	.	.	.	.
01470	DiGA (01470, 01471)	.	2.128	4.794	12
01471	DiGA (01470, 01471)	.	52	243	430
01789	NiPT (01789, 01790)	.	.	219	721
01790	NiPT (01789, 01790)	.	.	≤5	64
Fortsetzung nächste Seite					

GOP	Leistung	2020	2021	2022	2023
37700	AKI (37700, 37706)	.	.	.	81
37706	AKI (37700, 37706)	.	.	.	≤5
01210	Notfall Telemedizin (01210, 01212)2	.	.	34	610
01212	Notfall Telemedizin (01210, 01212)2	.	.	107	3.186
01320	Pauschalen Kapitel 1 EBM	27	35	8	12
01321	Pauschalen Kapitel 1 EBM	1.150	530	166	140
03001	Pauschalen Kapitel 3 EBM (Hausärztinnen/-ärzte)	251	149	486	1.627
03002	Pauschalen Kapitel 3 EBM (Hausärztinnen/-ärzte)	2.001	1.244	3.160	6.858
03003	Pauschalen Kapitel 3 EBM (Hausärztinnen/-ärzte)	41.335	103.499	203.777	415.917
03004	Pauschalen Kapitel 3 EBM (Hausärztinnen/-ärzte)	6.697	4.940	10.565	13.321
03005	Pauschalen Kapitel 3 EBM (Hausärztinnen/-ärzte)	1.847	597	649	904
04001	Pauschalen Kapitel 4 EBM (Pädiatrie)	2.994	2.497	1.823	1.804
04002	Pauschalen Kapitel 4 EBM (Pädiatrie)	5.923	4.674	3.683	4.148
04003	Pauschalen Kapitel 4 EBM (Pädiatrie)	95	60	27	24
04004	Pauschalen Kapitel 4 EBM (Pädiatrie)	≤5	≤5	.	≤5
04005	Pauschalen Kapitel 4 EBM (Pädiatrie)	≤5	.	.	≤5
05210	Pauschalen Kapitel 5 EBM (Anästhesie)	.	.	.	≤5
05211	Pauschalen Kapitel 5 EBM (Anästhesie)	980	1.063	952	720
05212	Pauschalen Kapitel 5 EBM (Anästhesie)	143	172	199	110
06210	Pauschalen Kapitel 6 EBM (Augenheilkunde)	40	37	46	62
06211	Pauschalen Kapitel 6 EBM (Augenheilkunde)	810	1.603	1.368	4.052
06212	Pauschalen Kapitel 6 EBM (Augenheilkunde)	439	4.455	4.449	2.253
07210	Pauschalen Kapitel 7 EBM (Chirurgie)	17	7	15	12
07211	Pauschalen Kapitel 7 EBM (Chirurgie)	739	1.054	2.422	5.140
07212	Pauschalen Kapitel 7 EBM (Chirurgie)	169	131	163	240
08210	Pauschalen Kapitel 8 EBM (Gynäkologie)	≤5	.	7	24
08211	Pauschalen Kapitel 8 EBM (Gynäkologie)	5.579	17.046	22.657	28.076
08212	Pauschalen Kapitel 8 EBM (Gynäkologie)	170	210	229	285
09210	Pauschalen Kapitel 9 EBM (HNO)	81	44	66	144
09211	Pauschalen Kapitel 9 EBM (HNO)	3.452	12.363	14.391	23.218
09212	Pauschalen Kapitel 9 EBM (HNO)	606	409	303	215
10210	Pauschalen Kapitel 10 EBM (Dermatologie)	421	267	161	138
10211	Pauschalen Kapitel 10 EBM (Dermatologie)	8.729	8.169	7.601	7.946
10212	Pauschalen Kapitel 10 EBM (Dermatologie)	1.579	967	845	1.509
11210	Pauschalen Kapitel 11 EBM (Humangenetiker)	59	112	69	44
11211	Pauschalen Kapitel 11 EBM (Humangenetiker)	474	1.224	931	949
11212	Pauschalen Kapitel 11 EBM (Humangenetiker)	59	120	92	104
13210	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	.	.	≤5	.
13211	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	216	34	128	113
13212	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	87	8	53	164
13291	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	145	109	100	199
13292	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	56	57	30	56
13341	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	49	20	73	337
13342	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	12	≤5	8	107
13390	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	.	.	<5	≤5
13391	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	611	1.020	799	401
13392	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	125	146	160	99
13491	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	87	59	21	11
13492	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	114	38	18	≤5
13540	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	.	.	≤5	.
13541	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	294	489	3.222	5.974
13542	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	317	281	352	205
13590	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	.	.	.	≤5
13591	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	214	158	498	675
13592	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	92	71	32	38
13640	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	≤5	.	.	≤5

Fortsetzung nächste Seite

GOP	Leistung	2020	2021	2022	2023
13641	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	1.953	985	805	892
13642	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	1.119	486	442	319
13690	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	.	≤5	.	≤5
13691	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	1.264	1.915	1.137	512
13692	Pauschalen Kapitel 13 EBM (Innere Medizin)	674	405	220	236
14210	Pauschalen Kapitel 14 EBM (Kinder- und Jugend- psychiatrie und -psychologie)	49	48	29	7
14211	Pauschalen Kapitel 14 EBM (Kinder- und Jugend- psychiatrie und -psychologie)	5.213	4.121	2.700	976
15210	Pauschalen Kapitel 15 EBM (Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen)	.	.	.	≤5
15211	Pauschalen Kapitel 15 EBM (Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie)	60	33	≤5	.
15212	Pauschalen Kapitel 15 EBM (Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie)	6	.	≤5	.
16210	Pauschalen Kapitel 16 EBM (Neurologen, Neuro- chirurgie)	.	.	.	≤5
16211	Pauschalen Kapitel 16 EBM (Neurologen, Neuro- chirurgie)	2.712	2.125	2.296	4.109
16212	Pauschalen Kapitel 16 EBM (Neurologen, Neuro- chirurgie)	2.401	1.261	1.144	1.284
18210	Pauschalen Kapitel 18 EBM (Orthopädie)	246	210	121	41
18211	Pauschalen Kapitel 18 EBM (Orthopädie)	3.592	10.395	23.892	36.121
18212	Pauschalen Kapitel 18 EBM (Orthopädie)	944	597	472	547
20210	Pauschalen Kapitel 20 EBM (Fachärztinnen/-ärzte für Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen)	9	70	50	23
20211	Pauschalen Kapitel 20 EBM (Fachärztinnen/-ärzte für Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen)	55	99	83	36
20212	Pauschalen Kapitel 20 EBM (Fachärztinnen/-ärzte für Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen)	6	≤5	≤5	≤5
21210	Pauschalen Kapitel 21 EBM (Psychiatrie)	≤5	.	.	.
21211	Pauschalen Kapitel 21 EBM (Psychiatrie)	6.952	5.916	4.584	4.575
21212	Pauschalen Kapitel 21 EBM (Psychiatrie)	2.067	1.476	1.145	910
21213	Pauschalen Kapitel 21 EBM (Psychiatrie)	9	≤5	≤5	.
21214	Pauschalen Kapitel 21 EBM (Psychiatrie)	3.742	3.115	2.111	1.840
21215	Pauschalen Kapitel 21 EBM (Psychiatrie)	3.053	1.778	1.124	987
22210	Pauschalen Kapitel 22 EBM (Psychosomatische Medizin und Psychotherapie)	.	≤5	≤5	.
22211	Pauschalen Kapitel 22 EBM (Psychosomatische Medizin und Psychotherapie)	5.282	6.327	3.700	1.970
22212	Pauschalen Kapitel 22 EBM (Psychosomatische Medizin und Psychotherapie)	938	1.249	700	435
23210	Pauschalen Kapitel 23 EBM (Psychotherapie)	14	16	5	<5
23211	Pauschalen Kapitel 23 EBM (Psychotherapie)	77.733	104.623	57.782	31.275
23212	Pauschalen Kapitel 23 EBM (Psychotherapie)	11.255	14.750	8.449	4.745
23214	Pauschalen Kapitel 23 EBM (Psychotherapie)	9.786	8.511	4.055	2.097
25214	Pauschalen Kapitel 25 EBM (Strahlentherapie)	42	60	14	10
26210	Pauschalen Kapitel 26 EBM (Urologie)	14	17	29	37
26211	Pauschalen Kapitel 26 EBM (Urologie)	516	3.380	4.933	6.049
26212	Pauschalen Kapitel 26 EBM (Urologie)	298	187	246	397
27210	Pauschalen Kapitel 27 EBM (Physik./Rehab. Med.)	.	≤5	≤5	≤5
27211	Pauschalen Kapitel 27 EBM (Physik./Rehab. Med.)	338	3.709	2.463	2.322
27212	Pauschalen Kapitel 27 EBM (Physik./Rehab. Med.)	78	175	93	110
30700	Pauschalen Kapitel 30 EBM (Spezielle Versor- gungsbereiche)	1.738	1.576	1.288	1.541

Zu 2.6: Regionale Abrechnungshäufigkeit von Videosprechstunden

Tabelle 57 Regionale Abrechnungshäufigkeit des Technikzuschlags Videosprechstunde (GOP 01450) nach KV-Bezirken für die Jahre 2020 bis 2023. Dargestellt sind die absolute Abrechnungshäufigkeit und in Klammern die normierte Abrechnungshäufigkeit je 100.000 Versicherte. Sortiert nach absoluter Abrechnungshäufigkeit im Jahr 2023.

KV-Bezirk	Abrechnungshäufigkeit GOP 01450 (je 100.000 Versicherte)			
	2020	2021	2022	2023
Bayern	532.290 (4.701)	650.773 (5.735)	508.022 (4.442)	403.765 (3.492)
Nordrhein	389.270 (4.613)	542.282 (6.433)	413.315 (4.886)	358.870 (4.213)
Westfalen-Lippe	219.742 (2.941)	287.964 (3.858)	231.396 (3.089)	214.408 (2.842)
Baden-Württemberg	264.179 (2.781)	347.710 (3.661)	256.884 (2.693)	198.544 (2.061)
Hessen	309.731 (5.637)	397.348 (7.231)	261.684 (4.739)	194.843 (3.490)
Niedersachsen	196.413 (2.756)	230.962 (3.236)	196.389 (2.737)	177.314 (2.448)
Berlin	298.689 (9.180)	378.964 (11.587)	261.017 (7.876)	175.560 (5.226)
Rheinland-Pfalz	108.793 (3.122)	140.134 (4.020)	120.623 (3.447)	114.176 (3.237)
Hamburg	118.944 (6.943)	169.278 (9.833)	119.026 (6.817)	90.597 (5.097)
Schleswig-Holstein	61.492 (2.439)	76.296 (3.016)	70.451 (2.766)	67.786 (2.642)
Sachsen	53.501 (1.404)	67.264 (1.772)	51.548 (1.356)	56.315 (1.473)
Brandenburg	38.692 (1.673)	50.331 (2.170)	42.035 (1.795)	29.216 (1.238)
Thüringen	36.232 (1.844)	50.185 (2.573)	36.457 (1.869)	28.491 (1.457)
Mecklenburg-Vorpommern	29.196 (1.987)	34.541 (2.351)	30.133 (2.048)	26.014 (1.759)
Sachsen-Anhalt	25.515 (1.238)	42.266 (2.064)	31.761 (1.551)	21.817 (1.063)
Bremen	31.604 (5.164)	34.260 (5.599)	26.539 (4.294)	21.089 (3.377)
Saarland	20.981 (2.431)	25.552 (2.975)	23.878 (2.784)	20.651 (2.392)

Zu 2.8: Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit nach Fachgruppen und Anteil der Fachgruppen an allen abgerechneten Videosprechstunden

Tabelle 58 Abrechnungshäufigkeit der Videosprechstunde (GOP 01450) nach Fachgruppen in den Jahren 2020 bis 2023 und Anteil an allen abgerechneten Videosprechstunden in % im Jahr 2023. Sortiert nach Abrechnungshäufigkeit im Jahr 2023. (Definition der Fachgruppen siehe Kapitel 1.2).

Fachgruppe	Abrechnungshäufigkeit GOP 01450 pro Jahr				% an allen Videosprechstunden 2023 (N=2.199.456)
	2020	2021	2022	2023	
Hausärztinnen/-ärzte	372.674	470.526	737.669	912.754	41,5%
Psychotherapie	1.897.725	2.477.308	1.483.048	875.073	39,8%
Gynäkologie	31.044	62.068	61.056	64.772	2,9%
Orthopädie	21.848	32.600	43.383	53.771	2,4%
Psychosomatische Med.	120.346	147.280	93.618	49.925	2,3%
Psychiatrie	94.828	114.343	69.940	46.232	2,1%
Kinder-/Jugendmed.	48.077	52.032	42.986	40.831	1,9%
HNO und Phoniatrie	12.847	20.513	22.606	29.933	1,4%
Innere Medizin	24.827	23.689	24.426	24.404	1,1%
Neurologie/Nervenheilk.	33.878	30.160	22.444	22.932	1,0%
Sonstige	29.386	31.238	20.924	17.091	0,8%
Dermatologie	21.164	21.344	17.702	16.642	0,8%
Urologie	5.886	8.786	11.846	11.634	0,5%
Chirurgie	5.274	6.718	7.713	11.287	0,5%
Anästhesiologie	8.185	9.822	7.777	8.178	0,4%
Augenheilkunde	2.294	8.309	7.213	7.113	0,3%
Physikalische/Rehab. Med.	3.514	7.178	5.088	5.011	0,2%
Humangenetik	1.431	2.122	1.705	1.857	0,1%
Strahlentherapie	27	72	14	16	0,0%
Labor	9	2	-	-	0,0%
Gesamt	2.735.264	3.526.110	2.681.158	2.199.456	100%

Zu 2.11.2: Betrachtung der Morbidität von Versicherten mit Videosprechstunden

Tabelle 59 Prozentualer Anteil der überproportional häufigen ICD-Diagnosen von Behandlungsfällen von Versicherten mit Inanspruchnahme einer Videosprechstunde („Mit Videosprechstunde“) im Vergleich zu den entsprechenden Behandlungsfällen aller Versicherten („Alle Versicherte“); Unterschied: Faktor für die faktorielle Erhöhung des Videosprechstunden-Anteils gegenüber dem Anteil aller Versicherten im Jahr 2022; Zum Vorgehen s. Kapitel 2.11.2.

Fachgruppe	ICD	Bezeichnung	Mit Videosprechstunde (%)	Alle Versicherte (%)	Unterschied (Faktor)
Psychotherapie	F60.31	Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ	2,6%	1,3%	2
	F42.2	Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt	2,5%	1,5%	2
	Z73	Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung	1,7%	1,0%	2
	F64.0	Transsexualismus	1,1%	0,5%	2
	F45.2	Hypochondrische Störung	1,0%	0,6%	2
	F50.2	Bulimia nervosa	0,8%	0,4%	2
	F50.9	Essstörung, nicht näher bezeichnet	0,8%	0,5%	2
	F50.1	Atypische Anorexia nervosa	0,6%	0,3%	2
	F33.4	Rezidivierende depressive Störung, gw. remittiert	0,6%	0,4%	2
	F50.4	Essattacken bei anderen psychischen Störungen	0,6%	0,4%	2
Psychiatrie	F90.0	Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung	26,1%	11,6%	2
	F81.0	Lese- und Rechtschreibstörung	4,4%	1,9%	2
	F40.1	Soziale Phobien	4,0%	2,3%	2
	F90.1	Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens	3,4%	2,2%	2
	F42.2	Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt	2,8%	1,8%	2
	F84.5	Asperger-Syndrom	2,6%	0,8%	3
	F98.80	Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität mit Beginn in der Kindheit und Jugend	2,1%	1,1%	2
	F40.2	Spezifische (isolierte) Phobien	1,7%	0,9%	2
	Z63	Andere Kontaktanlässe mit Bezug engeren Familienkreis	1,7%	0,7%	3
	F84.0	Frühkindlicher Autismus	1,5%	0,5%	3
Psychosomatik	F41.0	Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]	10,4%	6,7%	2
	F43.1	Posttraumatische Belastungsstörung	10,3%	6,6%	2
	F90.0	Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung	2,6%	1,5%	2
	F60.31	Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ	2,3%	1,3%	2
	F45.1	Undifferenzierte Somatisierungsstörung	2,1%	1,3%	2
	F61	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	1,8%	1,2%	2
	F40.2	Spezifische (isolierte) Phobien	1,6%	0,9%	2
	F50.2	Bulimia nervosa	1,6%	0,6%	3
	F42.0	Vorwiegend Zwangsgedanken oder Grübelzwang	1,4%	0,9%	2
	F45.2	Hypochondrische Störung	1,4%	0,8%	2
Neurologie	G43.0	Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]	7,9%	3,5%	2
	F43.2	Anpassungsstörungen	6,2%	3,4%	2
	F32.9	Depressive Episode, nicht näher bezeichnet	5,8%	3,4%	2
	G44.2	Spannungskopfschmerz	5,6%	3,5%	2
	G43.9	Migräne, nicht näher bezeichnet	5,4%	1,9%	3
	G43.1	Migräne mit Aura [Klassische Migräne]	5,1%	3,0%	2
	G35.10	Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe akuten Exazerbation/Progression	4,9%	2,5%	2
	R52.2	Sonstiger chronischer Schmerz	4,8%	3,1%	2
	F45.41	Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren	4,3%	2,8%	2
	R51	Kopfschmerz	3,4%	2,2%	2

Fachgruppe	ICD	Bezeichnung	Mit Videosprechstunde (%)	Alle Versicherte (%)	Unterschied (Faktor)
Hausärztinnen/-ärzte	J06.9	Akute Infektion der oberen Atemwege	35,8%	9,8%	4
	U07.1	COVID-19, Virus nachgewiesen	9,4%	2,0%	5
	A09.9	Sonstige/nicht näher bezeichnete Gastroenteritis/Kolitis	7,1%	2,1%	3
	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	5,8%	1,2%	5
	R51	Kopfschmerz	4,4%	1,9%	2
	B34.9	Virusinfektion, nicht näher bezeichnet	3,3%	1,2%	3
	A09.0	Sonstige Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs	3,1%	0,6%	5
	U08.9	COVID-19 in der Eigenanamnese	2,9%	1,5%	2
	U07.2	COVID-19, Virus nicht nachgewiesen	2,7%	0,4%	6
	R10.4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen	2,1%	1,3%	2
Kinder-/Jugendmed.	Z71	Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung/ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen	12,7%	5,9%	2
	L20.8	Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem	6,2%	4,0%	2
	L20.9	Atopisches [endogenes] Ekzem, nicht näher bezeichnet	5,1%	2,9%	2
	H10.9	Konjunktivitis, nicht näher bezeichnet	4,8%	2,1%	2
	R10.4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen	4,6%	3,0%	2
	L30.9	Dermatitis, nicht näher bezeichnet	4,6%	1,9%	2
	F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen	4,3%	2,7%	2
	J06.8	Sonstige akute Infektionen der oberen Atemwege	4,3%	2,1%	2
	Z29.8	Sonstige näher bezeichnete prophylaktische Maßnahmen	4,0%	2,4%	2
	B99	Sonstige/nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	4,0%	2,6%	2
Innere Medizin	R52.2	Sonstiger chronischer Schmerz	5,8%	0,9%	6
	J06.9	Akute Infektion der oberen Atemwege	5,7%	0,5%	10
	Z51.2	Andere Chemotherapie	5,0%	0,3%	14
	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	4,4%	0,1%	84
	G47.31	Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom	4,3%	2,8%	2
	I10.10	Maligne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	4,1%	0,2%	23
	A09.0	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs	4,1%	0,1%	73
	M05.80	Sonstige seropositive chronische Polyarthritiden: Mehrere Lokalisationen	3,5%	0,6%	6
	E55.9	Vitamin-D-Mangel	3,5%	2,2%	2
	A09.9	Sonstige/nicht näher bezeichnete Gastroenteritis/Kolitis	3,0%	0,4%	8
Gynäkologie	Z31.6	Allgemeine Beratung im Zusammenhang mit Fertilisation	8,6%	1,6%	5
	N97.9	Sterilität der Frau, nicht näher bezeichnet	8,5%	0,6%	15
	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	7,9%	0,0%	162
	Z71	Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung/ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen	7,0%	3,2%	2
	J06.9	Akute Infektion der oberen Atemwege	4,9%	0,1%	38
	N92.0	Zu starke/häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus	3,8%	1,7%	2
	R11	Übelkeit und Erbrechen	2,8%	0,2%	13
	Z31.9	Fertilisationsfördernde Maßnahme	2,4%	0,4%	6
	N39.0	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	2,4%	0,7%	3
	R51	Kopfschmerz	2,3%	0,2%	13

Fachgruppe	ICD	Bezeichnung	Mit Video- sprech- stunde (%)	Alle Versi- cherte (%)	Unter- schied (Faktor)
HNO/Phon.	J06.9	Akute Infektion der oberen Atemwege	22,1%	1,9%	12
	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	14,7%	2,6%	6
	J06.8	Sonstige akute Infektionen der oberen Atemwege	5,9%	0,4%	16
	G44.2	Spannungskopfschmerz	4,5%	0,0%	96
	G47.31	Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom	4,1%	1,7%	2
	R51	Kopfschmerz	4,0%	0,7%	5
	R07.0	Halsschmerzen	3,6%	0,7%	5
	U07.1	COVID-19, Virus nachgewiesen	3,2%	0,1%	42
	G43.1	Migräne mit Aura [Klassische Migräne]	2,5%	0,0%	114
	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] (V.a.)	1,8%	0,0%	37
Augenheil- kunde	H40.9	Glaukom, nicht näher bezeichnet	14,5%	6,4%	2
	J11.8	Grippe mit sonstigen Manifestationen (V.a)	11,6%	0,0%	4.209
	J11.8	Grippe mit sonstigen Manifestationen	8,6%	0,0%	3.630
	G44.2	Spannungskopfschmerz	4,0%	0,0%	202
	G44.2	Spannungskopfschmerz (V.a)	3,0%	0,0%	2.845
	E11.9-	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen	2,1%	1,3%	2
	H10.3	Akute Konjunktivitis, nicht näher bezeichnet	1,6%	1,0%	2
	H10.1	Akute allergische Konjunktivitis	1,6%	0,6%	2
	I10.0-	Benigne essentielle Hypertonie	1,6%	0,4%	4
	G43.0	Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]	1,4%	0,0%	83
Orthopädie	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	18,4%	0,0%	380
	J06.9	Akute Infektion der oberen Atemwege	8,0%	0,1%	100
	R51	Kopfschmerz	5,2%	0,3%	18
	G44.2	Spannungskopfschmerz	4,0%	0,1%	37
	J10.8	Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale In- fluenzaviren nachgewiesen	2,1%	0,0%	181
	M54.86	Sonstige Rückenschmerzen: Lumbalbereich	1,7%	0,9%	2
	A09.9	Sonstige/nicht näher bezeichnete Gastroenteritis/Kolitis	1,2%	0,0%	48
	J11.8	Grippe mit sonstigen Manifestationen	1,1%	0,0%	307
	G47.0	Ein- und Durchschlafstörungen	1,0%	0,0%	32
	M79.18	Myalgie: Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule	0,9%	0,5%	2
Urologie	G43.0	Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]	0,8%	0,0%	32
	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	8,8%	0,0%	520
	J06.9	Akute Infektion der oberen Atemwege	6,0%	0,0%	121
	N30.0	Akute Zystitis	4,6%	1,9%	2
	R50.9	Fieber, nicht näher bezeichnet	4,4%	0,0%	139
	A09.9	Sonstige/nicht näher bezeichnete Gastroenteritis/Kolitis	4,0%	0,0%	96
	J06.8	Sonstige akute Infektionen der oberen Atemwege	2,8%	0,0%	738
	N10	Akute tubulointerstitielle Nephritis	2,7%	0,1%	30
	N48.4	Impotenz organischen Ursprungs	2,6%	1,4%	2
	R10.4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen	2,5%	1,2%	2
Änästhesie	Z31.6	Allgemeine Beratung im Zusammenhang mit Fertilisation	2,3%	0,6%	4
	F43.0	Akute Belastungsreaktion	7,1%	0,8%	9
	F32.9	Depressive Episode, nicht näher bezeichnet	6,2%	3,7%	2
	Z51.4	Vorbereitung auf eine nachfolgende Behandlung	5,2%	2,8%	2
	J35.2	Hyperplasie der Rachenmandel	4,5%	1,2%	4
	Z91.1	Nichtbefolgung ärztlicher Anordnungen	3,5%	1,7%	2
	G43.0	Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]	3,4%	0,9%	4
	E66.99	Adipositas, nicht näher bezeichnet	3,1%	1,7%	2
	Z93.1	Vorhandensein eines Gastrostomas	3,1%	0,0%	63
	M53.0	Zervikozephalales Syndrom	3,0%	0,9%	3
	K02.8	Sonstige Zahnkaries	2,9%	0,3%	11

Fachgruppe	ICD	Bezeichnung	Mit Videosprechstunde (%)	Alle Versicherte (%)	Unterschied (Faktor)
Chirurgie	Z98.8	Sonstige Zustände nach chirurgischen Eingriffen	10,2%	3,3%	3
	J11.0	Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen	8,0%	0,0%	1163
	J06.9	Akute Infektion der oberen Atemwege	6,6%	0,1%	49
	G56.0	Karpaltunnel-Syndrom	5,6%	1,9%	3
	K91.2	Malabsorption nach chirurgischem Eingriff	4,3%	0,0%	277
	E66.09	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr	4,3%	0,2%	18
	N47	Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose	4,3%	0,6%	8
	R10.4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen	3,3%	0,4%	8
	G90.8	Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems	3,3%	0,0%	146
	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	3,2%	0,0%	116
Dermatologie	L70.0	Acne vulgaris	5,4%	3,1%	2
	L71.8	Sonstige Rosazea	4,1%	2,3%	2
	L21.9	Seborrhoisches Ekzem	4,0%	1,9%	2
	L70.9	Akne, nicht näher bezeichnet	3,6%	1,7%	2
	L40.8	Sonstige Psoriasis	3,3%	1,0%	3
	E88.21	Lipödem, Stadium II	2,8%	0,1%	27
	J30.3	Sonstige allergische Rhinopathie	2,3%	1,1%	2
	Z51.88	Sonstige näher bezeichnete medizinische Behandlung	2,2%	0,8%	3
	J30.4	Allergische Rhinopathie	2,2%	0,9%	2
	T78.4	Allergie, nicht näher bezeichnet	2,0%	1,0%	2

Zu 2.12: Authentifizierungen im Rahmen von Videosprechstunden

Tabelle 60 Regionale Abrechnungshäufigkeit der Authentifizierung von Versicherten (GOP 01444) im Rahmen der Videosprechstunde nach KV-Bezirken. Dargestellt sind die absolute Abrechnungshäufigkeit und in Klammern die normierte Abrechnungshäufigkeit je 100.000 Versicherte. Sortiert nach der Abrechnungshäufigkeit im Jahr 2023.

KV-Bezirk	Abrechnungshäufigkeit GOP 01444 (je 100.000 Versicherte)			
	2020	2021	2022	2023
Nordrhein	20.817 (247)	60.390 (716)	83.224 (984)	123.775 (1.453)
Bayern	27.755 (245)	31.126 (274)	56.649 (495)	93.626 (810)
Westfalen-Lippe	9.062 (121)	27.619 (370)	41.124 (549)	71.581 (949)
Hessen	9.062 (165)	22.563 (411)	30.337 (549)	60.136 (1.077)
Niedersachsen	15.210 (213)	23.745 (333)	28.776 (401)	57.947 (800)
Baden-Württemberg	19.409 (204)	40.315 (424)	36.860 (386)	48.839 (507)
Rheinland-Pfalz	3.688 (106)	10.008 (287)	12.871 (368)	31.603 (896)
Berlin	11.151 (343)	15.464 (473)	23.290 (703)	22.849 (680)
Hamburg	7.864 (459)	9.340 (543)	11.623 (666)	17.923 (1.008)
Schleswig-Holstein	3.326 (132)	5.420 (214)	11.024 (433)	17.317 (675)
Sachsen	2.538 (67)	3.847 (101)	4.369 (115)	16.884 (441)
Saarland	465 (54)	565 (66)	5.858 (683)	7.349 (851)
Thüringen	2.272 (116)	4.243 (218)	6.249 (320)	6.667 (341)
Mecklenburg-Vorpommern	2.088 (142)	3.364 (229)	4.547 (309)	6.214 (420)
Bremen	867 (142)	667 (109)	599 (97)	3.379 (541)
Sachsen-Anhalt	980 (48)	4.036 (197)	980 (48)	3.158 (154)
Brandenburg	1.455 (63)	2.850 (123)	4.312 (184)	2.103 (89)

Zu Kapitel 3: Videofallkonferenzen**Zu 3.3: Leistungsentwicklung der Videofallkonferenz**

Tabelle 61 Jährliche regionale Abrechnungshäufigkeit der Videofallkonferenz (GOP01442) nach KV-Bezirken. Dargestellt sind die absolute Abrechnungshäufigkeit und in Klammern die normierte Abrechnungshäufigkeit je 100.000 Versicherte. Sortiert nach der Abrechnungshäufigkeit im Jahr 2023.

KV-Bezirk	Abrechnungshäufigkeit GOP 01442 (je 100.000 Versicherte)			
	2020	2021	2022	2023
Nordrhein	2.247 (27)	2.326 (28)	2.328 (28)	1.388 (16)
Niedersachsen	3.251 (46)	1.740 (24)	1.724 (24)	1.310 (18)
Bayern	4.423 (39)	2.449 (22)	1.178 (10)	1.304 (11)
Sachsen	1.952 (51)	1.232 (32)	863 (23)	1.041 (27)
Hessen	1.588 (29)	847 (15)	676 (12)	679 (12)
Baden-Württemberg	1.669 (18)	1.213 (13)	568 (6)	660 (7)
Westfalen-Lippe	1.934 (26)	1.029 (14)	742 (10)	389 (5)
Rheinland-Pfalz	1.123 (32)	384 (11)	460 (13)	353 (10)
Schleswig-Holstein	1.114 (44)	209 (8)	527 (21)	346 (13)
Berlin	744 (23)	278 (8)	168 (5)	334 (10)
Mecklenburg-Vorpommern	350 (24)	375 (26)	236 (16)	285 (19)
Hamburg	417 (24)	520 (30)	328 (19)	228 (13)
Brandenburg	382 (17)	270 (12)	124 (5)	175 (7)
Thüringen	405 (21)	450 (23)	215 (11)	132 (7)
Sachsen-Anhalt	381 (18)	151 (7)	98 (5)	85 (4)
Bremen	166 (27)	64 (10)	29 (5)	28 (4)
Saarland	362 (42)	266 (31)	63 (7)	23 (3)

Tabelle 62 Abrechnungshäufigkeit der Videofallkonferenz (GOP01442) nach Einrichtungenformen in den Jahren 2020 bis 2023. In Klammern ist die mittlere Abrechnungshäufigkeit pro abrechnende Einrichtung angegeben.

Einrichtungsform	Abrechnungshäufigkeit GOP 01442 jährlich (durchschnittliche Abrechnungen je Einrichtung)			
	2020	2021	2022	2023
Einzelpraxis	12.317 (16)	7.488 (20)	5.992 (21)	4.989 (21)
Gemeinschaftspraxis	8.520 (18)	4.576 (23)	3.883 (25)	2.893 (23)
Krankenhaus	24 (6)	≤5 (≤5)	9 (9)	38 (10)
MVZ	1.383 (22)	1.397 (39)	360 (12)	840 (19)
Sonstige	264 (264)	337 (337)	83 (83)	.

Tabelle 63 Abrechnungshäufigkeit der Videofallkonferenz (GOP01442) nach Fachgruppen im Jahr 2023. Dargestellt sind die Abrechnungshäufigkeit (AH) pro Fachgruppe, die Gesamtanzahl Ärztinnen/Ärzte pro Fachgruppe und die Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte pro Fachgruppe (n Ä). Sortiert nach der AH.

Fachgruppe	Gesamtanzahl Ärztinnen/Ärzte	Abrechnungshäufigkeiten (AH) der GOP01442 und Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte (n Ä) 2023	
		AH	n Ä
Hausärztinnen/-ärzte	63.549	6.671	338
Neurologie/Nervenheilkunde	5.330	411	27
Kinder-/Jugendmedizin	9.133	245	21
Innere Medizin	14.420	238	16
Anästhesiologie	4.165	221	≤5
Urologie	3.963	202	8
Augenheilkunde	7.014	186	≤5
Gynäkologie	13.530	146	18
Orthopädie	9.190	127	13
Dermatologie	4.334	126	22
Psychotherapie	37.442	74	11
Chirurgie	7.965	41	8
HNO und Phoniatrie	4.861	28	12
Sonstige	23.516	27	8
Psychiatrie	3.647	17	7
Physik./Rehab. Medizin	640	.	.
Humangenetik	353	.	.
Psychosomatische Med.	2.235	.	.
Radiologie/Nuklearmedizin/Strahlentherapie	7.025	.	.

Zu Kapitel 4: Telemonitoring bei Herzinsuffizienz**Zu 4.3 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf für das Telemonitoring bei Herzinsuffizienz**

Tabelle 64 Abrechnungshäufigkeit aller Leistungen des Telemonitoring Herzinsuffizienz im Quartalsverlauf und insgesamt für das Jahr 2023. PBA = Primärbehandelnde Ärztinnen/Ärzte. TMZ = Telemedizinische Zentren.

	Leistung	Abrechnungshäufigkeit 2022			Abrechnungshäufigkeit 2023				Gesamt 2023
		2022/2	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4	
PBA	GOP 03325	259	324	256	345	312	493	391	1.541
	GOP 04325	8	11	≤5	10	12	12	≤5	39
	GOP 13578	1.610	2.425	2.390	3.711	3.313	3.810	3.684	14.518
	GOP 03326	326	301	360	455	490	592	469	2.006
	GOP 04326	≤5	0	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	10
	GOP 13579	1.374	2.412	3.245	3.801	4.320	4.895	5.403	18.419
TMZ	GOP 13583	531	929	1.396	2.399	1.664	1.686	1.634	7.383
	GOP 13584	2.072	2.501	3.332	4.176	4.876	5.701	6.524	21.277
	GOP 13585	916	1.322	1.299	1.256	1.337	1.938	2.228	6.759
	GOP 13586	59	460	929	1.788	2.345	2.819	3.306	10.258
	GOP 13587	12	42	76	116	239	335	406	1.096
	GOP 40910	32	429	888	1.735	2.309	2.775	3.245	10.064

Tabelle 65 Leistungsbedarf in € aller Leistungen des Telemonitoring Herzinsuffizienz im Quartalsverlauf und insgesamt für das Jahr 2023. PBA = Primärbehandelnde Ärztinnen/Ärzte. TMZ = Telemedizinische Zentren.

	Leistung	Leistungsbedarf 2022 in €			Leistungsbedarf 2023 in €				Gesamt 2023
		2022/2	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4	
PBA	GOP 03325	1.896	2.371	1.874	2.577	2.331	3.688	2.922	11.518
	GOP 04325	59	81	29	75	90	90	37	291
	GOP 13578	11.786	17.754	17.504	27.723	24.757	28.453	27.529	108.462
	GOP 03326	4.703	4.341	5.192	6.691	7.207	8.710	6.899	29.508
	GOP 04326	29	.	29	44	74	15	15	147
	GOP 13579	19.809	34.825	46.824	55.915	63.562	72.032	79.502	271.010
TMZ	GOP 13583	5.682	9.962	14.949	26.181	18.168	18.372	17.854	80.575
	GOP 13584	256.782	309.897	412.959	527.606	616.173	720.077	824.339	2.688.194
	GOP 13585	24.254	35.001	34.395	33.922	36.110	52.342	60.175	182.547
	GOP 13586	13.959	109.671	220.481	432.222	566.560	680.735	798.478	2.477.996
	GOP 13587	318	1.112	2.012	3.133	6.455	9.048	10.960	29.596
	GOP 40910	2.176	29.172	60.384	117.980	157.012	188.700	220.660	684.352

Zu 4.4 Regionale Abrechnungshäufigkeit für das Telemonitoring Herzinsuffizienz

*Tabelle 66 Abrechnungshäufigkeit der Leistungen des Telemonitoring Herzinsuffizienz, **die primärbehandelnde Ärztinnen/Ärzte (PBA) betreffen**, nach KV-Bezirken für das Jahr 2023. Dargestellt sind die absolute Abrechnungshäufigkeit und in Klammern die normierte Abrechnungshäufigkeit je 100.000 Versicherte. Sortiert nach der Abrechnungshäufigkeit der GOP 13579.*

KV-Bezirk	Abrechnungshäufigkeit (je 100.000 Versicherte)					
	GOP 03325	GOP 04325	GOP 13578	GOP 03326	GOP 04326	GOP 13579
Baden-Württemberg	96 (1,0)	3 (0,0)	1.483 (15,4)	66 (0,7)	3 (0,0)	2.378 (24,7)
Bayern	131 (1,1)	3 (0,0)	1.107 (9,6)	238 (2,1)	2 (0,0)	2.218 (19,2)
Sachsen-Anhalt	218 (10,6)		4.474 (218,0)	108 (5,3)	1 (0,0)	2.121 (103,4)
Niedersachsen	155 (2,1)	5 (0,1)	842 (11,6)	258 (3,6)		2.038 (28,1)
Mecklenburg-Vorpommern	21 (1,4)		779 (52,7)	48 (3,2)		1.794 (121,3)
Nordrhein	82 (1,0)	4 (0,0)	645 (7,6)	128 (1,5)	1 (0,0)	1.244 (14,6)
Westfalen-Lippe	126 (1,7)	3 (0,0)	630 (8,3)	307 (4,1)		1.053 (14,0)
Sachsen	25 (0,7)		868 (22,7)	34 (0,9)		991 (25,9)
Brandenburg	14 (0,6)		142 (6,0)	13 (0,6)		970 (41,1)
Hamburg	97 (5,5)	1 (0,1)	750 (42,2)	30 (1,7)		955 (53,7)
Hessen	320 (5,7)	4 (0,1)	615 (11,0)	495 (8,9)	2 (0,0)	809 (14,5)
Thüringen	28 (1,4)	5 (0,3)	768 (39,3)	69 (3,5)		671 (34,3)
Berlin	131 (3,9)	3 (0,1)	417 (12,4)	89 (2,6)	1 (0,0)	458 (13,6)
Rheinland-Pfalz	12 (0,3)	2 (0,1)	621 (17,6)	66 (1,9)		348 (9,9)
Schleswig-Holstein	20 (0,8)	5 (0,2)	234 (9,1)	38 (1,5)		230 (9,0)
Bremen	7 (1,1)	1 (0,2)	143 (22,9)	6 (1,0)		141 (22,6)
Saarland	58 (6,7)			13 (1,5)		

*Tabelle 67 Abrechnungshäufigkeit von GOP des Telemonitoring Herzinsuffizienz, **die telemedizinische Zentren (TMZ) betreffen**, in Bezug auf die KV-Bezirke für das Jahr 2023. Dargestellt sind die absolute Abrechnungshäufigkeit und die normierte Abrechnungshäufigkeit in Bezug auf 100.000 Versicherte. Sortiert nach der Abrechnungshäufigkeit der GOP 13584.*

KV-Bezirk	Abrechnungshäufigkeit (je 100.000 Versicherte)					
	GOP 13583 Aufkl./An- leitung	GOP 13584 Überwachung Aggregate	GOP 13585 Intensiv. (Aggregate)	GOP 13586 Überwachung ext. Geräte	GOP 13587 Intensiv. (ext. Geräte)	GOP 40910 (Gerätepau- schale)
Sachsen-Anhalt	400 (19,5)	2.868 (139,8)	1.427 (69,5)	369 (18,0)	166 (8,1)	360 (17,5)
Mecklenburg- Vorpommern	472 (31,9)	2.435 (164,6)	173 (11,7)	456 (30,8)	53 (3,6)	455 (30,8)
Baden-Württem- berg	695 (7,2)	2.195 (22,8)	1.507 (15,6)	605 (6,3)	84 (0,9)	599 (6,2)
Niedersachsen	616 (8,5)	1.940 (26,8)	720 (9,9)	698 (9,6)	239 (3,3)	696 (9,6)
Bayern	668 (5,8)	1.835 (15,9)	593 (5,1)	1.282 (11,1)		1.266 (10,9)
Sachsen	589 (15,4)	1.490 (39,0)	315 (8,2)	223 (5,8)	56 (1,5)	220 (5,8)
Westfalen-Lippe	620 (8,2)	1.415 (18,8)	7 (0,1)	982 (13,0)	≤5 (0,0)	968 (12,8)
Nordrhein	778 (9,1)	1.246 (14,6)	175 (2,1)	1.126 (13,2)	93 (1,1)	1.090 (12,8)
Berlin	503 (15,0)	1.156 (34,4)	401 (11,9)	794 (23,6)	24 (0,7)	760 (22,6)
Brandenburg	364 (15,4)	1.069 (45,3)	226 (9,6)	396 (16,8)		393 (16,7)
Thüringen	396 (20,3)	1.050 (53,7)	455 (23,3)	404 (20,7)	298 (15,2)	373 (19,1)
Schleswig-Hol- stein	133 (5,2)	824 (32,1)	207 (8,1)	178 (6,9)	33 (1,3)	164 (6,4)
Hessen	407 (7,3)	791 (14,2)	433 (7,8)	564 (10,1)	26 (0,5)	546 (9,8)
Rheinland-Pfalz	265 (7,5)	681 (19,3)	120 (3,4)	422 (12,0)	23 (0,7)	412 (11,7)
Hamburg	421 (23,7)	253 (14,2)		1.616 (90,9)		1.615 (90,9)
Bremen	56 (9,0)	29 (4,6)		143 (22,9)		147 (23,5)

Zu 4.6: Stand der Versorgungseinrichtungen für Telemonitoring Herzinsuffizienz

Tabelle 68 a: Anzahl der abrechnenden Telemedizinischer Zentren (TMZ) im 4. Quartal 2023 nach KV-Bezirken. Definition abrechnendes TMZ: Abrechnung mind. einer GOP 13584 oder GOP 13586; b: Anzahl der abrechnenden primärbehandelnder Ärztinnen/Ärzte (PBA) im 4. Quartal 2023. Definition abrechnende/r PBA: Abrechnung mind. einer GOP 03326, GOP 04326 oder GOP 13579

a	KV-Bezirk	Anzahl abrechnende TMZ	b	KV-Bezirk	Anzahl abrechnende PBA
	Bayern	36		Bayern	61
	Baden-Württemberg	23		Niedersachsen	42
	Hessen	15		Nordrhein	39
	Nordrhein	15		Baden-Württemberg	35
	Westfalen-Lippe	15		Hessen	34
	Berlin	14		Westfalen-Lippe	27
	Sachsen	14		Thüringen	23
	Niedersachsen	13		Berlin	20
	Sachsen-Anhalt	11		Sachsen-Anhalt	20
	Thüringen	10		Sachsen	15
	Hamburg	8		Mecklenburg-Vorpommern	12
	Mecklenburg-Vorpommern	7		Rheinland-Pfalz	12
	Rheinland-Pfalz	7		Hamburg	9
	Schleswig-Holstein	7		Brandenburg	6
	Brandenburg	≤5		Schleswig-Holstein	6
	Bremen	≤5		Bremen	≤5
	Saarland	0		Saarland	0
	Gesamt	201		Gesamt	362

Zu Kapitel 5: Telemedizinische Funktionsanalyse**Zu 5.3 Leistungsentwicklung der telemedizinischen Funktionsanalyse**

Tabelle 69 Abrechnungshäufigkeit der telemedizinischen Funktionsanalyse von ICD- (GOP 13574, GOP 04414 (Kinder)) und CRT-Aggregaten (GOP 13576, GOP 04416 (Kinder)) pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.

Leistung	Abrechnungshäufigkeit 2022				Abrechnungshäufigkeit 2023			
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
GOP 04414	≤5	≤5	≤5	9	≤5	≤5	6	≤5
GOP 04416	.	≤5	.	≤5	.	.	≤5	.
GOP 13574	6.386	6.446	6.307	6.325	6.275	6.158	6.089	6.349
GOP 13576	3.857	3.916	3.943	3.970	3.972	3.964	3.914	4.089

Tabelle 70 Leistungsbedarf in € der telemedizinischen Funktionsanalyse von ICD- (GOP 13574, GOP 04414 (Kinder)) und CRT-Aggregaten (GOP 13576, GOP 04416 (Kinder)) pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.

Leistung	Leistungsbedarf 2022				Leistungsbedarf 2023			
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
GOP 04414	412	165	412	742	168	168	505	168
GOP 04416	.	102	.	102	.	.	104	.
GOP 13574	287.106	290.367	283.548	284.263	287.997	282.860	279.364	291.475
GOP 13576	212.907	216.906	217.849	219.307	224.111	223.828	220.655	230.728

Tabelle 71 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € der Leistungen der telemedizinischen Funktionsanalyse in den Jahren 2018 bis 2023. In Klammern ist die Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit in % im Vergleich zum Vorjahr angegeben.

Jahr	Abrechnungshäufigkeit (Entwicklung in %)				Leistungsbedarf in €			
	GOP 04414	GOP 04416	GOP 13574	GOP 13576	GOP 04414	GOP 04416	GOP 13574	GOP 13576
2018	144	84	11.190	6.302	9.834	7.061	417.301	289.346
2019	22 (-85%)	6 (-93%)	14.304 (+28%)	8.590 (+36%)	1.703	585	616.647	455.514
2020	15 (-32%)	3 (-50%)	18.731 (+31%)	11.425 (+33%)	1.206	297	822.211	616.640
2021	17 (+13%)	3 (0%)	25.049 (+34%)	15.154 (+33%)	1.373	301	1.111.773	826.198
2022	21 (+24%)	2 (-33%)	25.464 (+2%)	15.686 (+4%)	1.732	203	1.145.285	866.969
2023	12 (-43%)	1 (-50%)	24.871 (-2%)	15.939 (+2%)	1.009	104	1.141.696	899.323

Zu 5.4 Regionale Abrechnungshäufigkeit der telemedizinischen Funktionsanalyse sowie nach Einrichtungformen und Fachgruppen

Tabelle 72 Abrechnungshäufigkeit der Leistungen der telemedizinischen Funktionsanalyse nach KV-Bezirken im Jahr 2023. Dargestellt sind die absolute Abrechnungshäufigkeit und in Klammern die normierte Abrechnungshäufigkeit je 100.000 Versicherte. Sortiert nach der AH der GOP 13574.

KV-Bezirk	Abrechnungshäufigkeit Jahr 2023 (je 100.000 Versicherte)			
	GOP 04414	GOP 04416	GOP 13574	GOP 13576
Bayern	.	.	2.650 (23)	1.547 (13)
Westfalen-Lippe	.	.	2.481 (33)	1.574 (21)
Baden-Württemberg	.	.	2.391 (25)	811 (8)
Brandenburg	.	.	2.196 (93)	1.623 (69)
Niedersachsen	10 (0)	.	2.191 (30)	1.543 (21)
Rheinland-Pfalz	≤5 (0)	≤5 (0)	1.813 (51)	1.367 (39)
Nordrhein	.	.	1.499 (18)	900 (11)
Mecklenburg-Vorpommern	.	.	1.449 (98)	1.291 (87)
Schleswig-Holstein	.	.	1.415 (55)	815 (32)
Berlin	.	.	1.260 (38)	1.150 (34)
Sachsen-Anhalt	.	.	1.244 (61)	825 (40)
Thüringen	.	.	1.175 (60)	710 (36)
Sachsen	.	.	1.055 (28)	815 (21)
Hessen	.	.	854 (15)	482 (9)
Hamburg	.	.	419 (24)	149 (8)
Bremen	.	.	409 (65)	120 (19)
Saarland	.	.	370 (43)	217 (25)

Tabelle 73 Abrechnungshäufigkeit der Leistungen zur telemedizinischen Funktionsanalyse nach Fachgruppen im Jahr 2023. Dargestellt sind die Abrechnungshäufigkeit (AH) pro Fachgruppe, die Gesamtanzahl Ärztinnen/Ärzte pro Fachgruppe und die Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte pro Fachgruppe.

Fachgruppe	Gesamtanzahl Ärztinnen/ Ärzte	Abrechnungshäufigkeiten (AH) und Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte (n Ä)							
		GOP 04414		GOP 04416		GOP 13574		GOP 13576	
		AH	n Ä	AH	n Ä	AH	n Ä	AH	n Ä
Hausärztinnen/-ärzte	63.549	.	.	.	.	64	≤5	7	≤5
Kinder- und Jugendmedizin	9.133	12	≤5	≤5	≤5	.	.	.	.
Innere Medizin	14.420	.	.	.	.	23.490	627	14.924	496
Sonstige	23.516	.	.	.	.	1.317	12	1.008	6

Zu Kapitel 6: Telekonsiliarische Befundbeurteilung radiologischer Aufnahmen**Zu 6.3 Leistungsentwicklung der telekonsiliarische Befundbeurteilung***Tabelle 74 Abrechnungshäufigkeit der telekonsiliarische Befundbeurteilung radiologischer Aufnahmen - pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.*

Leistung	Abrechnungshäufigkeit 2022				Abrechnungshäufigkeit 2023			
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
GOP 34800	40	22	102	67	23	17	126	37
GOP 34810	.	.	.	.	.	.	≤5	.
GOP 34820	28	7	≤5	11	8	8	≤5	≤5
GOP 34821	≤5	.	.	.	.	.	.	.

Tabelle 75 Leistungsbedarf in € der telekonsiliarischen Befundbeurteilung radiologischer Aufnahmen - pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.

Leistung	Leistungsbedarf 2022				Leistungsbedarf 2023			
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
GOP 34800	406	201	1022	678	233	146	1277	364
GOP 34810	.	.	.	.	.	.	13	.
GOP 34820	871	218	155	342	254	254	63	95
GOP 34821	44	.	.	.	.	.	.	.

Zu Kapitel 7: Elektronische Patientenakte**Zu 7.3: Leistungsentwicklung der elektronischen Patientenakte***Tabelle 76 Abrechnungshäufigkeit zur ePA pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.*

Leistung	Abrechnungshäufigkeit 2022				Abrechnungshäufigkeit 2023			
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
GOP 01431	1.653	2.961	2.182	3.423	5.553	4.534	4.998	5.849
GOP 01647	26.129	25.575	24.717	27.546	20.206	23.499	22.843	23.925
GOP 01648	12.314	10.981	6.608	6.332	10.826	7.465	8.653	19.381

Tabelle 77 Leistungsbedarf in € zur ePA pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.

Leistung	Leistungsbedarf in € 2022				Leistungsbedarf in € 2023			
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
GOP 01431	561	1.005	740	1.161	1.908	1.557	1.715	2.013
GOP 01647	44.270	43.322	41.887	46.651	34.843	40.508	39.370	41.227
GOP 01648	123.493	110.119	66.276	63.501	110.744	75.508	88.529	198.204

Tabelle 78 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € pro Jahr zur ePA. In Klammern ist die Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit in % im Vergleich zum Vorjahr angegeben.

Jahr	Abrechnungshäufigkeit (Entwicklung in %)			Leistungsbedarf in €		
	GOP 01431	GOP 01647	GOP 01648	GOP 01431	GOP 01647	GOP 01648
2021	3.839	58.247	.	1.269	97.318	.
2022	10.219 (+166%)	103.967 (+78%)	36.235	3.467	176.130	363.390
2023	20.934 (+105%)	90.473 (-13%)	46.325 (+28%)	7.193	155.948	472.984

Zu 7.4: Regionale Abrechnungshäufigkeit für die elektronische Patientenakte sowie nach Einrichtungsformen

Tabelle 79 Abrechnungshäufigkeit zur ePA nach Einrichtungsformen im Jahr 2023. In Klammern ist die mittlere Abrechnungshäufigkeit pro abrechnende Einrichtung angegeben.

Einrichtungsform	Abrechnungshäufigkeit (je Praxis)		
	GOP 01431	GOP 01647	GOP 01648
Einzelpraxis	4.491 (45)	47.920 (218)	38.097 (54)
Gemeinschaftspraxis	13.981 (157)	37.652 (471)	5.204 (17)
Krankenhaus	≤5 (2)	1.350 (338)	28 (28)
MVZ	2.457 (57)	3.197 (168)	2.995 (65)
Sonstige	≤5 (1)	354 (354)	≤5 (1)

Zu Kapitel 8: Elektronische Arztbriefe

Zu 8.3: Leistungsentwicklung eArztbriefe

Tabelle 80 Abrechnungshäufigkeit zu elektronischen Arztbriefen pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023. * Der Zuschlag zur Versandpauschale (GOP 01660) war nur bis zum Ende des 2. Quartals 2023 berechnungsfähig; bei den vorliegenden Abrechnungen ist von nachträglichen Abrechnungen auszugehen.

Leistung	Abrechnungshäufigkeit 2022				Abrechnungshäufigkeit 2023			
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
GOP 01660 (Zuschlag)	270.782	393.903	736.271	942.023	1.769.584	2.080.057	380*	33*
Pseudo-GOP 86900 (Versand)	290.005	424.144	806.597	1.158.802	1.914.500	2.257.688	1.818.691	1.559.498
Pseudo-GOP 86901 (Empfang)	150.153	217.401	399.666	600.467	1.102.277	1.383.826	1.154.495	1.136.915

Tabelle 81 Leistungsbedarf in € zu elektronischen Arztbriefen pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.

* Der Zuschlag zur Versandpauschale (GOP01660) war nur bis zum Ende des 2. Quartals 2023 berechnungsfähig; beim vorliegenden Leistungsbedarf ist von nachträglichen Abrechnungen auszugehen.

Leistung	Leistungsbedarf 2022 in €				Leistungsbedarf 2023 in €			
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
GOP 01660 (Zuschlag)	30.021	43.643	81.559	104.471	197.464	232.539	42*	4*
Pseudo-GOP 86900 (Versand)	36.775	50.209	86.022	112.211	161.541	189.492	81.750	78.538
Pseudo-GOP 86901 (Empfang)	24.079	42.476	85.858	132.737	233.894	296.597	126.326	139.481

Tabelle 82 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € für eArztbriefe in den Jahren 2021 bis 2023.

In Klammern ist die Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit in % im Vergleich zum Vorjahr angegeben. * Der Zuschlag zur Versandpauschale (GOP01660) war nur bis zum Ende des 2. Quartals 2023 berechnungsfähig.

Jahr	Abrechnungshäufigkeit (Entwicklung in %)			Leistungsbedarf in €		
	GOP 01660 (Zuschlag)	Pseudo-GOP 86900 (Versand)	Pseudo-GOP 86901 (Empfang)	GOP 01660	Pseudo-GOP 86900	Pseudo-GOP 86901
2021	356.913	382.832	358.257	39.416	46.705	47.546
2022	2.342.979 (+556%)	2.679.548 (+600%)	1.367.687 (+282%)	259.693	285.217	285.149
2023	3.850.054* (+64%)	7.550.377 (+182%)	4.777.513 (+249%)	430.049*	511.321	796.298

Zu 8.4: Regionale Abrechnungshäufigkeit für eArztbriefe sowie nach Einrichtungsformen

*Tabelle 83 Regionale Abrechnungshäufigkeit der Leistungen zu eArztbriefen nach KV-Bezirken. Dargestellt sind die absolute Abrechnungshäufigkeit und in Klammern die normierte Abrechnungshäufigkeit je 100.000 Versicherte. * Der Zuschlag zur Versandpauschale (GOP 01660) war nur bis zum Ende des 2. Quartals 2023 berechnungsfähig*

KV-Bezirk	Abrechnungshäufigkeit im Jahr 2023 nach KV-Bezirken (je 100.000 Versicherte)		
	GOP 01660 (Zuschlag)*	Pseudo-GOP 86900 (Versand)	Pseudo-GOP 86901 (Empfang)
Baden-Württemberg	488.565 (5.072)	840.283 (8.724)	380.287 (3.948)
Bayern	540.465 (4.674)	540.591 (4.675)	318.205 (2.752)
Berlin	47.282 (1.408)	119.022 (3.543)	98.430 (2.930)
Brandenburg	158.607 (6.722)	161.818 (6.858)	104.336 (4.422)
Bremen	62.310 (9.977)	247.367 (39.609)	118.613 (18.992)
Hamburg	26.363 (1.483)	129.960 (7.312)	103.429 (5.819)
Hessen	203.411 (3.643)	487.831 (8.737)	304.448 (5.453)
Mecklenburg-Vorpommern	250.122 (16.909)	562.794 (38.047)	466.859 (31.562)
Niedersachsen	453.130 (6.256)	455.829 (6.293)	246.396 (3.402)
Nordrhein	157.054 (1.844)	475.800 (5.586)	238.652 (2.802)
Rheinland-Pfalz	105.031 (2.978)	541.592 (15.354)	318.563 (9.031)
Saarland	15.036 (1.742)	67.419 (7.810)	35.399 (4.101)
Sachsen	314.633 (8.227)	714.785 (18.690)	526.912 (13.778)
Sachsen-Anhalt	245.408 (11.958)	245.863 (11.980)	183.737 (8.953)
Schleswig-Holstein	202.384 (7.888)	468.242 (18.251)	325.599 (12.691)
Thüringen	196.831 (10.065)	318.449 (16.284)	251.815 (12.877)
Westfalen-Lippe	383.422 (5.082)	383.422 (5.082)	234.373 (3.106)

*Tabelle 84 Abrechnungshäufigkeit für eArztbriefe nach Einrichtungsformen im Jahr 2023. In Klammern ist die mittlere Abrechnungshäufigkeit pro abrechnende Einrichtung angegeben. * Der Zuschlag zur Versandpauschale (GOP 01660) war nur bis zum Ende des 2. Quartals 2023 berechnungsfähig*

Einrichtungsform	Abrechnungshäufigkeit 2023 nach Einrichtungsformen (durchschnittliche Abrechnungen je Einrichtung)		
	GOP 01660 (Zuschlag)*	Pseudo-GOP 86900 (Versand)	Pseudo-GOP 86901 (Empfang)
Einzelpraxis	1.738.497 (221)	3.292.677 (305)	2.653.887 (110)
Gemeinschaftspraxis	1.737.696 (479)	3.448.070 (675)	1.870.879 (179)
MVZ	367.735 (521)	801.411 (794)	247.750 (150)
Sonstige	6.126 (142)	8.219 (155)	4.997 (68)

Zu 8.5: Abrechnungshäufigkeit für eArztbriefe nach Fachgruppen

*Tabelle 85 Abrechnungshäufigkeit für elektronische Arztbriefe nach Fachgruppen im Jahr 2022. Dargestellt sind die Abrechnungshäufigkeit (AH) pro Fachgruppe, die Gesamtanzahl Ärztinnen/Ärzte pro Fachgruppe und Anteil abrechnender Ärztinnen/Ärzte pro Fachgruppe (%Ä). * Der Zuschlag zur Versandpauschale (GOP 01660) war nur bis zum Ende des 2. Quartals 2023 berechnungsfähig*

Fachgruppe	Gesamtanzahl Ärztinnen/Ärzte	Abrechnungshäufigkeit (AH) und Anteil abrechnender Ärztinnen/Ärzte (% Ä) im Jahr 2023					
		GOP 01660 (Zuschlag)*		Pseudo-GOP 86900 (Versand)		Pseudo-GOP 86901 (Empfang)	
		AH	% Ä	AH	% Ä	AH	% Ä
Hausärztinnen/-ärzte	63.549	315.696	9%	641.306	13%	3.801.898	57%
Kinder- und Jugendmedizin	9.133	45.863	7%	99.408	12%	120.301	35%
Anästhesiologie	4.165	13.257	3%	30.846	4%	2.150	4%
Augenheilkunde	7.014	88.231	10%	169.918	13%	17.089	10%
Chirurgie	7.965	240.921	12%	488.755	17%	81.058	19%
Dermatologie	4.334	52.479	12%	93.542	17%	7.525	15%
Gynäkologie	13.530	69.339	11%	135.230	16%	140.823	33%
HNO und Phoniatrie	4.861	155.398	19%	293.047	27%	43.607	28%
Humangenetik	353	≤5	1%	1.356	2%	15	1%
Innere Medizin	14.420	1.301.664	22%	2.579.648	30%	152.700	29%
Labor	1.633	17.767	0%	27.241	1%	28	1%
Neurologie und Nervenheilkunde	5.330	311.193	18%	651.266	25%	53.955	29%
Orthopädie	9.190	419.745	16%	780.137	23%	284.449	36%
Pathologie	1.406	5.095	0%	12.164	0%	.	0%
Physikalische und Rehabilitative Medizin	640	14.825	15%	28.447	22%	10.959	35%
Psychiatrie	3.647	74.793	11%	151.632	15%	4.102	15%
Psychosomatische Medizin	2.235	391	1%	600	2%	74	1%
Psychotherapie	37.442	954	0%	2.585	1%	150	0%
Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie	7.025	449.572	9%	862.737	12%	2.520	4%
Urologie	3.963	209.734	20%	379.488	27%	39.992	29%
Sonstige	23.516	63.134	1%	121.024	2%	14.118	2%

Zu Kapitel 9: Anwendungen auf der elektronischen Gesundheitskarte**Zu 9.2.2: Leistungsentwicklung Notfalldatenmanagement**

Tabelle 86 Abrechnungshäufigkeit zum Notfalldatenmanagement pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.

Leistung	Abrechnungshäufigkeit 2022				Abrechnungshäufigkeit 2023			
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
GOP 01640 (Anlage)	89.788	82.016	73.357	78.829	130.046	142.278	150.870	149.002
GOP 01641 (Zuschlag NFD)	71.953.444	72.559.687	75.266.639	81.481.854	85.033.806	84.699.680	97.810.311	98.255.983

GOP 01642 (Löschung)	254	248	228	209	223	261	256	888
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tabelle 87 Leistungsbedarf in € zum Notfalldatenmanagement pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.

Leistung	Leistungsbedarf 2022 in €				Leistungsbedarf 2023 in €			
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
GOP 01640 (Anlage)	808.877	739.059	660.989	710.401	1.194.905	1.307.362	1.386.349	1.369.223
GOP 01641 (Zuschlag NFD)	32.416.074	32.685.946	33.904.323	36.704.343	39.095.323	38.941.598	44.969.867	45.173.046
GOP 01642 (Löschung)	28	27	25	23	25	29	29	98

Tabelle 88 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € pro Jahr für Notfalldatenmanagement. In Klammern ist die Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit in % im Vergleich zum Vorjahr angegeben. Die Entwicklung in den Jahren 2018 und 2019 ist nicht dargestellt.

Jahr	Abrechnungshäufigkeit (Entwicklung in %)			Leistungsbedarf in €		
	GOP 01640 (Anlage)	GOP 01641 (Zuschlag NFD)	GOP 01642 (Löschung)	GOP 01640	GOP 01641	GOP 01642
2020	27.421	19.118.577	20	446.067	8.464.908	2
2021	607.469 (+2.115%)	187.526.932 (+881%)	529 (+2.545%)	9.876.312	82.955.900	58
2022	323.990 (-47%)	301.261.624 (+61%)	939 (+78%)	2.919.326	135.710.686	104
2023	572.196 (+77%)	365.799.780 (+21%)	1.628 (+73%)	5.257.838	168.179.833	181

Zu 9.2.3: Regionale Abrechnungshäufigkeit des Notfalldatenmanagements sowie nach Fachgruppen und Einrichtungenformen

Tabelle 89 Regionale Abrechnungshäufigkeit der Leistungen zum Notfalldatenmanagement nach KV-Bezirken. Dargestellt sind die absolute Abrechnungshäufigkeit und in Klammern die normierte Abrechnungshäufigkeit je 100.000 Versicherte.

KV-Bezirk	Abrechnungshäufigkeit nach KV-Bezirken im Jahr 2023 (je 100.000 Versicherte)		
	GOP 01640 (Anlage)	GOP 01641 (Zuschlag NFD)	GOP 01642 (Löschung)
Baden-Württemberg	51.546 (535)	44.607.435 (463.100)	89 (1)
Bayern	71.886 (622)	61.476.855 (531.631)	252 (2)
Berlin	28.068 (836)	22.055.152 (656.562)	9 (0)
Brandenburg	21.410 (907)	12.701.273 (538.314)	651 (28)
Bremen	5.712 (915)	2.377.251 (380.647)	≤5 (0)
Hamburg	3.193 (180)	11.384.580 (640.508)	≤5 (0)
Hessen	30.463 (546)	25.948.758 (464.745)	94 (2)
Mecklenburg-Vorpommern	9.581 (648)	9.609.922 (649.675)	≤5 (0)
Niedersachsen	61.742 (852)	32.889.161 (454.074)	24 (0)
Nordrhein	102.973 (1.209)	41.009.655 (481.451)	275 (3)
Rheinland-Pfalz	16.544 (469)	19.617.725 (556.154)	77 (2)
Saarland	5.364 (621)	4.398.546 (509.517)	14 (2)
Sachsen	39.468 (1.032)	16.994.514 (444.369)	54 (1)
Sachsen-Anhalt	29.043 (1.415)	12.089.372 (589.091)	21 (1)
Schleswig-Holstein	17.420 (679)	12.348.602 (481.309)	26 (1)
Thüringen	29.202 (1.493)	7.242.738 (370.369)	34 (2)
Westfalen-Lippe	48.581 (644)	29.048.241 (384.981)	≤5 (0)

Tabelle 90 Abrechnungshäufigkeit der Leistungen des Notfalldatenmanagements nach Fachgruppen im Jahr 2023. Dargestellt sind die Abrechnungshäufigkeit (AH) pro Fachgruppe, die Gesamtanzahl Ärztinnen/Ärzte pro Fachgruppe und die Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte pro Fachgruppe (n Ä).

Fachgruppe	Gesamtanzahl Ärztinnen/Ärzte	Abrechnungshäufigkeit (AH) und Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte (n Ä) im Jahr 2023					
		GOP 01640 (Anlage)		GOP 01641 (Zuschlag NFD)		GOP 01642 (Löschung)	
		AH	n Ä	AH	n Ä	AH	n Ä
Hausärztinnen/-ärzte	63.549	130.777	3.560	153.747.621	55.233	96	86
Kinder- und Jugendme- dizin	9.133	6.456	310	21.110.851	7.595	8	≤5
Anästhesiologie	4.165	467	10	2.026.188	3.296	.	.
Augenheilkunde	7.014	6.499	68	22.773.976	6.366	.	.
Chirurgie	7.965	6.095	109	10.206.642	6.240	.	.
Dermatologie	4.334	4.206	94	16.455.955	3.804	.	.
Gynäkologie	13.530	334.529	1.977	29.715.531	11.645	1.498	89
HNO und Phoniatrie	4.861	7.156	116	18.336.862	4.343	≤5	≤5
Humangenetik	353	.	.	114.013	304	.	.
Innere Medizin	14.420	33.334	268	23.438.427	11.369	11	9
Labor	1.633	.	.	170.273	334	.	.
Neurologie und Ner- venheilkunde	5.330	2.873	78	9.418.723	4.509	≤5	≤5
Orthopädie	9.190	21.640	209	23.130.569	7.766	≤5	≤5
Pathologie	1.406	.	.	1.043	60	.	.
Physikalische und Re- habilitative Medizin	640	202	8	1.189.786	586	.	.
Psychiatrie	3.647	1.149	36	4.664.438	3.251	.	.
Psychosomatische Me- dizin	2.235	.	.	352.188	1.781	.	.
Psychotherapie	37.442	154	12	4.114.734	24.871	≤5	≤5
Radiologie, Nuklearme- dizin und Strahlenthe- rapie	7.025	10	7	10.972.898	5.828	.	.
Urologie	3.963	15.344	98	10.748.946	3.234	7	≤5
Sonstige	23.516	1.305	18	3.110.116	2.033	.	.

Tabelle 91 Abrechnungshäufigkeit für die Leistungen des Notfalldatenmanagements im Jahr 2023 nach Einrichtungsformen. In Klammern ist die mittlere Abrechnungshäufigkeit pro abrechnende Einrichtung angegeben.

Einrichtungsform	Abrechnungshäufigkeit nach Einrichtungsformen (durchschnittliche Ab- rechnungen je Einrichtung) im Jahr 2023		
	GOP 01640 (Anlage)	GOP 01641 (Zuschlag NFD)	GOP 01642 (Löschung)
Einzelpraxis	390.505 (108)	184.784.324 (2.624)	1.531 (12)
Gemeinschaftspraxis	147.383 (97)	140.935.880 (7.678)	78 (2)
MVZ	34.190 (117)	39.115.823 (10.107)	19 (2)
Sonstige	118 (20)	963.753 (1.054)	0 (0)

Zu Kapitel 10: Digitale Gesundheitsanwendungen**Zu 10.3: Leistungsentwicklung zu DiGA***Tabelle 92 Abrechnungshäufigkeit zu ärztlichen Leistungen im Zusammenhang mit DiGA pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.*

Leistung	Abrechnungshäufigkeit 2022				Abrechnungshäufigkeit 2023			
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
GOP 01471 (somnia)	836	756	845	931	1.622	1.373	1.209	1.212
GOP 01472 (Vivira)	.	.	928	1.922	5.065	4.290	4.264	4.715
GOP 01473 (zanadio)	.	.	.	.	951	880	1.348	1.014
GOP 01474 (Invirto)	.	.	.	.	.	176	178	167
GOP 01475 (Oviva)	.	.	.	.	.	.	.	396
GOP 01476 (Mawendo)	.	.	.	.	.	.	.	200

Tabelle 93 Leistungsbedarf in € für ärztliche Leistungen im Zusammenhang mit DiGA pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.

Leistung	Leistungsbedarf 2022 in €				Leistungsbedarf 2023 in €			
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
GOP 01471 (somnia)	6.026	5.420	6.064	6.613	11.800	10.022	8.845	8.845
GOP 01472 (Vivira)	.	.	6.692	13.859	37.238	31.538	31.348	34.665
GOP 01473 (zanadio)	.	.	.	.	6.990	6.469	9.907	7.455
GOP 01474 (Invirto)	.	.	.	.	.	1.294	1.308	1.228
GOP 01475 (Oviva)	.	.	.	.	.	.	.	2.911
GOP 01476 (Mawendo)	.	.	.	.	.	.	.	1.470

*Tabelle 94 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € pro Jahr für ärztliche Leistungen im Zusammenhang mit DiGA. In Klammern ist die Entwicklung der Abrechnungshäufigkeit in % im Vergleich zum Vorjahr angegeben. *Bei der Leistung zur DiGA Vivira gehen im Jahr 2022 nur das 3. und 4. Quartal in die Jahressumme ein. Bei der Leistung zur DiGA Invirto gehen jeweils nur das 2., 3. und 4. Quartal 2023 und zu den DiGA Oviva direkt und Mawendo nur das 4. Quartal 2023 ein.*

Jahr	Abrechnungshäufigkeit (Entwicklung in %)						
	GOP 01471 (somnia)	GOP 01472 (Vivira)*	GOP 01473 (zanadio)	GOP 01474 (Invirto)*	GOP 01475 (Oviva)*	GOP 01476 (Mawendo)*	Gesamt
2021	1.489	.	.	.	.	.	1.489
2022	3.368 (+126%)	2.850	.	.	.	.	6.218
2023	5.416 (+61%)	18.334	4.193	521	396	200	29.060

Jahr	Leistungsbedarf in €						Gesamt
	GOP 01471 (somnia)	GOP 01472 (Vivira)*	GOP 01473 (zanadio)	GOP 01474 (Invirto)*	GOP 01475 (Oviva)*	GOP 01476 (Mawendo)*	
2021	10.605	.	.	.	.	.	10.605
2022	24.123	20.550	.	.	.	.	44.673
2023	39.512	134.789	30.822	3.830	2.911	1.470	213.334

Zu 10.4: Regionale Abrechnungshäufigkeit zu DiGA sowie nach Fachgruppen und Einrichtungssformen

Tabelle 95 Regionale Abrechnungshäufigkeit der ärztlichen Leistungen zu DiGA nach KV-Bezirken. Dargestellt sind die absolute Abrechnungshäufigkeit und in Klammern die normierte Abrechnungshäufigkeit je 100.000 Versicherte.

KV-Bezirk	Abrechnungshäufigkeit DiGA-Leistungen (GOP 01471 bis 01476) nach KV-Bezirken (je 100.000 Versicherte) im Jahr 2023
Baden-Württemberg	2.756 (29)
Bayern	3.418 (30)
Berlin	892 (27)
Brandenburg	720 (31)
Bremen	1.349 (216)
Hamburg	470 (26)
Hessen	5.360 (96)
Mecklenburg-Vorpommern	300 (20)
Niedersachsen	2.626 (36)
Nordrhein	2.596 (30)
Rheinland-Pfalz	781 (22)
Saarland	243 (28)
Sachsen	1.383 (36)
Sachsen-Anhalt	946 (46)
Schleswig-Holstein	690 (27)
Thüringen	602 (31)
Westfalen-Lippe	3.928 (52)

*Tabelle 96 Abrechnungshäufigkeit der Leistungen im Zusammenhang mit DiGA nach Fachgruppen im Jahr 2023. Dargestellt sind die Abrechnungshäufigkeit (AH) pro Fachgruppe, die Gesamtanzahl Ärztinnen/Ärzte pro Fachgruppe und die Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte pro Fachgruppe (n Ä). * Bei der Leistung zur DiGA Invirto gehen jeweils nur das 2., 3. und 4. Quartal 2023 und zu den DiGA Oviva direkt und Mawendo nur das 4. Quartal 2023 ein.*

Fachgruppe	Gesamtanzahl Ärztinnen/ Ärzte	Abrechnungshäufigkeit (AH) und Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte (n Ä) im Jahr 2023					
		GOP 01471 (somnio)		GOP 01472 (Vivira)		GOP 01473 (zanadio)	
		AH	n Ä	AH	n Ä	AH	n Ä
Hausärztinnen/-ärzte	63.549	2.104	1.003	1.318	444	3.779	2.050
Chirurgie	7.965	282	≤5	3.312	47	.	.
Gynäkologie	13.530	128	76	.	.	≤5	≤5
HNO und Phoniatrie	4.861	415	83	.	.	.	.
Innere Medizin	14.420	633	70	15	14	405	43
Neurologie und Nervenheilkunde	5.330	411	86	.	.	.	.
Orthopädie	9.190	.	.	12.722	583	.	.
Physikalische und Rehabilitative Medizin	640	.	.	910	29	.	.
Psychiatrie	3.647	702	124	.	.	≤5	≤5
Psychosomatische Medizin	2.235	25	12	.	.	.	.
Psychotherapie	37.442	611	286	.	.	≤5	≤5
Sonstige	23.516	105	36	57	7	≤5	≤5

Fachgruppe	Gesamtan- zahl Ärztin- nen/ Ärzte	Abrechnungshäufigkeit (AH) und Anzahl abrechnender Ärz- tinnen/Ärzte (n Ä) im Jahr 2023						
		GOP 01474 (Invirto)*		GOP 01475 (Oviva)*		GOP 01476 (Mawendo)*		Gesamt
		AH	n Ä	AH	n Ä	AH	n Ä	
Hausärztinnen/-ärzte	63.549	12	9	392	269	19	13	7.624
Chirurgie	7.965	13	≤5	.	.	≤5	≤5	3.611
Gynäkologie	13.530	.	.	.	.	.	.	132
HNO und Phoniatrie	4.861	.	.	.	.	.	.	415
Innere Medizin	14.420	.	.	≤5	≤5	.	.	1.056
Neurologie und Nervenheilkunde	5.330	≤5	≤5	.	.	.	.	412
Orthopädie	9.190	.	.	.	.	177	19	12.899
Physikalische und Rehabilitative Medizin	640	.	.	.	.	.	.	910
Psychiatrie	3.647	23	12	.	.	.	.	726
Psychosomatische Medizin	2.235	8	≤5	.	.	.	.	33
Psychotherapie	37.442	462	221	.	.	.	.	1.074
Sonstige	23.516	≤5	≤5	≤5	≤5	.	.	168

Tabelle 97 Abrechnungshäufigkeit für ärztliche Leistungen zu DiGA (GOP 01471 bis 01476) nach Einrichtungsformen im Jahr 2023. In Klammern ist die mittlere Abrechnungshäufigkeit pro abrechnende Einrichtung angegeben.

Einrichtungstyp	Abrechnungshäufigkeit DiGA-Leistungen (GOP 01471 bis 01476) nach Einrichtungstypen im Jahr 2023 (durchschnittliche Abrechnungen je Einrichtung)
Einzelpraxis	16.868 (7)
Gemeinschaftspraxis	9.050 (7)
MVZ	3.136 (10)
Sonstige	6 (1)

Zu Kapitel 12: Telekonsilien

Zu 12.3: Leistungsentwicklung für Telekonsilien

Tabelle 98 Abrechnungshäufigkeit zu Telekonsilien pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.

Leistung	Abrechnungshäufigkeit 2022				Abrechnungshäufigkeit 2023			
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
GOP 01670 (Einholung)	9.036	8.435	8.779	9.352	11.903	10.947	12.985	12.597
GOP 01671 (Beurteilung)	2.740	3.050	3.469	3.979	4.908	4.376	4.763	4.845
GOP 01672 (Zuschlag)	713	554	578	643	752	640	814	1.050

Tabelle 99 Leistungsbedarf in € zu Telekonsilien in den Jahren 2022 und 2023 pro Quartal in den Jahren 2022 und 2023.

Leistung	Leistungsbedarf 2022 in €				Leistungsbedarf 2023 in €			
	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
GOP 01670 (Einholung)	112.001	104.553	108.815	115.924	150.483	138.409	164.161	159.258
GOP 01671 (Beurteilung)	39.517	43.987	49.997	57.384	72.205	64.375	70.072	71.278
GOP 01672 (Zuschlag)	5.222	4.058	4.233	4.709	5.618	4.782	6.082	7.845

Tabelle 100 Jährliche Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf für die Leistungen zu Telekonsilien. Bei der Abrechnungshäufigkeit ist zusätzlich die Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent angegeben.

Jahr	Abrechnungshäufigkeit (Entwicklung in %)			Leistungsbedarf in €		
	GOP 01670 (Einholung)	GOP 01671 (Beurteilung)	GOP 01672 (Zuschlag)	GOP 01670	GOP 01671	GOP 01672
2021	32.719	11.135	2.650	399.929	158.689	19.164
2022	35.602 (+9%)	13.238 (+19%)	2.488 (-6%)	441.293	190.886	18.222
2023	48.432 (+36%)	18.892 (+43%)	3.256 (+31%)	612.311	277.930	24.327

Zu 12.4: Abrechnungshäufigkeit für Telekonsilien – regional, nach Fachgruppen und Einrichtungsformen

Tabelle 101 Regionale Abrechnungshäufigkeit für Telekonsilien nach KV-Bezirken im Jahr 2023. Dargestellt sind die absolute Abrechnungshäufigkeit und in Klammern die normierte Abrechnungshäufigkeit je 100.000 Versicherte.

KV-Bezirk	Abrechnungshäufigkeit nach KV-Bezirken im Jahr 2023 (je 100.000 Versicherte)		
	GOP 01670 (Einholung)	GOP 01671 (Beurteilung)	GOP 01672 (Zuschlag)
Baden-Württemberg	12.543 (130)	4.701 (49)	1.751 (18)
Bayern	10.388 (90)	3.740 (32)	345 (3)
Berlin	2.696 (80)	171 (5)	41 (1)
Brandenburg	815 (35)	95 (4)	10 (0)
Bremen	674 (108)	149 (24)	29 (5)
Hamburg	1.104 (62)	278 (16)	79 (4)
Hessen	1.061 (19)	200 (4)	28 (1)
Mecklenburg-Vorpommern	1.293 (87)	684 (46)	32 (2)
Niedersachsen	4.049 (56)	1.181 (16)	280 (4)
Nordrhein	2.961 (35)	3.163 (37)	333 (4)
Rheinland-Pfalz	2.171 (62)	230 (7)	12 (0)
Saarland	275 (32)	110 (13)	9 (1)
Sachsen	1.245 (33)	1.352 (35)	32 (1)
Sachsen-Anhalt	699 (34)	335 (16)	18 (1)
Schleswig-Holstein	2.270 (88)	1.188 (46)	31 (1)
Thüringen	958 (49)	166 (8)	84 (4)
Westfalen-Lippe	3.230 (43)	1.149 (15)	142 (2)

Tabelle 102 Abrechnungshäufigkeit für Telekonsilien nach Fachgruppen im Jahr 2023. Dargestellt sind die Abrechnungshäufigkeit (AH) pro Fachgruppe, die Gesamtanzahl Ärztinnen/Ärzte pro Fachgruppe und die Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte pro Fachgruppe (n Ä).

Fachgruppe	Gesamtanzahl Ärztinnen/ Ärzte	Abrechnungshäufigkeit (AH) und Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte (n Ä) im Jahr 2023					
		GOP 01670 (Einholung)		GOP 01671 (Beurteilung)		GOP 01672 (Zuschlag)	
		AH	n Ä	AH	n Ä	AH	n Ä
Hausärztinnen/-ärzte	63.549	27.272	2.199	4.220	664	327	74
Kinder- und Jugendmedizin	9.133	1.310	184	634	67	117	10
Anästhesiologie	4.165	107	17	110	17	6	≤5
Augenheilkunde	7.014	50	14	513	9	6	≤5
Chirurgie	7.965	1.315	102	563	49	18	8
Dermatologie	4.334	1.729	55	686	48	548	18
Gynäkologie	13.530	4.117	319	817	234	285	16
HNO und Phoniatrie	4.861	1.061	35	255	26	79	8
Innere Medizin	14.420	6.278	316	6.588	300	905	51
Labor	1.633	≤5	≤5	.	.	.	.
Neurologie und Nervenheilkunde	5.330	1.098	75	1.679	64	216	20
Orthopädie	9.190	1.414	110	392	63	43	10
Pathologie	1.406	.	.	280	6	232	≤5
Physikalische und Rehabilitative Medizin	640	84	15	79	11	≤5	≤5
Psychiatrie	3.647	251	40	447	38	85	9
Psychosomatische Medizin	2.235	28	13	≤5	≤5	.	.
Psychotherapie	37.442	252	92	124	50	57	13
Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie	7.025	489	39	324	21	12	9
Urologie	3.963	1.058	104	1.004	55	301	19
Sonstige	23.516	518	33	173	19	15	≤5

Tabelle 103 Abrechnungshäufigkeit für Telekonsilien nach Einrichtungsformen im Jahr 2023. In Klammern ist die mittlere Abrechnungshäufigkeit pro abrechnende Einrichtung angegeben.

Einrichtungsform	Abrechnungshäufigkeit nach Einrichtungsformen im Jahr 2023 (durchschnittliche Abrechnungen je Einrichtung)		
	GOP 01670 (Einholung)	GOP 01671 (Beurteilung)	GOP 01672 (Zuschlag)
Einzelpraxis	20.605 (13)	9.425 (13)	2.053 (15)
Gemeinschaftspraxis	21.443 (25)	7.183 (17)	773 (14)
Krankenhaus	116 (9)	207 (17)	44 (9)
MVZ	6.022 (26)	2.054 (16)	379 (18)
Sonstige	246 (25)	23 (5)	7 (4)

Zu Kapitel 15: Notfallpauschalen per Videosprechstunde**Zu 15.3 Leistungsentwicklung für Notfallpauschalen per Videosprechstunde**

Tabelle 104 Abrechnungshäufigkeit für die Notfallpauschalen I und II als Videoleistung seit der Einführung im 3. Quartal 2022 und im Jahr 2023.

Leistung	Abrechnungshäufigkeit 2022		Abrechnungshäufigkeit 2023			
	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
GOP 01210V (Notfallpauschale I)	≤5	32	70	75	29	436
GOP 01212V (Notfallpauschale II)	12	95	203	227	338	2.418

Tabelle 105 Leistungsbedarf in € für die Notfallpauschalen I und II als Videoleistung seit der Einführung im 3. Quartal 2022 und im Jahr 2023.

Leistung	Leistungsbedarf 2022		Leistungsbedarf 2023			
	2022/3	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
GOP 01210V (Notfallpauschale I)	24	389	869	931	360	5.420
GOP 01212V (Notfallpauschale II)	237	1.878	4.094	4.578	6.817	48.768

Tabelle 106 Abrechnungshäufigkeit und Leistungsbedarf in € für die Notfallpauschalen I und II als Videoleistung seit der Einführung im 3. Quartal 2022 und im Jahr 2023.

Jahr	Abrechnungshäufigkeit (Entwicklung in %)		Leistungsbedarf in €	
	GOP 01210V (Notfallpauschale I)	GOP 01212V (Notfallpauschale II)	GOP 01210V	GOP 01212V
2022	34	107	414	2.115
2023	610	3.186	7.579	64.257

Tabelle 107 Regionale Abrechnungshäufigkeit für die Notfallpauschalen I und II als Videoleistung nach KV-Bezirken im Jahr 2023. Dargestellt sind die absolute Abrechnungshäufigkeit und in Klammern die normierte Abrechnungshäufigkeit je 100.000 Versicherte.

KV-Bezirk	Abrechnungshäufigkeit nach KV-Bezirken im Jahr 2023 (je 100.000 Versicherte)	
	GOP 01210V (Notfallpauschale I)	GOP 01212V (Notfallpauschale II)
Bayern	145 (1)	879 (8)
Hamburg	81 (5)	113 (7)
Hessen	78 (1)	128 (2)
Mecklenburg-Vorpommern	0 (0)	≤5 (0)
Niedersachsen	26 (0)	54 (1)
Nordrhein	127 (2)	998 (12)
Rheinland-Pfalz	42 (1)	358 (10)
Sachsen	0 (0)	≤5 (0)
Sachsen-Anhalt	0 (0)	≤5 (0)
Thüringen	44 (2)	175 (9)
Westfalen-Lippe	67 (1)	475 (6)

Tabelle 108 Abrechnungshäufigkeit für die Notfallpauschalen I und II als Videoleistung nach Fachgruppen im Jahr 2023. Dargestellt sind die Abrechnungshäufigkeit (AH) pro Fachgruppe, die Gesamtanzahl Ärztinnen/Ärzte pro Fachgruppe und die Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte pro Fachgruppe (n Ä).

Fachgruppe	Gesamtanzahl Ärztinnen/Ärzte	Abrechnungshäufigkeit (AH) und Anzahl abrechnender Ärztinnen/Ärzte (n Ä) im Jahr 2023			
		GOP 01210V (Notfallpauschale I)		GOP 01212V (Notfallpauschale II)	
		AH	n Ä	AH	n Ä
Hausärztinnen/-ärzte	63.549	136	27	757	67
Kinder- und Jugendmedizin	9.133	169	27	608	54
Anästhesiologie	4.165	.	.	≤5	≤5
Augenheilkunde	7.014	≤5	≤5	≤5	≤5
Chirurgie	7.965	.	.	≤5	≤5
Dermatologie	4.334	.	.	≤5	≤5
Gynäkologie	13.530	19	≤5	25	≤5
HNO und Phoniatrie	4.861	≤5	≤5	≤5	≤5
Innere Medizin	14.420	≤5	≤5	.	.
Neurologie und Nervenheilkunde	5.330	.	.	6	≤5
Orthopädie	9.190	8	≤5	≤5	≤5
Physikalische und Rehabilitative Medizin	640	.	.	≤5	≤5
Psychiatrie	3.647	≤5	≤5	≤5	≤5
Psychosomatische Medizin	2.235	≤5	≤5	10	3
Psychotherapie	37.442	.	.	≤5	≤5
Urologie	3.963	.	.	≤5	≤5
Sonstige	23.516	273	34	1.763	68

Tabelle 109 Abrechnungshäufigkeit für die Notfallpauschalen I und II als Videoleistung nach Einrichtung im Jahr 2023. In Klammern ist die mittlere Abrechnungshäufigkeit pro abrechnende Einrichtung angegeben.

Einrichtung	Abrechnungshäufigkeit nach Einrichtung im Jahr 2023 (durchschnittliche Abrechnungen je Einrichtung)	
	GOP 01210V (Notfallpauschale I)	GOP 01212V (Notfallpauschale II)
Einzelpraxis	168 (6)	770 (11)
Gemeinschaftspraxis	147 (6)	597 (11)
Krankenhaus	43 (14)	33 (16)
MVZ	23 (4)	56 (6)
Sonstige	229 (11)	1.730 (36)

